



IZA Transformatieplan

Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente +

Definitieve versie 27 juni 2024

Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Management samenvatting
2. Leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



Management samenvatting (1/2)

De essentie van de Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente+¹ is het toegankelijk houden van zorg ondanks de stijgende en complexer wordende zorgvraag en het toenemende arbeidstekort door middel van regionale digitale oplossingen die o.a. efficiëntere zorgprocessen bewerkstelligen.



Urgentie is groot met stijgende en complexer wordende zorgvraag en ruim 5% aan personeelstekort

Als regio Twente staan we voor een grote uitdaging als het gaat om **de stijgende en steeds complexer wordende zorgvraag** vanuit een **snelle verzilvering**² van onze inwoners (20% in 2020, 28% 65+ers in 2024³) en een stijgend aantal Twentse inwoners met een chronische aandoening (52% in 2024, +5000 inwoners in 2030).

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een alarmerend tekort aan zorgprofessionals: een verwachte toename van het **arbeidstekort** tot 5,2% in 2030, verzilvering van een aanzienlijk deel van ons personeel en demografische krimp van 1,6%.

De urgentie voor verandering is hierin groter dan ooit. Als regio **willen & moeten we bijdragen** om hierin het tij te keren. Deze wil vanuit alle deelnemende zorgpartijen, in combinatie met de mogelijkheid van een IZA-investering, maakt dat we nu het momentum hebben om een integrale transformatie samen vorm te geven.



Regionale digitale zorgtransformatie als antwoord op opgave

Om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave binnen Twente is **databeschikbaarheid** cruciaal. Een **regionale datahub** maakt het mogelijk om data vanuit de hele keten te combineren. Zorg kan zo **beter gecoördineerd** worden **en naadloos en geïntegreerd aangeboden** worden waarbij de Twentse inwoner centraal staat. Hierdoor kunnen we de groeiende zorgvraag

leveren met dezelfde hoeveelheid zorgmedewerkers. We werken zodoende samen aan de Digitale Regionale Zorgtransformatie in **één verbonden zorglandschap** waarbij we **passende (digitale) zorg lijnloos en lokaal aanbieden**.



Beschikbare, (her)bruikbare & bereikbare data vanuit 1 centrale plek

De regionale datahub maakt vanuit **één centrale plek** data **beschikbaar én bereikbaar** voor zorgaanbieders en inwoners van Twente, waarbij de data bij de bron blijft. De datahub voorziet in de uitwisseling, analyse en visualisatie van (gezondheids)data in de keten waarmee zorgaanbieders beschikken over de **juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment**. Inwoners krijgen meer inzicht en **regie** over hun data en kunnen vanuit **één herkenbare toegang** tot digitale diensten zorg afnemen in de regio Twente.

In het ontwerp is rekening gehouden met bestaande principes rondom interoperabiliteit, (inter)nationale informatiestandaarden, afsprakenstelsels, generieke functies en in lijn met de landelijke infrastructuur van CumuluZ.



Management samenvatting (2/2)



Use cases als startpotentieel van een schaalbare datahub

Vijf use cases vormen het startpunt van databeschikbaarheid middels de regionale datahub. Dit zijn: 360 graden beeld, regionaal diagnostisch portaal, advance care planning in de keten, gekoppelde thuismonitoring en regionaal capaciteitsinzicht. Door met deze vijf use cases te starten bouwen we vanaf de start aan een **schaalbare datahub**, waar in de toekomst nog meer use cases aan toegevoegd worden. Daarnaast is de ontwikkeling van de (toekomstige) use cases efficiënt door o.a. slim (her)gebruik van ontsluitingen tussen zorginformatiesystemen en door aan te sluiten op regionale en landelijke ontwikkelingen

Tot en met 2029 creëren we hiermee **€ 54,85 mln ruimte per jaar** voor de **opvang van de groeiende zorgvraag**. Hierin is meegenomen dat we als regio een extra potentieel verwachten vanuit dit fundament door de vijf use cases verder op te schalen en nieuwe use cases uit te rollen binnen de datahub.

Naast schaalbaarheid binnen de regio zien we ook andere mogelijkheden tot **opschaling buiten de regio**, vandaar de naam Twente+. Er lopen positieve gesprekken met de Achterhoek en Noord-Nederland over uitwisseling van digitale initiatieven (o.a. Zorgviewer). Hiermee kunnen we de zorgtransformatie in Twente én andere regio's en Nederland als geheel versnellen door op elkaars schouders te gaan staan c.q. hergebruiken van wat in andere regio's ontwikkeld is en niet opnieuw het wiel uit te (hoeven) vinden.

Om deze Digitale Regionale Zorgtransformatie tot uitvoering te brengen vraagt Twente voor de periode **2023 t/m 2026** voor **€ 37,97 mln** aan IZA-transformatiemiddelen aan.



Eén sectoraal plan waar alle zorgaanbieders in Twente achter staan

Om de transformatie van de zorg te realiseren werken alle zorgaanbieders in Twente vanuit **vertrouwen samen** in een **passende en gedragen governance**. Er is voor deze zorgtransformatie bestuurlijk draagvlak wat doorgegeven wordt aan de zorgprofessionals en inwoners van Twente.

Het zorgproces wordt vanuit de inwoner van Twente vormgegeven. Dit vraagt om het werken met **(data)standaarden, een uniform datamodel en gestandaardiseerde zorgpaden** rondom de zorgvraag van de inwoner met **uniforme werkprocessen**. Dit houdt in dat er bereidheid is om de eigen organisatie ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel, waarbij er voldoende ruimte is voor regionale verschillen zodat zorgprofessionals naar eigen inzicht en behoeften vanuit de lokale context kunnen handelen.

Om deze zorgtransformatie succesvol te realiseren is het cruciaal om aandacht te besteden aan adoptie van de veranderingen door de verschillende betrokken mensen, organisaties en sectoren. We hanteren een veranderaanpak waarin we de verschillende doelgroepen specificeren en gerichte adoptie en communicatie activiteiten op het juiste moment inzetten per doelgroep. Alleen zo kunnen we samen de Digitale Regionale Zorgtransformatie daadwerkelijk realiseren en in gebruik nemen.



Deelnemende zorgpartijen aan de Digitale Regionale Zorgtransformatie



Leeswijzer

Het IZA-transformatieplan

Dit IZA-transformatieplan is een essentieel document voor de aanvraag van IZA-transformatiegelden voor de Digitale Regionale Zorgtransformatie in Twente. Het vult het indieningsformat aan en biedt een gedetailleerde uitwerking van de voorgestelde zorgtransformatie. Het IZA-transformatieplan is opgedeeld in twee delen: de kern en de verdieping.

1. **Kern:** Dit gedeelte bevat de hoofdonderwerpen van het transformatieplan. De belangrijkste (samenvattende) slides van het IZA-transformatieplan zijn hierin opgenomen en geven input ter beoordeling van het transformatieplan.
2. **Verdieping:** Hierin gaan we dieper in op de details. In dit gedeelte zijn verdere uitwerkingen te vinden van de hoofdonderwerpen. Deze uitwerkingen geven meer context en toelichting bij de in de kern geïntroduceerde onderwerpen en hoe we hiertoe zijn gekomen. Daarnaast zijn alle bijlagen hierin te vinden.

Indeling

In de regio Twente geven we met de Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente+ antwoord op de groeiende uitdaging om met dalend of gelijkblijvend aantal handen meer zorg te verlenen. In hoofdstuk 1 Aanleiding, visie en waarde van de Digitale Regionale Zorgtransformatie lichten we deze groeiende uitdaging toe, beschrijven we onze gezamenlijke visie op de Digitale Regionale Zorgtransformatie, wat dit voor waarde oplevert voor de inwoner van Twente en hoe de zorgtransformatie zich landelijk en regionaal verhoudt tot andere initiatieven.

In de Digitale Regionale Zorgtransformatie realiseren we het fundament van een regionale datahub aan de hand van 5 use cases. Deze beschrijven we aan de hand van de kernproblematiek in de regio, de ambitie die we met elkaar hebben uitgesproken en wat dit voor inwoners, zorgprofessionals en de zorg oplevert in het hoofdstuk 2 Use cases. In hoofdstuk 3 Regionale datahub lichten we toe welke visie en uitgangspunten voor de regionale datahub zijn opgesteld, wat de beoogde beheergovernance van de regionale datahub is, welke doelarchitectuur hieronder ligt en hoe we tot de regionale datahub komen in een veranderportfolio.

De Digitale Regionale Zorgtransformatie vraagt verandering van de inwoners en zorgprofessionals in Twente. De opgave die hier ligt en de aanpak die we toepassen in de Digitale Regionale Zorgtransformatie beschrijven we in hoofdstuk 4 Zorgtransformatie. Binnen deze Digitale Regionale Zorgtransformatie werken we samen met elkaar vanuit vertrouwen. De governance die hieraan bijdraagt is beschreven in hoofdstuk 5 Governance. Hierin is opgenomen middels welke juridische samenwerkingsvorm en projectorganisatie en -governance we in de transformatieperiode willen samenwerken.

Met de Digitale Regionale Zorgtransformatie realiseren we binnen en buiten de transformatieperiode impact. Deze impact lichten we toe in hoofdstuk 6 Impactanalyse & maatschappelijke business case. Hierin beschrijven we de (maatschappelijke) baten van de zorgtransformatie, voor de inwoners van Twente en per zorgsector, en welke investering hiervoor nodig is. De planning van activiteiten gedurende de transformatieperiode is opgenomen in hoofdstuk 7 Integrale implementatieplanning. Tot slot, beschrijven we in kaart gebrachte risico's en hoe deze te voorkomen en/of te verhelpen zijn in hoofdstuk 8 Risico's en mitigerende maatregelen.



IZA Transformatieplan Regionale datahub

Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

1. De demografische opgave is groot in regio Twente om de zorg toekomstbestendig te houden
2. Digitale Regionale Zorgtransformatie als antwoord op de complexe uitdaging in de zorg
3. De Twentse inwoner en zorgprofessional staan centraal in de Digitale Regionale Zorgtransformatie
4. Digitale Regionale Zorgtransformatie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van het regio- en ROAZ-plan
5. Use cases vormen het fundament van de Digitale Regionale Zorgtransformatie
6. Via de regionale datahub realiseren de use cases gezamenlijk databeschikbaarheid in de zorg voor de inwoner
7. Voortbouwen op en aansluiten bij samenhangende regionale en landelijke initiatieven
8. De regionale datahub bereidt Twente voor op de toekomst (na 2026)

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



1.1 De demografische opgave is groot in regio Twente om de zorg toekomstbestendig te houden

Het regiobeeld toont een stijgende zorgvraag afgezet tegen een afnemend aantal zorgprofessionals

Als regio Twente staan we voor een grote uitdaging door **een stijgende en steeds complexer wordende zorgvraag**:



Snelle **verzilvering¹** van onze inwoners, met een verwachte toename van een derde meer ouderen (20% naar 28%) van 65+ tussen 2020 en 2040²



Een aanzienlijke stijging in de aantallen en **complexiteit van zorgvragen**, en dat terwijl op dit moment al 52%² van de Twentse inwoners te maken heeft met een chronische aandoening. Het aantal inwoners met ten minste één aandoening stijgt tot 2030 verder met meer dan 5000²

En worden we tegelijkertijd geconfronteerd met een **alarmerend tekort aan zorgprofessionals**, wat voortkomt uit meerdere factoren:



Verwachte toename van het **arbeidstekort** tot 5,2% in 2030, terwijl we tegelijkertijd kampen met een demografische krimp van 1,6%²

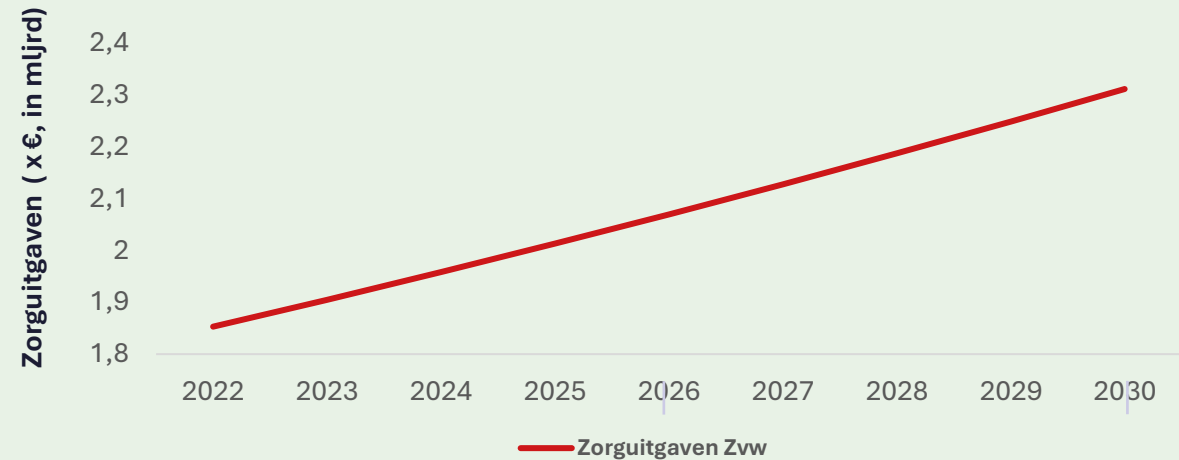


Aanzienlijke **verzilvering binnen ons zorgpersoneel**, met een stijging van het percentage werknemers ouder dan 55. Dit voorspelt een aanstaande golf van pensioneringen



Hoewel de groep vitale ouderen die elkaar kan mantelzorgen naar verwachting zal toenemen, bereikt het **mantelzorgpotentieel** een kritiek niveau. Waar het mantelzorgpotentieel in de regio nog 8,5% in 2023 was, daalt het naar 3,6% in 2040², wat duidt op een afname van beschikbare informele zorg

Als gevolg stijgen de jaarlijkse zorguitgaven in regio Twente tot ca. **2.3 miljard euro³** in 2030



Er dreigt een complexe uitdaging in het waarborgen van adequate zorgverlening in de regio: er moet een stijgende en steeds complexer wordende zorgvraag beantwoord worden met een afnemend aantal zorgprofessionals.

Dit vraagt om een ingrijpende regionale zorgtransformatie om een effectieve en duurzame oplossing te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst.



1.2 Digitale Regionale Zorgtransformatie als antwoord op de complexe uitdaging in de zorg

We organiseren de gezondheidszorg rondom de inwoner met de juiste data op de juiste plek

We hebben samen de ambitie uitgesproken om de gezondheidszorg van de inwoners anders te organiseren en te coördineren. We werken samen met de inwoner van Twente, de huisartsenpraktijken, wijkverpleging, verpleeghuizen, apotheken, GGZ-instellingen, laboratoria en de ziekenhuizen aan een Digitale Regionale Zorgtransformatie. We groeien naar een **verbonden zorglandschap** waarbij we passende (digitale) zorg lijnloos en lokaal aanbieden.¹ Door zorgaanbieders samen te brengen en te verbinden in één gecoördineerd netwerk kan de stap gemaakt worden van traditionele zorg vanuit verschillende silo's naar een stelsel met samenhangende integrale zorgprogramma's waarbij de vraag van de inwoner daadwerkelijk centraal staat. Dit betekent dat we keuzes maken over waar en hoe zorg geleverd wordt, waarbij we rekening houden met het IZA uitgangspunt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.²

De benodigde transformatie is een **maatschappelijke opdracht** die ons allen aangaat en niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgaanbieders. De inwoners van Twente hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om gezond en vitaal te blijven of worden. Een gezonde leefstijl en bewustwording hierover kan namelijk ook een positieve impact hebben op de gezondheid en de zorgvraag. Door de zorg anders te organiseren kan de inwoner van Twente meer regie op het eigen zorgproces nemen, met de potentie dat dit de zelf- en samenredzaamheid en vitaliteit binnen de regio vergroot.

Om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht binnen Twente is **databeschikbaarheid** cruciaal. Een **regionale datahub** maakt het mogelijk om data vanuit de hele keten en vanuit alle zorgaanbieders te combineren en zo het zorgproces door de hele keten heen in kaart te brengen.

Het belang van leren van fouten, slimmer handelen in de toekomst en **vertrouwen en samenwerking** bevorderen is essentieel voor de zorgtransformatie in Twente.

Zorg kan beter gecoördineerd worden en naadloos en geïntegreerd aangeboden worden aan de inwoner van Twente. De ontwikkeling van de regionale datahub is in nauwe afstemming met en aansluiting op landelijke initiatieven zoals de Zorgviewer en CumuluZ, waarbij Twente als een van de pilot regio's fungeert.



1) Dit raakt aan de IZA-doelstellingen voor hybride zorg, 2) In lijn met IZA-doelstellingen voor passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek



1.2 Digitale Regionale Zorgtransformatie als antwoord op de complexe uitdaging in de zorg

Met dezelfde hoeveelheid zorgprofessionals zijn we in staat antwoord te geven op de groeiende zorgvraag

Door databeschikbaarheid via een regionale datahub beschikken zorgaanbieders (en op termijn ook de inwoners van Twente) over de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment, via één portaal. Dit stelt de zorgprofessionals in staat om hun werk efficiënter te doen met minder administratieve lasten. We voorkomen zorg(instroom) daar waar dat geen waarde toevoegt voor de inwoner van Twente. Daarnaast verschuiven we onze focus op zorg naar **focus op gezondheid**. Ook kan relevante data gebruikt worden om zorgbehoeften beter te voorspellen en preventieve maatregelen te nemen. Doordat de zorgprocessen consistent en beter voorspelbaar zijn, worden wachtlijsten korter en nemen administratieve lasten af. We kunnen ook de beschikbare capaciteit beter benutten. Hiermee kan de zorgprofessional zich echt concentreren op wat het belangrijkste is: de inwoner van Twente. De uitgangspunten van de regionale datahub staan beschreven in hoofdstuk 3.3.

De datahub is in lijn met de landelijke data infrastructuur van CumuluZ. Met de regionale datahub worden daardoor de eerste stappen gezet naar (landelijke) databeschikbaarheid. Databeschikbaarheid maakt individuele preventie mogelijk, en creëert in de nabije toekomst ook de mogelijkheid om geavanceerde strategieën te ontwikkelen om de gezondheid van inwoners in Twente te verbeteren. Door de grote databeschikbaarheid en geavanceerde analyses is het mogelijk om bijvoorbeeld uitbraken van ziekten te voorspellen en te voorkomen.

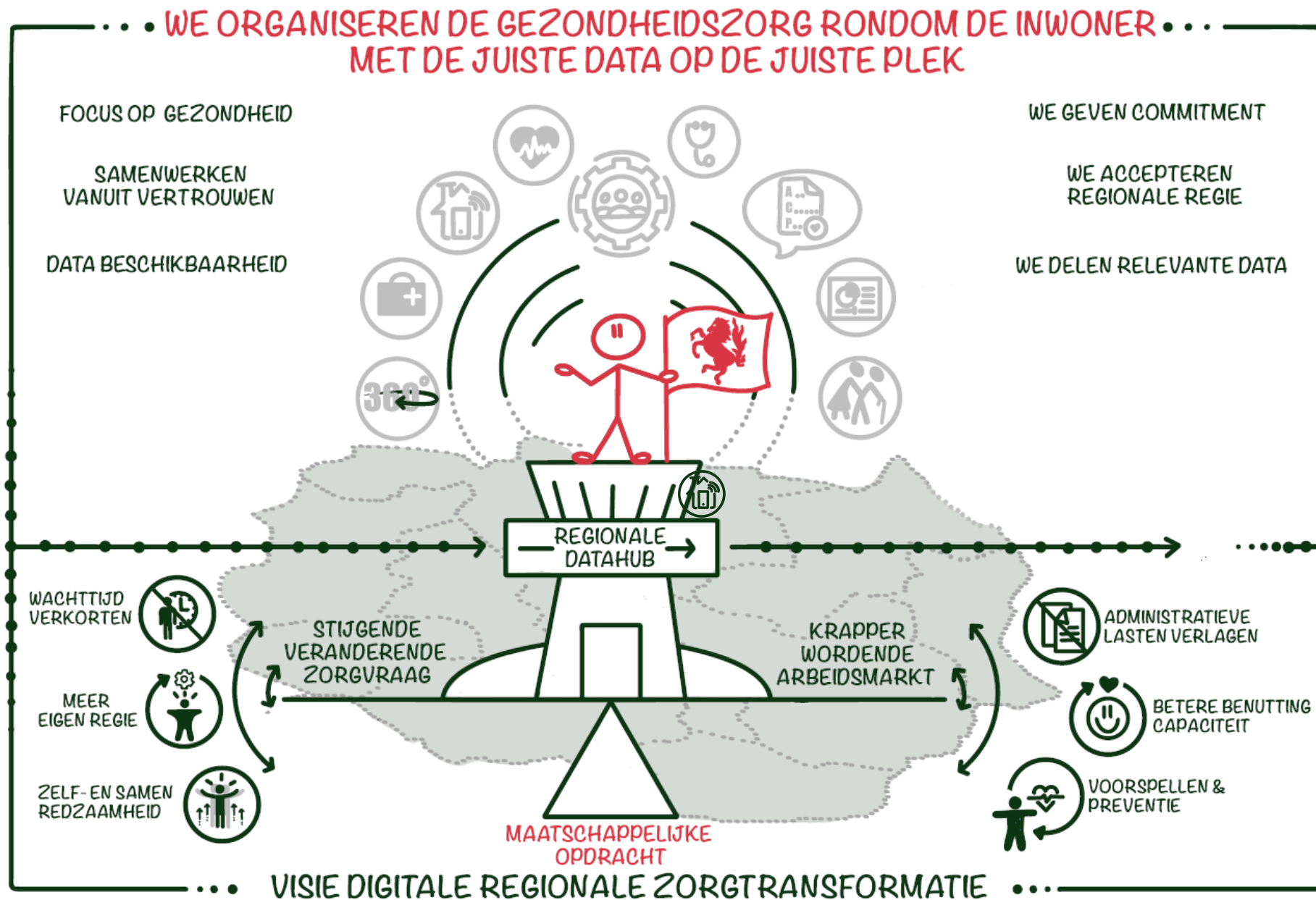
Om de transformatie van de zorg te realiseren werken alle zorgaanbieders in Twente vanuit **vertrouwen samen in de juiste governance**. Er is voor deze zorgtransformatie bestuurlijk draagvlak die doorgegeven wordt aan de zorgprofessionals en inwoners van Twente. Het zorgproces wordt vormgegeven

vanuit de inwoner van Twente. Dit vraagt om gestandaardiseerde zorgpaden rondom de zorgvraag van de inwoner met uniforme werkprocessen, wat inhoudt dat er bereidheid is om de eigen organisatie ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel. De regionale datahub faciliteert dit door (data) standaarden te implementeren en een uniform datamodel te creëren. Daarbij blijft er voldoende ruimte voor regionale verschillen zodat zorgprofessionals naar eigen inzicht en behoeften vanuit de lokale context kunnen handelen. De digitale regionale transformatie is daarom een hulpmiddel om de zorg toekomstbestendig te maken, waardoor regio Twente de groeiende zorgvraag aan kan met dezelfde hoeveelheid mensen.

Om de visie met elkaar te bereiken zijn er gezamenlijke uitgangspunten opgesteld hoe we invulling geven aan de maatschappelijke opgave:

- 1 We geven commitment dat we de transformatie met elkaar gaan realiseren en tot nieuwe organisatie-overstijgende processen komen
- 2 We accepteren regionale regie op het realiseren van onze gezamenlijke ambitie
- 3 We delen relevante data met elkaar voor het primaire zorgproces om betere zorg voor de inwoner te creëren





1.3 De Twentse inwoner en zorgprofessional¹ staan centraal in de Digitale Regionale Zorgtransformatie

Kwaliteit van leven, samenwerking tussen zorgprofessionals en werkplezier worden vergroot

Als **transfercoördinator in de VVT** kan ik beter samenwerken met andere zorgprofessionals en merk ik verbeterde doorstroom doordat ziekenhuizen onze capaciteit voor de opname van inwoners direct in kunnen zien.



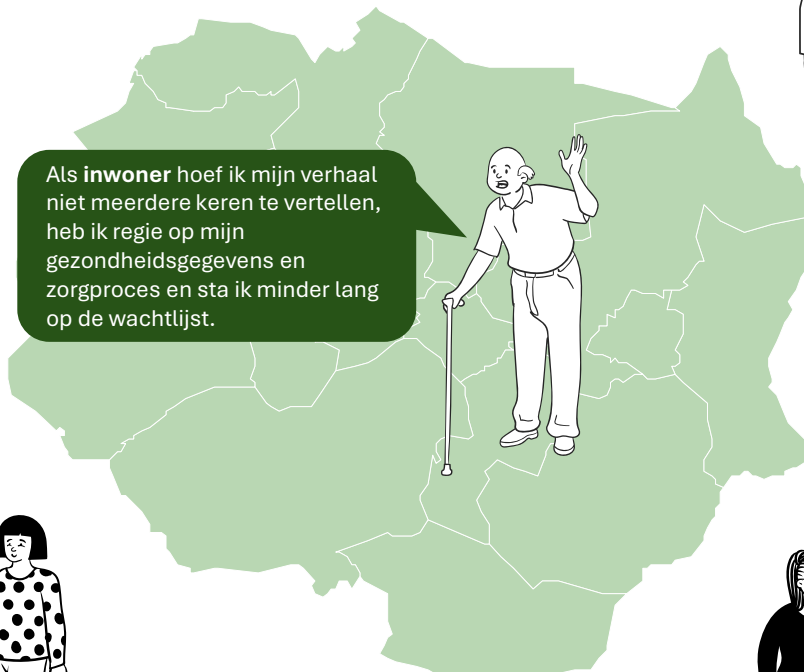
Als **monitoringsverpleegkundige²** heb ik beter en completer inzicht in de situatie van mijn patiënten, waardoor ik onnodige taken kan voorkomen en risico's tijdig kan signaleren. Dit verhoogt niet alleen de regie van de inwoner, maar zorgt ook voor meer werkplezier.



Als **diagnostiek specialist** kan ik trendanalyses uitvoeren en patronen herkennen om zorgbehoeften te voorspellen, wat bijdraagt aan proactieve zorgplanning.



Als **inwoner** hoef ik mijn verhaal niet meerdere keren te vertellen, heb ik regie op mijn gezondheidsgegevens en zorgproces en sta ik minder lang op de wachtlijst.



Als **huisarts** merk ik dat de inwoner meer eigen regie op het zorgproces voert en de zelfredzaamheid binnen de regio vergroot wordt. Dit bespaart ons contacttijd met de inwoner.



Als **medisch specialist** ervaar ik minder administratie, doordat ik minder tijd kwijt ben aan het verzamelen, registreren & verifiëren van informatie, doordat data in één portaal op een eenvoudige en snelle manier beschikbaar is.



Als **apotheker** heb ik meer informatie beschikbaar over de historische en huidige medicatie, waardoor ik passender en veiliger beleid kan uitvoeren. Dit voorkomt incidenten.



1) We zijn ons ervan bewust dat de afbeeldingen niet 1-op-1 representatie geven aan de beschreven inwoners en zorgprofessionals maar willen hiermee aangeven dat het een diverse groep betreft

2) Hoe deze functie wordt ingericht is nog nader te bepalen.



1.4 Digitale Regionale Zorgtransformatie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van het regio- en ROAZ-plan

Databeschikbaarheid middels een regionale datahub is essentieel voor de uitvoering van regionale thema's

Databeschikbaarheid via een regionale datahub

Regioplan Zorgkantoorregio Twente

De regiovisie van Twente Beter is “Komen tot meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar, door verdergaande samenwerking tussen inwoners, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten.”

Verregaande samenwerking betekent ook het delen van data over de grenzen van eigen instellingen heen en gebruiken voor o.a. de volgende thema's uit het regioplan:

- **Zorg voor Ouderen**, bijv. voor doorstroom in de Wlz
- **Samen beslissen / ACP**, in het beschikbaar maken van ACP-gegevens in de keten voor verschillende zorgprofessionals
- **Acute zorg / zorgcoördinatie**, voor inzicht in inwoner- en capaciteitsgegevens in acute situaties
- **Hybride zorgpaden**, voor regionale invulling van hybride zorg

Het regioplan is ontstaan vanuit de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter waarmee afstemming is voor dit transformatieplan.



ROAZ-plan Euregio

Een van de speerpunten in het ROAZ-plan is “geïntegreerde samenwerking in de acute zorg(keten) en aansluiting op andere domeinen”.

Optimale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid (o.a. capaciteitsgegevens en relevante patiëntgegevens) worden hiervoor als randvoorwaarde aangemerkt. Daarnaast speelt databeschikbaarheid een rol bij andere thema's uit het ROAZ-plan, o.a.:

- **Differentiatie, concentratie en spreiding** op basis van kwaliteit(snormen)
- **(Flexibel) anticiperen op zorgcontinuïteitsproblemen** ingegeven door schaarste
- **Het organiseren van zorgcoördinatie** in de regio



1.5 Use cases vormen het fundament van de regionale datahub

Directe toepassing van databeschikbaarheid door parallelle ontwikkeling van vijf use cases

Regionale datahub

Via de regionale datahub worden gegevens die bij één zorgaanbieder beschikbaar waren beschikbaar in de hele regio. Vijf use cases vormen de basis van databeschikbaarheid middels de regionale datahub. We houden hierbij rekening met landelijke wet- en regelgeving m.b.t. databeschikbaarheid (zie bijlage C)

Binnen de use cases vindt **directe toepassing** van databeschikbaarheid plaats en wordt op impactvolle wijze waarde gecreëerd voor de inwoner en zorgprofessional. Door met deze vijf use cases te starten bouwen we vanaf de start aan een **schaalbare datahub**, waar in de toekomst nog meer use cases aan toegevoegd worden. Daarnaast is de ontwikkeling van de use cases **efficiënt** door o.a. slim (her)gebruik van ontsluitingen tussen zorginformatiesystemen.



360-graden beeld

In het 360-graden beeld wordt relevante informatie van de inwoner getoond waarin o.a. beschikbaarheid van gegevens over verpleegkundige overdrachten, ACP, inzicht in diagnostische aanvragen en in de toekomst uitslagen vanuit het regionaal diagnostisch portaal



Regionaal diagnostisch portaal

Door labdiagnostiek aan te vragen via één portaal en inzicht in aangevraagde onderzoeken en uitslagen in *het 360-graden beeld* worden administratieve lasten verminderd en wordt dubbele diagnostiek voorkomen.



Advance care planning in de keten

Passende zorg voor kwetsbare inwoners door actuele beschikbaarheid van wensen, waarden en behoeften in een digitaal ACP overzicht in *het 360-graden beeld*



Gekoppelde thuismonitoring

Integrale zorg voor inwoners met een chronische ziekte door de beschikbaarheid van monitoringsgegevens voor alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor de inwoner



Regionaal capaciteitsinzicht

Vergrote toegankelijkheid van zorg en juiste zorg op de juiste plek door regionaal capaciteitsinzicht o.b.v. een dashboard en regionale werkafspraken



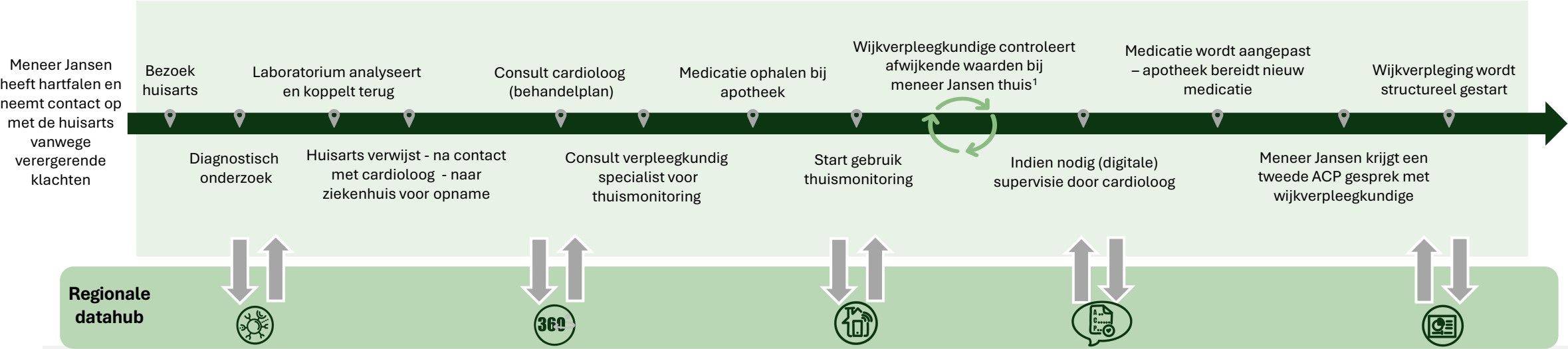
Medische beelden

Deze use case heeft als doel om medische beelden regionaal inzichtelijk te maken. Tijdens het opstellen van het transformatieplan is de use case Medische Beelden verkend, maar de use case is nog niet meegenomen in het plan omdat er meer uitwerktijd voor nodig is.



1.6 Via de regionale datahub realiseren de use cases gezamenlijk databeschikbaarheid in de zorg voor de inwoner

*Zorgprofessionals hebben inzicht in de juiste data van Meneer Jansen op de juiste plek in het zorgproces via één portaal
Meneer Jansen heeft het overzicht en de regie, en vindt de informatie gedurende de ‘reis’ ook op één plek terug*



Use cases

Regionaal diagnostisch portaal
Met informatie vanuit het regionaal diagnostisch portaal kan de huisarts (evt. in samenspraak met cardioloog) inzien wat er al qua diagnostiek aanwezig is via de datahub, en kan hierdoor een passende beslissing nemen over diagnostisch onderzoek.

360-graden beeld
Door de beschikbaarheid van de nodige patiëntinformatie op het juiste moment kunnen de huisarts en cardioloog een passende beslissing over de vervolgstap nemen.

Gekoppelde thuismonitoring
De betrokken regionale zorgprofessionals hebben toegang tot de gegevens van de inwoner, waardoor de inwoner op afstand gemonitord kan worden. De wijkverpleegkundige controleert de afwijkende waarden bij de inwoner thuis en kan dit ook direct aan de cardioloog terugkoppelen indien nodig.

Advance care planning in de keten
Gezien de situatie van de inwoner wordt er een tweede ACP gesprek ingepland met de wijkverpleegkundige. In het eerste gesprek zijn de wensen, waarden en behoeften van de inwoner vastgelegd in een digitaal ACP overzicht. In het tweede gesprek wordt dit getoetst en indien nodig geactualiseerd.

Regionaal capaciteitsinzicht
Via het dashboard capaciteitsinzicht kan de transferverpleegkundige inzien welke beschikbaarheid vanuit de wijkverpleging er is in de woonomgeving van de inwoner. Zo wordt contact opgenomen met de wijkverpleging of zorgbemiddeling, waarna de zorg wordt gestart.

1) '(Wijk)verpleegkundige' kan ook verwijzen naar een 'verzorgende' of een ander lid van een 'wijkteam'



1.7 Voortbouwen op en aansluiten bij samenhangende regionale en landelijke initiatieven (1/2)

We houden op inhoudelijk en strategisch vlak rekening met wat speelt in de regio en de rest van Nederland

Samenbrengen en waarde versterken van lopende initiatieven

In onze regio starten we niet vanaf nul. Da afgelopen jaren zijn er in verschillende samenwerkingsverbanden waardevolle initiatieven gestart op het gebied van het realiseren van databeschikbaarheid en het ontwikkelen van een (deel van de) regionale infrastructuur. Voorbeelden van lopende initiatieven zijn het 360-graden beeld vanuit Inzicht Twente, Zorg bij Jou (Santeon) voor hybride zorg en regionaal capaciteitsinzicht vanuit het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). In bijlage A is een overzicht van de samenwerkingsverbanden en samenhangende initiatieven opgenomen. Daarnaast lopen er voor de thema's ACP en Regionaal Capaciteitsinzicht ook andere aanvragen waarover afstemming is geweest zodat ze op elkaar aansluiten en er geen dubbeling in de aanvraag zit. We willen de initiatieven in de regio samenbrengen, hierop voortbouwen en meenemen in de ontwikkeling van de regionale datahub. Hierdoor borgen we de continuïteit van de lopende initiatieven, integreren we bestaande kennis en expertise en bevorderen we de acceptatie van en het draagvlak voor de zorgtransformatie. In sommige gevallen kan dit ook betekenen dat lopende initiatieven stoppen, bijv. omwille van schaalbaarheid in de regio, of dat we goed moeten onderzoeken en evalueren wat binnen welk initiatief valt (zie bijlage B voor het voorbeeld van de Buurtzorg Alliantie).



Bijdragen aan CumuluZ

Op landelijk niveau ontwikkelt de CumuluZ-coalitie¹ één publieke data-infrastructuur. De regionale datahub en CumuluZ hebben hetzelfde primaire doel: data uit de keten ontsluiten en beschikbaar stellen. Het CumuluZ initiatief is net als de regionale datahub een data-integratieplatform. De intentie van beide platformen is om op te schalen in een regionale setting. De uitgangspunten van CumuluZ zijn beoordeeld en getoetst op de uitgangspunten van de regionale datahub; deze komen met elkaar overeen en maken gebruik van dezelfde generieke componenten. Dit biedt vertrouwen in de integratie en schaalbaarheid van beide platforms. De regio Twente wil aansluiten op bewezen en beschikbare initiatieven en daarmee bijdragen aan het realiseren van CumuluZ.

Verhouding tot de Zorgviewer (Rivo Noord)

We werken functioneel samen met de regio Noord-Nederland (Rivo Noord) waar de Zorgviewer is ontwikkeld. De Zorgviewer is een technische oplossing om zorggegevens tussen de eerste, tweede en derde lijn te tonen. De Zorgviewer is vanuit CumuluZ gedachte ontwikkeld. De samenwerking tussen de regio's Twente en Noord-Nederland met betrekking tot de Zorgviewer kent vele voordelen en belooft een naadloze uitwisseling van zorggegevens wat leidt tot een meer holistische en efficiënte (coördinatie van) zorg voor de inwoners van deze regio's. Door de samenwerking kunnen we elkaars componenten gebruiken, wat leidt tot een meer geïntegreerde en efficiënte zorginfrastructuur. Zo kan de Zorgviewer profiteren van de functionaliteit van de use case 360-graden beeld en de geavanceerde data-analyse en verwerkingstechnologieën van de regionale datahub Twente. Andersom kan binnen de use case 360-graden beeld geleerd worden van de snelle praktische toepassing van de Zorgviewer op brede schaal. Zo voorkomen we dat we in Twente opnieuw het wiel uit proberen te vinden, wat ook financieel voordeel oplevert. Een inschatting van de tijdslijn, investering, functionele en technische verbinding voor aansluiting bij Zorgviewer is uitgewerkt in de verdieping, bijlage H.

1) De CumuluZ-coalitie bestaat op het moment van oplevering van dit transformatieplan uit de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), mProve en Santeon.



1.7 Voortbouwen op en aansluiten bij samenhangende regionale en landelijke initiatieven (2/2)

We houden op inhoudelijk en strategisch vlak rekening met wat speelt in de regio en de rest van Nederland

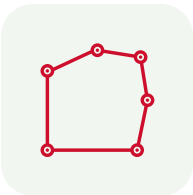
Verhouding tot de Achterhoek

De regio's Twente en de Achterhoek kennen door onze geografische ligging en betrokkenheid bij diverse projecten een langdurige samenwerking. Ook op het vlak van digitalisering wordt deze samenwerking verkend. Hiervoor zijn de gesprekken tussen de regio's constructief geweest. In de Achterhoek is een digitale omgeving gecreëerd met het zorgplatform en mijn-PGO, waarmee diverse trajecten, zoals Positieve gezondheid en Vitaliteit/leefstijl in de wijk, ondersteund kunnen worden. Hoewel de uitgangspunten van het platform en het gebruik van landelijke standaarden tussen beide regio's overeenkomt, wordt er in de regio Twente niet gekozen voor dezelfde leverancier van het platform. Dit hoeft samenwerking tussen de regio's niet in de weg te liggen. De samenwerking tussen beide regio's profiteert van de ervaring uit de Achterhoek m.b.t. procesontwikkeling en techniek en de testmogelijkheden op de techniek die in Twente wordt ontwikkeld. Ook op inhoud vullen de regio's elkaar aan. In de Achterhoek heeft de focus meer gelegen op de langdurige zorg en richt de regio Twente zich nu nog vooral op de directe zorg en gerelateerde data. Een mogelijk vervolg is dat de Achterhoek met de opgedane kennis van de afgelopen jaren gebruik maakt van het dataplatform wat in Twente ontwikkeld wordt waardoor kennis gebord wordt, ervaring gedeeld wordt en versnelling voor een bredere regio kan worden beproefd. Daarnaast is het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, uit de regio Achterhoek, recent lid geworden van Zorgnetoost en onderdeel geworden van dit proces om later evt. aan te haken op het initiatief



Samenwerking op use case niveau Advance Care Planning

De regionale samenwerkingsorganisaties (RSOs) Zorgring, RSO Zuid Limburg, Trijn en Zorgnetoost slaan de handen ineen om gezamenlijke inspanning te leveren voor de ontwikkeling van een robuuste data infrastructuur voor de use case Advance Care Planning (ACP). De use case ACP is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking tussen regio's kan leiden tot verbeterde zorguitkomsten. De achtergrond van de use case ACP is geworteld in de behoefte om inwoners een stem te geven in hun zorgproces, wanneer zij niet meer in staat zijn hun wensen duidelijk te maken. Hiervoor dienen wensen, waarden en behoeften met betrekking tot toekomstige medische behandelingen en zorg proactief vastgelegd worden. Dit vereist naadloze samenwerking en gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders en regio's. In deze samenwerking zijn datamanagement en digitale infrastructuur sleutels tot succes. Door met meerdere RSOs deze sleutels tot succes te organiseren, bouwen we aan een fundament waarin de regio's één taal gaan spreken: die van data. En we hebben het nadrukkelijk over een fundament, omdat toekomstige samenwerkingsinitiatieven (bijv. nieuwe use cases) voortbouwen op de infrastructuur die we nu gezamenlijk met elkaar neerzetten.



1.8 De regionale datahub bereidt Twente voor op de toekomst (na 2026)

Door uitbreiden, optimaliseren en samenwerken bouwen we aan de toekomst van de regionale datahub Twente

Momenteel leggen we het fundament voor een datahub die klaar is voor de uitdagingen van morgen en dit proces stopt niet na 2026. Integendeel, de Digitale Regionale Zorgtransformatie wordt een continu proces van **uitbreiden**, **optimaliseren** en **samenwerken**.

Ons doel is om toekomstbestendig te zijn, zodat we naadloos kunnen inspelen op nieuwe groei en technologieën. Daarbij maken we gebruik van en sluiten we aan bij bewezen succesvolle initiatieven, zowel op regionaal als landelijk niveau. Samen bouwen we aan een datahub die klaar is voor de technologische ontwikkelingen van morgen.

Uitbreiden



Use cases

- Verbreed de scope van de use cases, bijv. door de doelgroep uit te breiden
- Nieuwe use cases toevoegen, bijv. regionaal inzicht medicatie voorraad of datagedreven klinische beslisondersteuning

Functionaliteiten

- Verwerk en verrijk informatie in lijn met de ontwikkelingen van de nationale strategie en visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Optimaliseren



Terugkijken

- Optimaliseer passende zorgverlening en processen door bijv. verbetercyclus Value-Based-Healthcare (VBHC) en knelpunt analyses capaciteit

Vooruitzicht

- Focus op de introductie van nieuwe technologische toepassingen binnen de datahub, zoals Artificial Intelligence (AI) en Robotic Process Automation (RPA) waardoor we processen kunnen voorspellen en verder optimaliseren.

Samenwerken



Samenwerken

- Aansluiting bij initiatieven rondom een landelijk dekkende infrastructuur
- Twente als proeftuin omgeving voor het testen en valideren van nieuwe use cases, die daarna op grotere schaal kunnen worden uitgerold



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

1. Opbouw use cases
2. Use case: 360-graden beeld
3. Use case: Regionaal diagnostisch portaal
4. Use case: Advance care planning in de keten
5. Use case: Gekoppelde thuismonitoring
6. Use case: Regionaal capaciteitsinzicht

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



2.1 Opbouw van de use cases

Samenvatting per use case opgenomen in de kern, uitgebreide beschrijving in de verdieping

In dit kerndocument zijn de belangrijkste hoofdstukken voor de beoordeling van het transformatieplan per use case samengevat. Dit zijn de hoofdstukken ambitie, impact en transformatieplanning. In de verdieping per use case (zie Verdieping) is de detailuitwerking van de use case opgenomen, onder andere aangevuld met meer toelichting bij de aanpak die nodig is om de ambitie te realiseren.

Kern



Ambitie van de use case

Gebaseerd op de kernproblematiek in de regio, incl. voortbouw regionale e/o landelijke projecten/initiatieven, link met IZA-doelstellingen en mogelijkheden voor doorontwikkeling



Impact van de use case

De impact is zowel kwalitatief als kwantitatief in kaart gebracht. Met behulp van het quadruple aim-model¹ is de kwalitatieve impact bepaald. De kwantitatieve impact is benaderd o.b.v. de som van:

- **De doelgroep:** Specifieke doelgroep die beïnvloed wordt door de use case
- **Het effect:** Verschil tussen de huidige en toekomstige situatie voor die doelgroep
- **De inclusie:** Benodigde ingroeistappen over de tijd om het gewenste effect te kunnen bereiken



Transformatieplanning

Planning van de realisatie van de use case, incl. SMART-doelstellingen en KPI's om de voortgang te kunnen monitoren

De use cases zijn in verschillende werkgroepen uitgewerkt. In deze werkgroepen hebben **tientallen zorgprofessionals** vanuit verschillende sectoren, waaronder de VVT, MSZ, diagnostiek, huisartsenzorg, apotheekzorg, RSO en GGZ, zich ingezet. Zij hebben intensief samengewerkt in interviews, werk- en validatiesessies van midden maart tot midden mei om tot het transformatieplan te komen. Al met al een **indrukwekkende prestatie!**

Verdieping

Uitgebreide beschrijving van de ambitie, impact, beschrijving van het nieuwe zorgproces, hierbij betrokken stakeholders, te maken afspraken en randvoorwaarden (o.a. wet- en regelgeving en richtlijnen)



1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model. Hierin wordt de impact op (1) gezondheidsuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredenheid en (4) zorgkosten meegenomen.



2.2 Use case 360-graden beeld



2.2.1 360-graden beeld | Ambitie

De zorgprofessional ontlasten en meer tijd voor zorg geven door efficiënter en effectiever toegang tot benodigde (zorg-)informatie en hiermee de kwaliteit van zorg voor de inwoner verbeteren



Kernproblematiek

- Het is onbekend of een inwoner belangrijke behandelhistorie heeft om rekening mee te houden in diens zorgproces
- Behandelhistorie van de inwoner is niet toegankelijk, maar opgeslagen in gesloten bronsystemen
- Inwoner en/of mantelzorg zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van actuele informatie
- Inwoner mist inzicht in en overzicht van eigen gezondheidsinformatie

Link IZA-opgaven

- De beschikbaarheid van relevante zorggegevens maakt het mogelijk om **passende zorg** te leveren aan de inwoner. Er kan zo een betere inschatting worden gemaakt van de benodigde zorg, bijv. type medicatie of wensen, waarden en behoeften
- **Zorgprofessionals worden ontzorgd** door het 360-graden beeld en hun registratie/administratielast neemt af, daarnaast hoeft de zorgprofessional minder lang te wachten tot de overdracht is toegestuurd



Huidige situatie

In veel gevallen wordt er door zorgprofessionals van verschillende zorgaanbieders samengewerkt rondom de inwoner. Het is voor hen niet mogelijk of tijdrovend om een compleet van behandelhistorie van de inwoner te krijgen. Dit zorgt voor een **inefficiënt zorgproces**, omdat tijd verloren gaat door het achterhalen van benodigde informatie. De zorgprofessional kan daardoor minder tijd besteden aan kern-zorgtaken. Ook kan er **dubbelling van zorg of diagnostiek** plaatsvinden om informatie boven water te krijgen, bijv. in spoedsituaties. Daarnaast heeft het gevolgen voor de **kwaliteit van zorg**, zoals kans op niet-passende zorgverlening, verergering van ziekte, complicaties of foutief gebruik van medicatie.



Ambitie, eind 2026:

- **Ontlast het 360-graden beeld zorgprofessionals** door inzicht in beschikbare, gestandaardiseerde data o.b.v. zorginformatiebouwstenen (zibs) uit bronsystemen, in een 360-graden beeld. Hierdoor vermindert tijd die zij besteden aan het verzamelen van informatie en komt **meer tijd vrij voor hun kern-taak “zorgen”**. Inwoners krijgen hierdoor beter passende zorg
- Zijn de volgende toepassingen beschikbaar in het 360-graden beeld:
 - Overdracht tussen ZKH en VVT en vice versa o.b.v. informatiestandaarden BgZ en eOverdracht voortbouwend op het VIPP InZicht-traject
 - Een “generiek kerndossier” ten behoeve van inzage in de op dat moment beschikbare zibs, ten minste bestaande uit: BgZ, BgLZ, eOverdracht, huisartsgegevens, labuitwisseling en medicatieproces
 - Voor de samenwerking in ACP is een gestandaardiseerde minimale dataset beschikbaar, evt. in aanvulling op het “generiek kerndossier”. Deze wordt in nauwe samenhang met de ACP in de keten use case werkgroep samengesteld.¹



Doorontwikkeling, na 2026:

- Voegen we **nieuwe use cases/zorgpaden** toe, waaronder use cases voor het ZCC en de mogelijkheid tot het filteren van het 360-graden beeld op use case basis
- Voegen we de **functionaliteiten voor (selectief) verwerken en verrijken** van de informatie in het 360-graden beeld toe in lijn met de ontwikkelstappen in de NVS



2.2.2 360-graden beeld | Impact (1/2)

Verzamelen van benodigde (zorg)informatie kost minder tijd en kans op ontbreken informatie neemt af



Kwalitatieve impact¹ (kwantitatieve impact opgenomen op volgende slide)

1

- Juiste zorg op de juiste plek vanwege tijdig de juiste informatie
- Passende zorg vanwege inzicht in behandelhistorie en zorggegevens inwoner
- Doorstroom en continuïteit van zorg verbeterd door eerder beschikken over benodigde informatie

2

- Minder herhaling van vragen van zorgprofessionals gedurende inwonersreis en –situatie
- Meer vertrouwen in zorg, ook bij naasten en mantelzorg omdat eerder verstrekte informatie bij zorgprofessionals bekend is
- Minder belasting van inwoner door snellere en doelmatigere behandeling van en anticipatie op (acute) zorgvraag
- Beter inzicht in eigen ziekte en gezondheid, en hierdoor beter in staat door zelfmanagement

4

- Minder over- en onderbehandeling, (her-)opnames, en incidenten incl. eventuele herstellzorg gerelateerd aan het niet tijdig beschikbaar zijn van informatie
- Kostenbesparing per inwoner door doelmatigere behandeling
- Voorkomen van dubbeling van zorg door inzicht in behandelhistorie
- Meer tijd voor zorg door vermindering administratielast (informatie moet wel nog verwerkt worden in eigen systeem)

3

- Minder tijd kwijt aan verzamelen, registreren & verifiëren van benodigde informatie voor zorgprofessionals en zorg ondersteunend personeel
- Met completere informatie besluiten kunnen nemen
- Effectieve samenwerking tussen zorgprofessionals
- Meer werkplezier en minder werkdruk

1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model. Hierin wordt de impact op (1) gezondheidsuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredenheid en (4) zorgkosten meegenomen.

2) Disclaimer: Alleen zorgorganisaties in de huidige scope zijn meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken



2.2.2 360-graden beeld | Impact (2/2)

Verzamelen van benodigde (zorg)informatie kost minder tijd en kans op ontbreken informatie neemt af



Kwantitatieve impact

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.1.8 in de Verdieping

	ZKH				VVT				Apotheek- zorg		GGZ	Huisartsen
Doelgroep	Overdrachten van ziekenhuis naar VVT		Overdrachten van VVT naar ziekenhuis		#1 ^e Poli-consulten	Overdrachten van VVT naar ziekenhuis		Overdrachten van ziekenhuis naar VVT		# Ontslagen met medicatie	N.t.b.	#1 ^e gesprekken
% van de doelgroep	100%	30%	100%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	80%	N.t.b.	100%
Effect van 360-graden beeld voor de doelgroep ¹	7 min. reductie informatie verzamelen	5 min. reductie minder verificatie-bellen	15 min. reductie overnemen en interpreteren	10 min. reductie minder nabellen	1 min. reductie informatie verzamelen voor anamnese	7 min. reductie informatie verzamelen	5 min. reductie minder verificatie-bellen	15 min. reductie overnemen en interpreteren	10 min. reductie minder nabellen	4 min. reductie in verzamelen van informatie	N.t.b.	1 min. reductie informatie verzamelen voor anamnese
Inclusie	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.t.b.	0%
	2025	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	N.t.b.	40%
	2026	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	N.t.b.	80%
Zorgkosten ² (Z) of FTE												
Impact 2024 ²												
Impact 2025 ²												
Impact 2026 ²												
Cum. impact t/m 2026 ²												

1) Gebaseerd op de maatschappelijke kosten-baten analyse verpleegkundige overdracht (Verkennde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Verpleegkundige overdracht | Rapport | Gegevensuitwisseling in de zorg) en waar passend aangepast o.b.v. meningen van experts

2) x € 1.000

2.2.3 360-graden beeld | Transformatieplanning incl. KPIs



Transformatieplanning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Overdracht VVT naar ziekenhuis (5 VVT en 2 ziekenhuizen)	I		December Oplevering fase 1 - Procesbeschrijving overdracht incl. regionale werkafspraken - PvA registratie toestemming inwoners gegevens-uitwisseling	Maart Oplevering fase 2 - Realisatie integratie bronsystemen met datahub - Draaiboek uitrol overdracht per zorgorganisatie	Juni Oplevering fase 3 Go-live	September Oplevering fase 4 Evaluatie-rapportage implementatie 360-graden-beeld tbv overdracht					
Deelproject 2 – ‘Generiek kerndossier’: ontwerp en voorbereiden zorginformatiesystemen	I		December Oplevering fase 1 Procesbeschrijving gebruik 360-gr-beeld incl. regionale werkafspraken		Juni Oplevering fase 2 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 7 zorginstellingen	September Oplevering fase 3 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen	December Oplevering fase 4 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen	Maart Oplevering fase 5 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen			
Deelproject 3 – Uitrol: overdracht (3x VVT) en ‘generiek kerndossier’	I				Juni Oplevering fase 1 Draaiboek uitrol overdracht per zorgorganisatie (3x)	September Oplevering fase 2 - Go-live overdracht (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	December Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	Maart Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	Juni Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	September Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (4x)	December Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (4x) - Evaluatierapportage implementatie generiek kerndossier
Percentage van het aantal overdrachten van ZKH -> VVT, VVT -> ZKH waarbij het 360-graden-beeld is geopend	R						September +40% in MSZ en VVT	December +50% in MSZ en VVT	Maart +60% in MSZ en VVT	Juni +70% in MSZ en VVT	September +80% in MSZ en VVT
Implementatie Zorgviewer	R			Maart Oplevering fase 2 Implementatie Zorgviewer							



2.3 Use case Regionaal diagnostisch portaal





2.3.1 Regionaal diagnostisch portaal | Ambitie

Labdiagnostiek aanvragen lopen via één regionaal portaal voor inzicht in aangevraagde onderzoeken en uitslagen



Kernproblematiek

- Inefficiënte aanvraagprocedures, waar voor elke diagnostische test een aparte aanvraag moet worden ingediend, in verschillende systemen
- Er is een gebrek aan overzicht van diagnostiekaanvragen. Een overzicht van eerder door andere zorgprofessionals aangevraagde onderzoeken ontbreekt
- Het gebrek aan uitwisseling van resultaten en het ontbreken van een overzicht verhinderen zorgprofessionals om passende zorg te leveren
- Door het gebrek aan overzicht wordt er dubbeldiagnostiek uitgevoerd

Link IZA-opgaven

- **JZOJP**; versterken integraliteit van zorg in het netwerk om de inwoner en zorgverlening door de juiste zorgprofessional op het juiste moment
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals**; de registratielast van zorg-professionals neemt door de beschikbaarheid van relevante monitoringsgegevens af
- **Hybride zorg**; gekoppelde thuismonitoring ondersteunt de mogelijkheid van hybride zorg naar de regio



Huidige situatie

Bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek werken zorgprofessionals in de 1^e- en 2^e-lijn momenteel met verschillende systemen, die niet in verbinding staan met elkaar, waardoor resultaten alleen worden gedeeld met de aanvragende zorgprofessional en niet met andere betrokkenen. Het gebrek aan integratie zorgt voor een versnipperd overzicht. De afzonderlijke aanvraagprocedures voor verschillende types laboratoriumtests vergroten de complexiteit en tijd die nodig is voor het verwerken van meerdere orders voor één inwoner. Er ontbreekt één totaal overzicht van uitgevoerde onderzoeken en resultaten, wat essentieel is voor een goede patiëntenzorg.



Ambitie, eind 2026:

- Wordt voor het diagnostisch portaal eerst een basis gecreëerd voor 1^e-lijns zorgprofessionals en van daaruit verder ontwikkeld voor ook 2^e-lijns zorgprofessionals. De bouw van die basis is reeds gestart, gefinancierd door Labmicta.
- Is het portaal gekoppeld met Topicus (VIPlive) en interoperabel met de informatiesystemen van de ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, VVT instellingen en apotheken in de regio en de informatiesystemen van MedLon, LabPon en Labmicta
- Is er een focus op lab-diagnostiekaanvragen en inzage van onderzoeksresultaten voor zorgprofessionals met een behandelrelatie
- Is toestemming via Mitz is ingeregeld
- Via de regionale datahub verloopt ook inzage voor de inwoner zelf in het PGO
- Werkwijze van ziekenhuizen en diagnostische aanbieders is aangepast op de nieuwe situatie



Doorontwikkeling, na 2026:

(1) scope uitbreiding naar alle 1^e- en 2^e-lijns zorgprofessionals, beeldvormend- en functieonderzoek en koppeling aan planmodule voor de diagnostiek aanbieders, (2) data wordt gedeeld in het 360-graden beeld en in het PGO, (3) data uit het portaal wordt gebruikt voor secundair gebruik (o.a. advies preventie en leefstijl, en wetenschappelijk onderzoek).





2.3.2 Regionaal diagnostisch portaal | Impact

Door administratieve lasten te verminderen en inzicht te bieden kunnen er zorgpersoneel en -kosten worden bespaard



Kwalitatieve impact¹

1

- De kwaliteit van zorg voor inwoner wordt meer adequaat door inzage in uitgevoerde diagnostiek bij zorgprofessionals
- De efficiëntie van zorgverlening wordt meer adequaat door volledig inzicht in zorgdossier voor zorgprofessional
- Inwoners zijn beter geïnformeerd, wat resulteert in kwalitatief betere consulten met meer ruimte voor het goede gesprek

2

- Inwoners hebben zelf inzicht in uitslagen en meer controle over hun zorgproces, waardoor zij meer zelfsturend worden
- Het voorkomen van dubbele diagnostiek resulteert in minder belasting voor de inwoner
- Inzicht in het zorgdossier van de inwoner voor zorgprofessionals zorgt voor direct beschikbare informatie, wat efficiënte zorgverlening en verhoogde patiëntveiligheid bevordert

3

- Minder tijd kwijt aan consulten óf hebben meer tijd voor het goede gesprek doordat benodigde data (real-time) beschikbaar is
- Ervaren een efficiëntere diagnostiek aanvraag
- Minder tijd kwijt aan telefonisch contact met diagnostiek aanbieders over de beschikbaarheid van uitslagen

4

- Efficiëntere aanvraag en overzicht van diagnostiek binnen één portaal zorgt voor tijdswinst voor zorgprofessionals, die aan andere zorgtaken besteed kan worden
- Alle resultaten van aangevraagd en uitgevoerd onderzoek zijn zichtbaar, evenals nog niet uitgevoerde onderzoeken, wat dubbel diagnostiek voorkomt en kosten bespaart

Kwantitatieve impact²

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.2.8 in de Verdieping

		Huisarts ³ / 1 ^e lijn		Diagnostische centra	
Doelgroep		Het aantal huisartsen en/of 1 ^e lijns zorgprofessionals die in aanraking komen met (het aanvragen van) diagnostiek.		Het aantal verrichtingen diagnostiek in ziekenhuizen per jaar (excl. pathologie)	
Effect van de use case regionaal diagnostisch portaal op de doelgroep		1. Tijdsbesparing van 15 min. per dag door verbeterde efficiëntie voor het aanvragen van diagnostiek		2. Tijdsbesparing van 4 min. per telefoongesprek door inzicht in uitgevoerde diagnostiek (waarbij dit een besparing voor zowel de huisarts (2a) is, als ook voor de lab-medewerker (2b) die de telefoon niet meer aan hoeft te nemen	
				3. Reductie van 1,5% in uitgevoerde dubbel diagnostiek per jaar door overzicht van uitgevoerd onderzoek en daarmee een besparing van 2 min. per verrichting (evenredig verdeeld over de klinisch chemicus en de lab-medewerker)	
Inclusie	2024	10%	0%	0%	0%
	2025	70%	30%	0%	0%
	2026	80%	50%	50%	50%
	Sector	Huisarts ³ / 1 ^e lijn		Diagnostische centra	
Zorgkosten ⁴ (Z) of FTE					
Impact 2024					
Impact 2025					
Impact 2026					
Cum. Impact t/m 2026 ⁴					

Effect 2 is verdeeld over de sectoren huisarts en diagnostiek, waardoor de impact op zorgkosten en FTE's in beide sectoren is meegenomen.

1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model, waarin de impact op (1) gezondheidssuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredeheid en (4) zorgkosten is beschreven

2) Disclaimer: Voor de impactanalyse zijn alleen zorgorganisaties in de huidige scope meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken

3) Mogelijke veranderingen in rol e/o taken bij de implementatie van de regionale datahub, dienen verder afgestemd en gevalideerd te worden met de huisartsen in de regio.

4) x € 1000





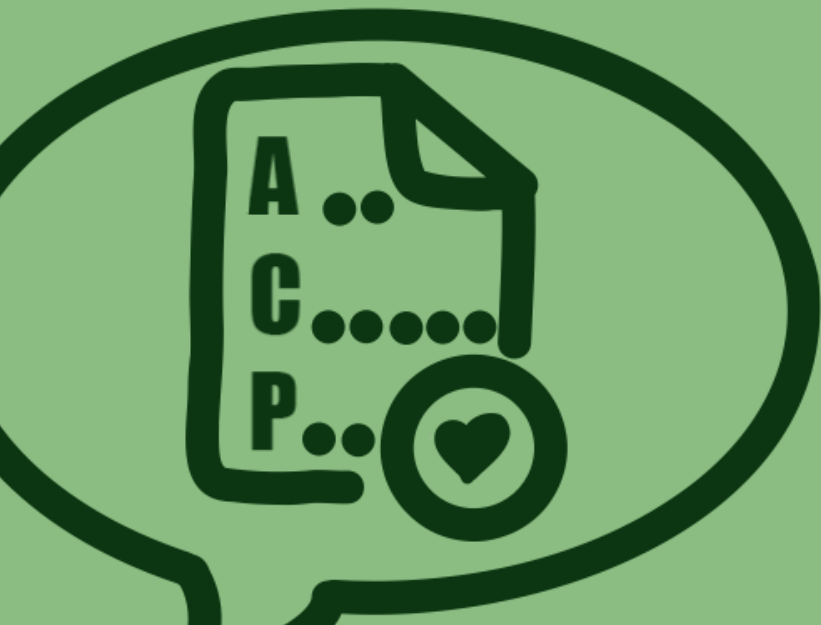
2.3.3 Regionaal diagnostisch portaal | Transformatieplanning incl. KPIs



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1: Eén portaal voor aanvragen diagnostiek en inzien uitslagen 1e lijn zorgverleners	I	Overgang naar productie	December Uitrol portaal 1^e lijn 10% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	Maart Uitrol portaal 1^e lijn 20% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	Juni Uitrol portaal 1^e lijn 40% van de huisartspraktijk en zijn aangesloten op het portaal	September Uitrol portaal 1^e lijn 75% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	December Uitrol portaal 1^e lijn 90% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal				
Deelproject 2: uitwisseling van de diagnostische data op basis van standaarden (ZIB's en HL7 FHIR) via de regionale datahub is mogelijk vanuit het bronsysteem van de diagnostiekaanbieder	I		December Oplevering Oplevering projectplan deelproject 2				December Inrichting Diagn. centra zijn technisch ingericht voor uitwisseling data via de datahub	Maart Gebruik 100% van de data kan worden uitgewisseld volgens open standaarden en ZIB's vanuit de bronsystemen van diagn. centra			
Deelproject 3: Zorgverleners hebben inzage in al het aangevraagde en uitgevoerde onderzoek	I						Oktober Projectplan Oplevering functioneel ontwerp en projectplan deelproject 3		Juni Functionaliteit Oplevering gewenste functionaliteiten leveranciers (Chipsoft en Topicus)	September Inrichting Portalen voor 1^e en 2^e lijn kunnen koppeling maken met de "viewer" tijdens aanvragen van diagnostiek	December Gebruik 80% van de zorgverleners hebben inzage in uitgevoerd en aangevraagde diagnostiek
Vermindering aantal <i>dubbele diagnostiek aanvragen</i> t.o.v. 0-meting	R								Juni - 6.000 Dubbele diagnostiek aanvragen	September - 15.000 (cum.) Dubbele diagnostiek aanvragen	December - 26.000 (cum.) Dubbele diagnostiek aanvragen



2.4 Use case Advance care planning in de keten



2.4.1 ACP in de keten | Ambitie

Passende zorgverlening omdat wensen, waarden en behoeften actueel en real-time inzichtelijk zijn

ACP in de keten heeft betrekking op de kwaliteit van leven van **elke inwoner die in een beslisfase van behandelen zit**. Om focus aan te brengen richten we ons tot en met 2026 op de doelgroep inwoners met een palliatieve zorgbehoefte. Hierna wordt de doelgroep van de use case verbreed.



Kernproblematiek

- Niet weten of en wat andere zorgprofessionals al aan wensen, waarden en behoeften (ACP-informatie) hebben geregistreerd
- Het niet integraal kunnen aanvullen en actueel houden van ACP-informatie
- Onduidelijkheid over regie op ACP-dossiervoering
- Niet-passende (acute) zorgverlening vanwege ontbreken inzicht in wensen, waarden en behoeften van inwoners

Link IZA-opgaven

- De beschikbaarheid van relevante zorggegevens maakt het mogelijk om **passende zorg** te leveren aan de inwoner en **niet-passende zorg te vermijden**. Er kan zo een betere inschatting worden gemaakt van de benodigde zorg, bijv. voor de keuze om iemand niet op te nemen, of ongewenste behandelingen worden voorkomen
- De regeltijd, waardoor in bijv. acute zorgsituaties vertraging wordt opgelopen, neemt door de beschikbaarheid van relevante zorggegevens af. Hierdoor wordt de **zorgprofessional ontzorgt**



Huidige situatie

Proactieve zorgplanning (ACP) is een dynamisch proces waar vaak meerdere stakeholders uit de 1^e, 2^e en 3^e lijn betrokken bij zijn. Momenteel worden ACP-gegevens van een inwoner binnen de zorginstellingen in Twente in verschillende systemen en platformen geregistreerd. Er bestaat **geen enkel overzicht of individueel ACP-dossier** waar alle betrokken stakeholders 24/7 toegang toe hebben. Door het ontbreken van dit overzicht heeft de inwoner vaak het gevoel geen gelijkwaardige partner te zijn in het zorgproces. Daarnaast kost het zorgprofessionals veel tijd om elders geregistreerde ACP-informatie telefonisch op te vragen, als deze al elders is vastgelegd. Het ontbreken van inzicht leidt tot **dubbele en niet-passende (acute) zorgverlening**, omdat deze niet aansluit op wensen, waarden en behoeften van de inwoner



Ambitie, eind 2026:

- Wordt met elke inwoner die in een beslisfase van behandelen zit, door de arts/verpleegkundige de wensen, waarden en behoeften met 'samen beslissen' als uitgangspunt cyclisch besproken en vastgelegd. Dit maakt dat de Twentse inwoner gelijkwaardiger wordt betrokken en meer eigen regie kan nemen in zijn/haar ziekte proces.
- Zijn voor deze inwoners de geregistreerde wensen, waarden en behoeften voor zorgprofessionals in het ziekenhuis, de huisartsenzorg (incl. HAP) en VVT (intra- en extramuraal) 24/7 inzichtelijk o.b.v. de laatste actuele gegevens (incl. herkomst en auteur), in de context van de voorgeschiedenis, in een digitaal ACP-overzicht, gebaseerd op ontsluitingen van diverse bronsystemen zoals EPDs, ECDs en HIS'en
- Wordt er meer passende zorg verleend en niet-passende zorg voorkomen. Hiermee ervaart de inwoner een grotere kwaliteit van leven en sterven
- Communiceren zorgprofessionals, betrokken in de palliatieve zorg rondom een inwoner, aanvullend op en direct gekoppeld aan het digitale ACP-overzicht, middels bijv. een communicatiekanaal



Doorontwikkeling, na 2026:

- Voegen we sectoren toe die nog niet binnen de scope van deze use case vallen, zoals ambulancezorg, apotheekzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, verslavingszorg, het ZCC, vrijwilligers en het sociaal domein
- Worden functionaliteiten zoals het verwerken en verrijken van ACP-informatie in het digitale ACP-overzicht toegevoegd





2.4.2 ACP in de keten | Impact

Meer tijd voor zorgprofessionals en meer regie en betrokkenheid van inwoners in het zorgproces



Kwalitatieve impact

1

- Meer passende en doelmatige zorg
- Juiste zorg op de juiste plek
- Voorkomen niet-passende zorg
- In de toekomst beter kunnen sturen op het ACP-proces door inzicht

2

- Inwoner krijgt zorg o.b.v. wensen, waarden en behoeften
- Meer eigen regie en gevoel betrokken te zijn
- Geruststelling en vertrouwen door beschikbaarheid wensen, waarden en behoeften bij betrokken zorgprofessionals
- Ontzorgen familieleden en mantelzorg vanwege meer samen kunnen beslissen

3

- Vertrouwen in het (proactiever) kunnen nemen van weloverwogen besluiten
- Verbetering relatie met inwoner
- Minder tijd kwijt aan overleg en overdracht in de keten (voor informeren / halen en brengen)
- Duidelijkheid over regievoering en benodigde acties m.b.t. ACP omdat wie, wat, en wanneer ACP-informatie heeft vastgelegd inzichtelijk is
- Makkelijker coördineren ACP-proces

4

- Voorkomen acute zorg, zoals ambulance-ritten en SEH-opnames
- Verminderen klinische ligdagen voor de doelgroep (te starten met palliatieve zorg)
- Minder gebruik van dure geneesmiddelen en behandelmaterialen vanwege het niet starten en/ of eerder staken van (onnodige) behandelingen door beter inzicht in wensen van de patiënt
- Voorkomen overlijden in ziekenhuis
- Minder diagnostiek
- Verschuiving zorglast naar 1^e lijn: Huisartsenzorg, wijkzorg en hospice

Kwantitatieve impact¹

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.3.8 in de Verdieping

		MSZ		Huisarts ⁵		VVT
Doelgroep		Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte en een SEH-bezoek in <30 dagen voor overlijden	Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte en een klinische opname <30 dagen voor overlijden	Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte	Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte	Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte
Effect van de use case ACP in de keten op de doelgroep		28% afname SEH-bezoeken van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte	20% afname klinische ligdagen van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte	80 min overleg/ overdracht besparing per inwoner met een palliatieve zorgbehoefte	30 min overleg/ overdracht besparing per inwoner met een palliatieve zorgbehoefte	90 min overleg/ overdracht besparing per inwoner met een palliatieve zorgbehoefte
Inclusie ²	2024	0%	0%	0%	0%	0%
	2025	12%	12%	12%	12%	12%
	2026	22%	22%	22%	22%	22%
(Zorg)kosten ⁴ en FTE						
Impact 2024 ⁴						
Impact 2025 ⁴						
Impact 2026 ⁴						
Cum. impact t/m 2026 ⁴						

De impact van ACP-keten is groter dan nu berekend. In de kwantitatieve impact van de use case ACP in de keten is alleen gerekend met de doelgroep inwoners met een palliatieve zorgbehoefte. We verwachten echter dat de doelgroep van deze use case in de praktijk groter is. Denk bijv. aan inwoners met een chronische aandoening zoals hartfalen of COPD. Ook zij staan, in gezamenlijkheid met hun behandelaar, voor beslismomenten in het behandelplan. Op basis van transmurale gegevensuitwisseling over hun wensen, waarden en behoeften kan niet-passende zorg voorkomen worden in hun behandelplan. Voorbeelden van niet-passende zorg zijn o.a. niet gewenste acute zorg, diagnostiek, behandelingen, (dure) geneesmiddelen en materialen.

1) Disclaimer: Alleen zorgorganisaties in de huidige scope zijn meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken, 2) Het inclusiepercentage houdt rekening met de bereidheid van inwoners om wensen, waarden en behoeften in de keten te registreren en delen en met de adoptie van de use case onder zorgprofessionals, 3) Dit percentage geeft de impact weer als percentage van het totaal te verminderen zorggebruik van deze doelgroep, 4) x € 1.000, 5) Mogelijke veranderingen in rol e/o taken bij de implementatie van de regionale datahub, dienen verder afgestemd en gevalideerd te worden met de huisartsen in de regio.



2.4.3 ACP in de keten | Transformatieplanning incl. KPIs



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 - Inhoud & werkwijze m.b.t. het digitale ACP overzicht	I		December: Oplevering fase 1 Deliverable: projectplan werkstroom A Investering: 3,3 FTE inzet personeel	Maart: Oplevering fase 2 Deliverable: regionaal kader werkwijze ACP in de keten Investering: 3,2 FTE inzet personeel	Juni: Oplevering fase 3 Deliverable: Implementatie-plan regionaal kader Investering: 3,4 FTE inzet personeel	September: Oplevering fase 4 Deliverable: ontwikkeld scholings-materiaal Investering: 3,6 FTE inzet personeel		Maart: Oplevering fase 5 implementatie regionaal kader werkwijze ACP Investering 3,2 FTE inzet personeel		September: Oplevering fase 6 Structurele inbedding van regionaal kader werkwijze ACP Investering: 3,4 FTE inzet personeel	
Deelproject 2 - Ontwikkelen digitaal ACP-overzicht (in samenhang met het 360-graden beeld)	I		December: Oplevering fase 1 Deliverable: projectplan werkstroom B		Juni: Oplevering fase 2 & 3 Deliverables: 1. regionale leidraad digitaal ACP-overzicht 2. Implementa-tieplan regionaal kader			Maart: Oplevering fase 4 & 5 Deliverable: implementatie digitaal ACP-overzicht in generiek kerndossier bij 9 instellingen		September: Oplevering fase 6 Deliverable: implementatie digitaal ACP-overzicht in generiek kerndossier bij 7 instellingen	
Vermindering <i>klinische ligdagen</i> t.o.v. 0-meting	R					September: -4% (cum.) in MSZ	December: -7% (cum.) in MSZ	Maart: -11% (cum.) in MSZ	Juni: -15% (cum.) in MSZ	September: -19% (cum.) in MSZ	December: -22% (cum.) in MSZ



2.5 Use case Gekoppelde thuismonitoring





2.5.1 Gekoppelde thuismonitoring | Ambitie

Voor inwoner en zorgprofessional één gezamenlijke en geïntegreerde oplossing voor thuismonitoring



Kernproblematiek

- Geen uitwisseling van informatie tussen verschillende thuismonitoringssystemen van verschillende aanbieders
- Gebrek aan een volledig overzicht van monitoringsgegevens voor zorgprofessionals
- Onnodige opnames van inwoners die anders in hun eigen omgeving gemonitord hadden kunnen blijven
- De aanwezigheid van multi-morbiditeit compliceert monitoring
- Investerings in monitoring leiden niet direct tot financiële besparingen op dezelfde plek

Link IZA-opgaven

- **JZOJP**; versterken integraliteit van zorg in het netwerk om de inwoner en zorgverlening door de juiste zorgprofessional op het juiste moment
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals**; de registratielast van zorg-professionals neemt door de beschikbaarheid van relevante monitoringsgegevens af
- **Hybride zorg**; gekoppelde thuismonitoring ondersteunt de mogelijkheid van hybride zorg naar de regio



Huidige situatie

De urgente uitdagingen in de regio door een stijgende (complexere) zorgvraag en een stijgende tekort aan zorgprofessionals, verhogen de druk op de zorg. Dit vraagt om een andere manier van werken. Zorginstellingen zetten individueel in op de herinrichting van (zorg)processen. Regionale gekoppelde thuismonitoring is essentieel voor beter overzicht, inzicht en integraliteit. Op dit moment is er door de versnippering van systemen/aanbieders echter geen overzicht van gegevens van inwoners, waardoor een compleet beeld ontbreekt, wat uitwisseling en acteren hierop lastig maakt. Daarnaast kunnen inwoners niet actief hun eigen regie pakken.



Ambitie, eind 2026

- Eind 2026 is gekoppelde thuismonitoring voor minimaal 5 transmurale zorgpaden in gebruik genomen door huisartsen en VVT in de 1e lijn en specialisten uit het ziekenhuis; er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over beschikbare capaciteit voor monitoring. Hierdoor...
 - is de inwoner leidend en heeft regie over het gepersonaliseerde zorgpad en ontvang de juiste zorg op het juiste moment door het juiste zorgprofessional. Ook is er minder fysiek contact nodig waardoor er minder tijd van de inwoner en zorgprofessional wordt gevraagd
 - kunnen zorgprofessionals zich richten op waardevolle zorg, wat leidt tot meer werkplezier en meer tijd voor de inwoner
 - wordt er efficiënt gebruik gemaakt van elkaars kunde en capaciteit
- Er zijn regionaal uniforme afspraken over de te gebruiken centrale thuismonitoring oplossing
- Ook niet-acute thuismonitoring is beschikbaar voor verschillende categorieën inwoners, daar waar dat zinvol en doelmatig is
- Er zijn afspraken gemaakt in de regio over standaarden, interoperabiliteit en overige randvoorwaardelijke criteria om netwerkzorg optimaal te faciliteren
- We zoeken aansluiting bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven zoals Zorg bij jou en CumuluZ
- De financiering van thuismonitoring is passend voor de betrokken zorgprofessionals



Doorontwikkeling, na 2026

Na de implementatie van de eerste 5 zorgpaden zijn de volgende doorontwikkelingen mogelijk op het gebied van gekoppelde thuismonitoring: (1) opschaling naar andere zorgpaden in de regio, (2) ontsluiting met een toenemend aantal zorginstanties en sectoren (bijv. sociaal domein, ggz en revalidatiezorg), (3) zelfstandigheid en actieve betrokkenheid van inwoners wordt verder ontwikkeld.





2.5.2 Gekoppelde thuismonitoring | Impact

Ruimte in de zorg wordt vrijgemaakt door (de duur van) ziekenhuisopnames en (poli)consulten te verminderen

Kwalitatieve impact¹



1

- Inwoners krijgen meer inzicht in hun eigen gezondheid, wat leidt tot meer rust en een hogere kwaliteit van leven
- Er is meer vertrouwen in de zorg en zorg wordt efficiënter aangeboden door deze op de juiste plaats te verstrekken
- Verbeterde toegang tot preventie en vroege signalering

2

- Inwoners hebben meer regie en zijn beter in staat tot zelfredzaamheid
- Naasten en mantelzorgers worden meer betrokken
- Zorg wordt flexibeler aangeboden via digitale toegangspunten
- Inwoners kunnen langer thuis blijven wonen
- Inwoners ervaren kortere lijnen tussen zorg en sociaal domein
- Eenduidige informatie vanuit één zorgprofessional (bijv. informatieverstrekking m.b.t. COPD)

3

- Zorgprofessionals ervaren vergemakkelijkte communicatie en een juiste verdeling van taken door betere samenwerking binnen de regio
- Meer werkplezier door juiste en volledige informatie over de juiste inwoner
- Minder administratieve werklust

4

- Meer tijd voor specialisten in het ziekenhuis voor hoog-complexe zorg door: minder opnames, verkorten ligduur, minder (poli)consulten
- Verschuiving van een controle-gebaseerde aanpak naar een vraaggerichte benadering, waarbij zorg wordt geleverd als het echt noodzakelijk is
- Meer tijd beschikbaar om te besteden aan de groeiende groep ouderen
- Door samenwerking in de regio is schaalvergroting mogelijk

Kwantitatieve impact²

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.4.8 in de Verdieping

	MSZ		Huisarts ³		Thuismonitoring
Doelgroep	Het aandeel klinische patiënten binnen de 5 te selecteren zorgpaden ⁴	Het aantal patiënten die nog worden opgenomen binnen de 5 te selecteren zorgpaden ⁴	Het aantal patiënten binnen de 5 te selecteren zorgpaden ⁴	Het aandeel patiënten binnen de 5 te selecteren zorgpaden ⁴ dat niet meer door de huisarts hoeft te worden gezien	Het aantal patiënten dat monitoringswaarden voortaan digitaal zullen doorgeven
Effect van de use case gekoppelde thuismonitoring op de doelgroep	20% afname van klinische opnames	Vermindering ligduur van 1-2 dagen	Vermindering van 1 policonsult per patiënt per jaar	Tijdsbesparing van 15 min. per patiënt per consult	Vermindering van 1 POH-consult (25 min.) per jaar
Inclusie ²	Onderstaande inclusie percentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)				
	COPD	Hartfalen	Diabetes type 2	Atriumfibrilleren	Chronisch nierfalen
2024	0%	0%	0%	0%	0%
2025	10%	10%	0%	0%	0%
2026	30%	30%	20%	10%	5%
	MSZ		Huisarts ³		Thuismonitoring
(Z)orgkosten ⁵ of FTE					
Impact 2024 ⁴					
Impact 2025 ⁴					
Impact 2026 ⁴					
Cum. impact t/m 2026 ⁵					

1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model, waarin de impact op (1) gezondheidsuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredenheid en (4) zorgkosten is beschreven , 2) Disclaimer: Voor de impactanalyse zijn alleen zorgorganisaties in de huidige scope meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken, 3) Mogelijke veranderingen in rol e/o taken bij de implementatie van de regionale datahub, dienen verder afgestemd en gevalideerd te worden met de huisartsen in de regio, 4) Exemplarisch uitgewerkt voor 5 zorgpaden: COPD, hartfalen, diabetes type 2, atriumfibrilleren en chronisch nierfalen, 5) x € 1.000, 6) Voor de kosten en impact voor de ziekenhuizen is het MST buiten beschouwing gelaten om dubbel telling te voorkomen, deze impact is meegenomen in de Zorg Bij Jou aanvraag.





2.5.3 Gekoppelde thuismonitoring | Transformatieplanning incl. KPI's



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Definiëren basis	I			Maart Oplevering projectplan live-gang Oplevering PvA & MVP (technisch)							
Deelproject 2 – Verbinden, keuzes maken en bouwen	I				Juni Keuzes maken Definitieve keuzes voor zorgpaden en implementatie plan						
Deelproject 3 – Implementatie en gebruik zorgpaden	I						December Implementatie zorgpad 1 Gem. voor 4% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	Maart Implementatie zorgpad 2 Gem. voor 7,75% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	Juni Implementatie zorgpad 3 Gem. voor 11,5% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	September Implementatie zorgpad 4 Gem. voor 15,25% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	December Implementatie zorgpad 5 Gem. voor 19% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik
Vermindering <i>poli consulten</i> t.o.v. 0-meting	R						December Gem. -65 consulten in MSZ	Maart Gem. -480 (cum.) consulten in MSZ	Juni Gem. -980 (cum.) consulten in MSZ	September Gem. -1480 (cum.) consulten in MSZ	December Gem. -2000 (cum.) consulten in MSZ

Disclaimer: de KPI's zijn gebaseerd op gemiddelde inclusiepercentages en patiënten aantallen binnen de vijf te implementeren zorgpaden. Aangezien de volgorde en selectie van de zorgpaden nog niet definitief zijn, kunnen de daadwerkelijke aantallen variëren. Deze cijfers dienen als richtlijn en kunnen fluctueren afhankelijk van de implementatievolgorde. Houd rekening met deze variabiliteit bij het evalueren van de KPI's. Aanpassingen zullen volgen zodra de definitieve selectie en volgorde van de zorgpaden zijn vastgesteld.



2.6 Use case Regionaal capaciteitsinzicht





2.6.1 Regionaal capaciteitsinzicht | Ambitie

Real-time inzicht in capaciteit, gezamenlijke afspraken over het proces en sturing in de acute en electieve zorgketen



Kernproblematiek

- Er is in de keten onvoldoende zicht op de beschikbare en gepaste capaciteit in relatie tot (acute) zorgvragen
- Het ontbreekt aan sector overstijgende samenwerking in de regio door een goed ingerichte zorgketen
- Te weinig sturing op het doelmatiger benutten van bestaande capaciteit binnen het regionale netwerk ten bate van voorspoedige uitstroom

Link IZA-opgaven

- Inzicht in de regionale capaciteit van de juiste zorg op het moment dat de inwoner deze nodig heeft. De verbeterde doorstroom naar die zorg draagt bij aan **JZOJP**
- Beschikbaarheid van relevante capaciteitsgegevens ontzorgt zorgprofessionals in het organiseren van vervolgzorg
- Regionaal capaciteitsinzicht levert een belangrijke basis voor zorgcoördinatie



Huidige situatie

Voor goede benutting van beschikbare zorgcapaciteit en het bepalen van de juiste vervolgzorg is de **beschikbaarheid van de juiste informatie noodzakelijk**. Anno 2024 is dit (nog) niet overal in de regio Twente het geval. Daarnaast kost het organiseren van passende vervolgzorg veel tijd en ook coördinatie van zorg in ANW-uren wordt bemoeilijkt door ontbrekende informatie. Hierdoor blijven inwoners vaak te lang op een **“verkeerd bed”** liggen, bijv. in het ziekenhuis of in de VVT. Deze situatie is voor zowel de inwoner als de zorgaanbieders onwenselijk. Daarnaast is het momenteel moeilijk om vooruit te kijken (of zelfs te voorspellen) welke capaciteit nodig zal zijn. Hierdoor blijft het **afstemmen van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio suboptimaal**.



Ambitie, eind 2026:

- Hebben ziekenhuizen, VVT-instellingen en zorgorganisaties die acute zorg aanbieden in de regio een ontsluiting naar een **regionaal capaciteitsdashboard**. In dit dashboard is beschikbare acute en planbare capaciteit inzichtelijk. Dit betreft niet alleen een bed of plek, maar ook welke zorg verleend kan worden. Huisartsen, ZorgCoördinatieCentrum-triagisten, transfer-verpleegkundigen en –coördinatoren gebruiken het regionaal capaciteitsdashboard om overdrachten te ondersteunen.
- Is er een **gezamenlijk zorgketenproces** beschreven voor overdrachten vanuit huisartsen en ziekenhuizen naar de VVT, zowel intramuraal als extramuraal. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande best-practices zoals de Twentse Transferketen en rekening gehouden met de komst van het zorgcoördinatiecentrum
- **Optimaliseren we het (keten)proces en stemmen vraag en aanbod af** o.b.v. ervaringen binnen het gezamenlijke zorgketenproces en inzichten uit het regionaal capaciteitsdashboard. Trendanalyses ondersteunen de keuzes voor procesverbeteringen en bieden mogelijkheid tot aanpassing van het aanbod op de zorgvraag. AI kan bij deze analyses ondersteunen



Doorontwikkeling, na 2026:

- Maken we ook de capaciteit van zorgaanbieders uit andere sectoren inzichtelijk, zoals ambulancezorg, revalidatiezorg, GGZ en acute apotheekzorg
- Worden analysemethoden uitgebreid, bijv. met AI, om te voorspellen wat de te verwachten zorgvraag gaat zijn. Hier kan dan meer tactisch en strategisch binnen de regio op worden gestuurd.





2.6.2 Regionaal capaciteitsinzicht | Impact

Meer tijd voor zorgprofessional en juiste zorg op de juiste plek voor de inwoner



Kwalitatieve impact¹

1

- Juiste zorg op de juiste plek
- Borging toegankelijkheid van zorg
- Meer passende en doelmatige zorg voor de inwoner
- Betere kwaliteit van leven voor de inwoner

2

- Inwoners hoeven minder (lang) te wachten op passende vervolgzorg door kortere doorlooptijd vanwege *zorgketenproces-afspraken en optimalisatie*
- Grotere tevredenheid door beter verwachttingsmanagement over vervolgzorg vanwege *inzicht*

3

- Zorgprofessionals hoeven minder te shoppen voor plekken bij vervolgzorg en krijgen ook minder directe persoonlijke verzoeken voor plaatsing vanwege *inzicht*
- Meer tijd voor het verlenen van zorgtaken vanwege *inzicht* en *zorgketenproces-afspraken*
- Juiste zorgprofessional wordt belast met nazorgtaken, waardoor juiste inzet van schaarse zorgprofessionals
- Vertrouwen in coördinatie van vervolgzorg tussen zorgprofessionals onderling vanwege *zorgketenproces-afspraken en procesoptimalisatie*

4

- Minder verkeerde bedproblematiek in ziekenhuizen door juiste uitstroom vanwege *zorgketenprocesafspraken en procesoptimalisatie*
- Minder verkeerde bedproblematiek in de VVT door juiste instroom want meer first-time-right plaatsingen vanwege *zorgketenprocesafspraken en procesoptimalisatie*
- Vermindering tijdsbesteding transfers door *inzicht*
- Betere benutting van bestaande en toekomstige capaciteit in ziekenhuizen en VVT vanwege *sturing en procesoptimalisatie*

Kwantitatieve impact²

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.5.8 in de Verdieping

		MSZ		VVT	
Doelgroep		Inwoners met spoed-overplaatsing van SEH naar ander ZKH	Verkeerde beddagen van inwoners met een indicatie GRZ, ELV en Wlz	Spoedoverplaatsingen door coördinatiepunten	Additionele ELV (mix laag & hoog) ligdagen om patiënten uit MSZ te accommoderen
Effect van use case Regionaal capaciteitsinzicht op de doelgroep		12 min. reductie zoektijd per overdracht (tijd)	0,8 dag per nazorgdossier ³	12 min. reductie van zoektijd per plaatsing (tijd)	0,8 dag per nazorgdossier ³
Inclusie	2024	0%	0%	0%	0%
	2025	20%	20%	20%	20%
	2026	50%	50%	50%	50%
(Z)orgkosten ⁴ of FTE					
Impact 2024					
Impact 2025					
Impact 2026					
Cum. impact t/m 2027 ⁴					

1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model, waarin de impact op (1) gezondheidsuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredenheid en (4) zorgkosten is beschreven, 2) Disclaimer: Voor de impactanalyse zijn alleen zorgorganisaties in de huidige scope meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken, 3) o.b.v. positieve resultaten behaald in Twentse Transferketen, 4) x € 1.000





2.6.3 Regionaal capaciteitsinzicht | Transformatieplanning incl. KPIs



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Deelopdrachten keteninrichting	I			Maart Oplevering projectplan overdracht ZKH – VVT (A) Oplevering PvA	Juni Implementatie projectplan overdracht ZKH – VVT (A) Evaluatierapport implementatie	September Oplevering projectplan overdracht HA – VVT (B) Oplevering PvA	December Oplevering projectplan overdracht HA/ZKH – Wijk (C) Oplevering PvA	Maart Implementatie projectplan overdracht HA – VVT (B) Evaluatierapport implementatie	Juni Implementatie projectplan overdracht HA/ZKH – Wijk (C) Evaluatierapport implementatie		
Deelproject 2 – Sturen en verbeteren	I				Juni Oplevering projectplan sturen & verbeteren Oplevering PvA		December Implementatie projectplan sturen & verbeteren Evaluatierapport implementatie		Juni Oplevering verbeterrapport 1 Evaluatierapport sturen & verbeteren		December Oplevering verbeterrapport 2 Evaluatierapport sturen & verbeteren
Deelproject 3 – Ontwikkelen regionaal capaciteitsdashboard	!				Juni Oplevering implementatie-plan reg. cap. dashboard Oplevering PvA		December Proof-of-concept reg. cap. dashboard Werkende versie 0.7 van dashboard bij 2 ZKH, 3 VVT		Juni Go-live reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij 2 ZKH, 3 VVT	September Opschaling reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij +1 ZKH, +4 VVT	December Opschaling reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij overige VVT
Vermindering <i>verkeerde beddagen</i> t.o.v. 0-meting	R						5% (cum.) in ZKH		10% (cum.) in ZKH		15% (cum.) in ZKH



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

1. Visie en geformuleerde uitgangspunten – Doelstellingen en waarde
2. Datahub beheergovernance – Governance uitgangspunten voor de datahub
3. Technische uitgangspunten & doelarchitectuur
4. Hoog-over veranderportfolio/roadmap

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



3.1 Regionale datahub inleiding | Overzicht verschillende onderdelen

Het hoofdstuk over de regionale datahub bestaat uit vier onderdelen met elk een duidelijke hoofdboodschap

	Onderdeel	Hoofdboodschap
p. 47-50	1 Visie en geformuleerde uitgangspunten Geeft een beschrijving van de waarde die gecreëerd wordt voor Twente en de centrale uitgangspunten van het dataplatform.	De datahub creëert waarde doordat data in één portaal op een snelle manier beschikbaar is voor de zorgprofessionals en inwoners. Dit leidt tot meer regie voor de inwoners. Daarbij geeft de datahub invulling aan uitgangspunten rondom databeschikbaarheid.
p. 51-53	2 Datahub beheergovernance Geeft inzicht in de uitgangspunten van de governance rondom de datahub, de organisatie van de datahub, en de dienstverlening en gebruik van de datahub.	De datahub voorziet in de uitwisseling, analyse en visualisatie van (gezondheids)data in de keten. De datahub faciliteert waardecreatie tussen de gebruikers van het platform.
p. 54-60	3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur Geeft inzicht in principes voor de regionale datahub architectuur. Verder geeft dit hoofdstuk een beschrijving van de technische uitgangspunten en de doelarchitectuur.	De datahub werkt vanuit een doelarchitectuur met landelijke en regionale principes. Deze doelarchitectuur is gebouwd met het Nictiz 5-lagen model als structuur én is verrijkt met principes uit referentiearchitecturen. Dit vormt het fundament. De datahub is schaalbaar en flexibel om mee te evolueren met toekomstige ontwikkelingen.
p. 61-62	4 Veranderportfolio/roadmap incl. impact per sector Geeft een overzicht van de te zetten stappen naar aanleiding van de uitgevoerde fit-gap analyse en de verwachte doorontwikkeling van het dataplatform	Op basis van de fit-gap analyse is de veranderopgave in kaart gebracht. We maken nu een fundament van de regionale datahub met 5 use-cases. Op dit fundament kunnen meer use-cases worden toegevoegd.



3.1 Regionale datahub Visie en geformuleerde uitgangspunten

3.1 Visie en geformuleerde uitgangspunten - Inleiding

De regionale datahub ondersteunt de transformatie van de zorg. De gezondheidszorg is meer geïntegreerd en georganiseerd rondom de inwoner, data zijn beter beschikbaar en de regionale capaciteit is inzichtelijk

De regionale datahub (ook wel dataplatform genoemd) maakt data centraal beschikbaar voor zowel zorgaanbieders als inwoners van Twente. De regionale datahub verbetert de beschikbaarheid én bereikbaarheid van data voor zorgaanbieders en inwoners. Hierdoor beschikken zorgaanbieders over de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment en wordt waarde gecreëerd voor de zorgaanbieders en inwoners. We maken zoveel mogelijk gebruik van landelijke initiatieven en (internationale) standaarden. De regionale datahub speelt een rol in zorg, onderzoek en onderwijs, en is van belang voor zorgaanbieders, onderzoekers en patiënten.

In het ontwerp van de datahub wordt rekening gehouden met vier belangrijke kenmerken:

1. Het **begeleiden van de patiënt** in de eigen zorgreis: we organiseren de zorg rondom de patiënt en vergroten het zelfmanagement van ziekten. De datahub introduceert één herkenbare toegang tot digitale diensten voor het afnemen van zorg voor inwoners in de regio Twente.
2. Het **delen van informatie**: een basisfunctie van het dataplatform is het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en inwoners. De uitwisseling van informatie gebeurt middels (internationale) standaarden.
3. Het **aanbieden en integreren van digitale zorgoplossingen**: de datahub verbindt met bestaande oplossingen voor digitale zorg en monitoring op afstand. Daarnaast is het dataplatform gericht op het verzorgen van connectiviteit en integraties met andere digitale oplossingen.
4. Het **coördineren van capaciteit**: het dataplatform biedt de mogelijkheid om inzicht te geven in de capaciteit van zorgaanbieders in Twente.

We dragen bij en conformeren ernaar om in de toekomst in landelijk verband data te verbinden.



3.1 Visie en geformuleerde uitgangspunten - Inleiding

De regionale datahub wordt gebouwd op basis van bewezen technologie en beschikbare (internationale) standaarden. Hiermee realiseren we een hoge mate van interoperabiliteit voor het platform

Medische gegevens en overige data worden via de datahub (binnen wet- en regelgeving) beschikbaar gesteld aan de zorgaanbieders in de regio Twente. De inwoners van Twente hebben via de datahub een verbeterd inzicht in de eigen (zorg) gegevens.

De datahub biedt toepassingen voor onder andere capaciteitsinzicht, een integraal patiëntbeeld, thuismonitoring, ACP en diagnostiek. De datahub koppelt ook met bestaande digitale zorgtoepassingen om zorggegevens te ontsluiten richting de inwoners van Twente.

Doordat de datahub gebruik maakt van nationale en internationale standaarden is de mate van interoperabiliteit hoog. De datahub gebruikt bestaande afsprakenstelsels en generieke functies. De datahub sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals CumuluZ, en vult daarop aan. Er is rekening gehouden met bestaande ontwerpprincipes zoals hieronder weergegeven.

Interoperabiliteit Interoperabiliteit betekent dat informatie makkelijk kan worden uitgewisseld tussen systemen zonder dat het de juiste betekenis verliest. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van standaarden en eenheid van taal. Voor een transformatie van de zorg is interoperabiliteit een randvoorwaarde. De datahub is in lijn met het NICTIZ 5-lagen model. Het hanteert standaarden, afsprakenstelsels en maakt gebruik van generieke functies zodra beschikbaar.	Informatiestandaarden Data is herbruikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van standaarden. Om data in de datahub te gebruiken wordt gebruik gemaakt van zorginformatie-bouwstenen (ZIBs). De datahub maakt gebruik van standaarden zoals de basisgegevensset zorg (BgZ) en de andere reeds bestaande standaarden voor informatieoverdracht.	Afsprakenstelsels Om data op een veilige en betrouwbare manier uit te wisselen, worden er afsprakenstelsels gehanteerd. Dit zijn sets van afspraken over eisen die gesteld worden aan gegevens-uitwisseling en databeschikbaarheid. De datahub maakt gebruik van bestaande afsprakenstelsels zoals AORTA-LSP, NUTS, MedMij en Twiin.	Generieke functies Generieke functie zijn functies die zorgbreed voor meerdere toepassingsgebieden nodig zijn om vindbaarheid, toegankelijkheid en maximale interoperabiliteit te realiseren. Bijvoorbeeld het geven van toestemming voor uitwisseling van gegevens of het identificeren van een zorgverlener. De datahub maakt gebruik van bestaande (en toekomstig beschikbare) generieke functies voor identificatie, authenticatie, toestemming, adressering, lokalisatie en autorisatie.
--	---	---	--



3.1 Visie en geformuleerde uitgangspunten – Doelstellingen en waarde

De regionale datahub combineert data van zorgaanbieders uit de gehele zorgketen en creëert hiermee aantoonbare waarde voor de zorgaanbieders en de inwoners van Twente

Door deze databeschikbaarheid beschikken zorgaanbieders over **de juiste informatie tijdig op de juiste plek**.

- We gebruiken data voor zorgprofessionals om zorgbehoeften beter te voorspellen en preventieve maatregelen te nemen
- We verbeteren de zorguitstroom van ZKH naar VVT door elkaars werkprocessen beter op elkaar af te stemmen
- We voorkomen zorg(instroom) daar waar dat geen waarde toevoegt voor de inwoner van Twente
- We verschuiven onze focus op zorg naar focus op gezondheid

De zorg kan **beter gecoördineerd worden** en de **zorgprocessen worden consistent en beter voorspelbaar**.

- Hierdoor verkorten we de wachttijd en nemen administratieve lasten af
- We kunnen de beschikbare capaciteit beter benutten
- Hiermee wordt het werkgeluk van de zorgprofessional verhoogd en kunnen zij zich echt concentreren op wat het belangrijkste is: de inwoner van Twente

De datahub kan de zorg verbeteren, voorkomen, versnellen en verplaatsen	
Meerwaarde voor de inwoner ➤ Kortere wachttijden ➤ Meer patiënt betrokkenheid wat leidt tot mogelijkheid tot zelfzorg en participatie ➤ Meer zelf- en samenredzaamheid	Meerwaarde voor de zorgprofessional ➤ Focus op zorg in plaats van administratie ➤ Snelle en laagdrempelige communicatie ➤ Betere benutting van capaciteit ➤ Betere analyse door beter overzicht



3.1 Visie en geformuleerde uitgangspunten - Doelstellingen en waarde

We realiseren waarde voor de betrokken stakeholders door drie centrale uitgangspunten. Door het hanteren van deze drie uitgangspunten maken we data toegankelijk voor de gehele regio Twente en daarbuiten

De regionale datahub realiseert de voorwaarden voor drempelloze databeschikbaarheid (beschikbaar, (her)bruikbaar en bereikbaar) door architectuurkeuzes met betrekking tot **interoperabiliteit**, het **scheiden van data en functionaliteit** én **een uniform datamodel**.

Dit doen we door met de regio bij te dragen aan een landelijke data-infrastructuur:

- Het opzetten van de regionale datahub staat niet op zichzelf. We sluiten aan bij de verschillende landelijke initiatieven, zoals Zorg bij jou, DigiZorg, het nationale test- en validatiecentrum en CumuluZ. Daar waar het nog niet beschikbaar is, ontwikkelen we dit met behulp van bestaande techniek
- Daarnaast lijnen we uit met de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel zoals opgesteld vanuit onder andere het ministerie van VWS. Het platform houdt ook rekening met de komst van de European Health Data Space (EHDS)

Hierdoor maken we data toegankelijk voor de gehele regio en daarbuiten.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid door interoperabiliteit

De zorginstellingen in Twente verbinden met de regionale datahub. Een belangrijk uitgangspunt is dat data bij de bron blijven, in de lokale bronsystemen bij de zorginstellingen. De bronsystemen worden middels gestandaardiseerde koppelingen (API's) gekoppeld aan de regionale datahub. Door data te ontsluiten naar de regionale datahub wordt de beschikbaarheid van data georganiseerd.

Beschikbaarheid en (her)bruikbaarheid door het scheiden van data en functionaliteit

Om databeschikbaarheid en hergebruik van data te garanderen, is het van belang om data en functionaliteit van elkaar te scheiden. Data wordt ontsloten naar de datahub. Hierdoor kunnen de data gebruikt worden voor meerdere toepassingen, in zowel primair gebruik in de zorg, als secundair gebruik voor bijvoorbeeld onderzoek. De visie is dat de data bij de bron blijft, waarbij alle instellingen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun eigen data en dat de datahub (met de juiste toestemming van de patient) gebruik maakt van deze data.

(Her)bruikbaarheid en bereikbaarheid door een uniform (gestandaardiseerd) datamodel

De datahub is gebouwd op een uniform datamodel dat gebruik maakt van open (internationale) standaarden voor opslag en uitwisseling van (gezondheids)data. Deze standaarden zorgen ervoor dat data op dezelfde wijze en in een afgesproken formaat worden uitgewisseld. Hierdoor is de data (her)bruikbaar en bereikbaar voor de zorginstellingen in de regio Twente.

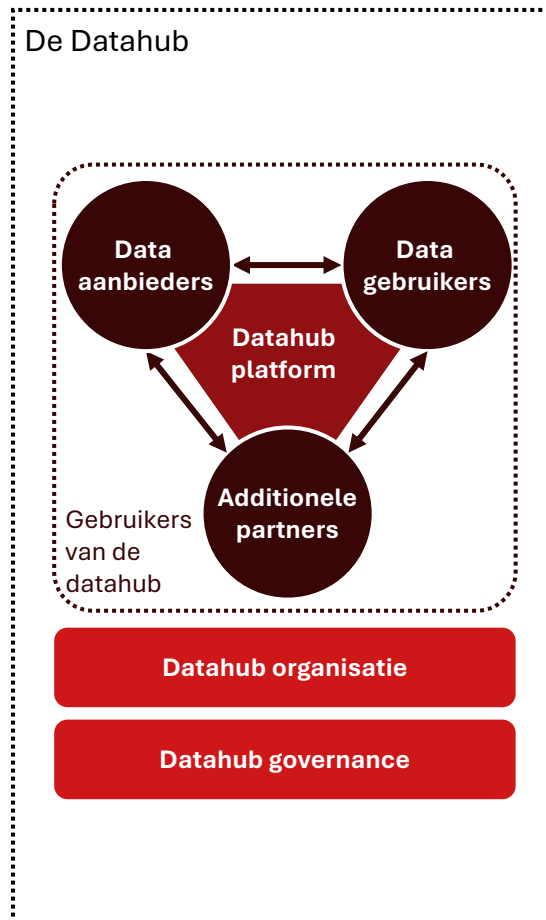
Naast de centrale uitgangspunten, zijn er nog verdiepende uitgangspunten rondom de governance en techniek opgesteld. Deze zijn te vinden in H3.2 (governance) en H3.3 (techniek)



3.2 Regionale datahub Datahub beheergovernance

3.2 Datahub beheergovernance – Governance uitgangspunten voor de datahub

De regionale datahub bestaat uit toepassingen (use-cases), de technologie (het dataplatform), de organisatie om het platform te faciliteren en de governance voor de besturing en de doorontwikkeling van het dataplatform



De drie lagen van de datahub

De datahub is een platform om bij te dragen aan de zorgtransformatie in de regio, bij te dragen aan databeschikbaarheid en te kunnen komen tot regionale levering van zorg. Verschillende rollen worden vervuld om de datahub als een platform succesvol te maken: een organisatie om in het dagelijkse beheer te voorzien, een governance waarin gezamenlijk de standaarden voor samenwerking worden vastgesteld en de verschillende rollen die gebruikers aan nemen in het realiseren van use cases.

De datahub bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De gebruikers van de datahub en de diensten waarmee ze worden ondersteund

- **Data aanbieders** bieden data aan voor uitwisseling en/of het faciliteren van dataproducten
- **Data gebruikers** maken gebruik van data en dataproducten die middels de datahub beschikbaar worden gesteld en/of gefaciliteerd
- **Additionele partners**, zoals leveranciers van digitale oplossingen of deelnemende partijen (individueel of in samenwerking) die een dienst ontwikkelen, kunnen geïntegreerd met de datahub worden aangeboden of ontwikkeld worden met de datahub als fundament
- Daarbij: één organisatie kan meerdere of zelfs alle rollen tegelijk vervullen

2. De datahub als het platform voor samenwerking

- **Datahub platform** is de technologie die samenwerking mogelijk maakt. Additioneel is dit het technologische fundament voor nieuwe innovaties en de (door)ontwikkeling van use cases die nieuwe regionale zorgleveringsmodellen en samenwerking ondersteunen

3. De datahub voor orkestratie en regie op het platform

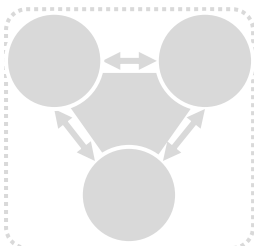
- **Datahub organisatie** is verantwoordelijk voor het dagelijkse management en beheer op de datahub, dat de technologie werkt naar behoren en gebruikers goed worden ondersteund. Dit betreft één centrale organisatie met regie over de datahub
- **Datahub governance** is de besturing van, en de kaderstelling voor de datahub op strategisch niveau. Waaronder het vaststellen van standaarden, beleid, strategie en andere kaders waarbinnen de datahub organisatie kan acteren. Dit is de governance zoals beschreven in hoofdstuk 5.3



3.2 Datahub beheergovernance – Governance uitgangspunten voor de datahub

Er zijn diverse verdiepende uitgangspunten opgesteld voor de data-uitwisseling tussen de verbonden zorgaanbieders per onderdeel van het dataplatform

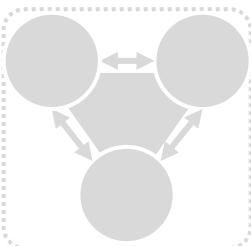
Uitgangspunten voor de datahub governance



Datahub governance

- U1.1 Transparantie en vertrouwen is de basis (in samenwerking, technologie en alle aspecten van de datahub)
- U1.2 De governance voor de datahub is een onderdeel van de governance van het bredere zorgecosysteem in de regio
- U1.3 De datahub is de standaard voor databeschikbaarheid voor netwerkzorg
- U1.4 De governance is afgestemd op de technologie en de organisatie
- U1.5 Duidelijke spelregels
- U1.6 Datahub eigenaarschap ligt bij de deelnemers: van de regio, voor de regio

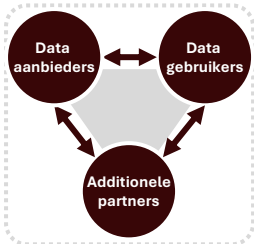
Uitgangspunten voor de datahub organisatie



Datahub organisatie

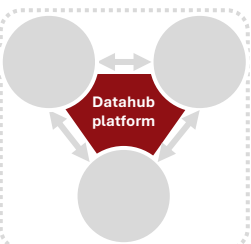
- U2.1 Voorkomen van dubbel werk in de regio en landelijk
- U2.2 Landelijk boven regionaal, regionaal boven lokaal
- U2.3 De datahub organisatie is afgestemd op de technologie
- U2.4 Maximaal gebruik van bestaande structuren en competenties: Bureau Zorgnetoost voert de centrale regie.
- U2.5 De datahub organisatie staat voor regie & fundament, en voor innovatie & vernieuwing
- U2.6 Het gaat om configuratie en om regie, geen eigen ontwikkeling
- U2.7 Techniek op regionaal niveau wordt regionaal en gezamenlijk ingekocht

Uitgangspunten voor de verbonden regio organisaties



- U3.1 Het regionale zorgproces is leidend voor de inrichting
- U3.2 Deelname betekent het accepteren van regionale regie en deels opgeven van autonomie
- U3.3 Wederkerigheid: deelnemers dragen waar ze kunnen bij aan de datahub en helpen elkaar
- U3.4 Iedereen heeft zijn eigen startpunt, route en snelheid. Maar iedereen voldoet ook aan minimale eisen
- U3.5 Het eigenaarschap van data van aanbieders ligt bij de aanbieders van de data
- U3.6 Het eigenaarschap van meta data en regionale data ligt bij de regievoerder van de datahub

Uitgangspunten voor het datahub platform

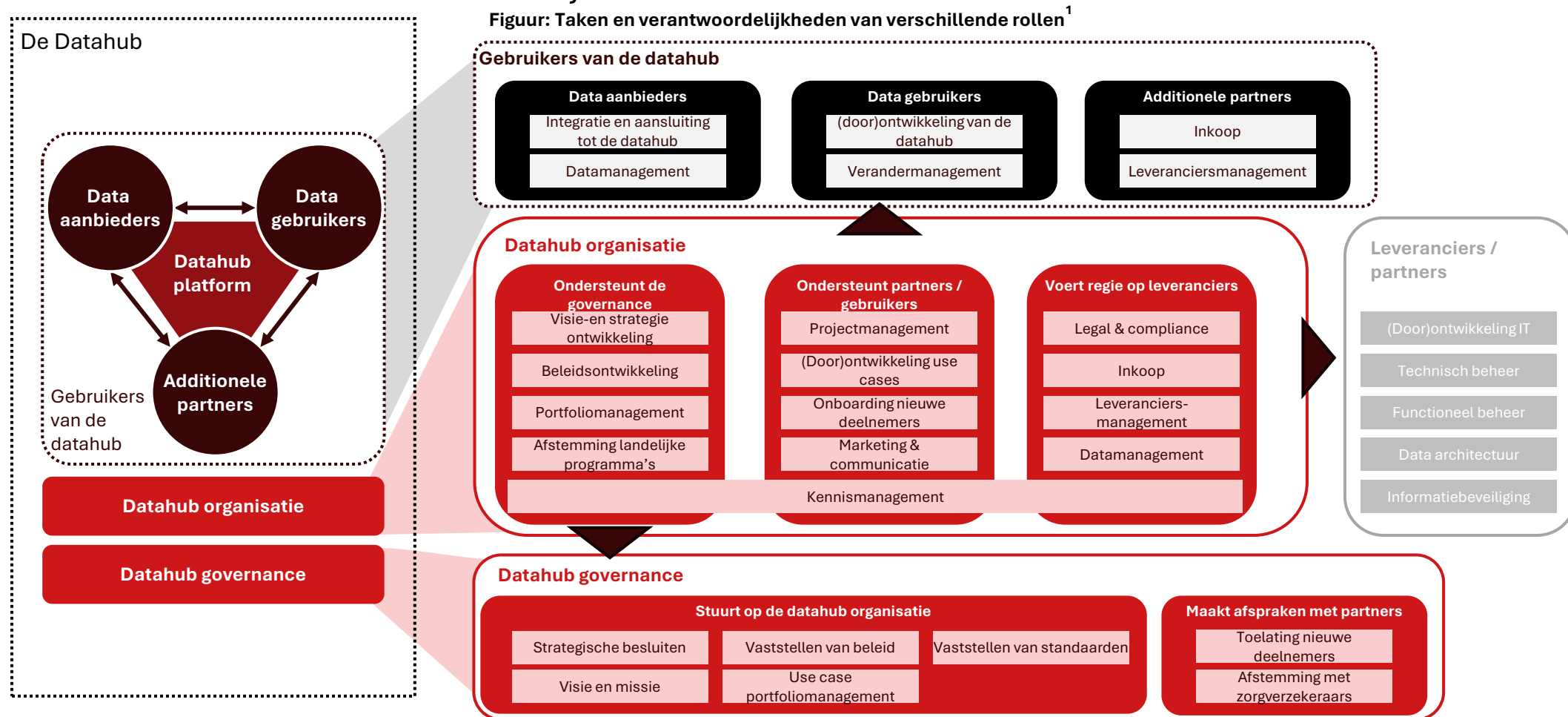


- U4.1 Faciliterend in de afhandeling van data aanvragen
- U4.2 Data is FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar)
- U4.3 Eén waarheidsbron met minimalisatie van data duplicatie en opslagretentie
- U4.4 Hergebruik van bestaande bouwstenen
- U4.5 Gebruik van open standaarden en landelijke richtlijnen (bijv. FHIR, OpenEHR maar ook CumuluZ, Health-RI, EHDS)
- U4.6 Schaalbaar en flexibel om mee te evolueren met toekomstige ontwikkelingen
- U4.7 We werken naar één uniform datamodel voor de regio
- U4.8 Transparant en uitlegbare dataverwerking
- U4.9 Bewust van kosten en voetafdruk
- U4.10 Security en privacy by design



3.2 Datahub beheergovernance – Governance en organisatie van de datahub

De verschillende lagen in de governance en organisatie van de datahub en haar gebruikers zullen voorzien in verschillende taken en verantwoordelijkheden



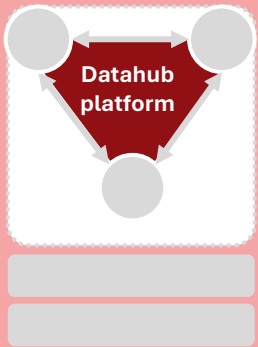
1) Dit betreft een overzicht van taken en verantwoordelijkheden, geen organogram. Het organogram voor zowel de project- als de beheerfase zijn toegelicht in [hoofdstuk 5.3](#)



3.3 Regionale datahub Technische uitgangspunten & doelarchitectuur

3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – technische uitgangspunten

Architectuur dient als brug tussen de visie op de regionale datahub en de technische realisatie hiervan



Een heldere visie en strategie vormt de leidraad voor deze transformatie, maar het succes ervan is sterk afhankelijk van de onderliggende architectuur

Om de ambitie van de regionale datahub te realiseren zijn er een breed scala aan veranderingen nodig, zowel in de IT-omgeving van de deelnemers als mede het opstellen van het regionale dataplatform, wat daarmee ook een uitgewerkte architectuur en het volgen van architectuur processen vereist.

Architectuur fungeert als de brug tussen de digitale strategie en de digitale initiatieven

In dit geval de visie op de regionale datahub en de realisatie van de datahub (het platform). Architectuur draagt zorg voor het vastleggen van de kaders en richtlijnen voor het ontwerp van het platform en de use case en geeft antwoorden op vragen die leven rondom de realisatie van de doelsituatie.



Binnen welke (technologische) kaders moeten de oplossingen van de datahub passen?

Hebben we de juiste data beschikbaar om de gewenste inzichten te verkrijgen?

Welke financiële kosten hangen aan de implementatie van onze digitale ambities?

Hoe verhoudt onze ambitie zich tot de huidige situatie?

Wat is er nodig om de juiste interfaces en datavoorzieningen te realiseren?

Welke diensten en gebruikers worden er geraakt door de digitale ambities?

Waar hebben onze ambities en beoogde veranderingen impact op?



3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – technische uitgangspunten

Er zijn tien technische uitgangspunten vastgesteld welke gezamenlijk het fundament vormen voor het ontwerp van de datahub. Deze uitgangspunten zijn afgeleid van de doelstellingen zoals gesteld in het IZA

Architectuur faciliteert de strategische IZA-doelen door het ondersteunen van ‘databeschikbaarheid over de grenzen van zorginstellingen heen’. Daarnaast, draagt het bij aan het realiseren van de digitale ambities van een regionale datahub door het stellen van de volgende uitgangspunten. Een verdieping op deze uitgangspunten staat in bijlage E.



3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – Visie datahub doelarchitectuur

Er is een experiment uitgevoerd met behulp van Microsoft Fabric. Microsoft Fabric ligt in lijn met een groot deel van de technische uitgangspunten, maar ook governance en organisatorische uitgangspunten. De technologiekeuze is echter nog niet gemaakt, dit wordt in het begin van de volgende fase gedaan.

U1.1 Transparantie en vertrouwen is de basis (in samenwerking, technologie en alle aspecten van de Datahub)

U1.3 De Datahub is de standaard voor netwerkzorg

U1.5 Duidelijke spelregels

U2.1 Voorkomen van dubbel werk in de regio en landelijk

U2.5 Het gaat niet enkel om beheer van de technologie, ook het faciliteren van innovatie (met de Datahub als het fundament)

U2.6 Het gaat om configuratie en om regie, geen eigen ontwikkeling

U3.4 Niet iedereen hoeft even snel te gaan, zolang er voldaan wordt aan een minimale snelheid

U3.7 Het eigenaarschap van data van aanbieders ligt bij de aanbieders van de data

U3.8 Het eigenaarschap van verrijkte, meta of creëerde data ligt bij de datahub

U3.9 Elkaar versterken en samen vooruitgang boeken

U4.1 Faciliterend in de afhandeling van aanvragen

U4.2 Data is FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar)

U4.3 Eén waarheidsbron met minimalisatie van data duplicatie en opslagretentie

U4.4 Hergebruik van bestaande bouwstenen

U4.5 Gebruik van open standaarden en landelijke richtlijnen (bijv. FHIR, OpenEHR maar ook CumuluZ, Health-RI, EHDS)

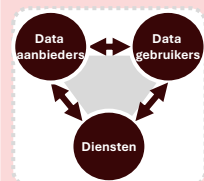
U4.6 Schaalbaar en flexibel om mee te evolueren met toekomstige ontwikkelingen

U4.7 We werken naar één uniform datamodel voor de regio

U4.8 Transparant en uitlegbaar

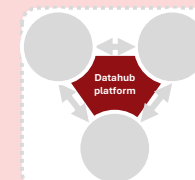
U4.9 Bewust van kosten en voetafdruk

U4.10 Security door ontwerp



Datahub organisatie

Datahub governance



Technologische innovatie voor de zorg – Microsoft Fabric biedt een solide basis voor databeschikbaarheid en innovatie in de zorgsector. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën kunnen zorgprofessionals sneller en efficiënter werken, wat resulteert in betere zorg voor inwoners.



Schaalbaar en flexibel – Microsoft Fabric biedt schaalbaarheid* en flexibiliteit, waardoor het platform kan groeien en evolueren naarmate de behoeften veranderen. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van nieuwe technologieën en innovaties zonder grote herinvesteringen.

*Schaalbaarheid in termen van toevoegen nieuwe gebruikers, het opzetten van omgevingen en het toevoegen van nieuwe use cases
Transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente +



Leent zich voor databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling – Microsoft Fabric is ontworpen om gegevens beschikbaar te maken wanneer en waar nodig, terwijl het voldoet aan internationale standaarden voor gegevensuitwisseling. Dit vermindert de regeldruk voor zorgprofessionals en maakt het mogelijk om de volledige zorgketen in de regio te overzien.



Bewezen trackrecord in de zorg – Microsoft Fabric heeft een bewezen staat van dienst in de gezondheidszorg, met succesvolle implementaties wereldwijd. KPMG en Microsoft ondersteunen bijvoorbeeld PHSA (Provincial Health Service Authority) met Microsoft Fabric om ervoor te zorgen dat de inwoners van BC (British Columbia) toegang hebben tot een gecoördineerd provinciaal netwerk van hoogwaardige gespecialiseerde gezondheidszorgdiensten met 24.000 medewerkers die de 5 miljoen inwoners bedienen.



Software as a Service (SaaS) Model – Microsoft Fabric wordt aangeboden als een SaaS-oplossing, gehost en onderhouden door Microsoft. Dit resulteert in vereenvoudigd beheer en snellere implementatie, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy- en informatiebeveiligingseisen. Er wordt geprofiteerd van regelmatige updates en onderhoud, waardoor men zich kan concentreren op het gebruik van het platform in plaats van op de infrastructuur.

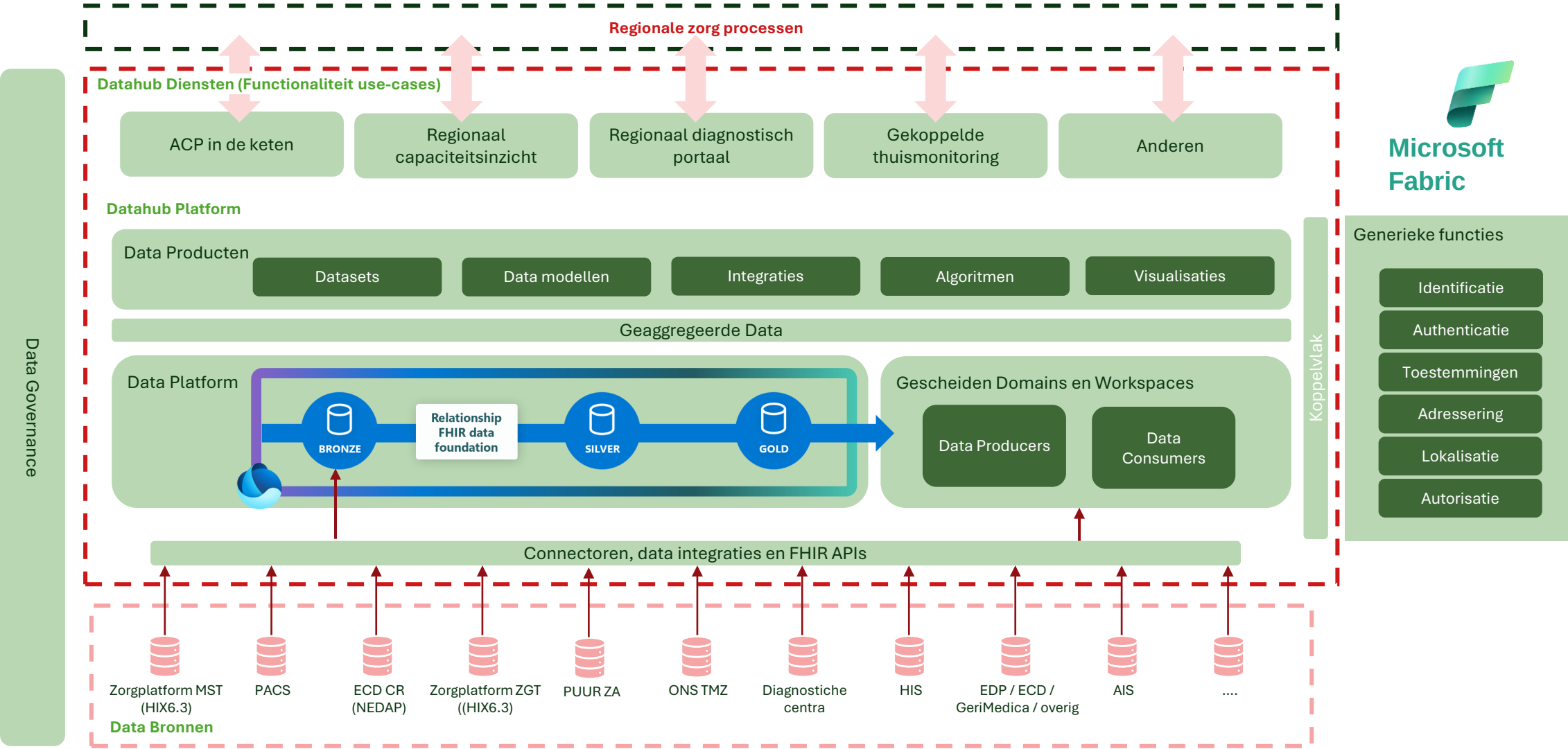


Alles in een oplossing – De technologie is een alles-in-één analyseoplossing en biedt een uitgebreide suite met services, waaronder data lake, data engineering en gegevensintegratie, allemaal op één plek. Dit onderscheidt het platform van andere initiatieven waarin deze oplossingen nog in veel mindere mate zijn geïntegreerd. Deze techniek wordt door Microsoft geleverd.



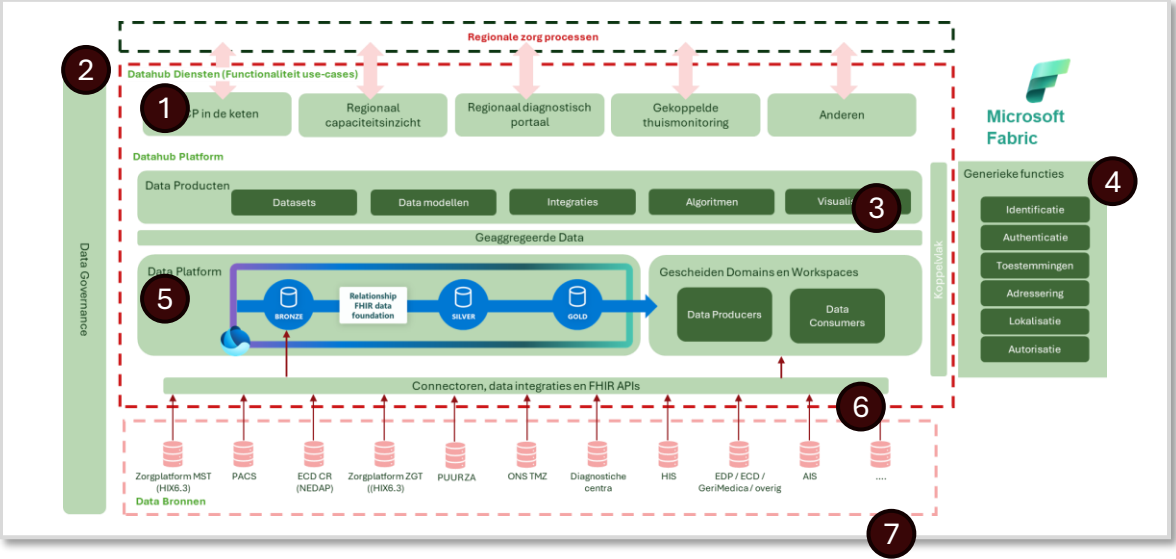
3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – Visie datahub doelarchitectuur

Doelarchitectuur – de regionale datahub Twente



3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – Visie datahub doelarchitectuur

De regionale datahub bestaat uit een gelaagde architectuur, met elke laag een eigen focus om zo de belangen en functionaliteit te scheiden

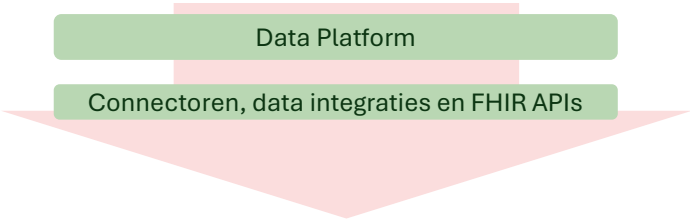
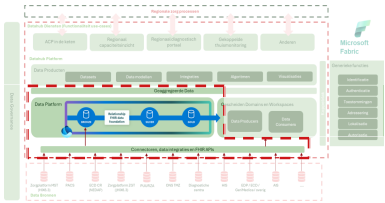


- 1 Per **datahub dienst / Use Case** wordt gebruik gemaakt van specifiek daarvoor opgezette workspaces / data science omgevingen. Deze zijn op maat gemaakt, hebben toegang tot de data benodigd voor de use case en gespecificeerde gebruikers.
- 2 Om de datahub veilig en uitlegbaar te houden is strikte **data governance** essentieel, specifiek in relatie tot de gevoelige data welke over het platform gedeeld kan worden. Hierin is een balans tussen mandaat van het platform en het in-control zijn van de data producenten benodigd om het platform tot een succes te brengen.
- 3 Als uitkomst van het data analyses en data verwerking worden **data producten** aangeboden. Deze worden aangeboden als bouwstenen te gebruiken in de verwezenlijking van use-cases.
- 4 Het data platform maakt waar mogelijk gebruik van (landelijke) bewezen **Generieke functies**. Voor een overzicht van welke generieke functies gebruik wordt gemaakt, zie bijlage G Dit ter bevordering van standaardisatie en hergebruik. Per use case worden de benodigde generieke voorzieningen ontsloten.
- 5 Een **integraal data platform** maakt het mogelijk om onmiddellijk inzichten te verschaffen. Zo kan de strategie “beschikbaarheid van gegevens over de grenzen van zorginstellingen heen” worden uitgevoerd omdat de regio's beschikken over de voor hen relevante gegevens. Binnen het platform zijn gezondheidszorgstandaarden zoals FHIR API's en workloads al beschikbaar om de implementatie te vergemakkelijken en te versnellen.
- 6 De **integratielaag** is een onderdeel van de datahub welke de verscheidene aanlever systemen koppelt aan de databases. De laag zorgt voor standaardisatie in uitwisseling van data, beveilig bij de integratie en autorisatie mechanismes. Dit verhoogt efficiëntie, vergroot de flexibiliteit en verlaagd de kosten. Fabric biedt ook standaard connectoren naar meerdere systemen en infrastructuren, maar ook naar standaard integratiecomponenten zoals API's voor een eenvoudige integratie.
- 7 Verscheidene **data bronnen** van de verschillende zorginstellingen, de data producenten, worden ontsloten via het data platform. Om data minimalisatie te waarborgen zal alleen de data benodigd ter ondersteuning van de use-cases worden geïntegreerd met het platform.



3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – Visie datahub doelarchitectuur

Onderstaand gaan we gedetailleerder in op de componenten en bieden we meer detail van de datalaag en hoe de integratie plaatsvindt (1/2)



- 4

Inzicht in data herleiding en vertalingen

Onderdeel van Microsoft Purview is het registreren van data, vertalen en data lineage van bron naar verwerkte data op het platform.
- 3

Vertalen van data naar het common data model

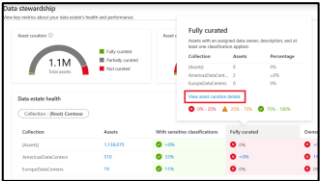
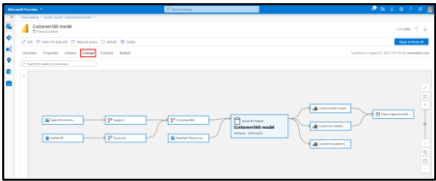
We maken gebruik van Microsoft common data model en/of OpenEHR mapping tabellen.
- 2

Data kwaliteit controle

Microsoft Purview biedt data kwaliteit controle tooling.
- 1

Inlezen data

Azure health data services heeft diverse mogelijkheden voor het ontsluiten van data. Deze ondersteunen onder andere HL7v2, CCDA, FHIR en DICOM.

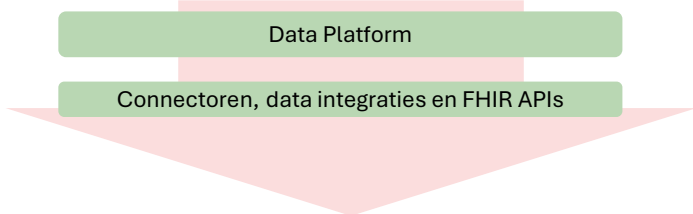
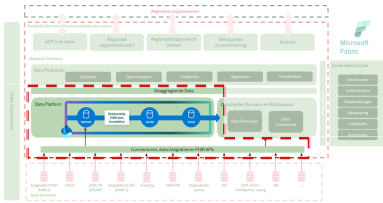


Let op: dit moet worden beschouwd als een startpunt en niet als het eindpunt, aangezien zowel de technologie als het model voortdurend worden verbeterd.



3.3 Technische uitgangspunten & doelarchitectuur – Visie datahub doelarchitectuur

Onderstaand gaan we gedetailleerder in op de componenten en bieden we meer detail van de datalaag en hoe de integratie plaatsvindt (2/2)



Belang

- 4

Inzicht in data herleiding en vertalingen

Om vertrouwen in het platform te krijgen moet alle data en verwerkingen terug te leiden zijn naar de bron
- 3

Vertalen van data naar het common data model

Een common data model is essentieel voor een succesvol regionaal data platform. Zonder common data model is data niet interoperabel.
- 2

Data kwaliteit controle

Kwaliteit moet aan de voordeur van het platform worden gewaarborgd. Zonder data van de juiste kwaliteit leveren de use-cases niet de gewenste waarde.
- 1

Inlezen data

Data moet kunnen worden geïntegreerd met elke bron volgens markt standaarden.

Uitdagingen

- Om dataconversies en vertalingen succesvol te volgen, is het van cruciaal belang om een gestandaardiseerde en algemeen aanvaarde datawoordenlijst te hebben om ervoor te zorgen dat datadefinities in lijn zijn met het gemeenschappelijke datamodel

Bestaande standaarden bieden te veel ruimte voor interpretatie. Daarnaast worden binnen sectoren en tussen instellingen verschillende definities gehanteerd

Niet elke zorginstelling beschikt over dezelfde datakwaliteit. Minimale vereiste kwaliteit en verbetering van kwaliteit moet worden gewaarborgd.

Niet elke bronsysteem ondersteunt data extractie of maakt extractie mogelijk via markt standaard integratie patronen.

Vervolgstappen: De volgende om het dataplatform van de Twentse regionale datahub te ontwikkelen is gericht op het gebruik van de verschillende connectiviteitsopties, waaronder de FHIR-standaard, om verbinding te maken met vereiste applicaties, zoals Chipsoft en NEDAP, en het uitbreiden van het Microsoft Common Data Model om het meer aanpasbaar en geschikt te maken. Dit vereist integratie van het Common Data Model met een robuuste gegevensopslagstandaard zoals OpenEHR om schaalbaarheid en interoperabiliteit in de gezondheidszorg te garanderen.

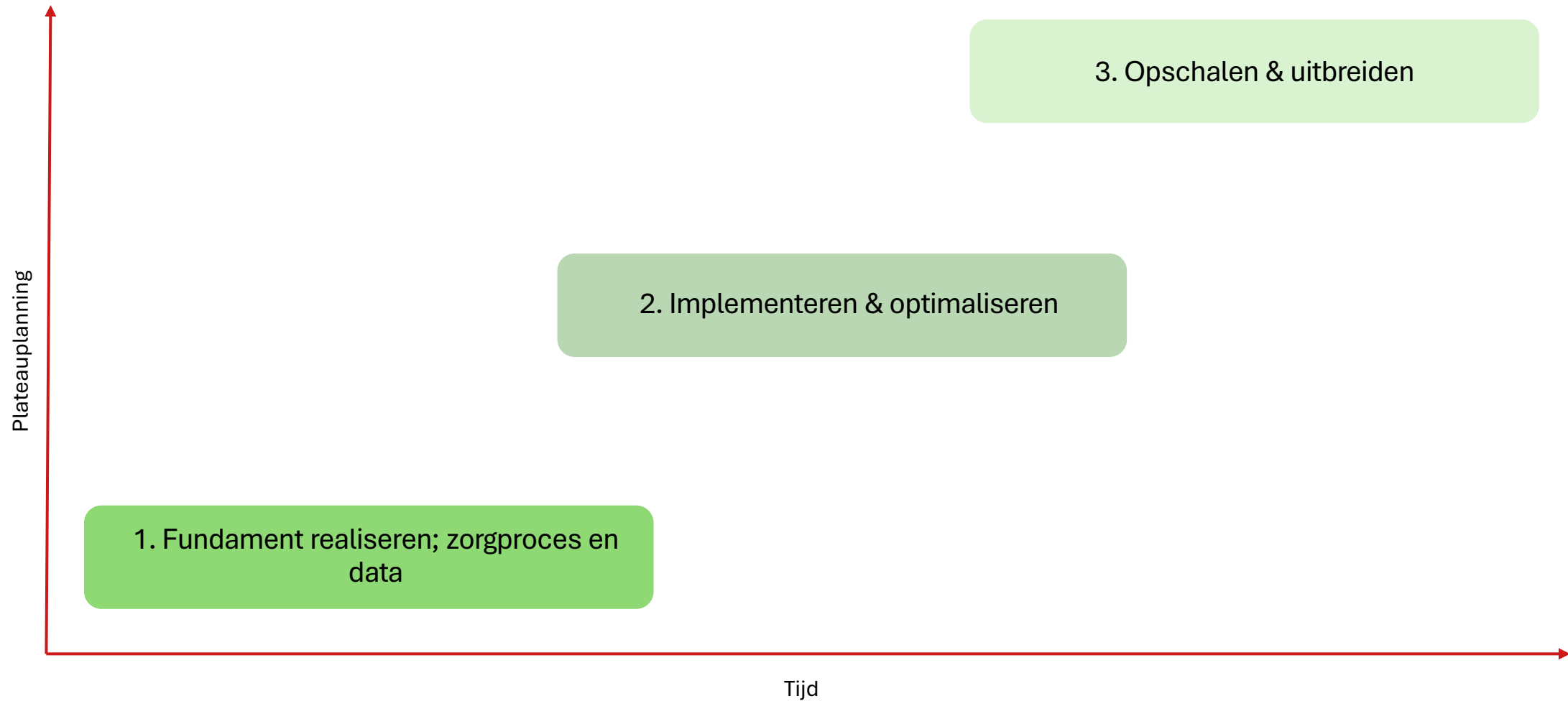


3.4 Regionale datahub Hoogover

veranderportfolio/roadmap

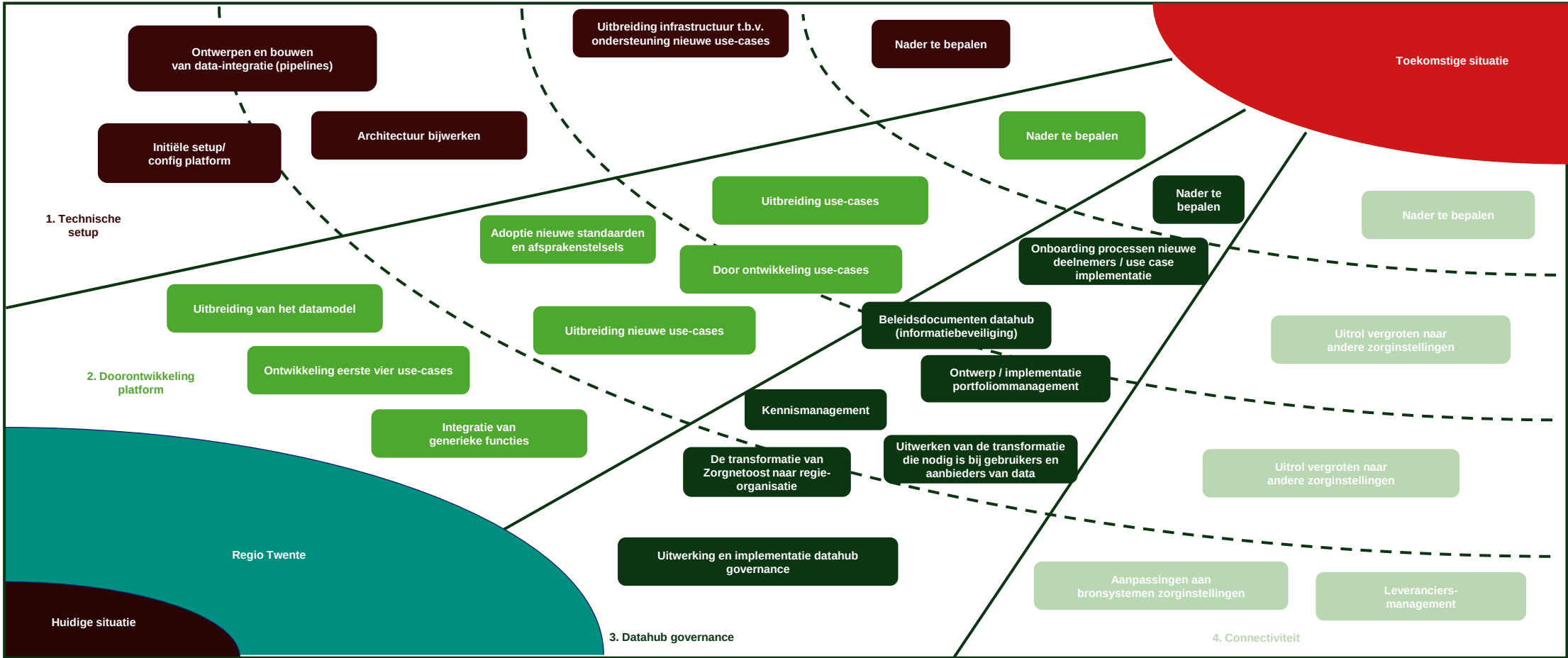
3.4 Hoog-over veranderportfolio/roadmap

In drie stappen realiseren we de zorgtransformatie in Twente



3.4 Hoog-over veranderportfolio/roadmap

Op basis van de fit-gap analyse is de veranderopgave voor regio Twente in kaart gebracht. De roadmap zal verder moeten worden vormgegeven en vertaald naar een detailplanning in de vervolg fase. Bepaalde onderstaande activiteiten zullen soms sequentieel en soms parallel plaats vinden.



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

1. Impactanalyse per stakeholder
2. Veranderaanpak
3. Communicatieplan tijdens fase 3 (implementatie)

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



4. Zorgtransformatie inleiding | Overzicht verschillende onderdelen

Het hoofdstuk zorgtransformatie bevat de impactanalyse, veranderaanpak en bijpassend communicatieplan

	Onderdeel	Hoofdboodschap
p. 69 - 71	1 Impactanalyse per stakeholder Geeft een beschrijving van de impact voor inwoners en zorgprofessionals in Twente én de impact op zorgaanbieders, middels een overzicht van welke use cases welke sectoren raken en sector specifieke impact	Zelf- en samenredzaamheid onder inwoners wordt vergroot en zij ervaren kortere wachttijden, verbeterde zorguitkomsten en betere kwaliteit van leven. Voor zorgprofessionals moet de zorgtransformatie leiden tot verlaging van administratieve lasten, beschikbare capaciteit beter benutten, hogere productiviteit en betere samenwerking in de regio.
p. 73 - 77	2 Veranderaanpak Beschrijft uitgangspunten, doelgroepen en veranderaanpak met activiteiten, toegespitst op de verschillende fases die doelgroepen, sectoren en organisaties doormaken	We hanteren een veranderaanpak zodat de Digitale Regionale Zorgtransformatie succesvol geadopteerd en gerealiseerd wordt in de regio én binnen de individuele organisaties, met blijvende verandering als resultaat
p. 79 - 80	3 Communicatieplan fase 3 (implementatie) Beschrijft kernboodschap, profilering en doelen van communicatie. En op basis daarvan een communicatieaanpak per doelgroep	We hanteren een communicatieplan om vanuit een stevige, strategische en overkoepelende basis het belang van vertrouwen en samenwerking te benadrukken via voeden, informeren, enthousiasmeren en gefaseerd betrekken van diverse (betrokken) doelgroepen



4.1 Zorgtransformatie Impactanalyse per stakeholder

4.1.1 Impact analyse voor de inwoner en zorgprofessional van Twente

Zorg voor de inwoner wordt gericht afgeschaald, sneller opgeschaald en domeinoverstijgend benaderd



Inwoner van Twente & mantelzorger

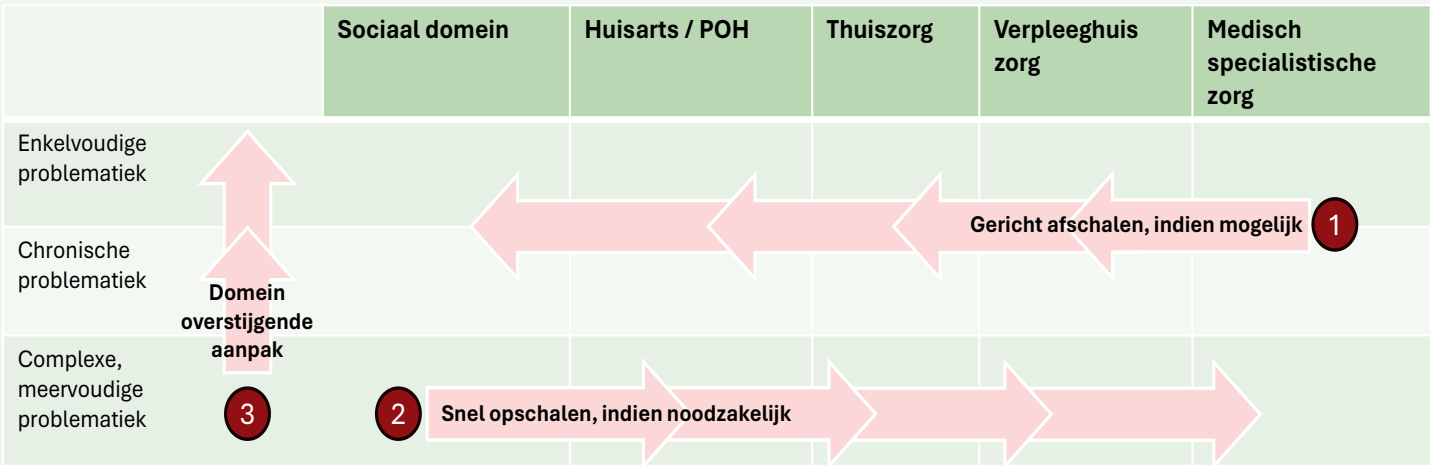


Zorgprofessional algemeen

- De gezondheidszorg wordt rondom de inwoner georganiseerd, met focus op gezondheid
 - Voorkomen zorg daar waar dat geen waarde toevoegt voor de inwoner
 - Op één plek, via één portaal krijgen inwoners meer inzicht in hun eigen gezondheid, wat leidt tot meer rust en regie en het ontzorgen van familieleden en mantelzorgers. Ook vergroot het de inwonertparticipatie, en de zelf- en samenredzaamheid van inwoners.
 - Kortere wachttijden door betere coördinatie van zorg.
 - Zorg wordt beter afgestemd en naadloos en geïntegreerd aangeboden, daardoor minder herhaling van vragen van zorgprofessionals gedurende inwonersreis
 - Verbeterde zorguitkomsten en betere kwaliteit van leven
- Juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment, via één portaal daardoor minder tijd kwijt aan overleg en overdracht in de keten (voor informeren / halen en brengen).
 - Door databeschikbaarheid en inzicht in capaciteit in de regio kan er snellere en doelmatige instroom en doorstroom in de keten plaatsvinden, zie het figuur hieronder. Beschikbare capaciteit wordt daardoor beter benut waardoor we met dezelfde zorgprofessionals de groeiende zorgvraag aankunnen. De komende tijd verkennen we de mogelijkheden en maken we duidelijke afspraken.
 - Er is een verlaging van de administratieve lasten doordat data in één portaal op een eenvoudige en snelle manier beschikbaar is. Zorgverleners zijn hierdoor minder tijd kwijt aan verzamelen, registreren & verifiëren van benodigde informatie. Daardoor is het mogelijk om met completere informatie veiliger en sneller besluiten te nemen en neemt de productiviteit toe.
 - Zorgprofessionals ervaren snelle en laagdrempelige communicatie wat de samenwerking binnen de regio verbetert.
 - Beschikbaarheid van primaire en secundaire data leidt tot verbeterde voorspellingsmogelijkheden.

Toelichting figuur:

- Gericht afschalen, indien mogelijk:** Inwoners worden waar mogelijk dichtbij huis of dichtbij in het (zorg)netwerk geholpen vanuit het verbonden netwerk.
- Snel opschalen, indien noodzakelijk:** Problematiek, en met name (meervoudige) complexe problematiek, wordt snel gesignaleerd en herkend, zodat inwoners snel naar de juiste plek verwezen kunnen worden.
- Domeinoverstijgende aanpak:** We handelen vanuit inwoner. Dit vraagt een domeinoverstijgende aanpak met focus op gezondheid in plaats van zorg met aandacht voor preventie en vroegsignalering, positieve gezondheid, instroom van zorg, bieden van (na)zorg en uitstroom van zorg. Door het inzicht en kennis van de mogelijkheden van de verschillende aanbieders in de regio en heldere afspraken, kan de inwoner de juiste zorg op de juiste plek ontvangen op basis van de hulpvraag. Door samenwerking in de regio is schaalvergroting mogelijk



4.1.2 Impact op zorgaanbieders

Overzicht van de use cases en de betrokken sectoren binnen de scope van het transformatieplan (t/m 2026)

De zorgsectoren in de regio ervaren impact van de Regionale Digitale Zorgtransformatie omdat de use cases op hun zorgprocessen inhaken of zelfs volledig transformeren. Welke use cases dat per sector zijn is in kaart gebracht in de figuur rechts¹. De specifieke impact op sectoren per use case is beschreven in hoofdstuk 2.



360-graden beeld



Regionaal diagnostisch portaal



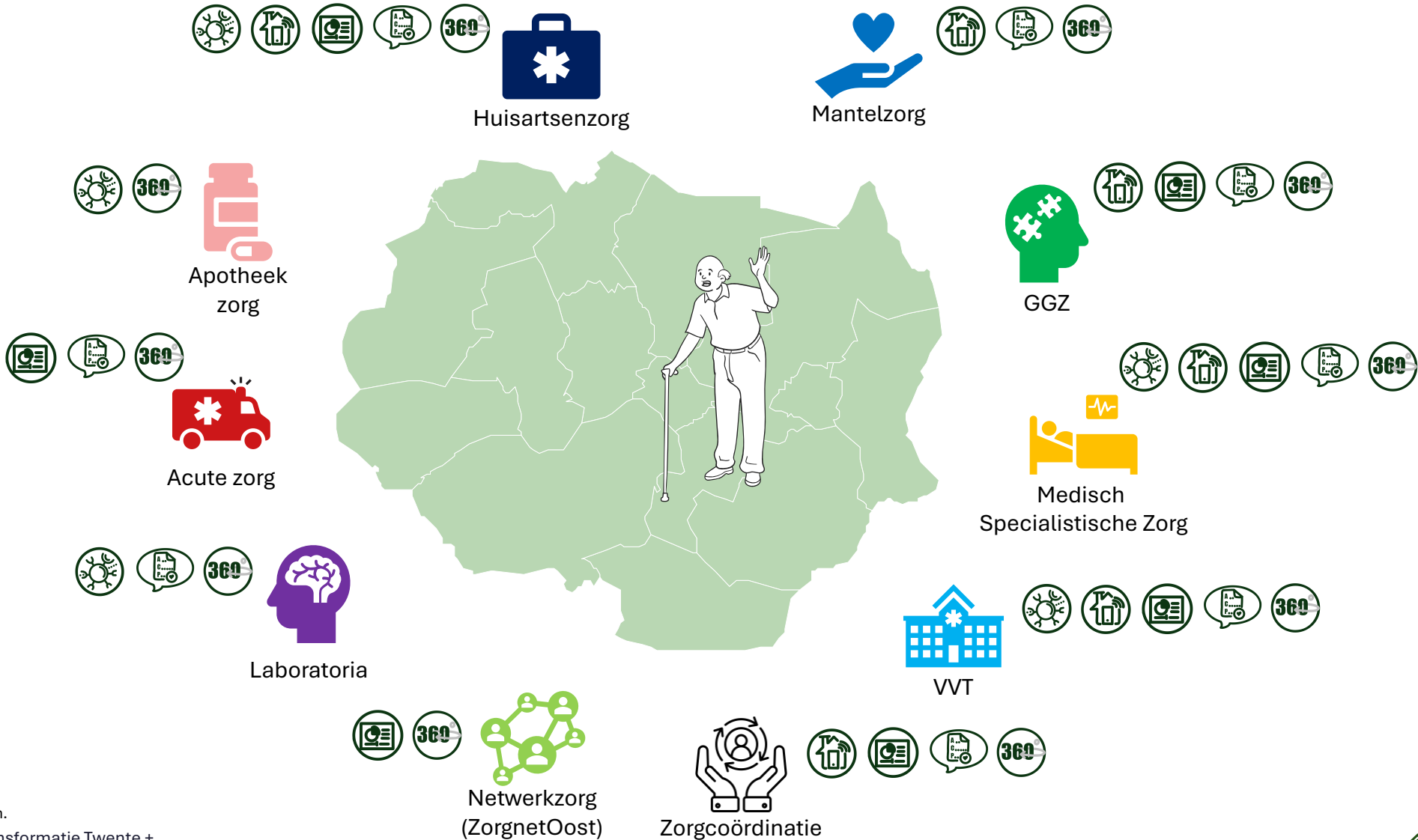
Advance care planning



Gekoppelde thuismonitoring



Regionale capaciteitsinzicht



69 1) De impact per sector omvat zowel gekwantificeerde (kwantitatieve) als niet gekwantificeerde (kwalitatieve) effecten.



4.1.2 Impact op zorgaanbieders

Daarnaast geldt voor een aantal stakeholders nog (sector)specifieke impact, bovenop de algemene impact voor de zorgprofessional



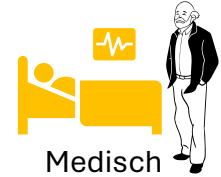
Huisartsenzorg

- Door voorkomen van zorg, vroegtijdige interventies, meer regie bij de inwoner en zelfzorg wordt de zelfredzaamheid van de inwoners vergroot. Als gevolg doet een deel van deze groep minder snel een beroep op de huisartsen.



VVT (verpleeghuis en wijkverpleging)

- Door breed capaciteitsinzicht en databeschikbaarheid kunnen de transfers verbeterd worden, wat leidt tot een betere instroom naar de VVT. Dit draagt bij aan de juiste zorgverlening aan de inwoner door de juist ketenpartner op het juiste moment. Dit zorgt voor het verminderen en voorkomen van verkeerde bedproblematiek.



Medisch
Specialistische Zorg

- Door de verbeterde doorstroom kan er goede mix ontstaan van hoog complexe zorg en laag complexe zorg. Dit kan ook bijdragen aan minder druk op andere zorgorganisaties.
- Verminderen en voorkomen van verkeerde bedproblematiek
- Voorkomen van acute zorg
- Minder opnames (op de SEH), verkorten ligduur, minder (poli)consulten door juiste zorg op juiste plek



Laboratoria

- Real-time toegang tot lab aanvragen en uitslagen versnelt diagnostische processen, wat leidt tot verbeterde operationele efficiëntie, en het voorkomen van dubbeldiagnostiek.
- Laboratoria kunnen trendanalyses uitvoeren en patronen herkennen om zorgbehoeften te voorspellen, wat een proactieve planning van (ziekenhuis)zorg in de regio mogelijk maakt.



Apotheekzorg

- Betere databeschikbaarheid en data van hogere kwaliteit zorgen voor meer passende en veiliger medicijngebruik.
- Minder gebruik van dure geneesmiddelen en behandelmaterialen vanwege eerder staken onnodige behandelingen.



4.2 Zorgtransformatie Veranderaanpak

4.2.1. Inleiding

Zoals in de visie beschreven hebben we met elkaar een maatschappelijke opdracht te volbrengen: het anders organiseren en coördineren van de gezondheidszorg van de inwoners van Twente en omgeving, gericht op gezondheid in plaats van zorg. Als samenleving moeten we anders gaan kijken naar ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het anders kan en moet, maar vooral omdat we dit willen. Iedereen wil zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijven, en onafhankelijk zijn van zorg. We gaan vandaag gezamenlijk de uitdagingen van morgen aan. Dat zien wij als onze **maatschappelijke opgave**. Dit doen we samen met alle betrokken zorgaanbieders vanuit alle sectoren, de inwoners en de financiers van zorg¹.

Nu is aan het ons om lef te tonen om onze (zorg)organisatie echt te veranderen. Het is hierbij van essentieel belang dat we als bestuurders met elkaar afspraken maken over hoe we binnen één verbonden zorglandschap passende (digitale) zorg lijnloos en lokaal aanbieden en de organisatie-overstijgende processen daarop aanpassen, wie op welk gebied het voortouw neemt en welke (gezamenlijke) investeringen nodig zijn. Op deze manier kunnen we de gezamenlijke ambitie vertalen naar concrete afspraken én onze eigen organisatie met concrete doelstellingen en actieplannen.

Dit vraagt om **een op maat gemaakte veranderaanpak** zodat de Digitale Regionale Zorgtransformatie succesvol geadopteerd en gerealiseerd wordt in de regio én binnen de individuele organisaties, met blijvende verandering als resultaat. In dit plan beschrijven we een generieke veranderaanpak, gericht op de verschillende betrokken doelgroepen en sectoren. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat iedere sector en individuele organisatie een eigen verandercontext en startpunt heeft – en de concrete activiteiten daarom ook per sector (of organisatie) kunnen verschillen (op maat toepassen). In de aanpak houden we rekening met de verschillende fases uit de verandercurve, om acceptatie van de verandering door alle betrokkenen te realiseren.



4.2.2 Uitgangspunten voor de veranderaanpak

Een succesvolle Digitale Regionale Zorgtransformatie vraagt om een zorgvuldig proces met aandacht voor inhoud, proces en draagvlak

- 1 **Duidelijke en gedragen urgentie en meerwaarde zijn het startpunt** van een succesvolle verandering. Daarom stellen we een duidelijk veranderverhaal op over het waarom, wat en hoe van de transformatie van zorg. Door het creëren van bewustwording en urgentiegevoel zorgen we voor momentum voor verandering. Daarbij maken we onderscheid in de meerwaarde vanuit verschillende perspectieven en stakeholders.
- 2 Inwoners hebben een belangrijke rol in het laten slagen van de Digitale Regionale Zorgtransformatie. Zij zijn verantwoordelijk voor een gezonde levenswijze, en waar mogelijk zelfzorg en zorg voor naasten. **Door inwoners bewust te maken van de zorgtransformatie en hun rol daarin, kunnen zij de juiste/benodigde (zorg)vragen stellen** aan de zorgorganisaties in de regio. Het stimuleren van de dialoog hierover is belangrijk. Hiervoor starten we een bewustwordings-campagne en formuleren we een duidelijke aanpak. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande regionale bewustwordingscampagnes van Twente Beter en de Twentse Koers in afstemming met het zorgkantoor.
- 3 Een succesvolle verandering vraagt om sterk persoonlijk leiderschap vanuit bestuurders, management én de zorgprofessionals. **Zij zijn de ambassadeurs en koplopers van de verandering.** Enthousiaste ambassadeurs kennen en delen het gezamenlijk verhaal van de regio en hebben oog voor de (individuele en regionale) belangen. De ambassadeurs starten met het verspreiden van het gezamenlijke verhaal richting andere betrokkenen.
- 4 Het anders organiseren en coördineren van (toekomstbestendige) gezondheidszorg vraagt om **aanpassen van bestaande processen, ontwerpen en borgen van nieuwe processen, onderling vertrouwen, samenwerken en anders denken en doen** van alle betrokken mensen. We bouwen voort op bestaande programma's en initiatieven. In de aanpak starten we met een *meting in de regio* om de voortgang te meten en te inventariseren welke werkafspraken, (in)formele samenwerkingsafspraken en procesbeschrijvingen er zijn.
- 5 Deze **veranderaanpak maken we specifiek voor de verschillende doelgroepen die we zien**. Bij de start van de implementatie bepalen we per sector en per organisatie de invulling van de zorgtransformatie activiteiten, zodat het aansluit bij de huidige context, de behoefte, de werkwijze binnen organisatie(s) in de sector en waar mogelijk bij lopende projecten in Twente.
 - We starten daarom met een 0-meting *per organisatie op bestuurlijk niveau, vanuit leiderschap in de organisatie en vanuit de operatie* waarin we onder andere ingaan op de veranderbereidheid, draagvlak en de volwassenheid van IT- en data infrastructuur. Deze meting wordt periodiek uitgevoerd en uitkomsten bespreken we om de aanpak aan te scherpen waar nodig.
 - Door het verschuiven van zorg is het versterken van de eerste lijn een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor nemen we specifieke activiteiten op in de veranderaanpak (incl. accreditatiepunten voor zorgprofessionals).
- 6 **Niet iedereen hoeft even snel te gaan.** Niet alle organisaties kunnen of willen direct instappen. We starten daarom met de relevante partijen die kunnen en willen deelnemen. Een groep organisaties die de eerste stap met elkaar kan verkennen, en anderen sluiten later aan.
- 7 **Doorbouwen op basis van vertrouwen en altijd vooruitgang met de grootst mogelijke kleine stap.** Het is niet mogelijk om alle consequenties van de transformatie voor de komende twee jaar te overzien. Voor zowel de regio als voor alle individuele partijen. Ook wanneer het moeilijk of spannend wordt moeten we ons blijven uitspreken. Daarom blijven we gedurende de route bouwen aan dit vertrouwen en de onderlinge samenwerking door het organiseren van verschillende bijeenkomsten en het continu bijstellen van de activiteiten.
- 8 Er is centrale coördinatie van zorgtransformatie activiteiten vanuit het programma/de regio. Daarnaast verwachten we dat **iedere betrokken zorgorganisatie zelf een intern projectteam opstart om de veranderbereidheid en zorgtransformatie binnen de eigen organisatie te realiseren**. Zo zorgen we voor optimale aansluiting bij organisatiecultuur en methodieken, eigenaarschap en borging binnen de organisaties.
 - Bij het opstellen en uitvoeren van de veranderaanpak worden **individuele organisaties geholpen door coaches** met de executie, communicatie, opleiding en training.
 - Het is mogelijk dat meerdere (kleinere) organisaties samen één projectteam inzetten.



4.2.3 Doelgroepen

De veranderaanpak is gericht op verschillende doelgroepen binnen de regio én binnen zorgorganisaties

Regio



Leiders van de verandering

Wie: Bestuurders, sponsors, projecteigenaren, projectleiders en betrokken zorgprofessionals van de betrokken zorgorganisaties

Rol:

- Ambassadeurs van de zorgtransformatie
- Enthousiasme creëren als voorlopers en inzetten verandering in eigen organisatie
- Visie en meerwaarde uitdragen binnen sectoren en organisaties en onder de inwoners
- Kaders en prioriteiten stellen binnen programma en regio



Programma werkgroepen

Wie: Afvaardiging van medewerkers uit organisaties die meewerken in het programma Digitale Regionale Zorgtransformatie

Rol:

- Uitvoering van het transformatieplan: (door)ontwikkeling en realisatie van zorgtransformatie, datahub en use-cases.
- Beleid en overkoepelende zorgpaden en processen opstellen
- Enthousiasme creëren als voorlopers



Inwoners

Wie: Patiënten/cliënten, verwanten, inwoners (niet in zorg) in de regio (incl. belangenorganisaties)

Rol:

- Gezond leven, vitaal blijven, zelfzorg en zorg voor naasten toepassen waar mogelijk
- Bewustwording dat de gezondheidszorg anders georganiseerd moet worden
- Toestemming geven voor (persoonlijke) databeschikbaarheid
- Participeren in use-cases en gebruiken van de datahub

Zorgorganisaties



Leiders van de verandering

Wie: Bestuurders, leidinggevenden, directeuren, managers en individuele zorgprofessionals van de betrokken zorgorganisaties

Rol:

- Ambassadeurs van de zorgtransformatie
- Visie uitdragen en enthousiasme creëren binnen de eigen organisatie
- Kaders en prioriteiten stellen binnen de eigen organisatie
- Verantwoordelijk voor implementatie per organisatie



Interne projectteams

Wie: Medewerkers in betrokken zorgorganisaties die meewerken in intern projectteam (per organisatie)

Rol:

- Verantwoordelijk voor veranderbereidheid en zorgtransformatie in eigen organisatie
- Uitvoeren van zorgtransformatie en communicatie activiteiten (o.b.v. info/formats vanuit het programma)



Zorgprofessionals & (Zorg)medewerkers

Wie: Zorgverlenend en ondersteunend personeel in betrokken zorgorganisaties

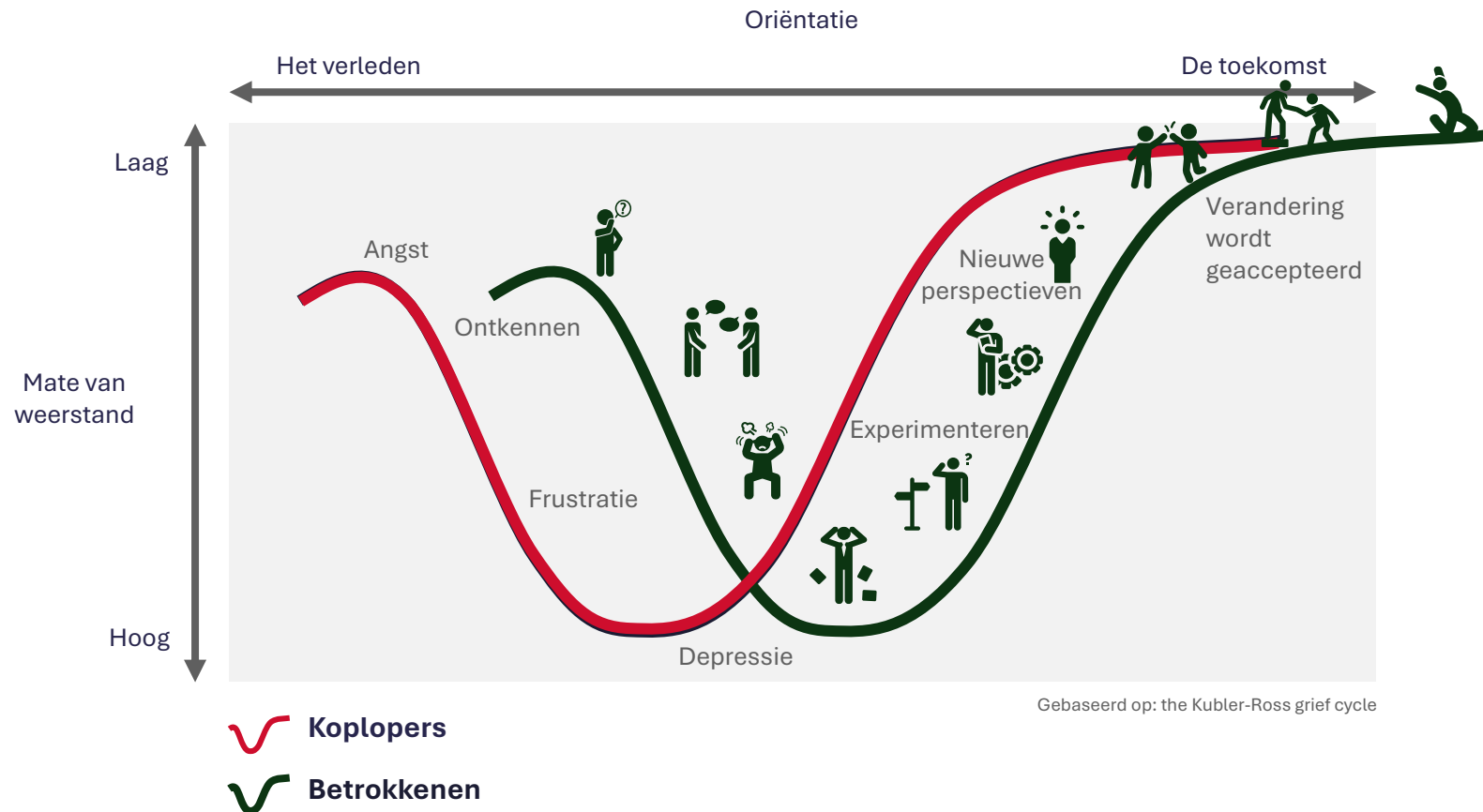
Rol:

- Aan de slag met de zorgtransformatie: toepassen van nieuwe zorgpaden/processen/werkwijzen
- Gebruikers van de datahub (let op onderscheid primair en secundair gebruik per rol)



4.2.4 Veranderaanpak: zorgtransformatie activiteiten inzetten op het juiste moment in de verandering

Tijdens een veranderproces doorlopen mensen verschillende fases, ieder in een eigen tempo

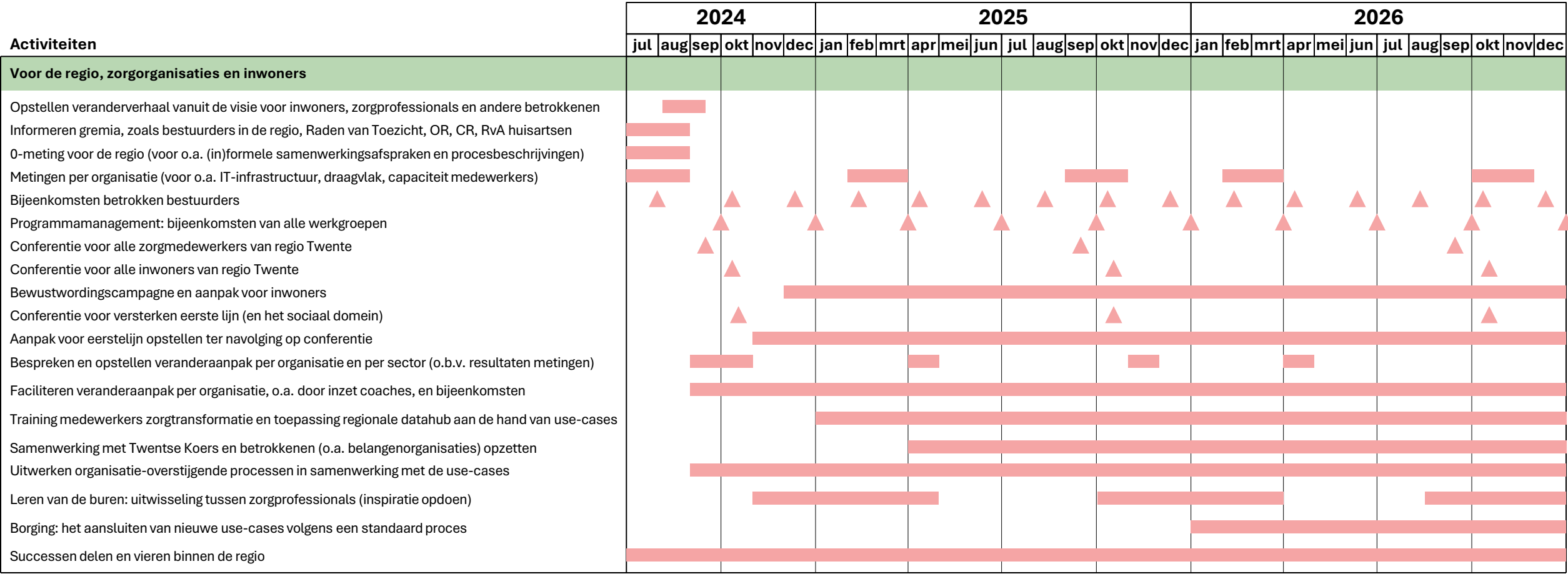


- **De start is niet voor iedereen gelijk.** Iedere persoon die betrokken is bij de verandering volgt zijn/haar **eigen verandercurve**, met verschillende fases, snelheden en aandachtspunten
- **Koplopers (zoals bestuurders) ervaren de fases in de verandercurve eerder** dan andere betrokkenen. We zijn ons bewust van dit verschil, zowel op regio als organisatie niveau, en hebben expliciet aandacht waar iemand zich op de verander curve bevindt.
- We zetten zorgtransformatie **activiteiten in op het juiste moment**: toegespitst op de verschillende fases die doelgroepen/ sectoren/ organisaties doormaken.
- Om alle betrokkenen door de verandercurve te begeleiden t/m acceptatie, besteden we in de veranderaanpak aandacht aan:
 1. **Snappen** van de noodzaak, urgentie en de impact van de verandering
 2. **Willen** veranderen, door voldoende betrokkenheid te voelen en de voordelen van de verandering te zien
 3. **Kunnen** veranderen door voldoende kennis, begeleiding, tijd en vaardigheden te hebben of krijgen.



4.2.5 Veranderaanpak: activiteiten

Het zorgtransformatieteam coördineert de veranderaanpak, in samenwerking met communicatie en programmateam



4.3 Zorgtransformatie Communicatieplan tijdens fase 3 (implementatie)

4.3 Communicatieplan voor fase 3: implementatie regionale datahub, als onderdeel van de digitale zorgtransformatie

Kernboodschap Digitale Regionale Zorgtransformatie: vanuit vertrouwen en samenwerking naar beschikbaarheid van gegevens om de zorg verder te verbeteren

Kernboodschap communicatieplan fase 3

Dit communicatieplan biedt een strategisch kader voor de inzet van communicatie tijdens fase 3 van de Digitale Regionale Zorgtransformatie. De kernboodschap van dit plan luidt: 'vanuit een stevige, strategische en overkoepelende basis het belang van vertrouwen en samenwerking benadrukken via voeden, informeren, enthousiasmeren en gefaseerd betrekken van diverse (betrokken) doelgroepen. Dit communicatieplan sluit aan op en versterkt de veranderaanpak, om acceptatie van de verandering door alle betrokkenen te realiseren.

Profilering van communicatie

Door communicatie vanaf de start stevig strategisch te profileren (overkoepelend, verbonden met stuurgroep) in plaats van versnipperd en/of uitvoerend, draagt dit direct bij aan het succes van de digitale transformatie en fase 3.



Doelen

Neerzetten stevige strategische basis

Communicatie is key in de transformatie, waarvoor in fase 3 een basis wordt gelegd. Door vanuit een centrale positie hiervoor de strategische lijnen te bepalen, kan daarlangs de communicatie verder vorm krijgen. Het begint bij een goede kernboodschap, eenduidige taal en toon en heldere kaders.

De aan te stellen communicatieadviseur werkt de kaders van dit plan verder uit voor fase 3, hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan op bestaande regionale communicatieplanningen van bijv. Twente Beter.

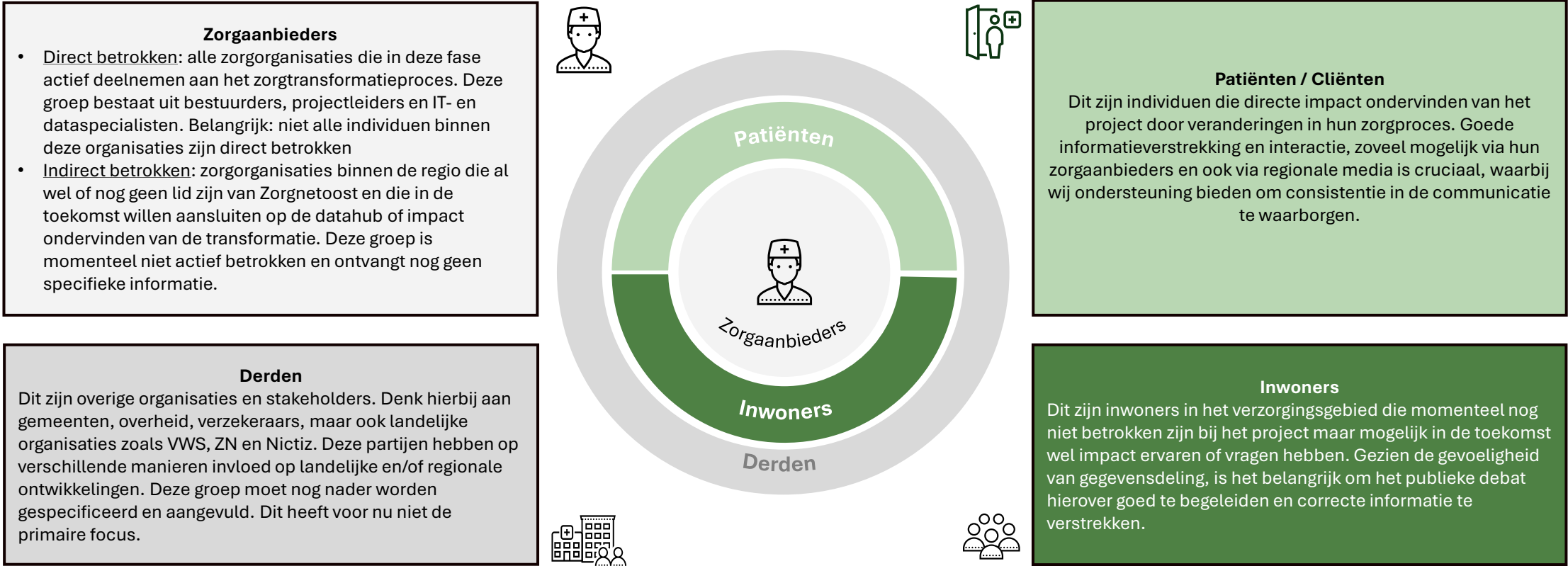
Betrokken organisaties voeden, informeren, enthousiasmeren en betrekken
Sommige organisaties zijn eerder/meer betrokken dan andere, maar uiteindelijk betreft de transformatie de hele regio. Via een klankbordgroep en daarnaast bredere vertegenwoordiging worden de communicatieprofessionals van regionale (zorg)organisaties gevoed, transparant geïnformeerd en enthousiast betrokken bij de transformatie en datahub. Zij vormen de linking-pin in hun eigen organisaties.



4.3 Communicatieplan voor fase 3: implementatie regionale datahub, als onderdeel van de digitale zorgtransformatie

De communicatie aanpak aanpassen per doelgroep

De doelgroepen zijn divers: direct betrokken zorgaanbieders, indirect betrokken zorgorganisaties, inwoners en derden zoals gemeenten en verzekeraars. Elk van deze groepen vereist een aangepaste communicatieaanpak en timing, waarbij de focus ligt op heldere informatieverstrekking en het stimuleren van betrokkenheid en creëren van transparantie. Een diverse mix van basis communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, en visuele materialen is nodig om de boodschap over te brengen en de brede doelgroepen gefaseerd effectief te bereiken. Naast de basis middelenmix maken we vooral ook gebruik van de bestaande middelen en kanalen per organisatie, in afstemming met hun communicatieprofessionals voor efficiënte inzet en maximaal effect.



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

1. Juridische samenwerkingsvorm
2. Afspraken gelijkgerichtheid & executiekracht
3. Projectgovernance en -organisatie
4. Financiering

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



5. Governance inleiding | Overzicht van de verschillende onderdelen en leeswijzer binnen dit hoofdstuk

Juridische vorm, gelijkgerichtheid, organisatie & governance en financiering zijn cruciaal voor succes implementatie

p. 83 - 85

1

Juridische samenwerkingsvorm | Middels welke juridische vorm gaan de deelnemende partijen samenwerken?

- Samenwerkingsvorm tussenfase 2-3 (voorbereiding implementatie)
- Samenwerkingsvorm fase 3 (implementatie) en fase 4 (doorontwikkeling)

p.87

2

Afspraken gelijkgerichtheid en executiekracht | Hoe wordt gewaarborgd dat alle partijen worden betrokken en samenwerken aan hetzelfde doel? Welke afspraken zijn gemaakt?

- Uitgangspunten gelijkgerichtheid en executiekracht

p. 89 - 92

3

Organisatie & governance | Hoe werken de deelnemende partijen in het programma samen? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Op welke wijze overlegt men met elkaar?

- Uitgangspunten
- Programmastructuur
- Governancestructuur
- Rollen en verantwoordelijkheden

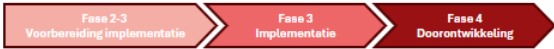
p.94

4

Financiering | Wie speelt welke rol in het financieringsproces?

- Afspraken project control

Leeswijzer en samenhang



Gedurende dit hoofdstuk vind je rechtsboven op de pagina een leeswijzer. De leeswijzer geeft aan op welke transformatiefase de informatie betrekking heeft:

- **Fase 2-3:** Voorbereiding implementatie (1 juni 2024 – 1 sept. /okt. 2024)
- **Fase 3:** Implementatie (1 sept. / okt. 2024 – ~31 december 2026)
- **Fase 4:** Doorontwikkeling (~ vanaf 1 januari 2027)

Wil je meer weten over de governance en organisatie van de datahub organisatie, kijk dan bij [hoofdstuk 3.2 Beheergovernance](#). Daar is dezelfde leeswijzer terug te vinden. NB: het eindproduct van Beheergovernance is in fase 4 gereed, implementatie start in fase 3.



5.1 Governance Juridische samenwerkingsvorm

5.1.1 Juridische samenwerkingsvorm

Samenwerkingsovereenkomst gedurende tussenfase 2-3 (voorbereiding implementatie) en fase 3 (implementatie)

Tussenfase 2-3: Besluit en onderbouwing

Programmastructuur

Er is door de stuurgroep en de werkgroep Projectgovernance en -organisatie besloten om in tussenfase 2-3 een **samenwerkingsovereenkomst** op te stellen voor alle deelnemende partijen m.b.t. de Digitale Regionale Zorgtransformatie.

De keuze voor een samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de volgende reden:

- Er moet voor het begin van fase 3 een **juridisch fundament** liggen voor:
 - De financiële afspraken m.b.t. de transformatiegelden
 - De verdeling van verantwoordelijkheden en plichten

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst kan besloten worden om de samenwerking onder te brengen in een rechtspersoon (vanaf fase 4).

Programmastructuur

Onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst zijn o.a.:

- De betrokken & tekenende partijen (zie huidige opzet in Verdieping 3 – Governance)
- Afspraken over toetreding en uittreding van partijen (gelijkgerichtheid)
- Afspraken bij eventuele geschillen
- Mandaat voor de verschillende deelnemende partijen
- Besluitvorming tussen de verschillende deelnemende partijen
- Governancestructuur (op stuurgroep niveau, o.a. deelnemers en overlegfrequentie)
- Afspraken over penvoering
- Duur van de overeenkomst
- Financiële afspraken (incl. kassiersfunctie)

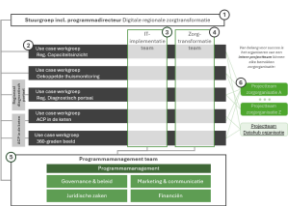
Fase 3: Advies en onderbouwing¹

Programmastructuur

Het advies voor fase 3 is om de programmastructuur te laten fungeren volgens de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst, zie 'Tussenfase 2-3: Besluit en onderbouwing' links. De samenwerkingsovereenkomst wordt in fase 3 hooguit aangevuld met de nieuwste inzichten en afspraken.

De samenwerkingsovereenkomst heeft in principe een looptijd tot en met fase 3. De redenering hiervoor vind je op de volgende slide – Programmastructuur.

Programmastructuur



Addendum van Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst deelnemende partijen van de Digitale Regionale Zorgtransformatie²

regiovisie
Twente Beter



Meer **kwaliteit van leven** voor en door de Twentenaar

1) Voorgaande is een advies; en kan enkel worden omgezet naar een besluit als o.a. het IT-implementatieteam meer technologische keuzes heeft gemaakt (fase 3) 2) De set aan deelnemende partijen kan in de toekomst uitgebreid worden. Zie de huidige opzet van de partijen in Verdieping 3 – Projectgovernance



5.1.2 Juridische samenwerkingsvorm

Coöperatie wordt gevormd gedurende fase 3 (implementatie) en treedt in werking in op 1 januari 2025

Fase 3 en 4: Advies en onderbouwing¹

Datahub organisatie

Het advies voor fase 4 luidt om de functies voor **datahub organisatie** (o.a. leveranciersmanagement, informatiebeveiliging) **centraal bij één entiteit** (bestaand of nieuw) **te beleggen** om onafhankelijke vertegenwoordiging van de bredere samenwerking te borgen. Zorgnetoost lijkt hierbij een logische keuze gezien het portfolio van Zorgnetoost (met focus op **regionale samenwerking bij informatie uitwisseling (ICT) tussen verschillende zorgaanbieders**) en de **bestaande klantrelaties** tussen Zorgnetoost en de zorgaanbieders in Twente. Het is qua besluitvorming en benodigde werkzaamheden (juridisch / financieel) **eenvoudiger om de juridische vorm van een huidige rechtspersoon (in dit geval Zorgnetoost) te wijzigen** dan een nieuwe rechtspersoon op te richten. Om die reden wordt geadviseerd om bij een bestaande rechtspersoon aan te sluiten.

Indien gekozen wordt om de datahub organisatie bij Zorgnetoost te beleggen, is het advies om de juridische rechtsvorm van Zorgnetoost om te zetten van een BV naar een **coöperatie** zodat deze past bij de vernieuwde rol van Zorgnetoost. Dit advies wordt gegeven om de volgende redenen:

- **Flexibele structuur:** Anders dan een BV is een coöperatie gericht op onderlinge samenwerking. Leden kunnen bovendien gemakkelijk toe- en uitreden zonder tussenkomst van een notaris (zoals aandeelhouders van een BV)
- **Vertegenwoordiging & besluitvorming:** Een coöperatie is voor en van de leden. De wet geeft de coöperatie veel vrijheid ten aanzien van de verdeling van stemmen (denk bijvoorbeeld aan verdeling van zeggenschap over verschillende clusters van zorgaanbieders). Binnen een BV is de zeggenschap in principe geregeld op basis van de mate van kapitaalinbreng van de aandeelhouders (vaak zijn er maar enkele aandeelhouders). De vertegenwoordiging en besluitvorming binnen de coöperatie wordt in fase 3 verder uitgewerkt

Zorgnetoost had al het voornemen om, op basis van een eerder juridisch advies buiten dit transformatieplan, de juridische entiteit te wijzigen van een BV naar een coöperatie. Zorgnetoost wil in juli 2024 een formeel besluit te nemen over de eventuele coöperatievorming. Na goedkeuring zal de coöperatie naar verwachting op 1 januari 2025 als rechtsvorm in werking treden voor Zorgnetoost.

De implicaties van dit advies worden in fase 2-3 en fase 3 nog verder uitgezocht en onderbouwd met hulp van juridische adviseurs.

Programmastructuur

De **programmastructuur** voor de regionale zorgtransformatie is in **fase 3** geregeld in de **samenwerkingsovereenkomst**. De bekostiging vindt plaats met transformatiegelden die door de zorginstellingen bij de samenwerking worden ontvangen. De **transitie** van de programmastructuur naar Zorgnetoost vindt pas plaats in **fase 4** (ook met het oog op de besluitvorming en btw-aspecten). Er wordt voorzien dat de programmaorganisatie vanaf fase 4 (doorontwikkeling) zal zijn geïntegreerd in Zorgnetoost.

NB:

- de volgende slide bevat de visualisatie van de juridische structuur in fase 3 en 4.
- voor een verdieping op bovenstaande uitleg, inclusief betrokkenheid van interne gremia en het toetreden van leden, zie Verdieping 3 - Governance



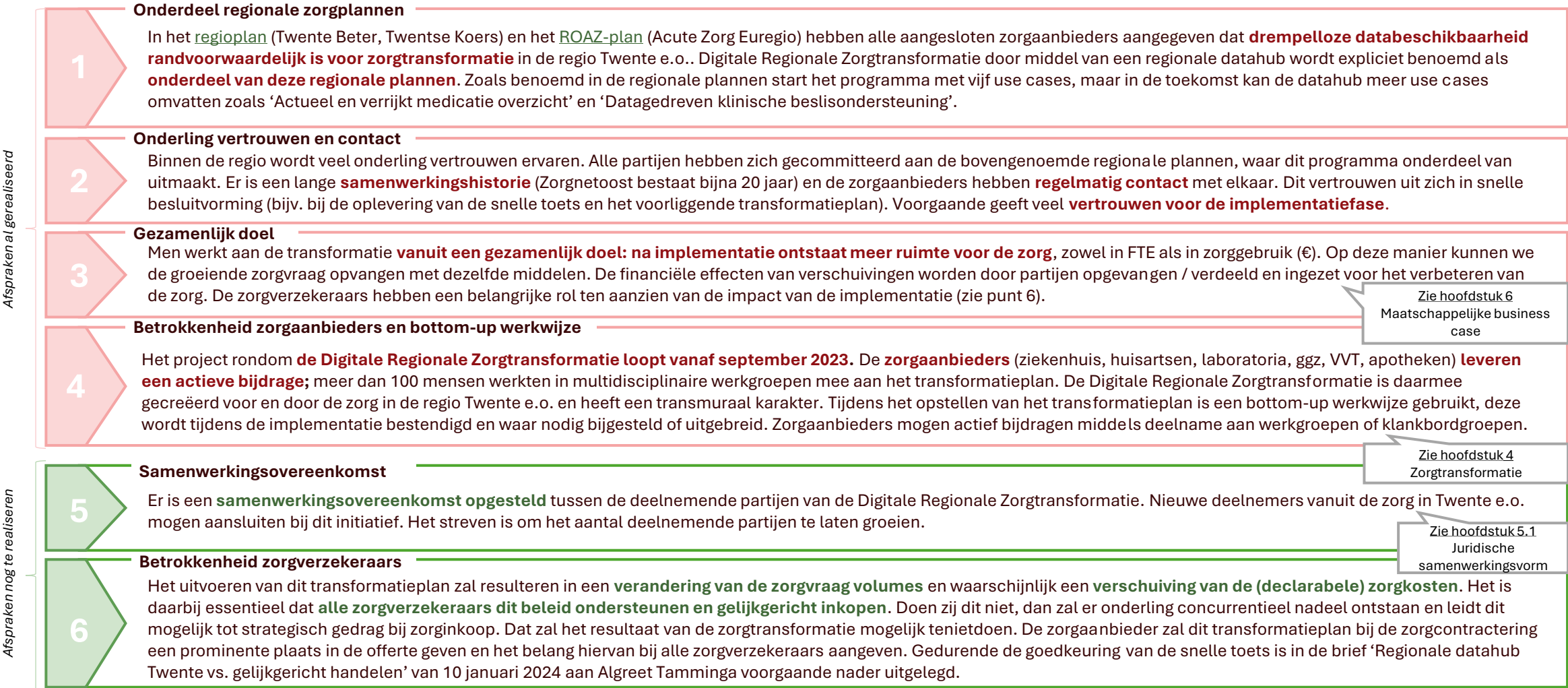
Van programmastructuur met samenwerkingsovereenkomst naar datahub organisatie in coöperatie Zorgnetoost¹

regiovisie
Twente Beter

5.2 Governance Afspraken gelijkgerichtheid & executiekracht

5.2 Afspraken gelijkgerichtheid en executiekracht

Onderstaande afspraken en werkwijzen dragen bij aan de gelijkgerichtheid binnen het programma Digitale Regionale Zorgtransformatie:



5.3 Governance Projectgovernance en -organisatie

5.3.1 Uitgangspunten en afwegingen ‘projectorganisatie en -governance’

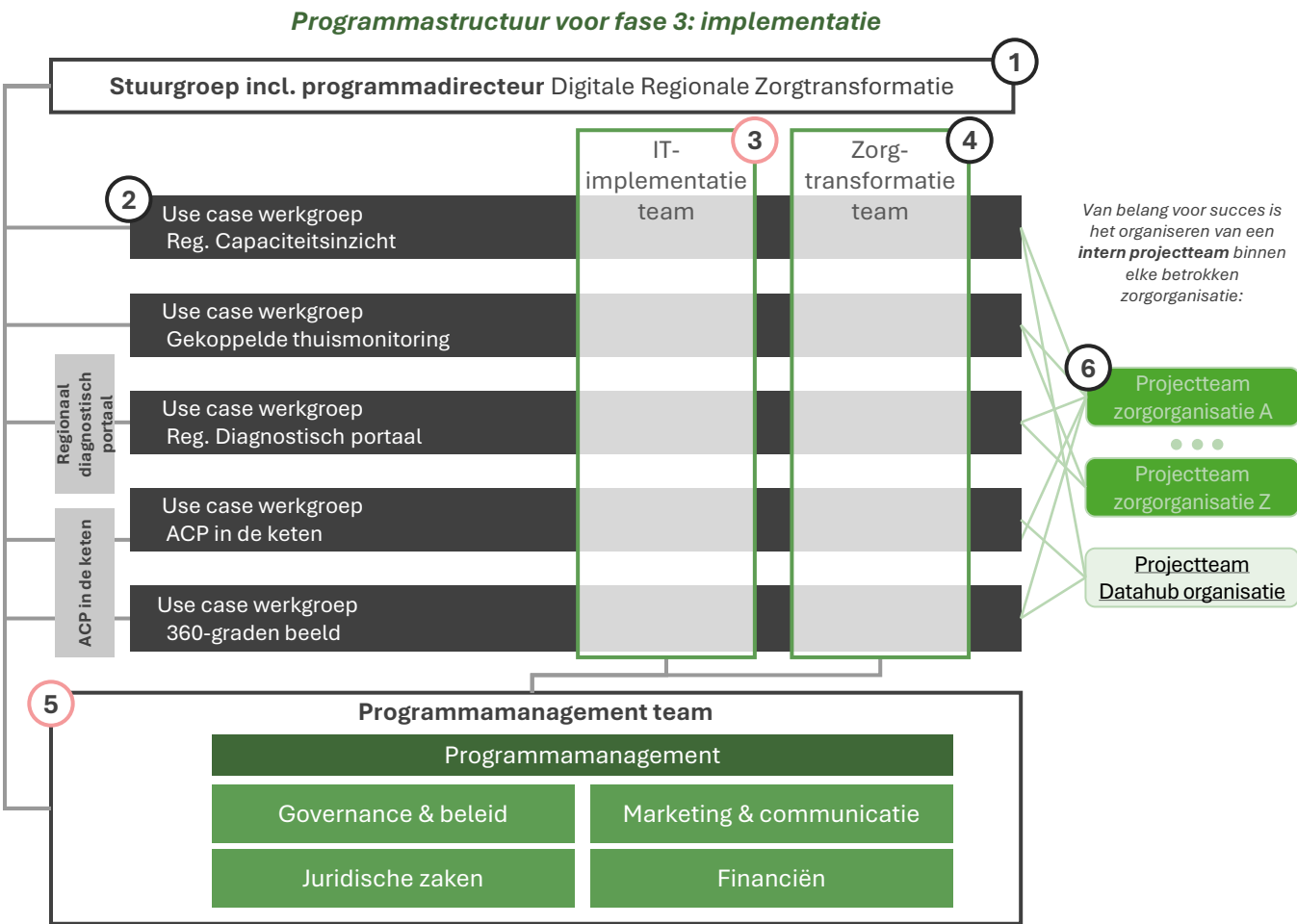
Leidende principes om de besluitvorming op het gebied van projectorganisatie en –governance te sturen

		Uitgangspunten	Afwegingen
Organisatie		De projectstructuur ten tijde van fase 2 heeft zichzelf bewezen. In fase 3 wordt op deze projectstructuur voortgeborduurd met accentverschuivingen zodat deze past bij de volgende fase. De projectstructuur wordt middels ervaringen uit soortgelijke initiatieven aangevuld met rollen en aanvullende verantwoordelijkheden ¹ . O.b.v. besluiten over het IT platform en de juridische inrichting wordt organisatie & governance gedurende fase 3 aangevuld.	Behoud van goed werkende elementen uit fase 2 met voldoende aanvulling om fase 3 tot een succes te brengen
		Er is voldoende representatie van de regio in het gehele programma, inclusief het programmamanagement. Denk hierbij aan ‘regionale eigenaren’ per werkstroom. Ook het huidige onafhankelijke programmamanagement wordt idealiter gecombineerd met regionale representatie.	De Digitale Regionale Zorgtransformatie moet gedragen en doorleefd worden binnen de regio
Governance		De bestaande samenstelling van de stuurgroep wordt voortgezet (MST, ZGT, Mediant, Zorgschakel Enschede, CarintReggeland, Labmicta en Acute zorg Euregio, HZT, TAO-UA, Zorgnetoost). NB: de stuurgroep zal blijven bestaan uit bestuurders, geen gedelegeerden vanuit partijen.	Balans tussen snelle, efficiënte besluitvorming en representativiteit van deelnemende partijen
		Er wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en ervaring en aansluiting gezocht bij bestaande samenwerkingsvormen in de regio (zoals Twente Beter en Zorgnetoost).	Realisatie van 1) efficiëntie en 2) kruisbestuiving tussen verschillende initiatieven
		Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de bestaande besluitvormingsstructuren binnen de regio. Indien nodig wordt afzonderlijk aangesloten op de interne besluitvorming binnen een (of meerdere) deelnemende partij(en).	Mogelijkheid voor partijen om bijv. achterban te informeren dan wel te consulteren voor besluitvorming
		Er wordt een standaard proces ingericht hoe deelnemende partijen kunnen aansluiten of afscheid nemen van Digitale Regionale Zorgtransformatie (o.b.v. principes voor gelijkgerichtheid). Er wordt een basis gelegd waar alle nieuw aangesloten partijen ondergebracht kunnen worden (eigen plek of vertegenwoordiging van groep).	Mogelijkheid voor een breed scala aan regionale zorgpartijen om deel te nemen aan het programma
		De input van de use case werkgroepen wordt meegenomen in het IT-implementatieteam en zorgtransformatieteam. Deze teams zorgen dat input vanuit de use case werkgroepen voldoende wordt meegenomen door programmamanagement.	De use case werkgroepen zijn de kern van het programma en moeten goed vertegenwoordigd zijn in de governance

5.3.2 Programmastructuur

Verschillende teams met oog voor techniek en verandering zorgen voor een succesvolle implementatie

Met onderstaande teams en werkgroepen wordt de Digitale Regionale Zorgtransformatie in fase 3 geïmplementeerd. Kern van de organisatiestructuur zijn de use case werkgroepen¹, die multidisciplinair invulling geven aan de use cases van de regionale datahub. De programmastructuur zal gefaseerd in de tijd worden uitgerold. NB: De keuzes van iedere use case met betrekking tot het IT platform heeft implicaties voor de programmastructuur, net zoals de juridische inrichting. De programmastructuur, rollen en verantwoordelijkheden worden hierop aangepast. In Verdieping 3 – Governance staan alle rollen en verantwoordelijkheden uitgebreid omschreven.



Teams en werkgroepen (incl. kernverantwoordelijkheden)

- 1 **Stuurgroep incl. programmadirecteur** – Besluitvorming, sturing en ondersteuning bij stakeholdermanagement.
- 2 **Use case werkgroepen¹** – Werken de technische implementatie en zorgtransformatie per use case verder uit in multidisciplinaire teams. Stemmen de technische functionaliteiten en ontwerpprincipes nauw af en wisselen hierop input uit met het IT-implementatieteam.
- 3 **IT-implementatieteam** – Draagt zorg voor technische implementatie van de regionale datahub. Stemt met use case werkgroepen af over samenhang technische functionaliteiten en ontwerpprincipes van datahub en use cases. Is daarnaast verantwoordelijk voor de beheergovernance van de datahub.
- 4 **Zorgtransformatieteam** – Coördineert de overkoepelende impact van de use cases op de zorg en de implementatie hiervan (binnen en over zorgaanbieders). Stemt met use case werkgroepen en Marketing & communicatie. Verantwoordelijk voor adoptie van de transformatie.
- 5 **Programmamanagementteam** – Coördineert de implementatie van de Digitale Regionale Zorgtransformatie. Bewaakt de scope, bemensing, planning, budget en kwaliteit. Zorgt voor draagvlak, commitment en juiste energie in de regio en binnen het programma.
- 6 **Decentrale projectteams** – Per betrokken zorgorganisatie is het van cruciaal belang om een intern projectteam in te richten. Deze decentrale projectteams creëren hun eigen projectplan en staan in nauw contact met het centrale programma. Lees ook [Hoofdstuk 4 Zorgtransformatie](#)

1) De use case werkgroepen gaan mogelijk gefaseerd in de tijd te werk.

.. = Rollen en verantwoordelijkheden veranderen bij wijziging juridische vorm / IT keuzes.

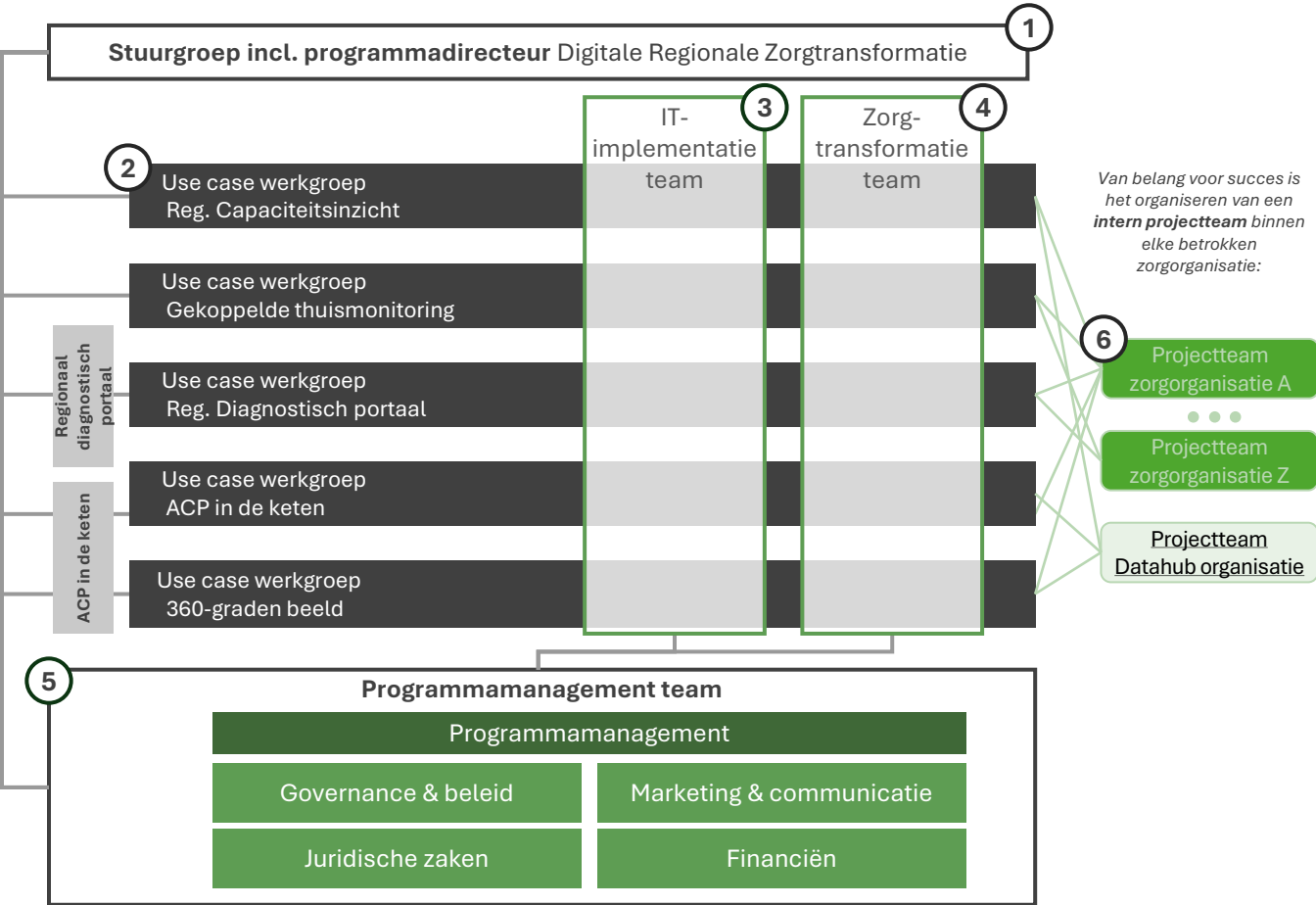


5.3.3 Governancestructuur | Programmaoverleggen¹

De groepen uit de programmastructuur stemmen regelmatig af om de integraliteit en voortgang te borgen

De verschillende groepen uit de programmastructuur overleggen op reguliere basis met elkaar om strategische, tactische en operationele afstemming te borgen. De overlegstructuur geeft een indicatie welke groepen aan elkaar input leveren. In de praktijk zal dit minder formeel en lineair verlopen; onderlinge afstemming en input zal tussen vrijwel alle groepen plaatsvinden. Voor een verdieping op onderstaande uitleg over de programmastructuur zie de slide in Verdieping 3 – Governance.

Programmastructuur voor fase 3: implementatie



Programmaoverleggen incl. onderlinge samenhang

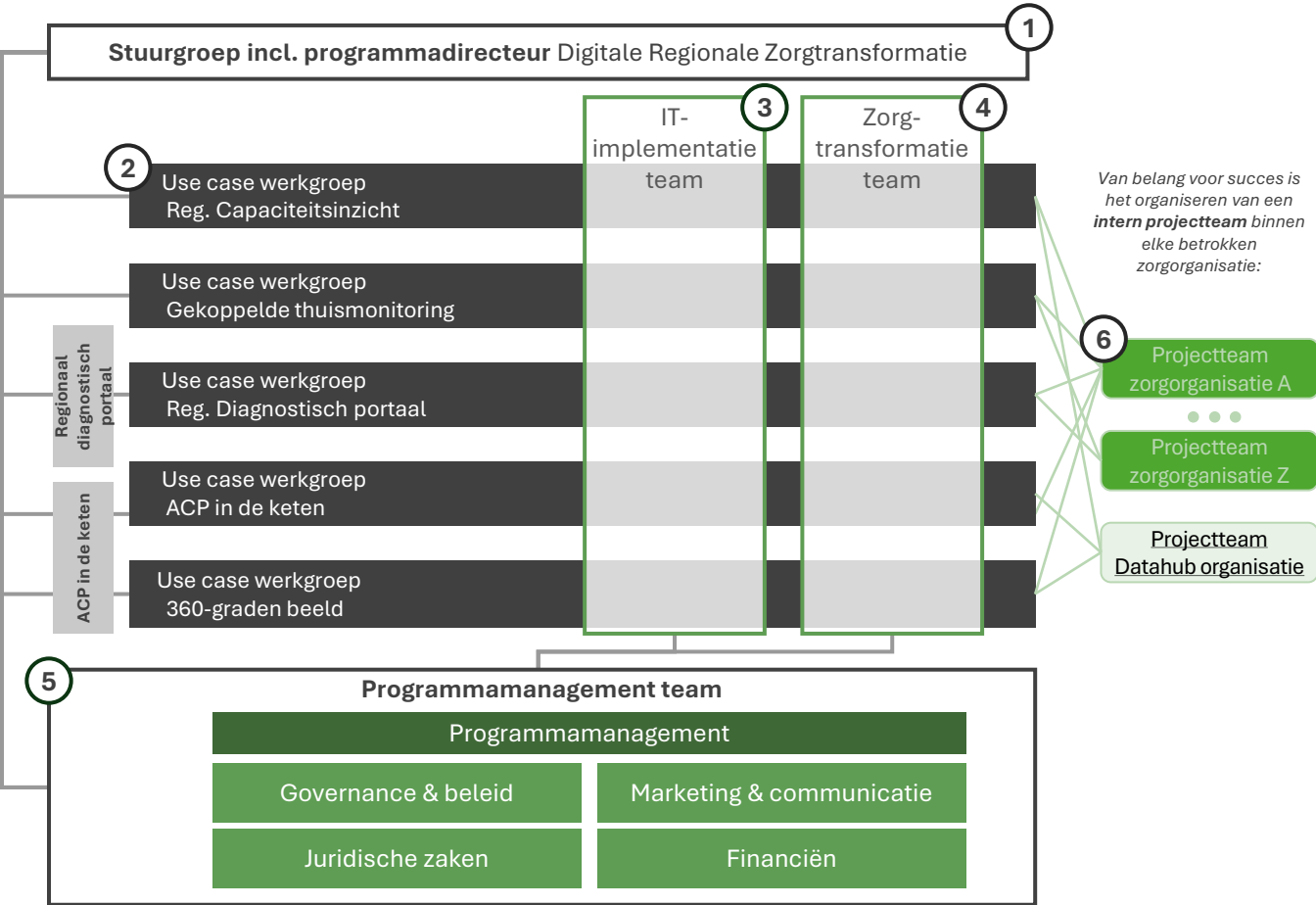


5.3.4 Governancestructuur | Stakeholderoverleggen¹

Regelmatige interactie met belangrijke stakeholders zoals verzekeraars, zorgprofessionals en inwoners

Diverse groepen uit de programmastructuur stemmen af met ‘externe stakeholders’ die niet deelnemen aan de programmastructuur. Op deze manier worden externe groepen geïnformeerd, betrokken en ontstaat kruisbestuiving over de gehele zorgketen. Deze stakeholderoverleggen worden hieronder beschreven. Voor een verdieping op de uitleg van de stakeholderoverleggen zie de slide in Verdieping 3 – Governance.

Programmastructuur voor fase 3: implementatie



Stakeholderoverleggen

Zorgverzekeraars overleg – Afstemming met zorgverzekeraar(s) over de voortgang van de Digitale Regionale Zorgtransformatie t.o.v. de vooraf bepaalde resultaats- en inspanningsverplichtingen.
1, 5

Governance en organisatie klankbordgroep – Toetsing van de financiering, organisatie- en governancestructuur, juridische samenwerkingsvorm bij experts op dit vlak vanuit zorgaanbieders.
5

Zorgprofessionals klankbordgroep – Toetsing van bevindingen binnen de use case groepen en/of het zorgtransformatieteam onder zorgprofessionals, ter vergroting van hun betrokkenheid.
2, 4

Inwoner focusgroepen (optioneel) – Toetsing van bevindingen onder inwoners bij specifieke onderwerpen waar hun betrokkenheid / co-creatie gewenst is.
2, 4

Architectuurboard – Toetsing van aanpak en uitkomsten van de technische architectuur.
2, 3

1) De governancestructuur kan wijzigen afhankelijk van de fase binnen de implementatie en de daarbijbehorende noodzaak van het overleg.



5.4 Governance Financiering

5.4.1 Financiering

Project control

Projectocontrol		Vanuit eerdere transformaties (o.a. ZBJ) is gebleken dat een combinatie van meerdere zorgaanbieders en meerdere verzekeraars het uitkeren van transformatiegelden onnodig ingewikkeld maakt.
		Voor de Digitale Regionale Zorgtransformatie kiezen partijen ervoor om een kassier aan te stellen die de gelden ontvangt en verdeelt onder de deelnemers. De kassiersfunctie wordt vervuld door het MST.
		De kassier zorgt voor een deugdelijke administratie (met procuratie) van waaruit verantwoording afgelegd kan worden over de inzet van mensen en de besteding van middelen binnen het project.
		De stuurgroep van het transformatieprogramma stuurt op de kosten en de voortgang met betrekking tot de afgesproken KPI's. Zij informeren tevens relevante stakeholders over deze voortgang.



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

1. Maatschappelijke business case
2. Duurzaamheid
3. Monitoring

7. Integrale implementatieplanning

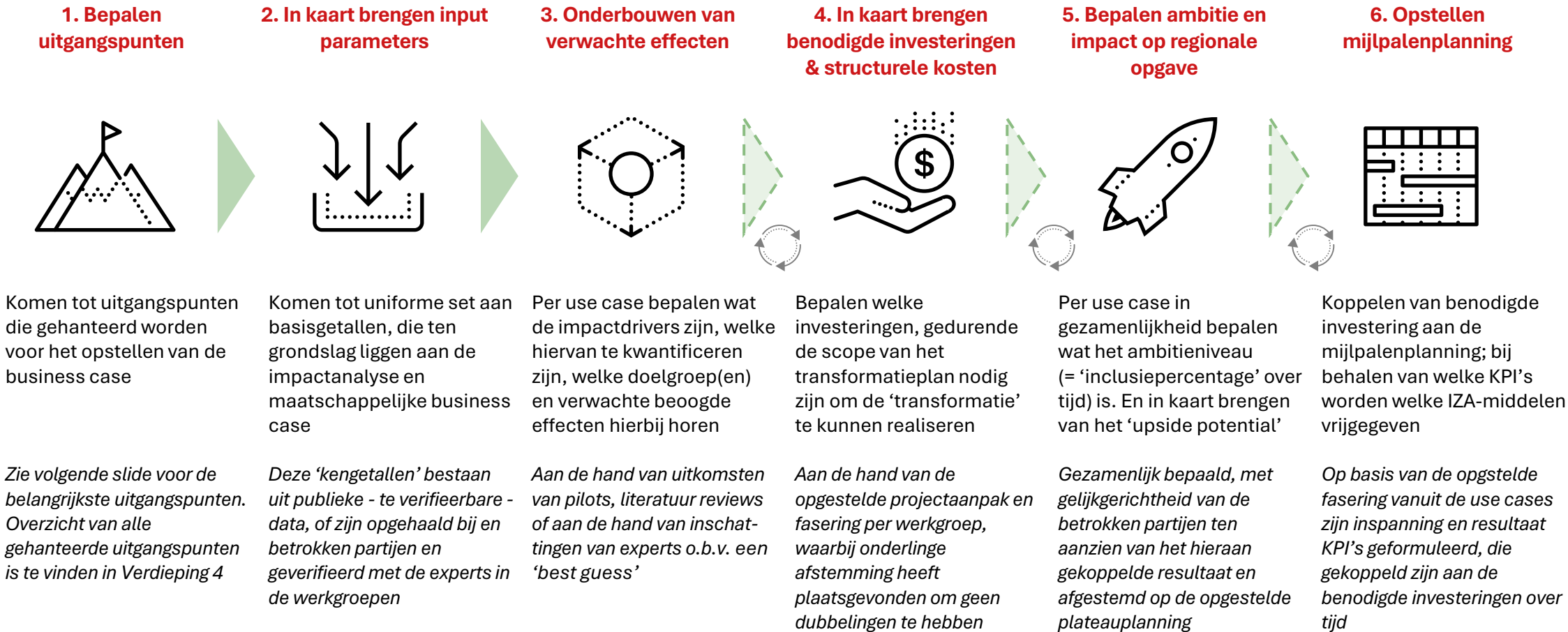
8. Risico's & mitigerende maatregelen



6.1 Maatschappelijke business case

6.1.1 Toelichting op totstandkoming van maatschappelijke business case

In 6 stappen komen tot een maatschappelijke business case met draagvlak bij alle partijen



Stappen 3 t/m 6 – zijn parallel & iteratief uitgewerkt

Benodigde investeringen hangen bijvoorbeeld af van de plateauplaning, en de ambitie dient te zijn afgestemd op verwachte oplevering van functionaliteiten en adoptievermogen in de regio.



6.1.2 Belangrijkste uitgangspunten onderliggend aan de maatschappelijke business case

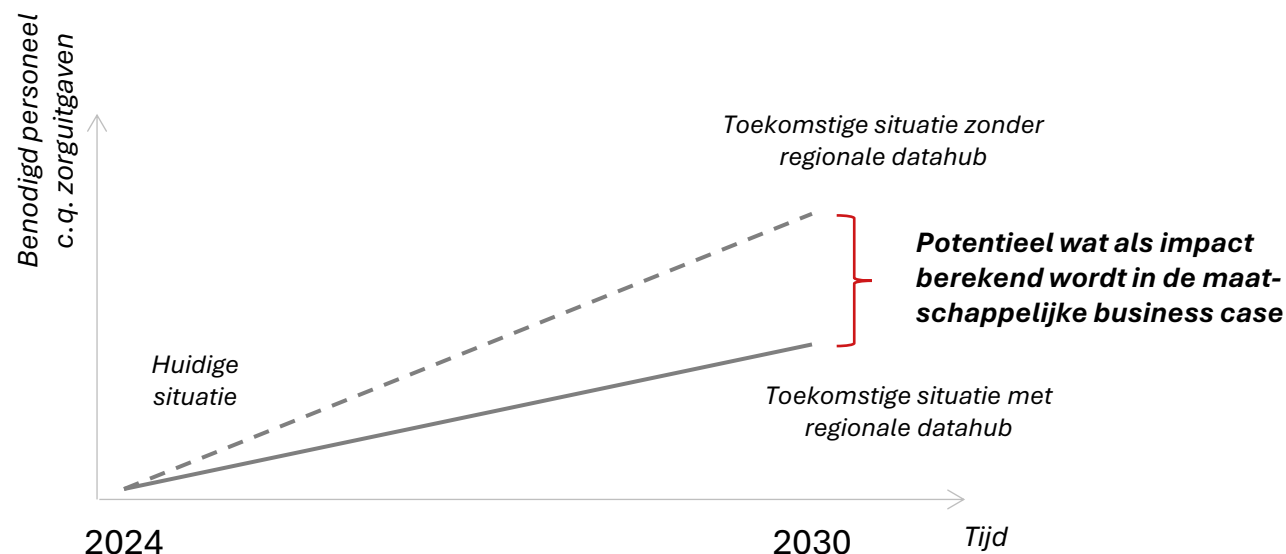
Vier uitgangspunten uit- en toegelicht¹

1 Het potentieel van de regionale datahub wordt uitgedrukt in **tijdswinst (in fte)** en **impact op zorguitgaven (€'s)**. Hierbij wordt de toekomstige situatie met regionale datahub afgezet tegen de toekomstige situatie zonder regionale datahub.

2 De tijdswinst betreft **geen fte-besparing**, maar gaat om een fictieve afbuiging om met **hetzelfde personeel meer** van de **zorgvraag** op te kunnen vangen – oftewel met hetzelfde aantal zorgverleners meer patiënten/cliënten kunnen zien.

3 Voor de doorrekening van de impact gaan we uit van een **potentieel- en investeringsberekening**. Hierbij hanteren we de **ceteris paribus** voorwaarde: 'alle overige factoren blijven gelijk'. We zetten de **toekomstige situatie met en zonder datahub** tegen elkaar af, gegeven de stijgende zorgvraag, waarbij we personele tekorten en andere limiterende factoren buiten beschouwing laten. Dit om de 'ontoegankelijkheid van zorg' en gezondheidsverlies niet te hoeven beprijzen. Het betreft dus een **fictieve doorrekening** om zoveel mogelijk **'appels met appels'** te kunnen **vergelijken**.

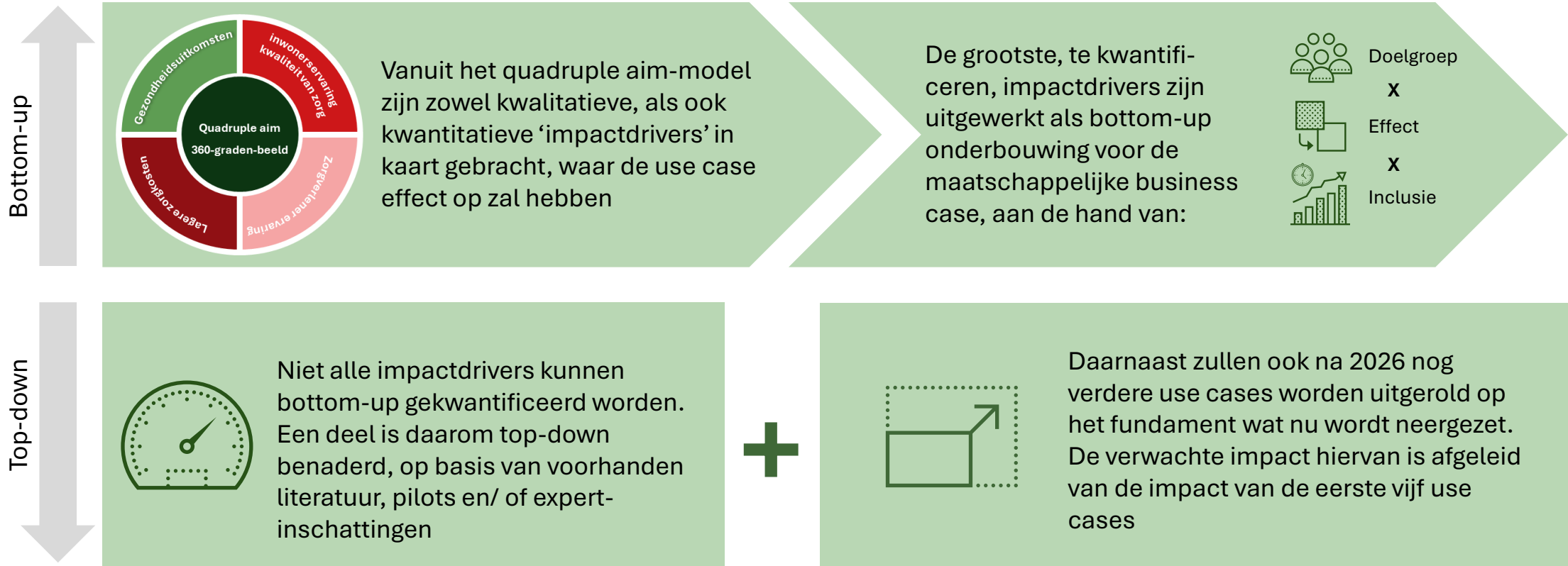
4 De hierboven beschreven **tijdswinst** (in fte) is een **uitkomst** van het verwachte effect van de use cases die onderdeel uitmaken van dit transformatieplan. Het **effectueren** hiervan dient binnen de zorgorganisaties plaats te vinden wat **niet alleen** een **digitale, maar ook** een **proces- en cultuurverandering** vergt. Deze veranderingen dienen gerealiseerd en geborgd te worden vanuit de **veranderaanpak** die ook onderdeel uitmaakt van dit transformatieplan.



1) Er zijn aanvullende uitgangspunten opgesteld met betrekking tot de maatschappelijke business case. Deze zijn te vinden in het verdiepingsdocument, Verdieping 4 Maatschappelijke business case.



6.1.3 De verwachte impact van de regionale datahub is zowel bottom-up als top-down benaderd



6.1.4 De verwachte impact op zorgkosten van de regionale datahub

Kwantitatieve impactdrivers zijn bottom-up doorgerekend, kwalitatieve impactdrivers zijn top-down benaderd

De regionale datahub buigt de verwachte jaarlijkse zorguitgaven in regio Twente af

Jaarlijkse zorguitgaven (x € miljarden)

- 1) In deze berekening is de stijging van de kwaliteit van zorg niet meegenomen in de benadering van impact
- 2) Bronnen: RIVM (% stijging zorguitgaven), Zorgcijfersdatabank (zorguitgaven)
- 3) De stijging van zorgkosten is benaderd door het RIVM en neemt hierin de volumegroei o.b.v. demografie, prevalentie en incidentie van ziekten etc. mee. Prijsontwikkelingen zijn hierin niet meegenomen (nominale groei)



6.1.4 De verwachte impact op het benodigde personeel van de regionale datahub

Kwantitatieve impactdrivers zijn bottom-up doorgerekend, kwalitatieve impactdrivers zijn top-down benaderd

De regionale datahub doet de vacaturedruk in regio Twente afnemen

Openstaande vacatures (in fte)

*In deze berekening is de stijging van de kwaliteit van zorg niet meegenomen in de benadering van impact;
**Bronnen: Overheid (aantal werkende in de zorg) ZBJ (% stijging personeelstekort), [KennispuntTwente](#) (aantal openstaande vacatures)



6.1.5 Kwantitatieve impactanalyse – ‘bottom-up’

In 2029 kunnen ca. 57 zorgprofessionals meer zorg verlenen en daarmee de stijgende zorgvraag afbuigen

Met de Digitale Regionale Zorgtransformatie middels de bouw van een regionale datahub en de realisatie van vijf use cases buigen we stijgende toekomstige zorgvraag af. Dit doen we door **meer ruimte voor de zorg** te creëren. Deze ruimte is zowel in zorgkosten als in personele inzet (fte) uit te drukken. Meer ruimte voor de zorg betekent niet dat we kunnen besparen op zorgkosten of personeel, maar geeft aan dat een deel van de toekomstige zorgvraag kan worden opgevangen.

De impact per use case kan niet afzonderlijk van de andere use cases worden benaderd. Zoals eerder duidelijk gemaakt in dit transformatieplan kennen de use cases grote afhankelijkheden van elkaar, bijv. op technisch vlak. Daarnaast versterken de use cases elkaars impact ook. Denk bijv. aan toekomstige overdrachten tussen zorgverleners waarbij zowel regionaal capaciteitsinzicht, als het 360-graden beeld ondersteunen. Deze synergie is niet doorberekend in de impactanalyse, maar is wel een realistische verwachting.

		Impact op huidig zorgpersoneel in 2029 (in fte)						Impact op zorgkosten jaarlijks vanaf 2029 (x € 1.000)							
		MSZ	VVT	Huis- artsen	Diag- nostiek	Apotheek	GGZ	Totaal	MSZ	VVT	Huis- artsen	Diag- nostiek	Apotheek	GGZ	Totaal
	360-graden beeld														
	Regionaal diagnostisch portaal														
	ACP in de keten														
	Gekoppelde thuismonito- ring ¹														
	Regionaal capaciteits- inzicht														
Totaal															

1) Voor gekoppelde thuismonitoring is er een negatieve impact op het huidige zorgpersoneel (-6,9 FTE). Dit betekent dat er extra inzet van (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en backoffice medewerkers nodig is om de thuismonitoring mogelijk te maken.

2) Voor een gedetailleerde uitsplitsing van de impact per sector, zie Verdieping 4 Maatschappelijke business case



6.1.6 Kosten tot en met 2029

Om het transformatieplan te verwezenlijken wordt een investeringsaanvraag gedaan van € 37,97 miljoen

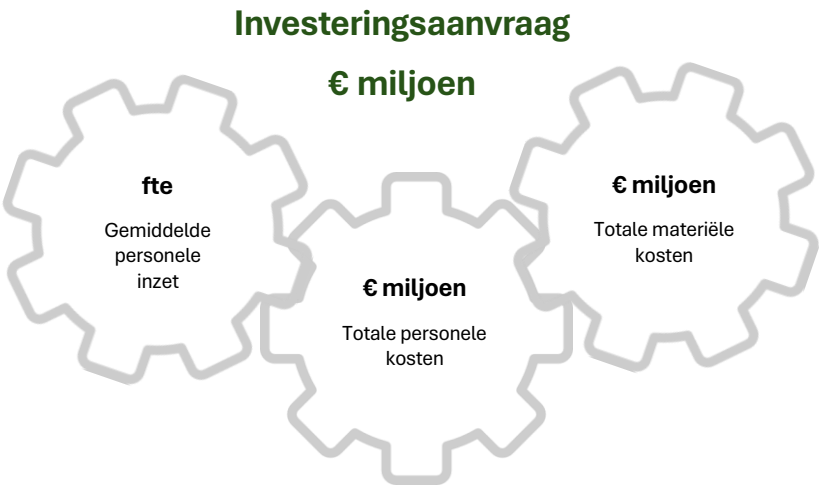
(x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Cumulatief
Frictie kosten								
Personeel								
Materieel								
Directe structurele kosten								
Personeel ²								
Materieel ³								
Totaal								

Toelichting

De incidentele personele kosten bestaan grofweg uit:

- 23% project- en programmamanagement
- 8% inzet van technische expertise
- 13% inzet van zorgexpertise
- 57% t.b.v. Zorgtransformatie

1) Betreft out-of-pocket kosten, bijvoorbeeld voor trainings- en communicatiematerialen
2) Betreft structurele personele inzet, bijvoorbeeld voor het voeren van de ACP gesprekken door de huisartsen
3) Betreft structurele materiële kosten, ten behoeve van licenties, dataopslag & -verwerking en infrastructuur & netwerk



6.1.7 Impact van de Digitale Regionale Zorgtransformatie in relatie tot de benodigde investering

Vanaf 2029 is de maatschappelijke business case positief, met een lonkend perspectief

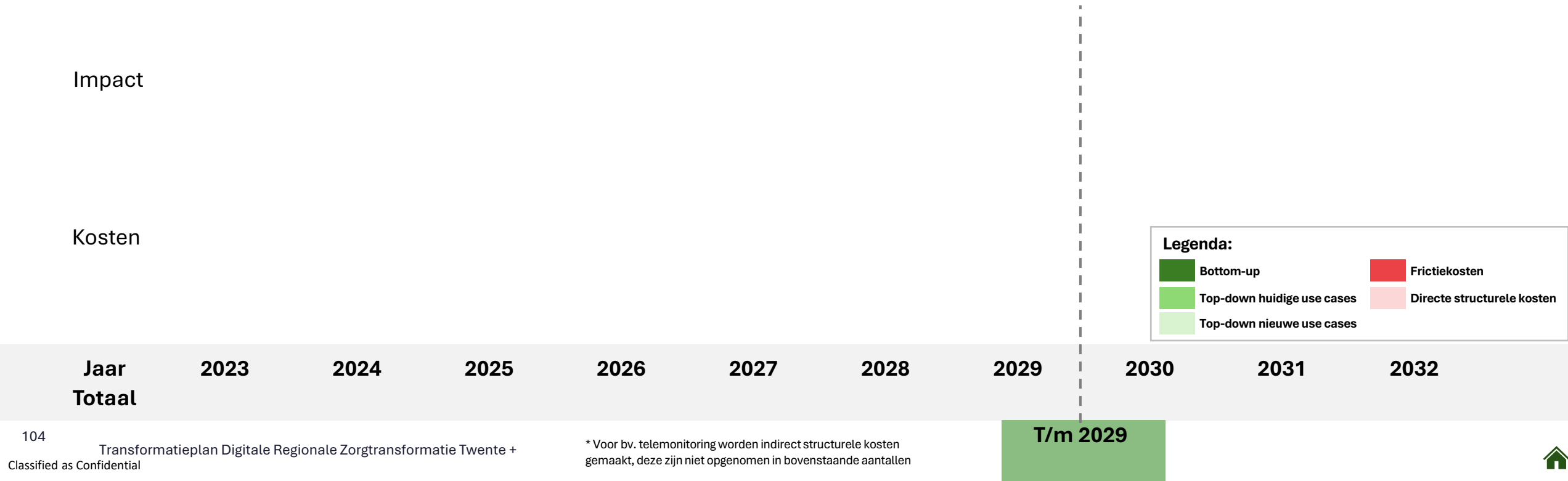
De **impact** kan worden uitgesplitst in **drie categorieën**:

- 1. Bottom-up gekwantificeerd: De impact die vanuit de impactdrivers, doelgroepen, effecten en inclusie over tijd is bepaald en doorgerekend
- 2. Top-down huidige 5 use cases: Een benadering van de impact die ook met de implementatie van de huidige 5 use cases gerealiseerd zal gaan worden, maar die niet bottom-up gekwantificeerd kon worden
- 3. Top-down nieuwe use cases: Een doorvertaling van nieuwe use cases die na 2026 uitgerold zullen worden op de regionale datahub, waarvoor de komende jaren het fundament gelegd zal worden

Ook de **kosten** kunnen in **twee categorieën** worden opgedeeld:

- 1. Frictiekosten: Deze zien op de uitwerking van processen, implementatie van technologie en adoptie & veranderaanpak in de regio – hiervoor worden IZA-middelen aangevraagd
- 2. Directe structurele kosten*: Deze zien op de kosten om de datahub in de lucht te houden, te beheren en door te ontwikkelen, zowel qua techniek als qua mensen – deze kosten worden niet meegenomen in de aangevraagde IZA-middelen

Samenvatting maatschappelijke business case (x € 1.000)



* Voor bv. telemonitoring worden indirect structurele kosten gemaakt, deze zijn niet opgenomen in bovenstaande aantallen



6.2 Duurzaamheid

6.2 Impact ten aanzien van duurzaamheid in de zorg

De datahub beperkt reisd Bewegingen en gaat verspilling tegen, maar vergroot de data opslag behoefte in de regio

De Digitale Regionale Zorgtransformatie via de datahub Twente heeft een positieve invloed op zowel het zorggebruik als het zorgpersoneel. Daarnaast draagt het ook bij aan het **verminderen van de klimaat- en milieu-impact van de zorg**. De gezamenlijke inspanningen die beschreven staan in dit plan hebben gunstige effecten op het klimaat, gericht op drie hoofdcategorieën: de inwoner, de zorgprofessional en de data.



Inwoners

- **Minder reisd Bewegingen:** door toegang tot digitale consulten en zorg op afstand, hoeven inwoners minder vaak te reizen voor zorgafspraken, wat leidt tot een vermindering van de CO₂-uitstoot
- **Minder opnames:** door het gebruik van digitale middelen zoals thuismonitoring kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gedetecteerd. Dit resulteert in minder noodsituaties en ziekenhuisopnames, wat niet alleen de druk op de zorg verlaagt maar ook de milieubelasting vermindert



Zorgaanbieders

- **Minder verspilling van geneesmiddelen en materialen:** door het optimaliseren van processen, zoals het diagnostiek aanvraagportaal, en het verbeteren van inzicht in de zorgbehoeften van de regio, kunnen zorgaanbieders efficiënter zorg verlenen. Dit resulteert in een doeltreffender gebruik van middelen en vermindert verspilling van geneesmiddelen en materialen



Data

- **Vermindering dubbele data opslag:** door data inzichtelijk te maken in de regio wordt voorkomen dat dezelfde gegevens meerdere keren worden opgeslagen. Dit bespaart opslagruimte en reduceert het benodigde energieverbruik
- **Toenemende data opslag:** de groei en verzilvering van de bevolking vereist meer opslagcapaciteit, wat resulteert in een hoger energieverbruik.



6.3 Monitoring

6.3.1 Monitoring en evaluatiemethodiek

Door monitoring op regionaal niveau kunnen effecten beoordeeld worden en kan er bijgestuurd worden als nodig

Om de implementatie van het plan succesvol te laten verlopen is tussentijdse monitoring vereist, in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars (als deelnemer in het Zorgverzekeraarsoverleg). Het doel van monitoring en evaluatie is om op **regionaal niveau** de effecten van de datahub te beoordelen, inzicht te verkrijgen om bij te kunnen sturen of verbeteren, en verantwoording af te leggen waar nodig. Regionale monitoring biedt een integraal beeld op de gezamenlijke **inspanningen** en **resultaten** (KPI's) in de regio, en de effecten hiervan, waardoor datagedreven keuzes kunnen worden gemaakt en bij kan worden gestuurd als dat nodig is.

Er zijn twee typen mijlpalen te onderscheiden waarop gemonitord kan worden: inspanningen en resultaten



Inspanningsgerichte KPI's zijn deliverables die door een succesvolle inspanning van indieners behaald worden. Deze mijlpalen zijn per werkgroep opgesteld en gekoppeld aan financiering. Het behalen van deze deliverables wordt gemonitord om de uitbetaling van het IZA mogelijk te maken. De inspanning is direct gerelateerd aan en voorwaardelijk voor het behalen van het resultaat.



Resultaatgerichte KPI's zijn SMART geformuleerd, navolgbaar en verifieerbaar, en staan proportioneel in relatie tot het gevraagde transformatiebedrag. Deze mijlpalen worden per werkgroep opgesteld en moeten dicht bij de activiteiten binnen de werkgroep liggen, niet verderop in de keten. Ook deze resultaten zijn gekoppeld aan financiering en moeten daarom worden gemonitord.

Voortgangsrapportage

Voor een effectieve monitoring van de KPI's zal elke werkgroep **per kwartaal** een voortgangsrapportage indienen bij de stuurgroep. Deze rapportages zijn essentieel voor het ondersteunen van strategische besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan verzekeraars. Door een gestandaardiseerd overzicht te bieden, geven deze rapportages inzicht in de status en voortgang van de KPI's. De kwartaalrapportages worden gebaseerd op data afkomstig van zorgpartijen in de regio Twente, aangevuld met andere relevante bronnen zoals het CBS. Dit gestructureerde en data gedreven proces zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare weergave van de prestaties, waarmee de stuurgroep goed geïnformeerde beslissingen kan nemen en transparantie naar alle stakeholders wordt gewaarborgd. Daarnaast heeft de voortgangsrapportage als bijkomend doel om te leren van wat er gedaan is, te evalueren en bij te sturen waar nodig. Daarnaast kan vanuit de beschikbare informatie in de datahub worden gemonitord op kwaliteit, (kosten)effectiviteit en doelmatigheid van zorg om hier indien nodig transparantie op te bieden richting stakeholders.

Aanpak

1. Het opstellen van de voortgangsrapportage per kwartaal, door de werkgroep projectleiders
2. Het creëren van inzicht door het samenbrengen van openbare bronnen – extern en intern – en het analyseren van deze gegevens
3. Samenvoegen van de duiding en analyse van de projectleiders naar een overzichtelijke rapportage met aandachtspunten voor de stuurgroep



6.3.2 Uitgangspunten monitoring en evaluatiemethodiek

- 1** We koppelen het uitkeren van IZA-middelen aan zowel inspannings- als resultaatgerichte mijlpalen. We bundelen de mijlpalen tot uitkeringsmomenten per kwartaal, om zo de voorfinanciering vanuit de regio te beperken. We streven naar maximaal 4 KPI's per use case.
- 2** Er wordt vanuit drie verschillende gebieden (werkgroepen) gekeken naar KPI's: implementatie (technische realisatie), proces (vanuit de use cases) en transformatie (cultuur en verandering in de regio). Voor transformatie wordt ook de uitbouw naar aanvullende use cases meegenomen.
- 3** In de eerste en tweede jaar van de looptijd worden voornamelijk inspanningsmijlpalen vastgesteld, waar mogelijk aangevuld met resultaatgerichte doelen. Het uitgangspunt is om de verhouding tussen inspanningsverplichtingen (I) en resultaatverplichtingen (R) in de loop van de tijd aan te passen. Hierbij wordt 2/3 van de investering in de vorm van inspanningsverplichtingen uitgekeerd.
- 4** Het effect voor een resultaatmijlpaal wordt gemeten op de plek waar de interventie plaatsvindt, niet verderop in de keten. Het effect in de keten wordt door veel meer beïnvloed dan waar vanuit het transformatieplan invloed op uitgeoefend kan worden. Hier is in de mijlpalen zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast wordt er een 0-meting gedaan om de huidige situatie in kaart te brengen en de effecten van de transformatie goed te kunnen meten.
- 5** Er wordt kwalitatief beredeneert wat het effect in de rest van de keten is, wanneer dit niet (causaal) kwantitatief te bepalen is.
- 6** Indien een mijlpaal behaald wordt, zal de declaratie gelijk zijn aan het opgegeven bedrag. Alleen in onderling overleg kan dit bedrag naar boven toe worden bijgesteld – waarbij alle declaraties tezamen het totale bedrag aan IZA-middelen nooit zal overschrijden. Bij het behalen van een mijlpaal en declaratie van de IZA-middelen zal een specificatie worden overlegd.
- 7** Indien mijlpalen niet volledig behaald worden, zal een percentuele proportionele korting worden doorgevoerd op de IZA-middelen die zijn gekoppeld aan deze mijlpaal. Dit geldt enkel voor de resultaatgerichte mijlpalen. Als op een later moment in de tijd de mijlpaal alsnog behaald wordt (in de looptijd van het IZA), zullen de resterende IZA-middelen worden uitgekeerd.
- 8** De monitoring van KPI's vindt sector overstijgend plaats en is gericht op de totale impact op de zorgketen, i.p.v. op prestaties van individuele zorgaanbieders. Het behalen van KPI's moet eerlijk worden toegerekend aan alle betrokken zorgaanbieders, zodat de uitkering van de IZA-middelen op gezamenlijke prestaties en impact is gebaseerd.



Hoe zijn de kosten gekoppeld aan de KPI's? Per kwartaal wordt aangevraagd wat er tot dan toe geïnvesteerd is. Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de use cases die in dat kwartaal een KPI hebben opgenomen, m.u.v. de goedkeuring van het transformatieplan en de implementatie van zorgviewer. Daarna zijn de kosten binnen de use case evenredig verdeeld over het aantal KPI's in dat kwartaal. Dit is enerzijds gedaan gezien de integraliteit en afhankelijkheid van de use cases t.o.v. elkaar en de zorgtransformatie als geheel en anderzijds om het risico per KPI te spreiden.



6.5 KPI's en gekoppelde financieringsmomenten (1/2)

Onderstaand zijn de KPI's vanuit de use cases beknopt opgenomen, een uitgebreide beschrijving is in het kernstuk van de use case terug te vinden. De resultaatgerichte KPI's zijn in het roze weergegeven, de inspanning KPI's in het zwart.

Use case	2024		2025				2026			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Algemeen										
360-graden beeld										
Regionaal diagnostisch portaal										



6.5 KPI's en gekoppelde financieringsmomenten (2/2)

Use case	2024		2025				2026			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
ACP in de keten										
Gekoppelde thuismonitoring										
Regionaal capaciteitsinzicht										
Totaal aangevraagde middelen (x 1000)										



Inhoudsopgave

0. Management samenvatting & leeswijzer

1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub

2. Use cases

3. Regionale datahub

4. Zorgtransformatie

5. Governance

6. Maatschappelijke businesscase

7. Integrale implementatieplanning

1. Implementatieplan

2. Implementatie en mijlpalenplanning

8. Risico's & mitigerende maatregelen



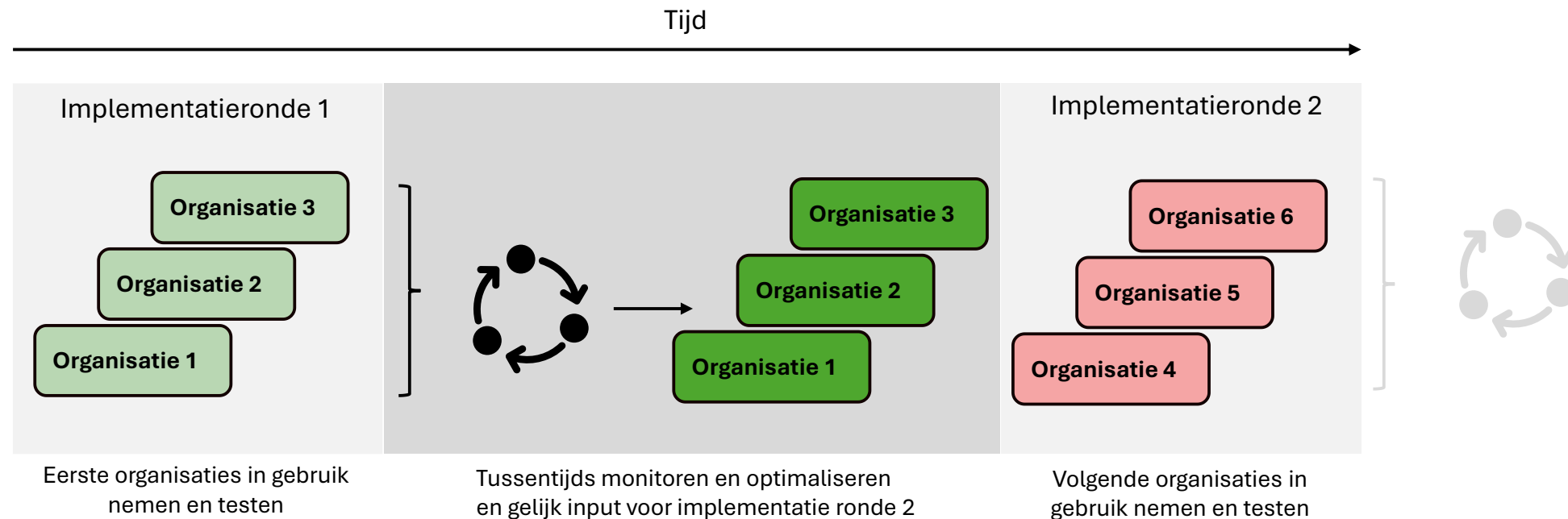
7.1 Implementatieplan

Uitgangspunten van implementatie

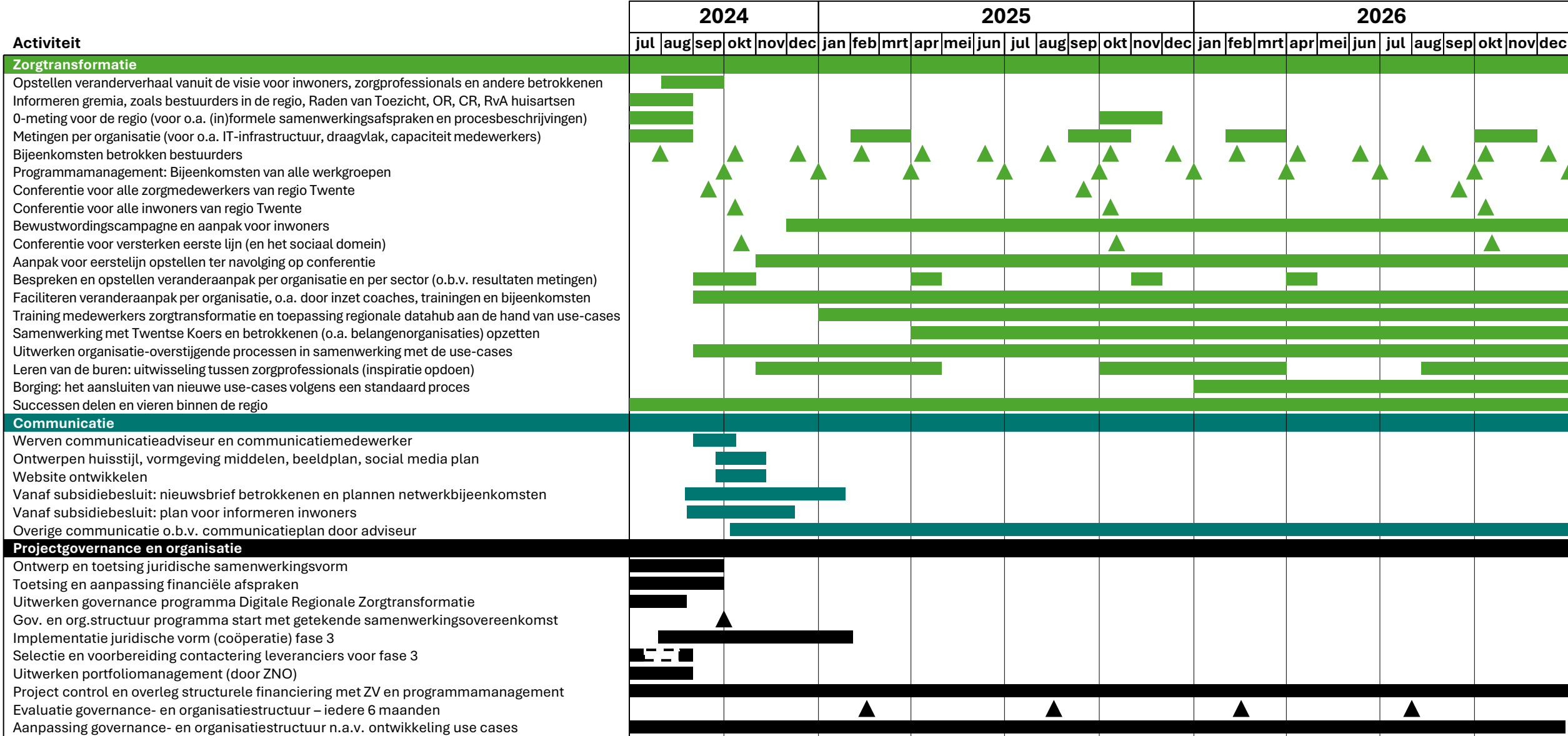
Er wordt een dakpansgewijze-implementatie methodiek gebruikt waarbij er gewerkt wordt met sprints per use case. Dit wil zeggen dat niet alles in één keer geïmplementeerd wordt, maar gefaseerd wordt opgebouwd om de implementatie behapbaar en continu te blijven verbeteren en monitoren. Op deze manier worden medewerkers meegenomen en kunnen ze wennen aan de nieuwe werkwijzen.

We organiseren de implementatie vanuit de inwoner. Dit wil zeggen dat we vanuit de inwoner beredeneren bij welke organisaties of (1^e-lijns) samenwerkingsverbanden de implementatie moet plaatsvinden.

We hanteren het principe dat niet iedereen even snel hoeft te gaan. Dit wil zeggen dat niet alle organisaties direct kunnen of willen instappen. Er moet een gezonde balans tussen draagvlak, toegevoegde waarde en vooruitgang zijn. Organisaties die direct kunnen en willen instappen starten in implementatie ronde 1 en 2. Andere organisaties sluiten later aan, bijvoorbeeld in implementatierondes 3, 4, 5 etc.



7.2 Implementatie en mijlpalenplanning (1/3)



7.2 Implementatie en mijlpalenplanning (2/3)

Activiteit	2024						2025												2026											
	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Implementatie datahub																														
Technische setup																														
Initiële setup/configuratie platform																														
Ontwerpen en bouwen van data-integratie (pipelines)																														
Architectuur bijwerken																														
Uitbreiding infrastructuur t.b.v. ondersteuning nieuwe use cases																														
Doorontwikkeling platform																														
Uitbreiding van datamodel																														
Ontwikkeling eerste use cases																														
Integratie generieke functies																														
Adoptie nieuwe standaarden en afsprakenstelsels																														
Doorontwikkeling use cases																														
Connectiviteit																														
Leveranciersmanagement																														
Aanpassingen aan bronsystemen zorginstellingen																														
Datahub governance																														
Uitwerking en implementatie datahub governance																														
De transformatie van ZNO naar regie organisatie																														
Kennismanagement																														
Uitwerken van de transformatie die nodig is bij gebruikers en aanbieders van data																														
Ontwerp / implementatie portfoliomanagement																														
Beleidsdocumenten datahub (informatiebeveiliging)																														
Onboarding processen nieuwe deelnemers / use case implementatie																														



7.2 Implementatie en mijlpalenplanning (3/3)

Activiteit	2024						2025												2026											
	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Algemene startactiviteiten voor alle use cases																														
Technische ontwikkeling platform																														
Ontwikkelen integraties met (bron)systemen																														
Inhoudelijke definities en regionale werkafspraken en zorgprocessen uitwerken																														
360-graden beeld																														
Ontwikkeling Overdracht VVT en ziekenhuizen																														
Ontwikkelen generiek kerndossier																														
Realiseren koppelingen kerndossier tussen zorginformatiesystemen																														
Verbreding uitrol overdracht overige VVT																														
Uitrol generiek kerndossier zorgaanbieders Twente																														
Advance Care Planning																														
Voorbereidingen (samenstellen WG, werkprocessen voorbereiden, etc.)																														
Ontwikkelen digitaal ACP overzicht																														
Uitrol digitaal ACP overzicht (in afstemming met generiek kerndossier)																														
Regionaal capaciteitsinzicht																														
Realisatie regionaal capaciteitsdashboard																														
Regiobrede keteninrichting																														
Opschalen uitrol regionaal capaciteitsdashboard																														
(Keten)proces optimalisatie obv inzichten vanuit dashboard																														
Gekoppelde thuismonitoring (in afstemming met Zorg bij Jou)																														
Kick-off en verkenning zorgpaden in de regio																														
Verbinden, keuzes maken en ontwerpen: definitief PvA incl. samenhang lokale programma's																														
Implementeren één zorgpad																														
Borgen en opschalen één zorgpad																														
Volgende vier zorgpaden implementeren																														
Regionaal diagnostisch portaal																														
Ontwikkeling diagnostisch regionaal portaal																														
Uitrol diagnostisch regionaal portaal eerstelijnszorg																														
Uitrol diagnostische centra																														
Uitrol tweedelijnszorg																														



Inhoudsopgave

- 0. Management samenvatting & leeswijzer
- 1. Aanleiding, visie en waarde van de regionale datahub
- 2. Use cases
- 3. Regionale datahub
- 4. Zorgtransformatie
- 5. Governance
- 6. Maatschappelijke businesscase
- 7. Integrale implementatieplanning
- 8. Risico's & mitigerende maatregelen**



8. Belangrijkste risico's¹ & mitigerende maatregelen (2/2)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Project-management	1	Onvoldoende beschikbaarheid van menscapaciteit t.b.v. het maken van nieuwe werkafspraken en de uitvoering	Hoog	Hoog	• Escaleren naar en afstemmen met stuurgroepleden • Planning vroegtijdig kenbaar maken om tijdig mensen vrij te maken om plannen uit te kunnen voeren (commitment vanuit de organisaties en contractueel vastleggen) • Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans • Er zijn out-of-pocket kosten opgenomen in de business case om in dit geval extern personeel te kunnen inschakelen
Project-management	2	Gebrek aan integraliteit en samenwerking van de use cases, waardoor niet het maximale uit de use cases gehaald kan worden	Hoog	Hoog	• Sessies organiseren met alle use cases om dit te borgen en bespreken, met name om de tijdslijnen en technische afhankelijkheden in detail met elkaar door te nemen
Project-management	3	Gebrek aan capaciteit en focus door grote hoeveelheid verschillende projecten in de regio	Hoog	Hoog	• Prioriteren binnen de regio vanuit bestuurders en/of initiatieven onder de paraplu van dit project organiseren
Project-management	4	Vertraging in de uitbetaling van IZA-transformatiegelden door het niet op tijd behalen van mijlpalen o.b.v. de KPIs	Hoog	Hoog	• Regelmatig monitoren en rapporteren op de KPIs zodat eventuele vertragingen tijdig gesignaleerd kunnen worden • Nauwe afstemming met de zorgverzekeraars over de haalbaarheid van de mijlpalen i.r.t. de realiteit van de transformatie
Governance	5	Het betrekken van een uitgebreide groep belanghebbenden, met name in het vinden van de juiste balans tussen betrokkenheid en de beschikbare tijd van zorgprofessionals voor dit programma	Hoog	Hoog	• Optie deelname aan werkgroepen óf klankbordgroep
Zorgtransformatie	6	Verandermoeheid onder betrokkenen door meerdere projecten/initiatieven tegelijkertijd of opvolgend (in de regio en/of in organisaties). Dit kan ontstaan door de voortdurende veranderingen.	Hoog	Hoog	• Prioritering en bijsturen door bestuurders noodzakelijk • In het veranderverhaal staan we nadrukkelijk stil bij de ambitie en waarom we het belangrijk vinden deze ambitie te realiseren. We sluiten daarbij zo veel als mogelijk aan op de dagelijkse praktijk. • Een team wordt ingezet om de veranderingen te helpen realiseren en te ondersteunen in de dagelijkse praktijk.



8. Belangrijkste risico's & mitigerende maatregelen (1/2)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Zorgtransformatie	7	Geen goede borging in de regio door hoge mate van externe inzet	Hoog	Hoog	- Mensen vanuit de regio inzetten als eigenaren en in werkgroepen. Externen (gefaseerd) laten uitstromen zodra mogelijk - In de veranderaanpak is op verschillende momenten voorzien dat er een goede borging van kennis en verandering plaatsvindt. Zo worden coaches ingezet om individuele organisaties te helpen en vinden diverse bijeenkomsten plaats in kader van bewustwording en zorgtransformatie
Zorgtransformatie	8	Weerstand tegen (technologische) verandering bij zorgprofessionals en inwoners	Hoog	Hoog	Bewustwording creëren over de noodzaak en kansen om zorg anders te organiseren en te coördineren. Daarnaast moeten we samen successen vieren en successen uitdragen in de regio en daarbuiten
Implementatie datahub	9	Generieke functie Toestemming (MITZ) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	(Werk-)afspraken maken mbt het vastleggen van toestemming in bronsystemen van zorgaanbieders
Implementatie datahub	10	Generieke functie Identificatie & Autorisatie voor zorgprofessionals (Dezi) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	Tijdelijke work-around ontwikkelen en implementeren (bijv SSO)
Implementatie datahub	11	Ontwikkeling Landelijk Vertrouwensstelsel gaat te langzaam	Hoog	Hoog	Ontwikkeling data- en integratiediensten in samenspraak met CumuluZ-coalitie, andere regio's, leveranciers, e.d.
Implementatie datahub	12	Kwaliteit van (gestructureerde) data is te laag door interpretatieverschillen van standaarden bij het inbouwen/doorontwikkelen van informatiestandaarden/zorginformatiebouwstenen (ZIBs) door leveranciers terwijl deze wel gekwalificeerd zijn door Nictiz	Hoog	Hoog	- Agenderen bij VWS, Nictiz, e.a. mbv voorbeelden uit de praktijk - Afspraken maken m.b.t. wijze van aggregeren data - Gezamenlijke teststrategie Nictiz, leveranciers en zorgaanbieders formuleren en uitvoeren
Implementatie datahub	13	Onvoldoende (personele) capaciteit bij functioneel beheer en ICT voor technische inrichting/koppeling tussen EPD/ECD en dashboard	Hoog	Hoog	- Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren - Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans





Verdieping en bijlage
IZA Transformatieplan
Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente +

Definitieve versie 27 juni 2024

Inhoudsopgave Verdieping en bijlage IZA transformatieplan

1. Verdieping 1 use cases

- [1.1 360-graden beeld](#)
- [1.2 Regionaal diagnostisch portaal](#)
- [1.3 ACP in de keten](#)
- [1.4 Gekoppelde thuismonitoring](#)
- [1.5 Regionaal capaciteitsinzicht](#)

2. Verdieping 2 datahub beheergovernance

- [2.1 Governance uitgangspunten voor de datahub](#)
- [2.2 Governance en organisatie van de datahub](#)

3. Verdieping 3 projectgovernance

4. Verdieping 4 Maatschappelijke business case

5. Verdieping 5 Risico's en mitigerende maatregelen

6. Bijlagen

- [A – Regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven](#)
- [B – Toelichting Buurtzorg Alliantiepartners](#)
- [C – Landelijke wet- en regelgeving m.b.t. databeschikbaarheid](#)
- [D – Visie op CumuluZ](#)
- [E – Technische uitgangspunten en doelarchitectuur](#)
- [F – Overzicht van huidige applicaties/oplossingen in de regio](#)
- [G – Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden](#)
- [H – Kosten datahub](#)
- [I – Landelijke architectuur principes](#)
- [J – Generieke functies](#)
- [K – Toelichting van gebruik generieke functies per use-case](#)
- [L – Afkortingenlijst](#)



Verdieping 1 Use cases

1. Verdieping van de use cases

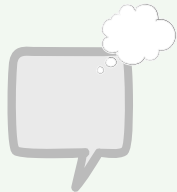
Uitgebreide beschrijving per use case in de verdieping, samenvatting opgenomen in de kern

In dit verdiepingsdocument is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van alle hoofdstukken voor de beoordeling van het transformatieplan per use case. Deze uitwerking biedt onder andere extra toelichting op de aanpak die nodig is om de ambitie te realiseren. Hoewel er is geprobeerd om consistentie te waarborgen, kunnen er variaties zijn in de informatie in dit verdiepingsdocument en de samenvattingen in het kerndocument. **Bij eventuele verschillen is de informatie in het kerndocument leidend.**

Verdieping

Uitgebreide beschrijving van de ambitie, impact, beschrijving van het nieuwe zorgproces, hierbij betrokken stakeholders, te maken afspraken en randvoorwaarden (o.a. wet- en regelgeving en richtlijnen)

Kern



Ambitie van de use case

Gebaseerd op de kernproblematiek in de regio, incl. voortbouw regionale e/o landelijke projecten/initiatieven, link met IZA-doelstellingen en mogelijkheden voor doorontwikkeling



Impact van de use case

De impact is zowel kwalitatief als kwantitatief in kaart gebracht. Met behulp van het quadruple aim-model¹ is de kwalitatieve impact bepaald. De kwantitatieve impact is benaderd o.b.v. de som van:

- **De doelgroep:** Specifieke doelgroep die beïnvloed wordt door de use case
- **Het effect:** Verschil tussen de huidige en toekomstige situatie voor die doelgroep
- **De inclusie:** Benodigde ingroeistappen over de tijd om het gewenste effect te kunnen bereiken



Transformatieplanning

Planning van de realisatie van de use case, incl. SMART-doelstellingen en KPI's om de voortgang te kunnen monitoren

De use cases zijn in verschillende werkgroepen uitgewerkt. In deze werkgroepen hebben **tientallen zorgprofessionals** vanuit verschillende sectoren, waaronder de VVT, MSZ, diagnostiek, huisartsenzorg, apotheekzorg, RSO en GGZ, zich ingezet. Zij hebben intensief samengewerkt in interviews, werk- en validatiesessies van midden maart tot midden mei om tot het transformatieplan te komen. Al met al een **indrukwekkende prestatie!**



Verdieping 1.1 360-graden beeld



1.1.1 360-graden beeld | Kernproblematiek

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt bij het verzamelen van benodigde zorginformatie van andere zorgaanbieders



Huidige situatie

In veel gevallen wordt er door zorgprofessionals van verschillende zorgaanbieders samengewerkt rondom de inwoner. Dit zijn bijv. een huisarts die hoofdbehandelaar is van een inwoner die thuis zorg van een andere zorgprofessional ontvangt, of een inwoner die eerder met ontslag naar huis kan en daar gespecialiseerde verpleegkundige zorg ontvangt. Als zorgprofessional wil je graag een zo compleet mogelijk beeld van de behandelhistorie hebben van een inwoner, zodat je optimaal zorg kunt verlenen. Als inwoner wil je erop kunnen vertrouwen dat een zorgprofessional jou de best mogelijke zorg kan verlenen, o.b.v. een compleet beeld van jouw behandelhistorie. In de huidige situatie is het niet mogelijk of tijdrovend om dit beeld compleet te krijgen. Dit zorgt voor een inefficiënt zorgproces, omdat tijd verloren gaat door het achterhalen van benodigde informatie. Veelal moet deze informatie vervolgens overgetypt worden in het eigen bronsysteem, omdat informatie niet direct hergebruikt kan worden in het eigen systeem. De zorgprofessional kan daardoor minder tijd besteden aan kern-zorgtaken. Ook kan er dubbeling van zorg of diagnostiek plaatsvinden om informatie boven water te krijgen, bijv. in spoedsituaties. Ook heeft het ontbreken van benodigde informatie gevolgen voor de kwaliteit van zorg, zoals kans op verergering van ziekte, complicaties of foutief gebruik van medicatie.



Knelpunt 1: Behandelhistorie onbekend

In de huidige situatie lopen zorgverleners er tegen aan dat ze niet weten of een inwoner belangrijke behandelhistorie heeft waar zij rekening met dienen te houden. Deze belangrijke behandelhistorie bestaat uit zowel medische, medicatie, verpleegkundige als paramedische gegevens en behandelplannen, waarin o.a. zorgplan, wondzorg, zelfzorg en de ADL-status in zijn opgenomen. Het is nu niet mogelijk om inzicht te krijgen waar en door wie eerdere zorg is verleend.



Knelpunt 2: Behandelhistorie niet toegankelijk

Los van weten of er behandelhistorie is, kunnen zorgverleners daar in de huidige situatie vaak niet gemakkelijk bij. Deze informatie is opgeslagen in systemen, ontoegankelijk voor zorgverleners die voor een andere zorgaanbieder of met een ander systeem werken. Voorbeelden van zulke systemen zijn patiënt- en cliëntdossiers en huisarts-, apothekers- of laboratorium informatiesystemen. Het ontbreekt aan één overzicht waarin deze behandelhistorie beschikbaar is.



Knelpunt 3: Alle ballen op de inwoner en/of mantelzorger

Bij het ontbreken van zicht op en inzicht in behandelhistorie is de inwoner en/of de mantelzorger de aangewezen persoon om als eerste deze informatie aan te leveren. Dit wordt bijv. gedaan middels het invullen van vragenlijsten. Inwoners moeten deze soms keer op keer invullen met veelal dezelfde informatie, wat hen onnodig lastig valt. Daarnaast is de inwoner en of mantelzorger dan de enige bron voor het geven van informatie, wat onwenselijk is gezien de mogelijk kwetsbare situatie van de inwoner.



Knelpunt 4: Inwoner mist eigen inzicht/overzicht

De inwoner heeft beperkte toegang tot de eigen (zorg-)informatie, veelal via een portaal per zorgaanbieder of eHealthtoepassing. Doordat de eigen (zorg-)informatie verspreid is over meerdere bronnen is het voor de inwoner lastig overzicht te houden. Welke informatie waar bekend is en hoe deze in samenhang te interpreteren is onduidelijk, waardoor de inwoner niet geholpen wordt bij het nemen van eigen regie, zelfmanagement of zelfzorg.



1.1.2 360-graden beeld | Ambitie

De zorgverlener ontlasten en meer tijd voor zorg geven door efficiënter en effectiever toegang tot benodigde (zorg-) informatie en hiermee de kwaliteit van zorg voor de inwoner verbeteren



Ambitie voor eind 2026 – Groot denken, klein beginnen

Eind 2026 worden **zorgprofessionals ontlast** in de samenwerking rondom een inwoner door inzicht in beschikbare, gestandaardiseerde data (zorginformatiebouwstenen= zibs) uit bronsystemen van andere zorgprofessionals, in een integraal beeld op zorgdata van de inwoner (NB conform wet- en regelgeving). Hierdoor **minimaliseert tijd** die zij besteden aan het verzamelen van informatie en hebben zij **meer tijd voor hun kerntaak “zorgen”**. De inwoner krijgt hierdoor beter passende zorg.

Deze ambitie geldt voor zorgprofessionals werkzaam in in ieder geval voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, VVT, apotheekzorg en labdiagnostische zorg.

De 360-graden-beeld op basis van gestandaardiseerde data die beschikbaar is eind 2026 bestaat uit:

- De overdracht ZKH <-> VVT op basis van de informatiestandaarden BgZ en eOverdracht
- Een generieke ‘kernset/samenvatting’ per inwoner op basis van huidige beschikbare zibs van ten minste de volgende informatiestandaarden: BgZ, BgLZ, eOverdracht, Huisartsgegevens, Labuitwisseling en Medicatieproces
- Voor de **samenwerking m.b.t. ACP** is er een gestandaardiseerde minimale dataset beschikbaar i.r.t. de betrokken zorgprofessionals/zorgorganisaties (eventueel aanvulling van de ‘kernset/ samenvatting’ per inwoner). Deze gestandaardiseerde minimale dataset is in nauwe samenhang met een ACP in de keten werkgroep samengesteld.

SMART-Doelstellingen (zie hoofdstuk 1.1.10 voor verdieping)

- In maart 2025 is zorgviewer als toepassing van het 360-graden beeld geïmplementeerd
- Eind 2026 gaan 80% van het aantal overdrachten van ZKH → VVT, VVT → ZKH via 360-graden beeld, waarbij het 360-graden beeld is geopend

Link met IZA-opgaven

- **Passende zorg**; de beschikbaarheid van relevante zorggegevens maakt het mogelijk om passende zorg te leveren aan de inwoner. Er kan zo een betere inschatting worden gemaakt van de benodigde zorg, bijv. type medicatie
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals**; de registratielast van zorgprofessionals neemt door de beschikbaarheid van relevante zorggegevens af, daarnaast hoeft de zorgprofessional minder lang te wachten tot een analoge overdracht is toegestuurd



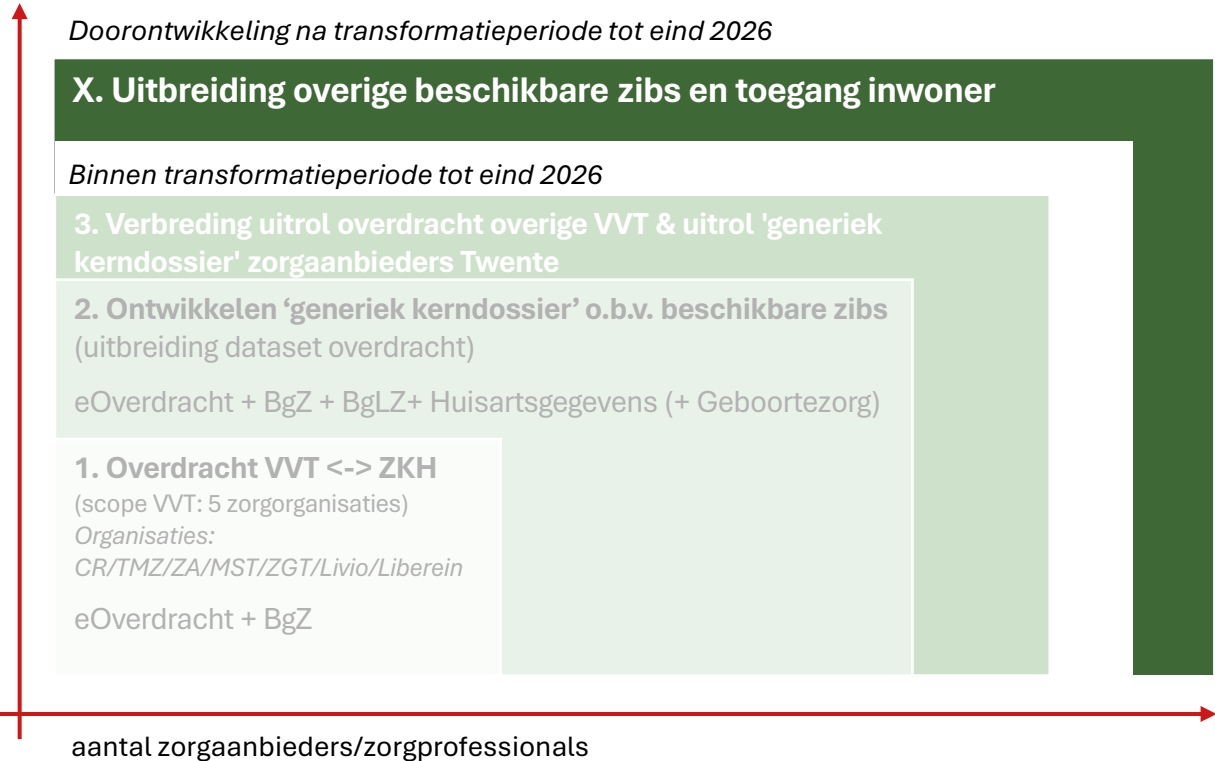
1.1.3 360-graden beeld | Doorontwikkeling

Vanuit het ontwikkelde fundament uitbreiden met overig beschikbare zibs en verbreden voor meer zorgaanbieders/zorgprofessionals



Doorontwikkeling

In het transformatieplan worden **drie fases** beschreven. Fase 1 focust op de overdracht tussen VVT en ziekenhuis, Fase 2 focust op uitbreiding van de dataset tot een generiek kerndossier o.b.v. beschikbare zibs en in Fase 3 wordt de uitrol in de regio uitgebreid. **Na de transformatieperiode start fase X:** Uitbreiding naar overige beschikbare zibs en toegang realiseren voor de inwoner. Deze fase heeft het getal X om te duiden dat er geen limiet is aan het aantal fases dat hierna wordt doorlopen. Fase X bestaat ten minste uit de volgende onderdelen: **het toevoegen van nieuwe use cases/zorgpaden en toepassing van de mogelijkheid tot (selectief) verwerken en verrijken van zorgdata.**



Doorontwikkelingen in fase X.

Toevoegen van nieuwe use cases/zorgpaden aan 360-graden beeld

Toevoegen van nieuwe use cases/zorgpaden, zoals met het ZCC aan het 360-graden beeld en de mogelijkheid tot het filteren van relevante zorginformatie op use case-basis

Mogelijkheid tot (selectief) verwerken

In lijn met de ontwikkelstappen van de NVS voegen we in de doorontwikkeling de functionaliteit (selectief) verwerken toe

Mogelijkheid tot verrijken

In lijn met de ontwikkelstappen van de NVS voegen we in de doorontwikkeling de functionaliteit verwerken toe



1.1.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Algemene beschrijving inwonersreis/gebruikersreis

Direct inzicht in actuele medische en verpleegkundige zorginformatie t.b.v. het organiseren en uitvoeren van passende (vervolg)zorg



Beoogde effecten voor zorgprofessional en inwoner

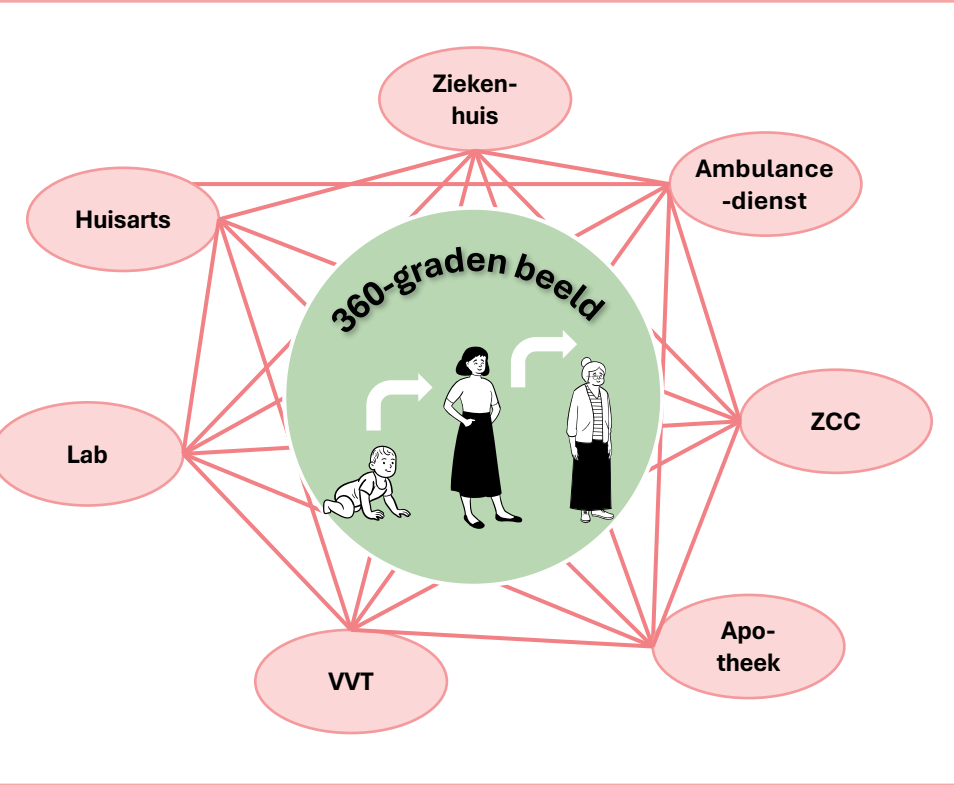
- De beschikbare (zorg)informatie over de inwoner kan sneller en effectiever verzameld worden
- Hierdoor zijn er minder afstemmomenten nodig met andere zorgprofessionals
- Hierdoor kan de inwoner eventueel sneller de juiste passende zorg geboden worden
- Wordt de kans verkleint dat cruciale informatie gemist wordt.



1.1.4 Beschrijving 360-graden beeld in de praktijk – Thuisbehandeling bij palliatieve zorgbehoefte

Direct inzicht in actuele medische en verpleegkundige zorginformatie t.b.v. het organiseren en uitvoeren van passende (vervolg)zorg

In de netwerkzorg rondom een inwoner is er niet één lineair zorgpad waarin het 360-graden beeld zowel de inwoner als zorgprofessional ondersteund in gezondheid en ziekte. Daarom kiezen we ervoor om de toepassing van het 360-graden beeld aan de hand van twee inwonersreizen toe te lichten: **thuisbehandeling bij een palliatieve zorgbehoefte** en een acute ongeplande opname. Het uitgangspunt hierbij is dat de beschikbaarheid van gegevens past binnen de toestemming van de inwoner en andere wet -en regelgeving.



Thuisbehandeling van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte

Informatie in 360-graden beeld nodig van:

- 1 Vanuit de **huisarts of het ziekenhuis** kan palliatieve zorg worden aangevraagd voor een inwoner met een palliatieve zorgbehoefte. Als deze inwoner heeft aangegeven graag thuis te willen sterven, wordt er gekeken naar passende vervolgzorg.

In het 360-graden beeld kan men zien of er ook **al verpleegzorg of persoonlijke verzorging** aan de inwoner wordt verleend. Dit moest in de oude situatie achterhaald worden door per mail, telefoon of in verschillende systemen informatie op te halen. O.b.v. het inzicht in het 360-graden beeld kan de juiste zorgaanbieder worden benaderd voor het verlenen van de palliatieve en/of andere zorg.*
- 2 Dit is bijv. het **palliatief MTH-team**. Dit team kan thuis o.b.v. het 360-graden beeld de **medische behandelhistorie, ontslagmedicatie, laatste labuitslagen en het verpleegkundig zorgplan** van de inwoner inzien en hierdoor passende zorg verlenen. Deze passende zorg betreft bijv. de juiste medicatietoediening bij pijnbestrijding of verzorging van een sonde.
- 3 Tijdens de thuisbehandeling blijft de **huisarts of de medisch specialist** in het ziekenhuis hoofdbehandelaar. De zorg die zij in deze fase verlenen, bijv. pijnbehandeling, registreren zij in hun zorginformatiesysteem (EPD/HIS). Dit is voor andere zorgverleners zoals het **palliatief MTH-team** inzichtelijk via het 360-graden beeld. Voorheen was dit niet mogelijk. Dit wordt nu ook mogelijk voor bijv. de apotheek als regisseur voor de digitale medicatie-toedienlijsten. Het palliatief MTH-team en andere betrokken zorgverleners hoeven nu geen extra contact op te nemen met de hoofdbehandelaar om toegang te krijgen tot deze informatie.
- 4 Uiteindelijk sterft de inwoner thuis. Betrokken zorgverleners hebben allen het meest actuele inzicht gehad in medische en verpleegkundige zorginformatie. Het 360-graden beeld heeft hen hierin optimaal ondersteund..

VVT

VVT

VVT/Ha/
ZKH/
Apo/Lab

Ha/ZKH

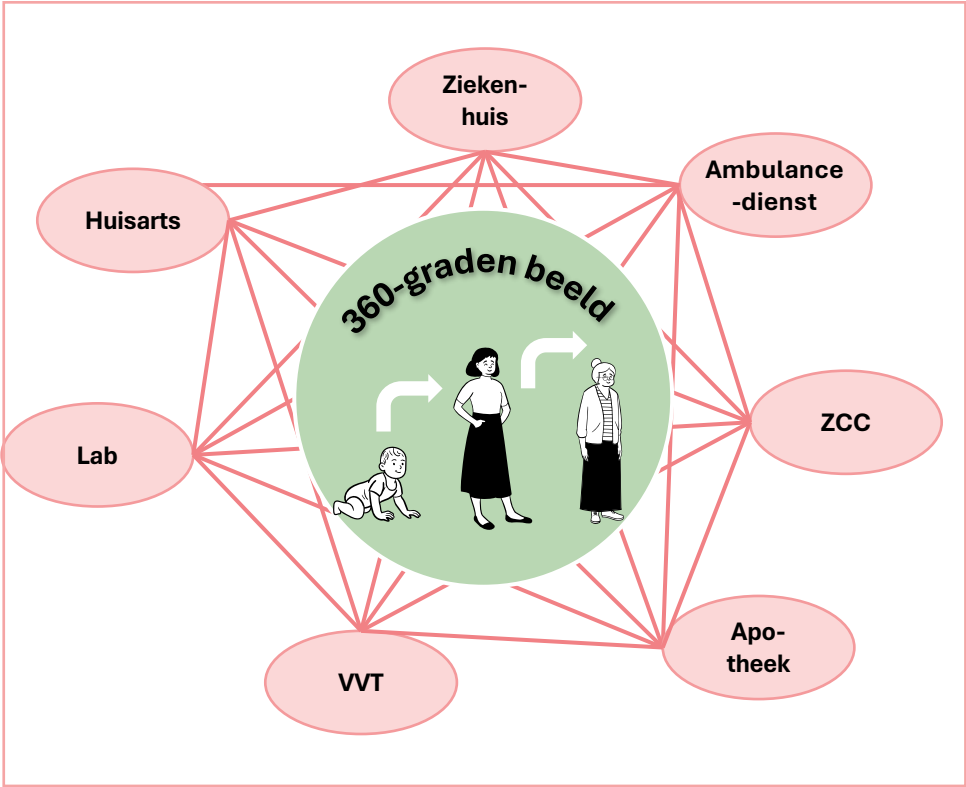
*) relatie met de use case regionaal capaciteitsinzicht



1.1.4 Beschrijving 360-graden beeld in de praktijk – Acute ongeplande opname

Direct inzicht in actuele medische en verpleegkundige zorginformatie t.b.v. het organiseren en uitvoeren van passende (vervolg)zorg

In de netwerkzorg rondom een inwoner is er niet één lineair zorgpad waarin het 360-graden beeld zowel de inwoner als zorgprofessional ondersteund in gezondheid en ziekte. Daarom kiezen we ervoor om de toepassing van het 360-graden beeld aan de hand van twee inwonerreizen toe te lichten: thuisbehandeling bij een palliatieve zorgbehoefte en **een acute ongeplande opname**. Het uitgangspunt hierbij is dat de beschikbaarheid van gegevens past binnen de toestemming van de inwoner en andere wet- en regelgeving.



Acute ongeplande opname in het ziekenhuis

Informatie in 360-graden beeld nodig van:

- 1 Vanuit de **huisarts, verpleeghuis of de thuissetting** kan een inwoner een acute zorgbehoefte hebben en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Deze acute zorgbehoefte kan overlegd worden met een zorgprofessional, bijv. bij de **huisarts, de HAP of het ZCC**, die de acute zorg coördineert. Hiervoor kan een **ambulance** ingeschakeld worden. Het ambulancepersoneel kan in het 360-graden beeld de benodigde gegevens van de inwoner inzien waardoor bijv. het toedienen van medicatie waarvoor de inwoner allergisch is, voorkomen kan worden.
- 2 In het ziekenhuis ziet de **SEH-arts en/of triageverpleegkundige** de behandelhistorie van de inwoner in het 360-graden beeld. Zo is bijv. inzichtelijk wat er door de **huisarts** met de inwoner is afgestemd voor behandelplan, wat het **verpleegkundig zorgplan** vanuit de VVT is en als de inwoner met de ambulance is vervoerd, welke **overdracht door het ambulancepersoneel** is genoteerd.
- 3 Hierdoor kan in het ziekenhuis de juiste acute zorg op het juiste moment, op basis van de juiste informatie worden verleend zonder dat cruciale informatie niet beschikbaar was.
- 4 Eventueel kan aanvullend met de hoofdbehandelaar, mantelzorger of inwoner zelf worden afgestemd, maar is dit niet per se nodig voor de primaire informatiebehoefte. Het scheelt de zorgprofessional veel tijd om m.b.v. het 360-graden beeld tot het zorgplan/de zorginterventie te komen.
- 5 De inwoner wordt passend opgenomen en het behandelplan is ook voor betrokken zorgverleners inzichtelijk in het 360-graden beeld. Na ontslag is de **in het ziekenhuis vastgelegde informatie** inclusief ontslagmedicatie¹ inzichtelijk voor de **huisarts, VVT en/of apotheek**, wat bijdraagt aan een soepele overdracht.

VVT/Ha/
ZKH/
Apo/Lab

VVT/Ha/
ZKH/Amb
/Apo/Lab

ZKH

¹) Het **onvolledig of niet tijdige inzage van ontslagmedicatie** staat in de regio op **nummer 1** op de lijst van oorzaken **externe VIM meldingen**



1.1.5 Betrokken stakeholders op organisatieniveau en hun rol in het zorgproces (1/2)

Zorgprofessionals worden in hun bestaande rol gefaciliteerd door het 360-graden beeld



Verdieping op de betrokken stakeholders

	Primaire/secun- daire stakeholder	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
Zorgprofessional- generiek	Primair	Hoog	- De zorgprofessional heeft contact met de inwoner - De zorgprofessional registreert dit contact in het eigen bronsysteem Deze zorggegevens zijn voor een andere zorgprofessional beschikbaar middels het 360-graden beeld - De zorgprofessional opent het eigen bronsysteem incl. 360-graden beeld (bijv. m.b.v. single sign-on koppeling) - De zorgprofessional kan de beschikbare informatie binnen de toestemmingsgrondslag bekijken in het 360-graden beeld	- Aan de registratiekant verandert er voor de zorgprofessional niets t.o.v. huidig proces, op voorwaarde dat de zibs goed worden gevuld en hiermee de datakwaliteit op orde is (eenheid van taal) - Aan de raadpleegkant is de benodigde informatie direct beschikbaar voor de zorgprofessional. Dit resulteert in sneller kunnen handelen en met meer informatie besluiten kunnen vormen. - Zorgprofessional kan op elk gewenst moment toegang krijgen tot zorginformatie van andere zorgorganisaties
Inwoner	Primair	Hoog	- De inwoner heeft contact met de zorgprofessional en dit wordt geregistreerd in het bronsysteem van de zorgprofessional - De inwoner heeft toestemming voor de beschikbaarheid van gegevens in het 360-graden beeld geregistreerd	De inwoner hoeft minder vaak reeds eerder verstrekte informatie nogmaals te verstrekken
Huisarts¹	Primair	Hoog	- De huisarts behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - De huisarts kan de hoofdbehandelaar zijn van de inwoner, afhankelijk van de zorgvraag - Vaak eerste aanspreekpunt voor inwoners	- De huisarts heeft de gegevens die door andere zorgverleners zijn geregistreerd in hun bronsystemen beschikbaar in het 360-graden beeld en kan hierdoor weloverwogen besluiten nemen m.b.t. behandelplan & nodige vervolgzorg - De huisarts is minder tijd kwijt aan het opvragen van informatie over bijv. de behandelhistorie van een inwoner bij andere zorgverleners
Zorgprofessional in het ziekenhuis (bijv. SEH- arts/verpleegkundige of medisch specialist)	Primair	Hoog	- De zorgprofessional behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - De medisch specialist kan de hoofdbehandelaar zijn van de inwoner, afhankelijk van de zorgvraag - De SEH-arts kan de hoofdbehandelaar zijn van de inwoner, afhankelijk van de zorgvraag	- De zorgprofessional in het ziekenhuis heeft de gegevens, die door andere zorgverleners zijn geregistreerd in hun bronsystemen, beschikbaar in het 360-graden beeld en kan hierdoor weloverwogen besluiten nemen m.b.t. behandelplan & nodige vervolgzorg - De zorgprofessional in het ziekenhuis is minder tijd kwijt aan het opvragen van informatie over bijv. de behandelhistorie van een inwoner bij andere zorgverleners
Zorgprofessional werkend bij een VVT- instelling (bijv. (wijk)verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde)	Primair	Hoog	- De zorgprofessional behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - Het verlenen van verpleegkundige zorg aan inwoners, zowel in verpleeg- en verzorgingshuizen als thuis	- De zorgprofessional in de VVT-instelling heeft medische en verpleegkundige behandelplannen geregistreerd door andere zorgverleners inzichtelijk in het 360-graden beeld en hiermee kan eventuele dubbelzorg/-diagnostiek voorkomen worden - De zorgprofessional in de VVT-instelling weet dat geregistreeerde behandelplannen inzichtelijk zijn in het 360-graden beeld

1) Mogelijke veranderingen in rol e/o taken bij de implementatie van de regionale datahub, dienen verder afgestemd en gevalideerd te worden met de huisartsen in de regio.



1.1.5 Betrokken stakeholders op organisatieniveau en hun rol in het zorgproces (2/2)

Zorgprofessionals worden in hun bestaande rol gefaciliteerd door het 360-graden beeld



Verdieping op de betrokken stakeholders

	Primaire/secundaire stakeholder	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
Zorgondersteunend personeel <i>bijvoorbeeld: afdelingssecretaresse</i>	Secundair	Hoog	Zorgondersteunend personeel houdt zich o.a. bezig met het verzamelen van zorginformatie van andere zorgorganisaties zodat zorgprofessionals ontlast worden en kan nu veel gericht op zoek naar nog ontbrekende zorginformatie die niet zichtbaar is in het 360-graden-beeld	De rol van zorgondersteunend personeel, zoals bijv. zorgadministratief personeel of de poli-assistent, zal drastisch veranderen. Het verzamelen van zorginformatie zal veel minder tijd in beslag gaan nemen..
Zorgprofessional in laboratorium	Secundair	Midden	- De zorgprofessional in het laboratorium behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - Uitvoeren van diagnostische onderzoeken	- De zorgprofessional in het laboratorium heeft de gegevens die door andere zorgverleners zijn geregistreerd in hun bronsystemen beschikbaar in het 360-graden beeld en kan hierdoor weloverwogen besluiten nemen m.b.t. labuitslagen - De zorgprofessional is minder tijd kwijt aan het opvragen van informatie over bijv. de behandelhistorie van een inwoner bij andere zorgverleners en aan het reageren op informatieverzoeken vanuit andere zorgprofessionals
Zorgprofessional werkzaam bij een apotheek (bijv. apothekersassistent)	Primair	Midden	- De zorgprofessional behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - Het verlenen van farmaceutische zorg aan inwoners, zowel in verpleeg- en verzorgingshuizen als thuis	De apotheek heeft de gegevens die door andere zorgverleners zijn geregistreerd in hun bronsystemen beschikbaar in het 360-graden beeld en kan hierdoor weloverwogen besluiten nemen bijv. m.b.t. medicatiebewaking
Zorgprofessional in het ZCC	Primair	Hoog	Triageren en coördineren van acute zorgsituaties ondersteund door beschikbare zorginformatie in het 360-graden beeld	De regiearts en ZCC-triagist hebben op dit moment niet het 360-graden beeld tot hun beschikking en triëren o.b.v. overgedragen informatie door andere zorgprofessionals
Ambulancepersoneel <i>(NB niet in eerste scope)</i>	Primair	Hoog	- Het ambulancepersoneel behoudt dezelfde rol in het nieuwe zorgproces als voorheen - Het verlenen van spoedzorg in acute situaties	- Het ambulancepersoneel kan o.b.v. beschikbare informatie sneller en weloverwogen handelen in acute situaties - Overdrachten van het ambulancepersoneel worden ook in het 360-graden beeld inzichtelijk voor andere zorgverleners
Leverancier bronsysteem	Secundair	Hoog	Voldoen aan de benodigde functionaliteiten m.b.t. de gestructureerd documenteren en ontwikkelen API's t.b.v. gestandaardiseerd data uitwisselen om databeschikbaarheid in het 360-graden beeld mogelijk te maken	Onderdeel zijn van de zorg- en digitale transformatie als ontwikkelpartner
Zorgnetoost	Secundair	Laag	Regieorganisatie van de regionale datahub inclusief de dienst 360-graden beeld	Zorgnetoost moet transformeren naar deze nieuwe rol (NB Wordt elders in het transformatieplan beschreven)



1.1.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Organisatie- en regiobeleid

Landelijke wet- en regelgeving m.b.t. databeschikbaarheid is het uitgangspunt en aanvullend kunnen regionale werk- en zorgprocesafspraken gemaakt worden

Wet- en regelgeving & beleid

- AVG
- UAVG
- Dataproductieverdrag
- Wegiz
- Wabvpz
- WDO
- EHDS
- Wet BIG
- WGBO
- WKKGZ
- WBO
- WMO
- WOGS
- DIAZ (wetsvoorstel)

- Gedurende de transformatieperiode zullen met name de gegevensuitwisselingen die binnen de Wegiz verplicht gaan worden invloed kunnen hebben op de opschaling en verbreding van het gebruik van het 360-graden-beeld. Daarnaast zal naar verwachting het delen van gegevens in een acute situatie wettelijk geregeld gaan worden binnen de WOGS

Regionale afspraken

- Afhankelijk van de snelheid van het beschikbaar komen van generieke voorzieningen m.b.t. identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemming, adressering, lokalisatie, e.d. zal dit geregeld moeten worden in een samenwerkingsovereenkomst
- Huidige werkafspraken m.b.t. aanvraag nazorg overdracht zullen herijkt moeten worden in relatie tot het 360-graden-beeld

- Zolang de WOGS nog niet is goedgekeurd, zullen aanvullende afspraken gemaakt moeten worden m.b.t. het uitwisselen van gegevens in een spoedsituatie
- Zolang MITZ nog niet breed beschikbaar is, zullen aanvullende afspraken gemaakt moeten worden over het registreren van toestemming voor gegevensuitwisseling

Richtlijnen

Naast landelijke wet- en regelgeving zullen processen zoveel als mogelijk worden geharmoniseerd/geüniformeerd conform procesafspraken in informatiestandaarden en andere landelijke afspraken/protocollen/e.d.

- Uitgangspunt is ‘standaardisatie, tenzij’

Randvoorwaarde



1.1.7 Randvoorwaarden nieuwe werkwijze



Randvoorwaarden



Randvoorwaarde aan de techniek

- Bronsystemen kunnen zorginformatie en ontsluiten o.b.v. (inter-)nationale standaarden zoals o.a. verplicht gesteld binnen de VIPP-programma's InZicht, OPEN, VIPP5 en BabyConnect
- De zorgprofessional heeft toegang vanuit het eigen bronsysteem tot het 360-graden-beeld
- Data kan geaggregeerd en gefilterd worden waarbij de bron en datering van de getoonde zorgdata altijd inzichtelijk blijft
- Zodra generieke voorzieningen beschikbaar komen, zullen deze worden toegepast
- Gegevens moeten geautomatiseerd worden ontsloten zonder menselijke tussenkomst, o.b.v. de toestemmingsregistratie door de inwoner



Randvoorwaarde aan het proces

- Geen additionele randvoorwaarden



Randvoorwaarde aan de mens

- Bij het documenteren in het eigen bronsysteem dient de zorgprofessional zich er van bewust te zijn c.q. zich te vergewissen dat data ook voor andere zorgprofessionals als ook de inwoner bruikbaar moet kunnen zijn
- Op de juiste manier, met eenheid van taal (bijv. Snomed) , data documenteren zodat zibs goed gevuld worden



1.1.8 Impactanalyse 360-graden beeld

Verzamelen van benodigde (zorg)informatie kost minder tijd en kans op ontbreken informatie neemt af

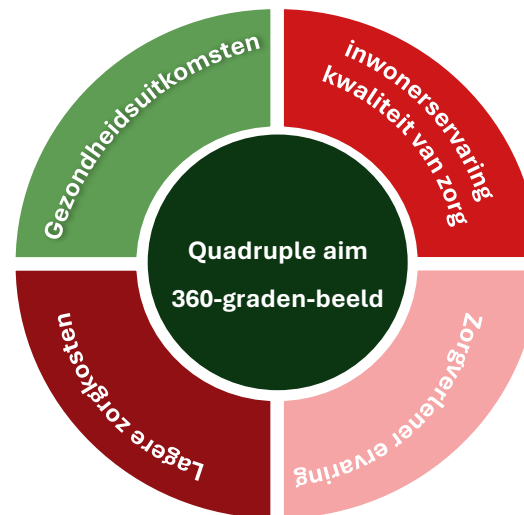
Het 360-graden beeld verbetert de ervaring van inwoners in kwaliteit van zorg omdat benodigde zorginformatie direct inzichtelijk is voor zorgprofessionals. Daarnaast verbetert de tevredenheid van de zorgprofessional, omdat zij minder tijd kwijt zijn aan het verzamelen van deze gegevens en gerichter met andere zorgprofessionals kunnen samenwerken. Dit leidt tot een verbetering van en meer ruimte voor de zorg in de regio Twente.

Betere uitkomsten van zorg

- Juiste zorg op de juiste plek vanwege tijdig de juiste informatie
- Passende zorg vanwege inzicht in samenvatting zorggegevens van een inwoner
- Doorstroom en continuïteit van zorg versneld door eerder beschikken over benodigde informatie

Lagere zorgkosten

- Minder over- en onderbehandeling, (her-)opnames en incidenten gerelateerd aan het niet tijdig beschikbaar hebben van zorginformatie (bijv. m.b.t. medicatie en allergieën)
- Kostenbesparing per inwoner door doelmatige behandeling
- Voorkomen van dubbelingen in zorg
- Meer tijd voor zorg door vermindering administratiezorglast per inwoner, met de kanttekening dat bij viewen alleen er nog steeds informatie door verpleegkundigen verwerkt moet worden in eigen systeem



Betere inwonerservaring kwaliteit van zorg

- Minder herhaling van vragen van zorgverleners gedurende inwonersreis en -situatie
- Meer vertrouwen in zorg omdat reeds eerder verstrekte informatie bekend is bij zorgprofessional
- Minder belasting van de inwoner door snellere en doelmatige behandeling van en anticipatie op (acute) zorgvraag
- Beter inzicht in eigen ziekte en gezondheid m.b.v. het 360-graden-beeld en hierdoor ook vertrouwen bij naasten en mantelzorg
- Beter in staat tot zelfmanagement m.b.v. 360-graden-beeld

Zorgprofessionaltevredenheid

- Minder tijd kwijt aan het verzamelen, registreren en verifiëren van benodigde informatie bij anamnese, triage en/of evaluatie behandel-/zorgplan, geldt zowel voor zorgverleners als zorgadministratief personeel (bijv. regelen nazorg kan afgehandeld worden door transferbureau zonder tijdsbeslag op afdelingsverpleegkundige)
- Met meer beschikbare c.q. completere informatie besluiten voor zorginterventies/behandelplannen kunnen nemen en hierdoor beter de inwoner kunnen helpen
- Effectievere samenwerking tussen zorgprofessionals mogelijk door beschikbaarheid informatie in 360-graden beeld
- Minder administratieve last draagt bij aan werkplezier en werkdruk



1.1.8 Impact analyse

Verzamelen van benodigde (zorg)informatie kost minder tijd en kans op ontbreken informatie neemt af



Kwantitatieve impact

Zie voor een beschrijving en onderbouwing van de kwantitatieve impactanalyse hoofdstuk 1.1.8 in de Verdieping

	ZKH				VVT				Apotheek- zorg		GGZ	Huisartsen
Doelgroep	Overdrachten van ziekenhuis naar VVT		Overdrachten van VVT naar ziekenhuis		#1 ^e Poli-consulten	Overdrachten van VVT naar ziekenhuis		Overdrachten van ziekenhuis naar VVT		# Ontslagen met medicatie	N.t.b.	#1 ^e gesprekken
% van de doelgroep	100%	30%	100%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	80%	N.t.b.	100%
Effect van 360-graden beeld voor de doelgroep ¹	7 min. reductie informatie verzamelen	5 min. reductie minder verificatie-bellen	15 min. reductie overnemen en interpreteren	10 min. reductie minder nabellen	1 min. reductie informatie verzamelen voor anamnese	7 min. reductie informatie verzamelen	5 min. reductie minder verificatie-bellen	15 min. reductie overnemen en interpreteren	10 min. reductie minder nabellen	4 min. reductie in verzamelen van informatie	N.t.b.	1 min. reductie informatie verzamelen voor anamnese
Inclusie	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.t.b.	0%
	2025	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	N.t.b.	40%
	2026	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	N.t.b.	80%
Zorgkosten ² (Z) of FTE												
Impact 2024 ²												
Impact 2025 ²												
Impact 2026 ²												
Cum. impact t/m 2026 ²												

1) Gebaseerd op de maatschappelijke kosten-baten analyse verpleegkundige overdracht (Verkennde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Verpleegkundige overdracht | Rapport | Gegevensuitwisseling in de zorg) en waar passend aangepast o.b.v. meningen van experts

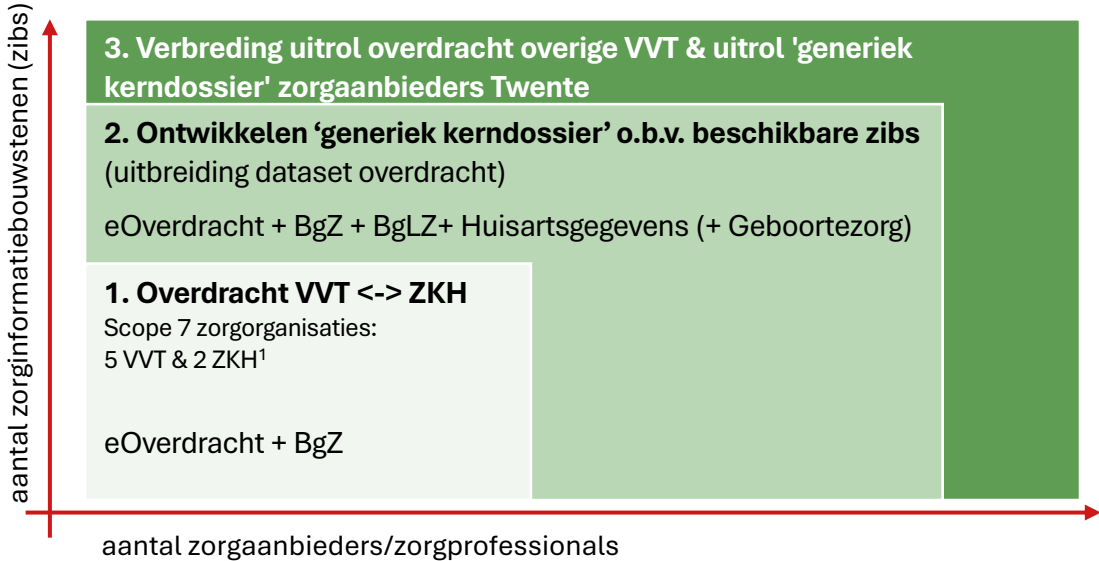
2) x € 1.000

1.1.9 Maatschappelijke business case | Het 360-graden beeld wordt in drie plateaus ontwikkeld en geïmplementeerd

In parallel en over de tijd schaalt het 360-graden beeld op

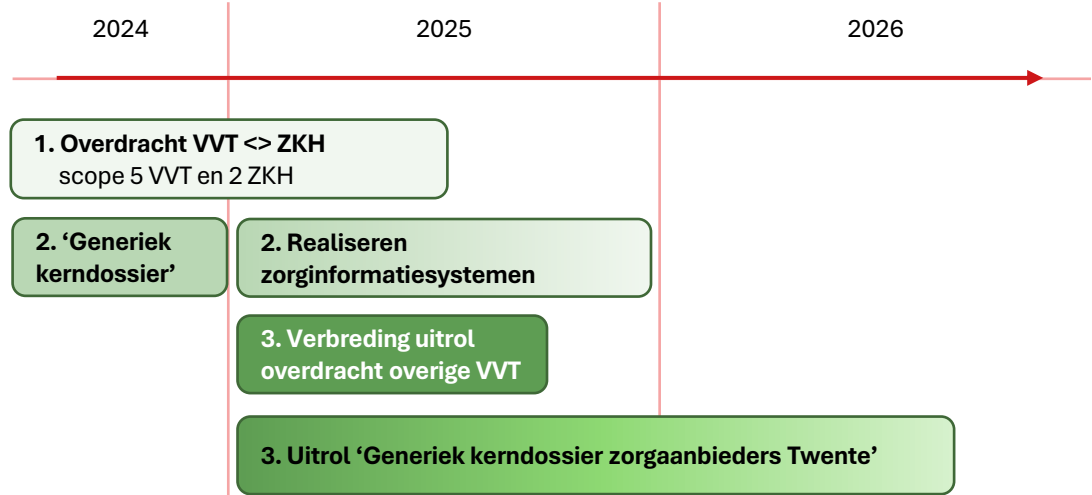
Het 360-graden wordt tijdens de transformatieperiode tot eind 2026 in **drie plateaus** ontwikkeld en geïmplementeerd. Plateau 1 focust op de overdracht tussen VVT en ziekenhuis, plateau 2 focust op uitbreiding van de dataset tot een generiek kerndossier o.b.v. beschikbare zibs en uitbreiding naar meer zorgaanbieders en in plateau 3 wordt de uitrol in de regio uitgebreid. Door de aanpak in drie fases kan het aantal zorgaanbieders / zorgprofessionals dat werkt met de toepassing en het aantal zorginformatiebouwstenen dat beschikbaar is in het 360-graden beeld gebalanceerd worden opgeschaald

Globaal overzicht van de focus per plateau



De drie plateaus zijn in parallel en volgordelijk over de tijd uitgezet. In 2024 starten plateau 1 en 2. De reden hiervoor is de beschikbaarheid van zorginformatiebouwstenen voor het generiek kerndossier in een groot aantal applicaties. Als onderdeel van plateau 2 worden in 2025 de koppelingen tussen de zorginformatiesystemen gerealiseerd. Dit is van belang voor de regiobrede uitrol van plateau 3, die gelijktijdig start. In plateau 3 worden de overdracht tussen VVT en ziekenhuizen en het “Generiek kerndossier” die in plateaus 1 en 2 zijn ontwikkeld regiobreed uitgerold.

Plateauplanning van de fases/deelprojecten

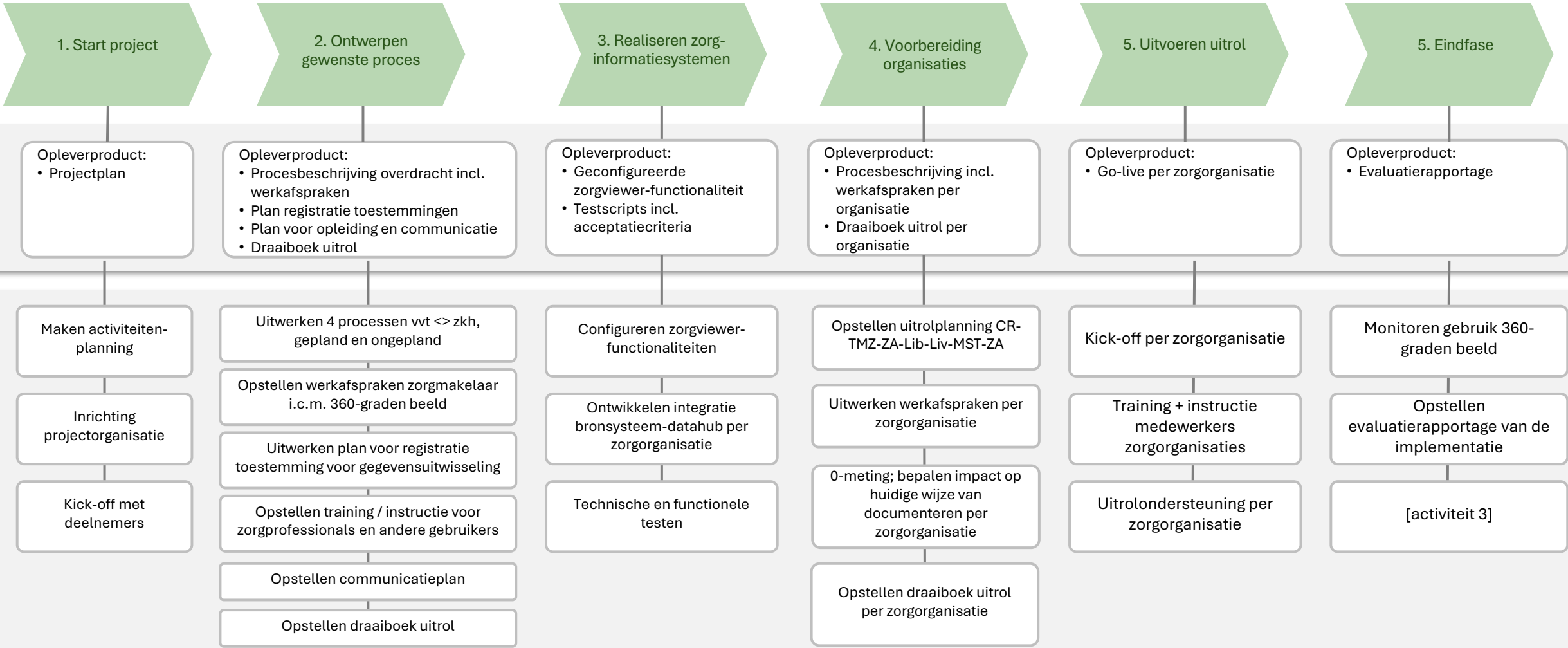


*) dit zijn de VVT-organisaties CarintReggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, Livio en Liberein en ziekenhuizen Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente



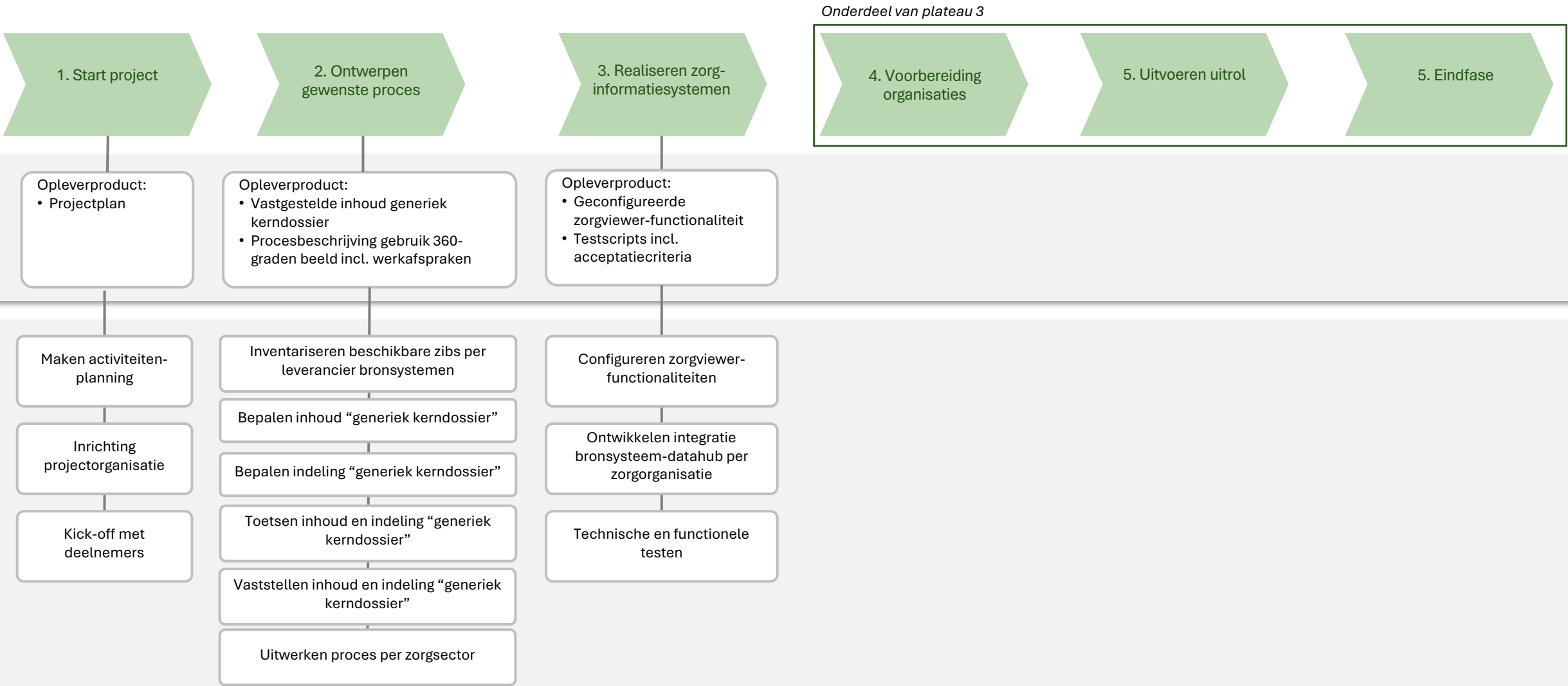
1.1.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak plateau 1 – Overdracht VVT <> ZKH – scope klein

Van procesuitwerking van overdrachten vanuit ziekenhuis naar VVT en vice versa tot kick-offs per zorgorganisatie



1.1.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak plateau 2 – “Generiek kerndossier”

Van bepaling inhoud “generiek kerndossier” tot uitrol per zorgorganisatie

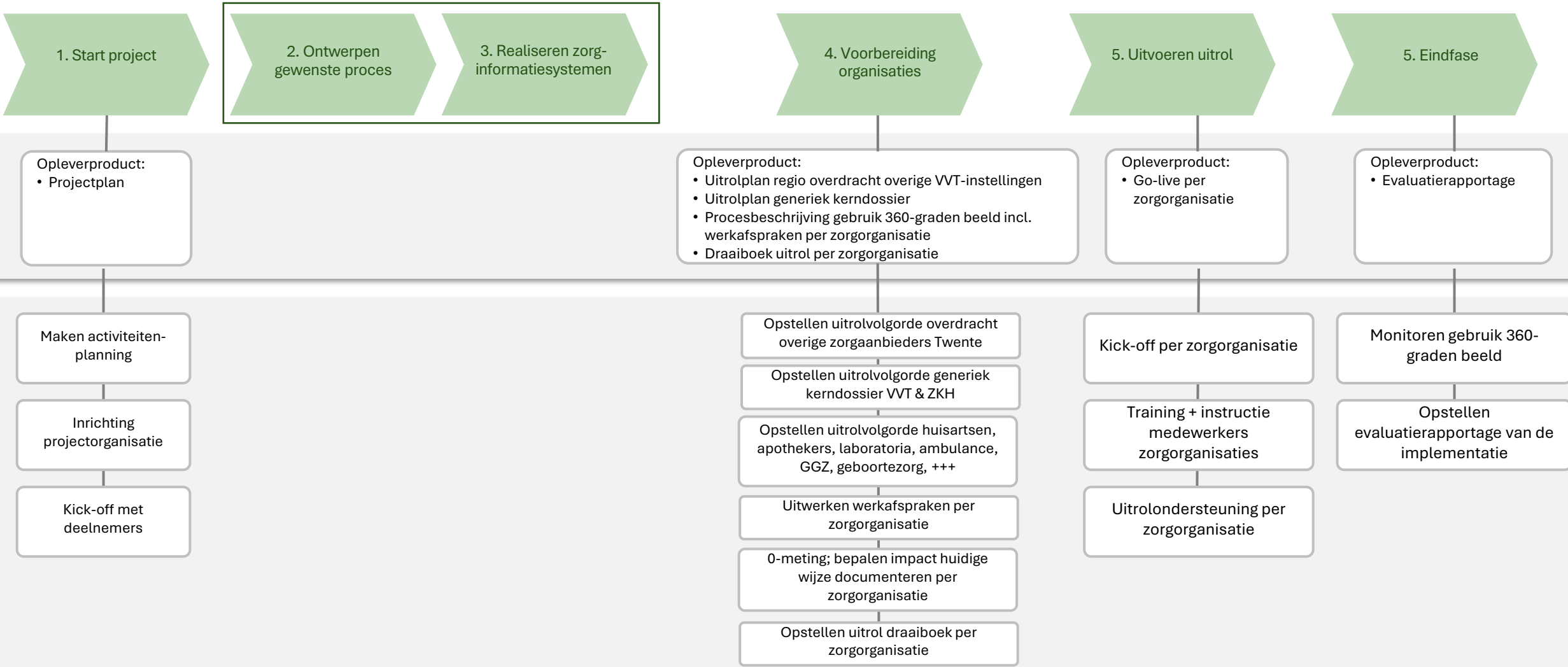


1.1.9 Maatschappelijke business case | Plateau 3 – Verbreding uitrol zorgaanbieders Twente

Uitgewerkte processen van plateau 1 en 2 uitrollen naar overige zorgaanbieders in de regio

Al gedaan in plateaus 1 en 2

Plateau 3: uitrol overdracht overige VVT-instellingen en uitrol generiek kerndossier



1.1.9 Maatschappelijke business case | Projectplanning & resourceallocatie

Gemiddelde personele inzet per jaar (FTE)			
Rollen	2024	2025	2026
Projectmanager			
PMO			
Arts			
(Gesp.) verpleegkundige			
Zorgmanager			
Projectleider			
Sponsor			
Totaal aantal (FTE)			
Totaal percentage extern (%)			

Legenda:

Intern

Extern

Intern/Extern



1.1.10 SMART-doelstellingen & KPIs

Door toestemming van de inwoner en gebruik van het 360-graden beeld door zorgprofessionals onze doelen behalen

 Transformatieplanning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Overdracht VVT naar ziekenhuis (5 VVT en 2 ziekenhuizen)	I		December Oplevering fase 1 - Procesbeschrijving overdracht incl. regionale werkafspraken - PvA registratie toestemming inwoners gegevens-uitwisseling	Maart Oplevering fase 2 - Realisatie integratie bronsystemen met datahub - Draaiboek uitrol overdracht per zorgorganisatie	Juni Oplevering fase 3 Go-live	September Oplevering fase 4 Evaluatie-rapportage implementatie 360-graden-beeld tbv overdracht					
Deelproject 2 – ‘Generiek kerndossier’: ontwerp en voorbereiden zorginformatiesystemen	I		December Oplevering fase 1 Procesbeschrijving gebruik 360-gr-beeld incl. regionale werkafspraken		Juni Oplevering fase 2 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 7 zorginstellingen	September Oplevering fase 3 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen	December Oplevering fase 4 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen	Maart Oplevering fase 5 Realisatie integratie bronsystemen met datahub; 3 zorginstellingen			
Deelproject 3 – Uitrol: overdracht (3x VVT) en ‘generiek kerndossier’	I				Juni Oplevering fase 1 Draaiboek uitrol overdracht per zorgorganisatie (3x)	September Oplevering fase 2 - Go-live overdracht (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	December Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	Maart Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	Juni Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (3x)	September Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (3x) - Draaiboek uitrol generiek kerndossier per zorgorganisatie (4x)	December Oplevering fase 3 - Go-live generiek kerndossier (4x) - Evaluatierapportage implementatie generiek kerndossier
Percentage van het aantal overdrachten van ZKH -> VVT, VVT -> ZKH waarbij het 360-graden-beeld is geopend	R						September +40% in MSZ en VVT	December +50% in MSZ en VVT	Maart +60% in MSZ en VVT	Juni +70% in MSZ en VVT	September +80% in MSZ en VVT
Implementatie Zorgviewer	R			Maart Oplevering fase 2 Implementatie Zorgviewer							



1.1.11 Risico-analyse & mitigerende maatregelen

Scope	Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Algemeen	Generieke functie Toestemming (MITZ) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	• (Werk-)afspraken maken m.b.t. het vastleggen van toestemming in bronsystemen van zorgaanbieders
Algemeen	Generieke functie Identificatie & Autorisatie voor zorgprofessionals (Dezi) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	• Tijdelijke work-around ontwikkelen en implementeren (bijv SSO)
Algemeen	Ontwikkeling Landelijk Vertrouwensstelsel gaat te langzaam	Hoog	Hoog	• Ontwikkeling data- en integratiediensten in samenspraak met CumuluZ-coalitie, andere regio's, leveranciers, e.d.
Algemeen	Kwaliteit van (gestructureerde) data is te laag door interpretatieverschillen van standaarden bij het inbouwen/doorontwikkelen van informatiestandaarden/zorginformatiebouwstenen (zibs) door leveranciers terwijl deze wel gekwalificeerd zijn door Nictiz	Hoog	Hoog	• Agenderen bij VWS, Nictiz, e.a. m.b.v. voorbeelden uit de praktijk • Afspraken maken m.b.t. wijze van aggregeren data • Gezamenlijke teststrategie Nictiz, leveranciers en zorgaanbieders formuleren en uitvoeren
Algemeen	Kwaliteit van data door de veranderde/gestandaardiseerde/gestructureerde wijze van documenteren door zorgprofessionals is onvoldoende	Gemiddeld	Hoog	• Ontwikkelen adoptieplan, trainingsplan, communicatieplan en meet-/monitoringsplan • Begeleiding bij ingebruikname
Algemeen	Benodigde medewerkers zijn onvoldoende beschikbaar	Gemiddeld	Hoog	• Escaleren naar en afstemmen met stuurgroepleden
Algemeen	Projectportfolio's zorgaanbieders zijn onvoldoende gelijkgericht	Gemiddeld	Gemiddeld	• Afspraken maken op stuurgroep-/bestuurlijk niveau m.b.t. prioriteit regionale projecten in relatie tot organisatie specifieke projecten
Algemeen	Tempo implementatie te laag waardoor de verwachte baten niet of te laat behaald kunnen worden	Gemiddeld	Gemiddeld	• Afspraken maken op stuurgroep-/bestuurlijk niveau met zorgverzekeraars
Algemeen	Leveranciers werken onvoldoende mee c.q. geven prioriteit aan eigen roadmap (bijv. m.b.t. het verwerken van zibs)	Gemiddeld	Hoog	• Hanteren landelijke afspraken, standaarden en wetgeving • In afstemming/samenspraak (door)ontwikkelen met andere regio's/zorgorganisaties, koepels, VWS, e.d.
Algemeen	Onvoldoende draagvlak bij gebruikers (zorgprofessionals, inwoners, e.d.) om te werken met de geboden oplossingen	Gemiddeld	Hoog	• Ontwikkelen altijd in samenspraak met gebruikers • Ontwikkelen adoptieplan



Verdieping 1.2 Regionaal diagnostisch portaal





1.2.1 Regionaal Diagnostisch Portaal | Kernproblematiek

Het gebruik van meerdere portalen voor diagnostiekaanvragen en een gebrek aan overzicht van uitgevoerd onderzoek resulteren in een inefficiënte werkwijze en dubbeldiagnostiek. Het geheel voldoet niet aan de stelling “zinnige en zuinige zorg”



Huidige situatie

Bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek werken zorgprofessionals in de 1^e en 2^e lijns zorg momenteel met meerdere, door diagnostiekaanbieders beschikbaar gestelde, portalen. Deze systemen staan niet in verbinding met elkaar, waardoor resultaten alleen worden gedeeld met de aanvragende zorgprofessional en niet met andere betrokken zorgprofessionals. Dit gebrek aan integratie leidt tot een versnipperd inzicht in patiëntgegevens. De afzonderlijke aanvraagprocedures voor verschillende types laboratoriumtests, zoals klinische chemie en microbiologie, vergroten de complexiteit en tijd die nodig is voor het verwerken van meerdere orders voor één inwoner. Hierdoor ontbreekt een totaal overzicht van uitgevoerde onderzoeken met bijbehorende resultaten, wat essentieel is voor een effectieve patiëntenzorg. Gebruikte portalen zijn o.a.: LabOnline, ZorgDomein, Cyberlab, HiX (EPD) en overige EPD's



Knelpunt 1: Inefficiëntie aanvraagprocedures

zorgprofessionals moeten omslachtig voor elke diagnostische test bij verschillende laboratoria aparte aanvragen doen via diverse portalen, wat het aanvraagproces inefficiënt maakt.

Bijv.: aparte aanvragen in portaal klinisch chemisch lab en microbiologisch lab



Knelpunt 2: Gebrek aan overzicht aanvragen

Het gebruik van diverse portalen van diagnostiekaanbieders leidt tot onoverzichtelijkheid in diagnostiekaanvragen, waarbij een samenhangend overzicht van alle, inclusief eerder door andere zorgprofessionals aangevraagde, onderzoeken ontbreekt.



Knelpunt 3: Gebrek aan diagnostiek uitwisseling

Het gebrek aan uitwisseling van diagnostische resultaten en het ontbreken van volledig zicht op uitgevoerde onderzoeken verhinderen de zorgprofessionals om passende patiëntenzorg te leveren waarbij de inwonerveiligheid in gevaar kan komen.



Knelpunt 4: Dubbeldiagnostiek

Door het gebrek aan overzicht van (reeds) aangevraagde en resultaten van uitgevoerde onderzoeken, wordt er dubbeldiagnostiek uitgevoerd.





1.2.2 Regionaal diagnostisch portaal | Ambitie

Het creëren van een regionaal diagnostisch portaal draagt bij aan zinnige en zuinige zorg en zal zorgprofessionals in zowel de eerste als 2e lijn voorzien van een compleet overzicht van relevante en actuele diagnostische informatie. Dit stelt hen in staat via een efficiëntere werkwijze om accurate analyses te maken, de resultaten te integreren met specialistische kennis en klinische context, en biedt daarmee een leidend advies voor behandelaars en inwoners.



Ambitie

- Voor het diagnostisch portaal wordt eerst een basis gecreëerd voor 1^e-lijns zorgprofessionals en van daaruit verder ontwikkeld voor ook 2^e-lijns zorgprofessionals. De bouw van die basis is reeds gestart, gefinancierd door Labmicta.
- Het portaal is eind 2026 gekoppeld met Topicus (VlPlive) en interoperabel met de informatiesystemen van de ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, VVT instellingen en apotheken in de regio en de informatiesystemen van MedLon, LabPon en Labmicta
- Focus op labdiagnostiek aanvragen en inzage van onderzoeksresultaten voor zorgprofessionals met een behandelrelatie
- Toestemming via Mitz is ingeregeld
- Via de regionale datahub verloopt ook inzage voor de inwoner zelf in het PGO
- Werkwijze van ziekenhuizen en diagnostische aanbieders is aangepast op de nieuwe situatie

SMART-Doelstellingen

In 2026 een ontwikkeld regionaal diagnostisch portaal voor aanvragen van diagnostiek en van waaruit relevante en actuele diagnostiek uitslagen kunnen worden opgevraagd door zorgprofessionals voor een 360-graden beeld (pathologie, klinisch chemie, microbiologie en later de radiologie). Zodat een zo goed mogelijke diagnose en behandelplan kan worden opgesteld voor de inwoner. Het bestaande platform PALGA voor pathologie dient in de overweging te worden meegenomen.

- 1^e-lijns aanvragers zijn in 2025 aangesloten op het diagnostisch portaal voor aanvragen van onderzoek
- 1^e- en 2^e-lijns aanvragers hebben in 2027 inzage in al het aangevraagd en uitgevoerde onderzoek.
- De verschillende systemen van betrokken stakeholders zijn in 2026 aangesloten op de regionale datahub
- Toestemming inwoner voor uitwisseling data is geregeld via MITZ in 2025
- uitwisseling van de diagnostische data op basis van standaarden (zibs en HL7 FHIR) via de regionale datahub is mogelijk

Link met IZA-opgaven

- **Passende zorg;** de beschikbaarheid van relevante diagnostiek is van belang om passende zorg te kunnen leveren aan de inwoner. Er kan zo een betere inschatting worden gemaakt van de benodigde zorg, bijv. behandeling met antibiotica.
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals;** de registratielast van zorgprofessionals neemt door de beschikbaarheid van relevante diagnostische gegevens af, daarnaast wordt het aanvragen van diagnostiek vergemakkelijkt door het portaal





1.2.3 Regionaal Diagnostisch Portaal | Doorontwikkeling

Het regionaal diagnostisch portaal bevat een volledig portfolio rondom diagnostiek, waarbij data uitgewisseld kan worden binnen alle lijnen in de zorgketen.



Doorontwikkeling

Na de implementatie van het transformatieplan zijn de volgende doorontwikkelingen mogelijk op het gebied van Diagnostiek aanvragen en inzage van uitslagen voor de gehele zorgketen in de regio Twente

Scope uitbreiding

- Het portaal is ontsloten voor alle 1^e- en 2^e-lijns zorgprofessionals en huisartsenposten.
- Beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek is toegevoegd aan het portaal.
- Het portaal is gekoppeld aan een planmodule van de diagnostiek aanbieder.

Data uitwisseling is gerealiseerd

- Het portaal is gekoppeld aan de regionale datahub zodat de diagnostiek een bijdrage levert aan het integraal beschikbaar zijn van zorggegevens.
(koppeling met use case: 360-graden beeld)
- Data wordt gedeeld in PGO t.b.v. meer inzage en regie bij de inwoner in de coördinatie van haar/zijn zorgproces

Hergebruik data

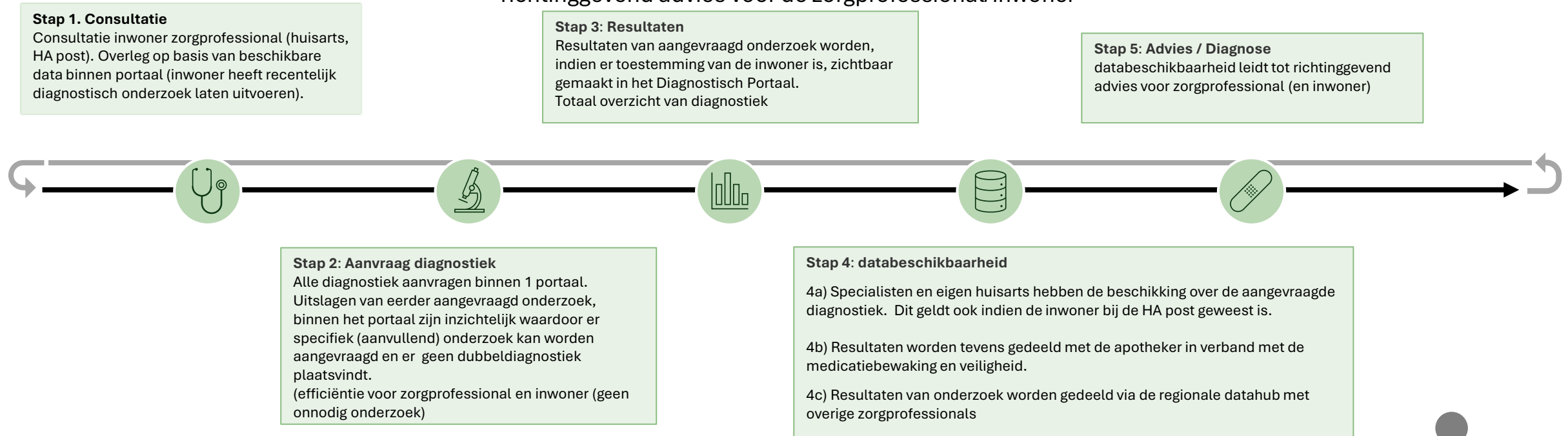
- Het portaal levert data die gebruikt kan worden in het zorgproces t.b.v. advies preventie en leefstijl voor inwoners. Daarnaast kan data gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek





1.2.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Beschrijving inwonerreis/gebruikersreis

Diagnostiek in één keer goed, op de juiste plek op het juiste moment: het hele proces van een juiste klinische vraagstelling, dat leidt tot juiste analyse(s) en waarbij uitkomsten worden gecombineerd met domein-specialistische expertise en klinische context wat vervolgens weer leidt tot een richtinggevend advies voor de zorgprofessional/inwoner



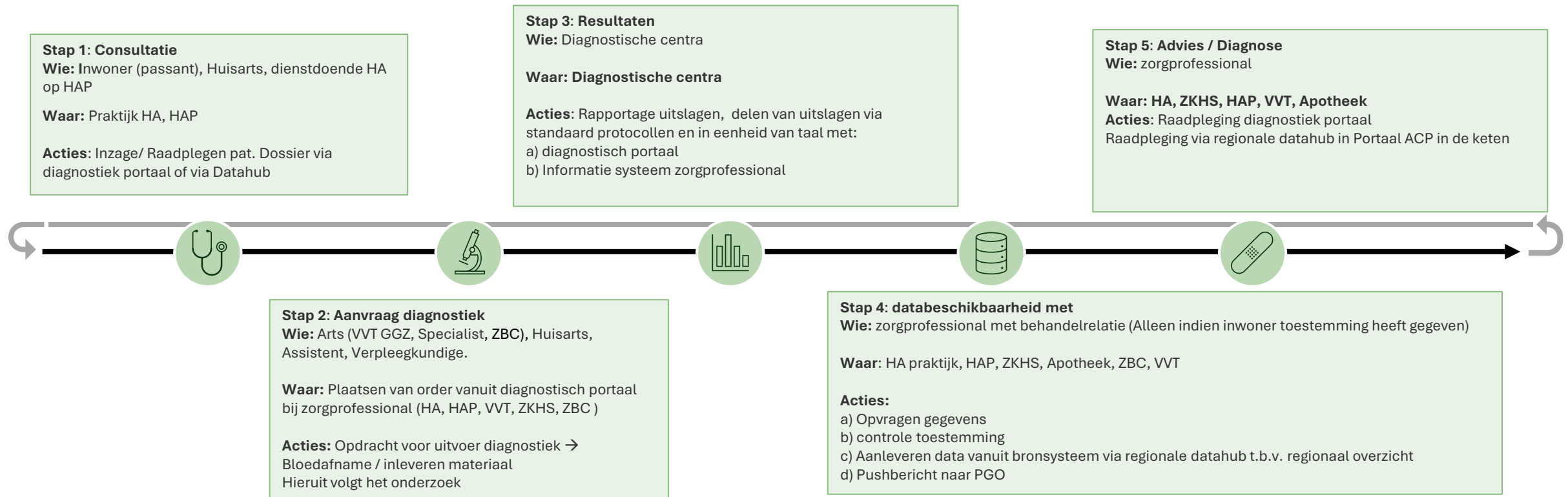
Beoogde effecten voor inwoner

- Consultatie van inwoner met welke zorgprofessional dan ook leidt altijd tot informatiedeling binnen de zorgketen indien de inwoner hier toestemming voor heeft gegeven. Effect hiervan is dat er geen overbodige diagnostiek wordt uitgevoerd.
- Voorkomen van dubbel uitgevoerde diagnostiek voorkomt: a) extra belasting van en extra kosten voor de inwoner (vanuit eigen risico); b) extra kosten binnen het zorgproces
- Behandeling inwoner is meer adequaat door inzage in uitgevoerde diagnostiek bij zorgprofessionals.
- zorgprofessional is minder tijd kwijt aan consult doordat benodigde data beschikbaar is.
- Inwoner heeft zelf inzicht in uitslagen, meer controle op zijn zorgproces





1.2.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Stappen nieuwe zorgproces



Beoogde effecten zorgproces

- *Efficiënte diagnostiekaanvraag*
- *Voorkomen van dubbeldiagnostiek en daarmee voorkomen van extra belasting van de inwoner en extra kosten binnen het zorgproces*
- *Inzicht zorgdossier voor zorgprofessional → alle info beschikbaar → adequate en efficiënte zorgverlening*
- *Inwoner heeft meer controle over eigen zorg door inzage in uitgevoerd onderzoek*





1.2.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Fit-gap analyse (1/2)

	Consultatie	Aanvraag diagnostiek	Resultaat	databeschikbaarheid	Advies / Diagnose
1. Huidige proces en workflow	Van inwoner of passant op HAP is niet altijd data beschikbaar	Aanvragers hebben voor aanvragen diagnostiek vele verschillende portalen beschikbaar. Geplaatste orders zijn vaak niet inzichtelijk. Mutaties aan orders die nog uitgevoerd moeten worden is niet altijd mogelijk	Onderzoeksresultaten worden alleen gedeeld met de aanvrager van diagnostiek. Dit geschiedt in velerlei vormen (EDI-fact, HL7, Papier etc.) zonder afspraken over eenheid van taal	- databeschikbaarheid vindt niet plaats, behalve in sommige gevallen tussen diagnostiek aanbieder en apotheek via Lab4APO - Patiënt toestemming is niet geheel doorgevoerd	Advies Diagnose veelal alleen op basis van zelf aangevraagd onderzoek
2. Vereisten nieuwe proces	- Databeschikbaarheid is geregeld - Toestemming inwoner is geregeld - Eenheid van taal voor uitwisseling is geregeld	Een portaal voor alle diagnostiek waarbij er inzage/notificatie functie is voor de nog niet uitgevoerde orders	- Standaarden voor communicatieprotocollen - Afspraak codeersysteem t.b.v. eenheid van taal - Toestemming inwoner is geregeld - Uitslagen van 1^e lijn worden zichtbaar bij aanvraag 2^e lijn en vice versa	- Standaarden voor communicatieprotocollen - Afspraak codeersysteem t.b.v. eenheid van taal - Patiënt toestemming is geregeld	- Databeschikbaarheid is gerealiseerd\ - zorgprofessional heeft totaalbeeld van aangevraagde en uitgevoerde diagnostiek
3. Verschillen tussen de processen	Nu is bij sommige zorgprofessionals geen data beschikbaar van de inwoner	Huidige situatie zijn er verschillende portalen voor diagnostiek. In het nieuwe proces wordt de diagnostiek van de verschillende diagnostiek aanbieders gebundeld in één aanvraag/resultaat portaal. Dit kan verder uitgebouwd worden met functie onderzoeken, radiologie ed.	- Binnen huidig proces worden resultaten in principe alleen gedeeld met aanvrager van onderzoek - Binnen huidige proces wordt er gecommuniceerd via diverse protocollen - Er is geen sprake van “eenheid van taal”	databeschikbaarheid in nieuw proces is gerealiseerd	Bij het nieuwe proces heeft de zorgprofessional een beter beeld om een advies te geven of een diagnose te stellen
4. Voorgestelde overbrugging	- Toestemming inwoner is eenduidig vastgelegd via MITZ - Eenheid van taal is geregeld. Nu wordt er gewerkt met verschillende codeersystemen. (NHG-labcode, Chipsoft codering, EDI-fact, LOINC, SNOMED - Eenduidig communicatie protocol (HL7 FHIR en ZIB's).	- Implementatie en uitrol voor 1^e lijns zorgverleners. - Aansluiting 2^e lijns aanvragers op het portaal. - Authenticatie en identificatie voor toegang portaal	- Afspraak communicatie protocol - Afspraak codeersysteem - Inrichting van codeersysteem in bronsysteem diagnostiek aanbieders - Inwoner toestemming (via MITZ) regelen - Realisatie koppelingen op basis van afgesproken communicatieprotocollen	- Afspraak communicatie protocol - Afspraak codeersysteem - Inrichting van codeersysteem in bronsysteem diagnostiek aanbieders - inwoner toestemming (via MITZ) regelen - Realisatie koppelingen op basis van afgesproken communicatieprotocollen	





1.2.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Fit-gap analyse (2/2)

	Inhoud & Techniek	Proces & Beleid	Mens Inwoner/ zorgprofessional
1. Huidige proces en workflow	- Zorgprofessional maakt in beginsel gebruik van zijn eigen informatiesysteem. (HIS, VIP-live, HIX, VIS etc.) - Tijdens consult en anamneses worden er in dit systeem de gegevens van de inwoner geregistreerd inclusief de zorgvraag. - Voor 1^e zorgprofessionals is er vaak de mogelijkheid om het zorgdossier van inwoner van een collega uit de praktijk in te zien. - Indien de inwoner/passant zich meldt op een HAP kan de zorgprofessional, indien hier toestemming voor is gegeven, ook het zorgdossier inzien zoals opgetekend bij een ander zorgprofessional. - Er is vaak geen data beschikbaar vanuit zorgsegmenten. - Indien er sprake is van een diagnostiek aanvraag kan de zorgprofessional via een SSO koppeling overschakelen naar een portaal voor aanvragen van diagnostiek (Cyberlab, Lab Online, ZorgDomein, HIX-aanvraagmodule). - Iedere diagnostiek aanbieder heeft zijn eigen portaal. Tijdens de aanvraag is niet inzichtelijk welke diagnostiek er reeds is uitgevoerd, waardoor er kans is op dubbeldiagnostiek. - De aanvraag is vaak digitaal gekoppeld aan het LIS. - Onderzoeksresultaten worden vanuit het LIS gedeeld met het informatiesysteem van de zorgprofessional en alleen met de aanvrager van het onderzoek. - Advies en diagnose vindt plaats op basis van zelf aangevraagd onderzoek	- Van inwoner of passant is niet altijd (alle) data beschikbaar - zorgprofessionals maken gebruik van diverse order aanvraagportalen - Diagnostiek aanvragen leiden tot dataoverdracht tussen aanvraagportaal en LIS van diagnostiekaanbieder - De gebruikte protocollen voor dataoverdracht worden bepaald door de aanvragende zorgprofessional en de diagnostiekaanbieder (aanvraag en rapportage) (HL7, EDI, papier) - Tijdens het aanvragen van diagnostiek is niet inzichtelijk welke diagnostiek reeds is aangevraagd en uitgevoerd - Rapportage geschiedt op basis van afspraken tussen diagnostiek aanbieder en zorgprofessional, waarbij verschillende coderingen gebruikt worden (NHG-labcode, eigen code diagnostiek aanbieder, LOINC, SNOMED) . - Advies en diagnose van de inwoner vindt plaats o.b.v. zelf aangevraagd onderzoek. (geen databeschikbaarheid van ander onderzoek uitgevoerd voor de inwoner) - Data uitwisseling vindt (vaak) niet plaats tussen aanbieder en apotheek (geen databeschikbaarheid)	- Niet alle data rondom diagnostiek van de inwoner is inzichtelijk voor de zorgprofessional, hierdoor ontstaat de kans dat er overbodige diagnostiek wordt aangevraagd. Dit is belastend voor de inwoner. Tevens heeft inwoner geen inzicht in eigen dossier - Doordat de zorgprofessional geen inzicht heeft in eerder uitgevoerde diagnostiek wordt er een advies dan wel diagnose gesteld op basis van zelf aangevraagd onderzoek. - De apotheker veelal ook geen overzicht van uitgevoerd onderzoek waardoor de medicatiebewaking bemoeilijkt wordt. - Voor de zorgprofessional is het aanvragen van diagnostiek omslachtig doordat iedere diagnostiek aanbieder zijn eigen portaal hanteert.
2. Vereisten nieuwe proces	- Databeschikbaarheid is geregeld - Toestemming inwoner is geregeld - Eenheid van taal voor uitwisseling van data is geregeld - Koppelingen tussen de verschillende systemen op gestandaardiseerde manier plaatsvindt	- Een portaal voor alle diagnostiek waarbij er inzage/notificatie functie is voor de nog niet uitgevoerde orders - Standaarden voor communicatieprotocollen - Afspraak codeersysteem t.b.v. eenheid van taal	- zorgprofessionals vragen alle diagnostiek aan in één portaal gekoppeld aan hun informatiesysteem. - Tijdens aanvragen van diagnostiek heeft de zorgprofessional inzage in eerder uitgevoerd onderzoek. - Apotheek heeft ook inzage in uitgevoerd onderzoek inwoner heft inzage in zijn eigen data
3. Voorgestelde overbrugging tussen oud en nieuw	- Toestemming inwoner is eenduidig vastgelegd (MITZ) - Eenheid van taal is geregeld. Nu wordt er gewerkt met verschillende codeersystemen. (NHG-labcode, Chipsoft codering, EDI-fact, LOINC, SNOMED) - Eenduidig communicatieprotocol.(HL7 FHIR ZIB) - Informatiesystemen bieden de mogelijkheid om eerder uitgevoerde diagnostiek op te vragen en te tonen	- Toestemming inwoner t.b.v. dataoverdracht tussen zorgprofessionals is eenduidig vastgelegd (MITZ) - Implementatie regionaal portaal voor 1^e lijns zorgprofessionals is gerealiseerd - Bronsystemen van diagnostiek aanbieders zijn in staat om data uit te wisselen met regionaal portaal of EPD's via een van te voren afgesproken protocol (HL7 FHIR, ZIB's) - Vaststellen van het communicatieprotocol - Gebruik van LOINC en SNOMED t.b.v. eenheid van taal	





1.2.5 Betrokken stakeholders op organisatieniveau, hun rol in het zorgproces en de transformatie



Verdieping op de betrokken stakeholders

	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
Huisarts¹ / Verloskundige / POH / Verpleegkundige	• Hoog	• (1^e) behandelaar van de inwoner • Efficiënte Aanvragen van diagnostiek • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose	• Tijdwinst door efficiënt aanvragen • Alle diagnostiek op één plek (SSO koppeling) • Geen aanvraag van onnodige diagnostiek door inzicht in eerder aangevraagde diagnostiek
Ziekenhuis / Medisch specialist	• Hoog	• 1^e behandelaar van de inwoner • Efficiënt Aanvragen van diagnostiek • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose	• Alle diagnostiek op één plek (SSO koppeling) • Geen aanvraag van onnodige diagnostiek door inzicht in eerder aangevraagde diagnostiek
VVT Arts / Thuiszorgmedewerker / Verpleegkundige	• Hoog • Midden • Midden	• Behandelaar van de inwoner • Aanvragen van diagnostiek • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose	• Alle diagnostiek op één plek (SSO koppeling) • Geen aanvraag van onnodige diagnostiek door inzicht in eerder aangevraagde diagnostiek
Apotheek	• Hoog	• Door inzage in uitgevoerde diagnostiek verhoging van medicatiebewaking en veiligheid van de inwoner.	• Uitslagen van uitgevoerde diagnostiek zijn inzichtelijk (middels SSO koppeling)
Diagnostische centra	• Hoog	• Uitvoeren van aangevraagde diagnostiek	• Efficiëntere verwerkwerking van aangevraagde diagnostiek. • Rapportage volgens afgesproken protocollen en met eenheid van taal. • Aanleveren van onderzoeksresultaten via de datahub t.b.v. regionaal portaal
GGZ	• Hoog	• Behandelaar van de inwoner aanvragen van diagnostiek • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose • Door inzage in uitgevoerde diagnostiek verhoging van medicatiebewaking en veiligheid van de inwoner	• Uitslagen van uitgevoerde diagnostiek zijn inzichtelijk • Geen aanvraag van onnodige diagnostiek door inzicht in eerder aangevraagde diagnostiek
ZBC		• Behandelaar van de inwoner • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose • Uitslagen inzien t.b.v. advies of diagnose	• Alle diagnostiek op één plek (SSO koppeling) • Geen aanvraag van onnodige diagnostiek door inzicht in eerder aangevraagde diagnostiek





1.2.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Organisatie- en regiobeleid

Wet- en regelgeving & beleid

- Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg
- Geneesmiddelenwet (art 66a)
- Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten
- NEN-7510, ISO-15189
- Wet gebruik BSN in de zorg

Regionale afspraken

- 1,5-lijnszorg, zinnige zorg, JZOJP, MTH-zorg, nachtzorg, etc.
- Samenwerking Twentse laboratoria medische diagnostiek (lab en beeldvormend)
- Nieuwe regionale projectenkalender en ‘modus operandi’ ZorgNetOost (Manifest regionale samenwerking)
- Zorgnetwerkomgeving THOON & FEA

Richtlijnen

- Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg
- TWIIN
- AORTA
- MedMIJ
- Richtlijn Laboratorium Diagnostiek NHG

Randvoorwaarden

- Unieke identificatie voor inwoners
- Unieke identificatie voor zorgprofessionals en laboratoria
- Toestemming inwoner is geregeld.
- Verwerkingsregister per type zorgprofessional
- Data blijft bij de bron.
- Beveiligd transport van data

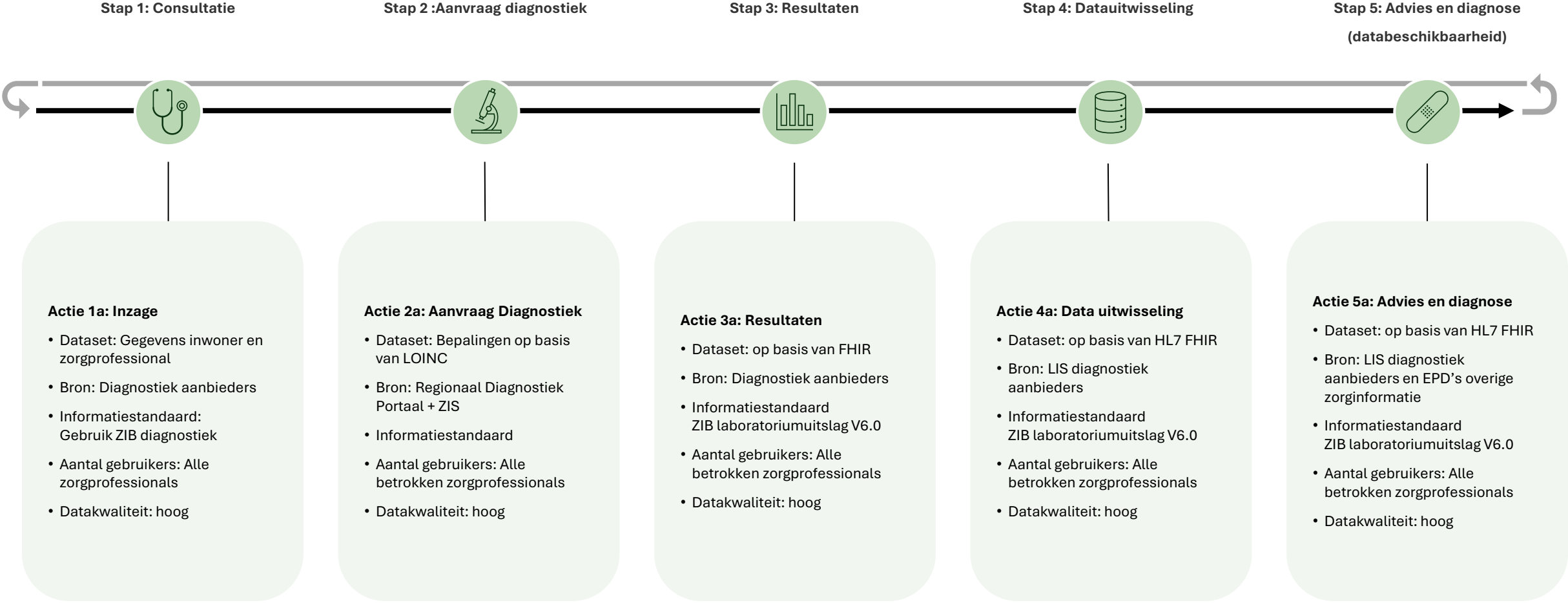
- Eenheid van taal betreffende diagnostiek
- Standaardisatie data protocollen
- Gebruik MITZ voor toestemming inwoner
- Afspraken aanvraagportalen 1^e en 2^e lijn
- Alle EPD's zijn aangesloten en committeren zich aan de voorgestelde standaarden en werkwijzen

- De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.





1.2.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Acties die plaatsvinden m.b.t gegevensuitwisseling in het nieuwe zorgproces





1.2.7 Randvoorwaarden nieuwe werkwijze



Randvoorwaarden



Randvoorwaarde aan de techniek

- Data wordt geleverd vanuit het bronsysteem (LIS van diagnostiekaanbieders). LIS systemen zijn gekoppeld aan de “datahub”
- Data is gecodeerd volgens (inter)nationale standaarden (LOINC, SNOMED)
- Afspraken zijn gemaakt betreffende eenheid van taal
- Koppelingen volgens landelijke standaarden. HL7 FHIR en ZIB's
- Koppeling voor toestemming inwoner via MITZ is gerealiseerd
- Koppeling tussen 1e en 2e lijn diagnostiek portalen is gerealiseerd
- Inzage van eerder uitgevoerd onderzoek is zichtbaar binnen de EPD's van de zorgprofessional bij raadpleging zorgdossier of aanvraag diagnostisch onderzoek



Randvoorwaarde aan het proces

- 1e lijns zorgprofessionals, VVT's en GGZ zijn aangesloten op het regionaal diagnostisch portaal. (SSO)
- Diagnostiek aanvragen vanuit de 2e lijn geschiedt via de vigerende HIX aanvraagmodule.
- Toestemming van inwoner voor uitwisseling data is eenduidig vastgelegd.
- Uitslagen van eerder uitgevoerd diagnostisch onderzoek zijn zichtbaar voor de zorgprofessionals tijdens het aanvragen van diagnostiek.
- Uitwisseling van dat rondom diagnostiek geschiedt op basis van (internationaal) standaarden
- Coderingssystemen zijn op elkaar afgestemd. (LOINC, SNOMED)
- Data uitwisseling, m.b.t. diagnostiek, vindt plaats vanuit de bronsystemen (LIS diagnostiek aanbieders)



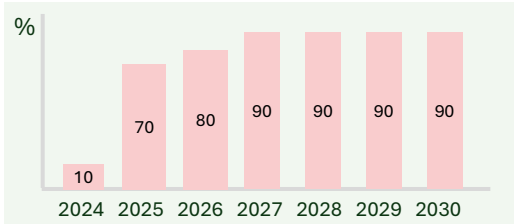
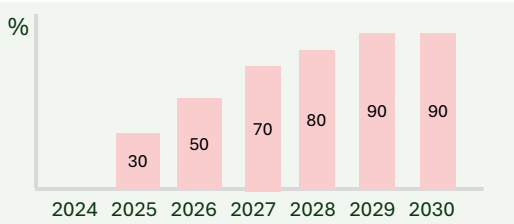
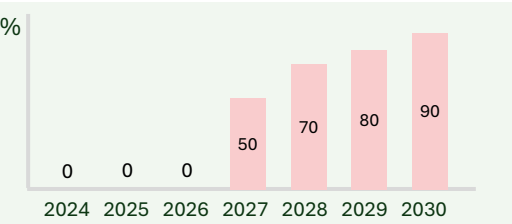
Randvoorwaarde aan de mens

- 1e lijns aanvragers maken gebruik van het regionaal diagnostisch portaal voor aanvragen diagnostiek.
- Laagdrempelig en beschikbaar is een must
- Inwoners kunnen met een eenduidig identificatie en autorisatie middel inloggen op hun eigen omgeving (PGO)





1.2.8 Impactanalyse

	 Efficiëntie	 Inzicht in uitgevoerde diagnostiek	 Dubbel diagnostiek	 Inzicht en regie zorgproces inwoner																																																
Beschrijving	Alle diagnostiek aanvragen binnen één portaal creëert overzicht en efficiëntie tijdens het aanvragen van diagnostiek omdat er niet gewisseld hoeft te worden tussen de verschillende portalen van de diagnostiek aanbieders. Dit levert tijdswinst op welke gebruikt kan worden voor andere zorgtaken.	Inzicht zorgdossier van de inwoner voor zorgprofessional zorgt voor direct beschikbare informatie, wat een adequate en efficiënte zorgverlening en verhoogde patiëntveiligheid bevordert. Dit verbetert niet alleen de zorg voor de inwoner, maar biedt ook tijdswinst voor de zorgprofessional, doordat (telefonisch) contact met diagnostiekaanbieders over de beschikbaarheid van uitslagen niet meer nodig is.	Alle resultaten van aangevraagd en uitgevoerd onderzoek zijn zichtbaar. Daarnaast zijn alle aangevraagde maar nog niet uitgevoerde onderzoeken zichtbaar. Dit voorkomt mogelijk uitvoer van dubbel diagnostiek. Dit bespaart a) onnodige belasting en onnodige kosten voor de inwoner, en b) kosten binnen het zorgproces.	Inwoners worden steeds meer zelfsturend in hun eigen ziekteproces. Door beschikbaar maken van uitslagen onderzoek in PGO heeft inwoner meer controle over eigen zorg door inzage in uitgevoerd onderzoek. Hierdoor wordt het consult bij de zorgprofessional mogelijk verkort.																																																
Betrokken sector(en)	Huisartsen en 1 ^e lijns zorgprofessionals		Diagnostische centra	Inwoners binnen het zorgproces																																																
Doelgroep	Het aantal huisartsen en/of 1e lijns zorgprofessionals die in aanraking komen met (het aanvragen van) diagnostiek.		Het aantal verrichtingen diagnostiek in ziekenhuizen per jaar (excl. pathologie)	Patiëntenpopulatie met vooral de “chronische inwoners” als primaire groep																																																
# omvang	# huisartsenpraktijken in de regio Twente		# verrichtingen diagnostiek ziekenhuizen per jaar	# inwoners, groeiende door toenemende zelfregie en chronische patiënten																																																
% inclusie-percentage over de jaren	 <table><tr><th>Jaar</th><th>% inclusie</th></tr><tr><td>2024</td><td>10</td></tr><tr><td>2025</td><td>70</td></tr><tr><td>2026</td><td>80</td></tr><tr><td>2027</td><td>90</td></tr><tr><td>2028</td><td>90</td></tr><tr><td>2029</td><td>90</td></tr><tr><td>2030</td><td>90</td></tr></table>	Jaar	% inclusie	2024	10	2025	70	2026	80	2027	90	2028	90	2029	90	2030	90	 <table><tr><th>Jaar</th><th>% inclusie</th></tr><tr><td>2024</td><td>30</td></tr><tr><td>2025</td><td>50</td></tr><tr><td>2026</td><td>70</td></tr><tr><td>2027</td><td>80</td></tr><tr><td>2028</td><td>90</td></tr><tr><td>2029</td><td>90</td></tr><tr><td>2030</td><td>90</td></tr></table>	Jaar	% inclusie	2024	30	2025	50	2026	70	2027	80	2028	90	2029	90	2030	90	 <table><tr><th>Jaar</th><th>% inclusie</th></tr><tr><td>2024</td><td>0</td></tr><tr><td>2025</td><td>0</td></tr><tr><td>2026</td><td>0</td></tr><tr><td>2027</td><td>50</td></tr><tr><td>2028</td><td>70</td></tr><tr><td>2029</td><td>80</td></tr><tr><td>2030</td><td>90</td></tr></table>	Jaar	% inclusie	2024	0	2025	0	2026	0	2027	50	2028	70	2029	80	2030	90	Levert kwaliteit van zorg op voor de inwoner doordat consulten efficiënter worden ingedeeld, resulterend, niet zozeer in kortere, maar in betere consulten, waarbij meer ruimte is voor het goede gesprek.
Jaar	% inclusie																																																			
2024	10																																																			
2025	70																																																			
2026	80																																																			
2027	90																																																			
2028	90																																																			
2029	90																																																			
2030	90																																																			
Jaar	% inclusie																																																			
2024	30																																																			
2025	50																																																			
2026	70																																																			
2027	80																																																			
2028	90																																																			
2029	90																																																			
2030	90																																																			
Jaar	% inclusie																																																			
2024	0																																																			
2025	0																																																			
2026	0																																																			
2027	50																																																			
2028	70																																																			
2029	80																																																			
2030	90																																																			
Effect van de impact	Tijdsbesparing van 15 min. per dag door verbeterde efficiëntie voor het aanvragen van diagnostiek. Zorgprofessionals hoeven niet meer in verschillende systemen in te loggen.	Tijdsbesparing van 4 min. per telefoongesprek door inzicht in uitgevoerde diagnostiek	Reductie van 1,5% in uitgevoerde dubbel diagnostiek per jaar door overzicht van uitgevoerd onderzoek																																																	

Deze impact is kwalitatief en daarom niet gekwantificeerd



1.2.8 Impactanalyse | Regionaal diagnostisch portaal

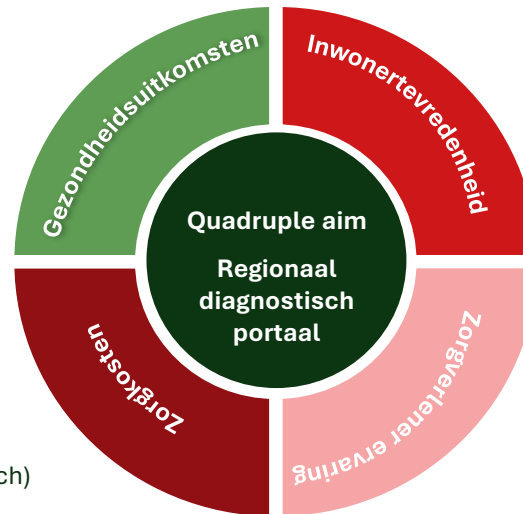
Informatie rondom diagnostiek is in één overzicht beschikbaar waardoor dubbele diagnostiek wordt verminderd en aanvragen van diagnostiek gemakkelijker gaat

Gezondheidszorg uitkomsten

- Inwoners krijgen meer inzicht in hun eigen gezondheid, wat leidt tot meer rust en een hogere kwaliteit van leven
- Er is meer vertrouwen in de zorg en zorg wordt efficiënter aangeboden door deze op de juiste plaats te verstrekken
- Alle informatie is beschikbaar voor het stellen van een goede diagnose of advies

Zorgkosten

- Tijdwinst welke gebruikt kan worden voor andere zorgtaken omdat er niet gewisseld hoeft te worden tussen de verschillende portalen van de diagnostiek aanbieders
- Tijdwinst voor de zorgprofessional, doordat (telefonisch) contact met diagnostiekaanbieders over de beschikbaarheid van uitslagen niet meer nodig is
- Voorkomen van dubbele diagnostiek doordat aangevraagde en uitgevoerde onderzoeken zichtbaar zijn. Dit bespaart onnodige kosten voor de inwoner



Inwonertevredenheid

- Inwoners hebben inzicht en controle in hun eigen zorgdossier en dus mogelijk meer controle over hun eigen gezondheid
- Daarnaast zijn inwoners beter geïnformeerd, wat kan resulteren in het teruglopen van het aantal consulten of kwalitatief betere consulten
- Voorkomen van dubbeldiagnostiek resulteert in minder belasting en kosten voor de inwoner

Zorgprofessionaltevreidenheid

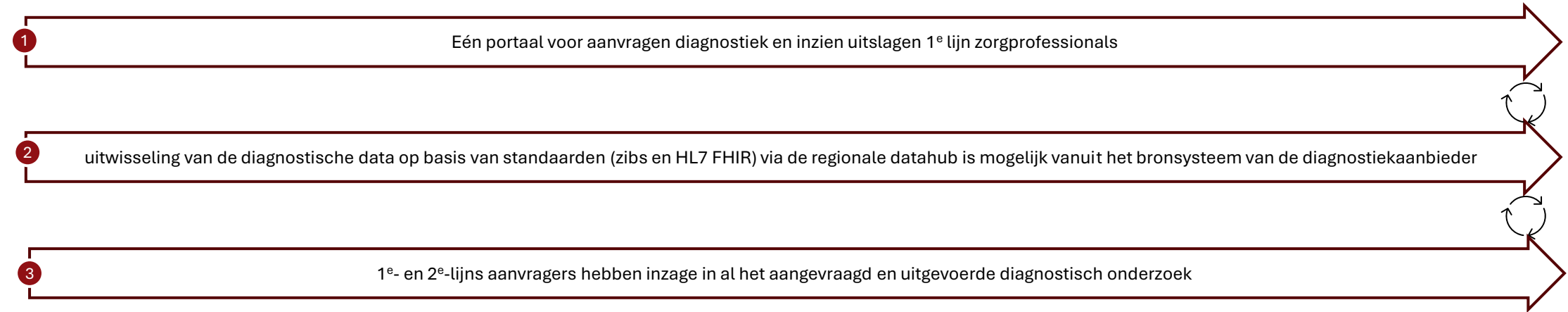
- Door via één portaal aanvragen te kunnen doen uitslagen van diagnostisch onderzoek in te zien, wordt er minder tijd besteed aan het aanvragen van onderzoek en het bevragen van de diagnostische centra
- Alle informatie van de inwoner is beschikbaar is voor het stellen van een goede diagnose of advies
- Apothekers krijgen inzicht in uitgevoerde diagnostiek. Hierdoor wordt de medicatieverstrekking en medicatiebewaking geoptimaliseerd wat patiëntveiligheid bevordert





1.2.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak

Om te kunnen voldoen aan gestelde doelen en ambities wordt realisatie van het regionaal diagnostisch portaal opgedeeld in drie deelprojecten



Tussen de deelprojecten zullen meerdere test en validatiefases plaatsvinden waarin functionaliteiten worden toegevoegd of aangepast aan het diagnostisch portaal en of EPD's van zorgprofessionals waarbij werkprocessen aangepast worden





1.2.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak

Deelproject 1: Eén portaal voor aanvragen diagnostiek en inzien uitslagen 1e lijn zorgprofessionals

1

Eén portaal voor aanvragen diagnostiek en inzien uitslagen 1^e lijn zorgprofessionals

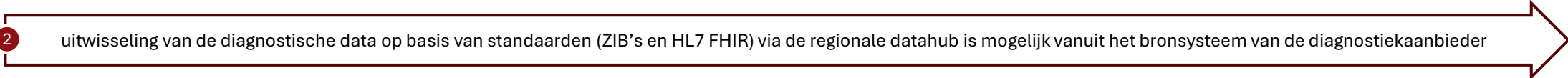
1. Start project	2. Analyse en ontwerp	3. Implementatie	4. Test en acceptatie	5. Pilot fase	6. eindfase
• Onderlinge afspraken diagnostiek aanbieders • Inrichten projectteams • Afstemming met gebruikers (stakeholders) • Bepalen uitgangspunten en scope • Vaststellen impact en doelstellingen en voorwaarden • Uitvoeren DPIA • Bepalen projectplan(ning) • Opleveren projectplan • Kick off	• Bepalen eisen en wensen gebruikers • Bepalen workflow en onderlinge uitwisseling data • Samenstellen inhoud portaal • Fit-gap analyse gewenste inrichting t.o.v. technische mogelijkheden van het middel. • Opstellen functioneel ontwerp • Toetsen functioneel ontwerp • Accorderen functioneel ontwerp door alle betrokkenen	A. Inrichting portaal • Bepalen lay-out aanvraagschermen • Inrichting aanvraagschermen per diagnostiek aanbieder • Inrichting gebruikers • Inrichting . B. Technische ontwikkeling • Specificaties koppeling vaststellen • Offerte fase leverancier LIS • Inrichting koppelvlakken (firewall etc.) • Realisatie koppeling LIS – aanvraag portaal • Realisatie onderlinge koppelingen diagnostiek leveranciers C. Communicatie • Aanmaken gebruikers handleiding • Aanmaken e-learning gebruikers • Opstellen communicatieplan	• Opstellen testplan • Opstellen acceptatiecriteria • Uitvoer testplan • Review test • (Aanpassingen aan technische inrichting) • Uitvoeren gebruikers-acceptatietesten • Opstellen validatie document • Kwaliteitsreview met diverse stakeholders • Accorderen technische validatie Overzetten naar productieomgeving • Opstellen validatiecriteria • Uitvoerketentesten • Oplevering validatie document • Accorderen validatie document	• Gebruikers aanmaken • Implementeren en uitvoeren kleinschalige pilot in de productieomgeving • Monitoren pilot o.b.v. succesfactoren & KPIs • Oplossen issues o.b.v. ervaringen • Uitvoer ketentest • Kwaliteitsreview • Go no GO productiefase	• Structureel inrichten productieomgeving • Inrichting monitoring • Inrichting beheer • Borging van proces in ISMS • Afronding project • Beheerfase





1.2.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak

Deelproject 2: Data uitwisseling via de regionale datahub is mogelijk en gerealiseerd



1. Start project	2. Analyse en ontwerp	3. Implementatie	4. Test en acceptatie technisch	5. Pilot fase	6. eindfase
• Inrichten projectteams • Afstemming met regionaal gekozen architectuur • Vaststellen impact en voorwaarden voor deelproject A en B • Uitvoeren DPIA • Bepalen projectplan(ning) voor deelproject A en B	• Procesanalyse werkwijze overdracht data vanuit diagnostische centra • Fit-gap analyse huidige inrichting LIS t.o.v. uitgangspunten en voorwaarden. Deelproject A (aanpassingen LIS) • Bepalen aanpassingen t.b.v. de te implementeren informatiestandaarden en codestelsels binnen LIS Deelproject B (technisch ontwerp) • Definieren werkwijze data-uitwisseling • Opstellen functionele eisen, uit te wisselen dataset binnen architectuur regionale datahub • Functioneel ontwerp	A. Aanpassingen LIS • Inventarisatie bepalingen te voorzien van open standaarden • Aanpassingen doorvoeren • Controle en validatie door vak-deskundigen. B. Technische ontwikkeling • Specificaties koppeling vaststellen • Offerte fase leverancier LIS • Inrichting koppelvlakken (firewall etc.) • Realisatie koppeling LIS – datahub op basis van open standaarden (Afhankelijk van gekozen regionale architectuur) • Technische test en validatie koppelingen	• Opstellen testplan • Opstellen acceptatiecriteria • Uitvoer testplan • Review test • (Aanpassingen aan technische inrichting) • Uitvoeren gebruikers-acceptatietesten • Opstellen validatie document • Kwaliteitsreview met diverse stakeholders • Accorderen technische validatie	• Implementeren en uitvoeren kleinschalige pilot in de productieomgeving • Monitoren pilot o.b.v. succesfactoren & KPIs • Oplossen issues o.b.v. ervaringen • Uitvoer ketentest • Kwaliteits review • Go no GO productie	• Structureel inrichten productieomgeving • Inrichting monitoring • Inrichting beheer • Borging van proces in ISMS • Afronding project





1.2.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak

Deelproject 3: 1e en 2e lijns aanvragers hebben inzage in al het aangevraagd en uitgevoerd diagnostisch onderzoek

3

1^e en 2^e lijns aanvragers hebben inzage in al het aangevraagd en uitgevoerde diagnostisch onderzoek

0. Vooronderzoek, analyse en ontwerp	1. Start	3. Implementatie	4. Test en acceptatie technisch	5. Pilot fase	6. eindfase
• Bepalen gewenste werkwijze met stakeholders. • Definieren gewenste werkwijze data uitwisseling • Opstellen RFP voor leveranciers • Overleg leveranciers betreffende mogelijkheden • Vaststellen gewenste werkwijze met stakeholders en leveranciers • Fit-gap analyse huidige inrichting t.o.v. uitgangspunten en voorwaarden. • Aanmaken functioneel ontwerp met stakeholders en leveranciers • Offertefase met leveranciers • Planning ontwikkeling met leveranciers • Afstemmen met implementatie team datahub	• Inrichten projectteams • Afstemming met regionaal gekozen architectuur • Vaststellen impact en doelstellingen en voorwaarden • Uitvoeren DPIA • Bepalen projectplanning • Opleveren projectplan	A. Aanpassingen portalen diagnostiek • Implementatie fase gewenste functionaliteit (Chipsoft) • Test en evaluatiefase in afstemming met datahub • Controle en validatie door vakdeskundigen. • Implementatie fase gewenste functionaliteit (Topicus) • Test en evaluatiefase in afstemming met datahub • Controle en validatie door vakdeskundigen. B. Technische ontwikkeling • Specificaties koppeling vaststellen • Inrichting koppelvlakken (firewall etc.) • Realisatie koppeling diagnostiek portaal – datahub op basis van open standaarden (Afhankelijk van gekozen regionale architectuur) • Technische test en validatie koppelingen	• Opstellen testplan • Opstellen acceptatiecriteria • Uitvoer testplan • Review test • (Aanpassingen aan technische inrichting) • Uitvoeren gebruikers-acceptatietesten • Uitvoer ketentest • Opstellen validatie document • Kwaliteitsreview met diverse stakeholders • Accorderen technische validatie	• Implementeren en uitvoeren kleinschalige pilot in de productieomgeving • Monitoren pilot o.b.v. succesfactoren & KPIs • Oplossen issues o.b.v. ervaringen • Uitvoer ketentest • Kwaliteits review • Go no GO productie	• Structureel inrichten productieomgeving • Inrichting monitoring • Inrichting beheer • Borging van proces in ISMS • Afronding project



1.2.9 Maatschappelijke business case | Projectplanning & resourceallocatie

Gemiddelde personele inzet per jaar (FTE)			
Rollen	2024	2025	2026
Werkgroeplid			
Arts			
(Gesp.) verpleegkundige			
Projectleider			
Sponsor			
Werkgroeplid			
Huisarts			
Werkgroeplid			
IT-architect			
Totaal aantal (FTE)			
Totaal percentage extern (%)			

Legenda:

Intern

Extern

Intern/Extern





1.2.10 KPI's



Transformatie-planning	I/R	2024	2025				2026				
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1: Eén portaal voor aanvragen diagnostiek en inzien uitslagen 1e lijn zorgverleners	I	Overgang naar productie	December Uitrol portaal 1^e lijn 10% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	Maart Uitrol portaal 1^e lijn 20% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	Juni Uitrol portaal 1^e lijn 40% van de huisartspraktijk en zijn aangesloten op het portaal	September Uitrol portaal 1^e lijn 75% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal	December Uitrol portaal 1^e lijn 90% van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het portaal				
Deelproject 2: uitwisseling van de diagnostische data op basis van standaarden (ZIB's en HL7 FHIR) via de regionale datahub is mogelijk vanuit het bronsysteem van de diagnostiekaanbieder	I		December Oplevering Oplevering projectplan deelproject 2				December Inrichting Diagn. centra zijn technisch ingericht voor uitwisseling data via de datahub	Maart Gebruik 100% van de data kan worden uitgewisseld volgens open standaarden en ZIB's vanuit de bronsystemen van diagn. centra			
Deelproject 3: Zorgverleners hebben inzage in al het aangevraagde en uitgevoerde onderzoek	I						Oktober Projectplan Oplevering functioneel ontwerp en projectplan deelproject 3		Juni Functionaliteit Oplevering gewenste functionaliteiten leveranciers (Chipsoft en Topicus)	September Inrichting Portalen voor 1^e en 2^e lijn kunnen koppeling maken met de “viewer” tijdens aanvragen van diagnostiek	December Gebruik 80% van de zorgverleners hebben inzage in uitgevoerd en aangevraagde diagnostiek
Vermindering aantal <i>dubbele diagnostiek aanvragen</i> t.o.v. 0-meting	R								Juni - 6.000 Dubbele diagnostiek aanvragen	September - 15.000 (cum.) Dubbele diagnostiek aanvragen	December - 26.000 (cum.) Dubbele diagnostiek aanvragen





1.2.11 Risico's & mitigerende maatregelen

Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Toestemming inwoner is niet eenduidig vastgelegd via MITZ, waardoor data uitwisseling niet mogelijk is	Gemiddeld	Hoog	Eenduidige afspraken betreffende gebruik MITZ. Iedere toeleverancier van data gebruikt zijn consensus module om te bepalen of het gerechtvaardigd is dat de persoonlijke gezondheidsdata wordt uitgewisseld. De houders van de bronsystemen zijn verantwoordelijk totdat MITZ in gebruik kan worden genomen
Adopteren portaal door gebruikers voldoet niet aan de gestelde doelstellingen waardoor het effect “efficiënt gebruik” vermindert en de gestelde KPI's niet worden gehaald	Gemiddeld	Gemiddeld	Goede voorbereiding voor uitrol. Communicatieplan met juiste propositie Begeleiding en hulp voor gebruikers regelen. Doorontwikkeling op wensen van gebruikers
technische onmogelijkheden om alle resultaten van uitgevoerd onderzoek te tonen tijdens aanvraag van diagnostiek binnen het aanvraagportaal, waardoor het effect van voorkomen van dubbeldiagnostiek vermindert	Gemiddeld	Hoog	Impact en Gap analyse tijdig kenbaar maken bij leveranciers en stakeholders. Tijdig doorontwikkel traject met leveranciers bepalen. Alternatieven in kaart brengen en waar nodig uitvoeren
Geen capaciteit voor inrichting en beheer, waardoor gestelde doelen weggezet in de tijd niet worden gehaald en er dus niet kan worden voldaan aan inspanningsverplichting en levering verplichtingen	Gemiddeld	Hoog	Afspraken betreffende commitment van alle betrokken stakeholders op bestuurlijk niveau welke periodiek zullen worden geëvalueerd.
Financiële middelen voor realisatie zijn ontoereikend om de gewenste doelen te behalen	Gemiddeld	Hoog	Afspraken betreffende commitment van alle betrokken stakeholders op bestuurlijk niveau welke periodiek zullen worden geëvalueerd.
Betrokken partijen hebben verschillende politieke en commerciële belangen waardoor één portaal voor laboratorium diagnostiek voor de 1 ^e lijn niet haalbaar is. Hierdoor vervallen vrijwel alle baten zoals beschreven in de use case	Laag	Hoog	Bindende afspraken betreffende commitment en gebruik van alle betrokken diagnostiek aanbieders



Verdieping 1.3 ACP in de keten





1.3.1 ACP in de keten | Proactieve zorgplanning in Twente

De regio zet binnen verschillende samenwerkingsverbanden in op proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning, ofwel advance care planning (ACP), is het proces waarin o.a.

behandelwensen, waarden, behandelgrenzen en behoeften van inwoners worden besproken en vastgelegd



Uit het hoofdstuk Advance Care Planning van het regioplan Twente Beter

Proactieve zorgplanning (ACP) is een multidisciplinair en dynamisch proces van in gesprek gaan, vooruit denken, plannen en organiseren van gewenste passende zorg. Door middel van gesprekken wordt bepaald welke zorg aansluit bij huidige en toekomstige levensdoelen en –keuzes van het individu. Het omvat gezamenlijke besluitvorming met de inwoner en zorgprofessionals onderling over behandelafspraken die zijn afgestemd op de wensen, waarden en behoeften. ACP speelt vaak een belangrijke rol in het palliatieve zorgproces.

In de regio Twente zijn verschillende samenwerkingsverbanden actief om proactieve zorgplanning in de regio zo goed mogelijk te organiseren. In de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en binnen de themalijn ACP van Twente Beter¹ komen deze samenwerkingsverbanden samen om regiobreed in te zetten op de volgende pijlers: bewustwording bij inwoners en zorgprofessionals, samenwerking rondom de kwetsbare persoon, regie voor coördinatie van zorg en communicatie.



De **Netwerken Palliatieve Zorg Twente** hebben de regio Twente als werkgebied. Zij hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Hiervoor bieden zij inwoners, naasten en zorgprofessionals ondersteuning met o.a. informatie, communicatie en scholing



Binnen het samenwerkingsverband **Twente Beter** wordt gewerkt aan de themalijn Advance Care Planning. Bij deze themalijn zijn naast Netwerken Palliatieve Zorg Twente ook samenwerkende partners vanuit de tafels **Zorg voor Morgen** (sub-regio Almelo) en **Samenwerken aan Waarde** (sub-regio Enschede) betrokken.

In de werkgroep ACP in de keten, die het transformatieplan van deze use case heeft opgesteld, zit vertegenwoordiging vanuit deze samenwerkingsverbanden om de aansluiting op de pijlers in de regio te borgen.





1.3.2 ACP in de keten | Kernproblematiek

Geen drempelloos gegevensverkeer over ACP in de keten mogelijk, waardoor zowel inwoner als zorgprofessional niet altijd over de juiste actuele gegevens beschikken om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen



Huidige situatie

Bij proactieve zorgplanning (ACP) zijn niet alleen individuele zorgprofessionals betrokken bij de inwoner, maar meerdere stakeholders uit de eerste, tweede en derde lijn. Momenteel worden ACP-gegevens binnen de zorginstellingen in Twente in verschillende systemen en platformen geregistreerd. Er bestaat geen enkel overzicht of individueel ACP-dossier waar alle betrokken stakeholders 24/7 toegang toe hebben. Deze stakeholders omvatten onder andere zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsenzorg (inclusief huisartsenpost), ambulancedienst, toekomstig zorgcoördinatiecentrum, woonzorg (intramuraal) en wijkzorg (extramuraal).

Het ontbreken van dit overzicht geeft de inwoner het gevoel geen gelijkwaardige partner te zijn in het zorgproces. Hoewel er veel over de inwoner wordt gesproken, wordt er niet altijd met de inwoner gesproken. Bovendien heeft de inwoner zelf geen inzicht in welke zorgprofessionals op de hoogte zijn van zijn of haar (veranderende) wensen, waarden en behoeften. Deze zijn afhankelijk van de levensfase, het ziektebeeld en eventuele progressie. Hierdoor moet de inwoner vaak aan elke zorgprofessional hetzelfde verhaal vertellen, wat onnodige belasting met zich meebrengt, tot fouten kan leiden en tijdrovend is als dezelfde ACP-informatie elders al is geregistreerd. In acute situaties kan dit ertoe leiden dat de inwoner geen weloverwogen beslissing kan nemen over passende vervolgzorg.

Daarnaast kost het zorgprofessionals veel tijd om elders geregistreerde ACP-informatie telefonisch op te vragen, als deze al elders is vastgelegd. Het gebrek aan inzicht in ACP-informatie leidt tot dubbele zorgverlening en niet-passende zorg, omdat deze niet aansluit op de wensen en behoeften in de laatste levensfase. Dit heeft ook invloed op zorgprofessionals, die graag zo goed mogelijk geïnformeerde zorg willen verlenen.

Binnen De Netwerken Palliatieve Zorg Twente, Zorggroep Sint Maarten, Liberein en De Posten loopt momenteel een project waarbij in het ONS systeem (ECD van Nedap) voor zowel intramurale als extramurale verzorgers een waarschuwing (als pop-up) wordt gegeven dat de inwoner palliatief is en in welke fase deze zich bevindt. Aan elke fase zijn specifieke taken gekoppeld. Een van die taken kan bijvoorbeeld zijn dat er een ACP gesprek moet plaatsvinden. De gegevens uit zo'n ACP gesprek zou je graag in de keten willen kunnen delen. Op dit moment is niet te garanderen dat die gegevens dan altijd up-to-date zijn.



Knelpunt 1: Niet weten of en wat andere zorgprofessionals al hebben geregistreerd

Als zorgprofessional heb je geen zicht op de ACP-informatie die elders is geregistreerd. Dit creëert een informatieachterstand en afhankelijkheid van andere zorgprofessionals. Het blijkt vaak lastig om de juiste zorgprofessional te kunnen spreken om verschillende redenen (wisselende diensten, afwezigheid, veel zorgprofessionals betrokken).



Knelpunt 2: Het niet integraal kunnen aanvullen en actueel houden van ACP-informatie

Het individueel zorgplan van een kwetsbare inwoner kan worden aangepast o.b.v. nieuwe wensen of behoeften. Het ontbreken van één overzicht geeft hierin onduidelijkheid en verwarring. Bijvoorbeeld over welke registratie dan leidend is en het meest actueel in het zorgproces? En spreken we hierin wel dezelfde taal?



Knelpunt 3: Onduidelijkheid over regie op dossiervoering

Transmuraal maar ook intramuraal is het vaak niet duidelijk wie de regie voert over de wensen, waarden en behoeften in het ACP-dossier van een inwoner. In de huidige situatie zien we vaak dat iedere zorgprofessional voor het eigen specialisme verantwoordelijk is en regie voert op behandeling. Er is nu geen integraal dossier dat verduidelijkt hoe de taakverdeling in de dossiervoering op wensen, waarden en behoeften wordt bepaald en als basis kan dienen voor coördinatie en samenwerking in het zorgproces.





1.3.3 ACP in de keten | Ambitie tot en met 2026

Passende zorgverlening omdat wensen, waarden en behoeften actueel en real-time inzichtelijk zijn voor betrokken zorgprofessionals



Ambitie tot en met 2026

ACP is van toepassing op **elke inwoner in Twente** omdat het betrekking heeft op de behandelwensen, waarden, behandelgrenzen en behoeften voor ieder mens. Om binnen de transformatieperiode resultaten te kunnen behalen bakenen wij de scope van deze use case af door ons te richten op de **doelgroep inwoners met een palliatieve zorgbehoefte**. In de doorontwikkeling van de use case kan waar passend de doelgroep breder getrokken worden.

Het zou fantastisch zijn als eind 2026...

- Elke inwoner die in een beslisfase van behandelen zit, cyclisch met de arts/verpleegkundige de wensen, waarden en behoeften en met 'samen beslissen' als uitgangspunt bespreekt en vastlegt. Dit maakt dat de Twentse inwoner gelijkwaardiger wordt betrokken en meer eigen regie kan nemen in zijn/haar ziekte proces.
- Voor deze inwoners de geregistreerde wensen, waarden en behoeften voor zorgprofessionals in het ziekenhuis, de huisartsenzorg (incl. HAP) en VVT (intra- en extramuraal) 24/7 inzichtelijk zijn o.b.v. de laatste actuele gegevens (incl. herkomst en auteur), in de context van de voorgeschiedenis in een digitaal ACP-overzicht, gebaseerd op ontsluitingen van diverse bronsystemen zoals EPDs, ECDs en HIS'en
- Elke inwoner in de palliatieve fase zo veel mogelijk overlijdt op de plek van diens voorkeur door goede gegevensuitwisseling van ACP-informatie
- Er meer passende zorg wordt verleend en niet-passende zorg voorkomen. Hiermee ervaart de inwoner een grotere kwaliteit van leven en sterven
- Zorgprofessionals, betrokken in de palliatieve zorg rondom een inwoner, aanvullend op en direct gekoppeld aan het digitale ACP-overzicht communiceren, middels bijv. een communicatiekanaal

Link met IZA-opgaven

- **Passende zorg en vermijden niet-passende zorg;** de beschikbaarheid van relevante zorggegevens maakt het mogelijk om passende zorg te leveren aan de inwoner en niet-passende zorg te vermijden. Er kan zo een betere inschatting worden gemaakt van de benodigde zorg, bijv. voor de keuze om iemand niet op te nemen, of ongewenste behandelingen worden voorkomen
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals;** de regeltijd, waardoor in het zorgproces vertraging wordt opgelopen in bijv. acute zorgsituaties, neemt door de beschikbaarheid van relevante zorggegevens af. Hierdoor kan er meer tijd worden besteed aan verlening van passende zorg voor de inwoner.





1.3.4 ACP in de keten | Doorontwikkeling

Verwerken en verrijken van wensen, waarden en behoeften, met meer automatisering in het zorgproces en meer sectoren aangesloten



Doorontwikkeling

Na de implementatie van het transformatieplan zijn de volgende doorontwikkelingen mogelijk op het gebied ACP in de keten

Toevoegen van andere sectoren

Als doorontwikkeling voegen we sectoren toe die nog niet binnen de scope van deze use case zijn gevallen. Dit zijn sectoren zoals:

- Ambulancezorg
- Apothekerszorg
- Gehandicaptenzorg
- GGZ
- Verslavingszorg
- Zorgcoördinatiecentrum
- Vrijwilligers
- Sociaal domein, met daar binnen bijv. de hulp thuis uit de Wmo

Mogelijkheid tot verwerken en verrijken van ACP-gegevens

Naast het inzien van de wensen, waarden en behoeften van kwetsbare inwoners, streven we ernaar om in de toekomst de ACP-informatie te verwerken en te verrijken. Vooral in de palliatieve fase zijn deze wensen, waarden en behoeften dynamisch en vereisen voortdurende afstemming en aanpassing. Dit vraagt om nieuwe functionaliteiten en duidelijke werkafspraken voor gegevens-uitwisseling, inclusief afspraken over verantwoordelijkheden en regievoering.

Automatisering in het zorgproces

Automatisering in het proces kan de volgende dingen betekenen:

- Het automatisch meesturen en kunnen escaleren van behandelwensen. Dit vindt plaats nog voordat een inwoner is ontslagen, bij een verwijzing en terugkoppeling naar zowel de huisarts als de medische specialist.
- Een automatische reminder/melding als er wijzigingen worden aangebracht of als het digitaal ACP-overzicht niet helemaal compleet is ingevuld door regievoerder.

Evt. Benchmarking

Het benchmarken van palliatieve zorgindicatoren of andere specifieke thema's biedt tal van voordelen. Het stelt ons in staat om snel nieuwe situaties te identificeren, regionale en landelijke verschillen op te sporen, aanstaande uitdagingen te voorspellen en vroegtijdig verbeterplannen in te zetten



1.3.5 ACP in de keten | Beschrijving fictieve inwoner- en gebruikersreis ACP in de keten

Er kan t.a.t. rekening gehouden worden met Henk's wensen, waarden en behoeften door actueel inzicht

Vanuit de vastgestelde ambitie is een fictieve inwoner- en gebruikersreis uitgewerkt om weer te geven hoe het toekomstige zorgproces met proactieve zorgplanning, ondersteund door transmurale gegevensuitwisseling, kan plaatsvinden. In deze inwoner- en gebruikersreis komen meerdere stakeholders naar voren die in onderstaande legenda zijn opgenomen

De volgende **stakeholders** worden genoemd in de fictieve inwoner- en gebruikersreis van **Henk**:

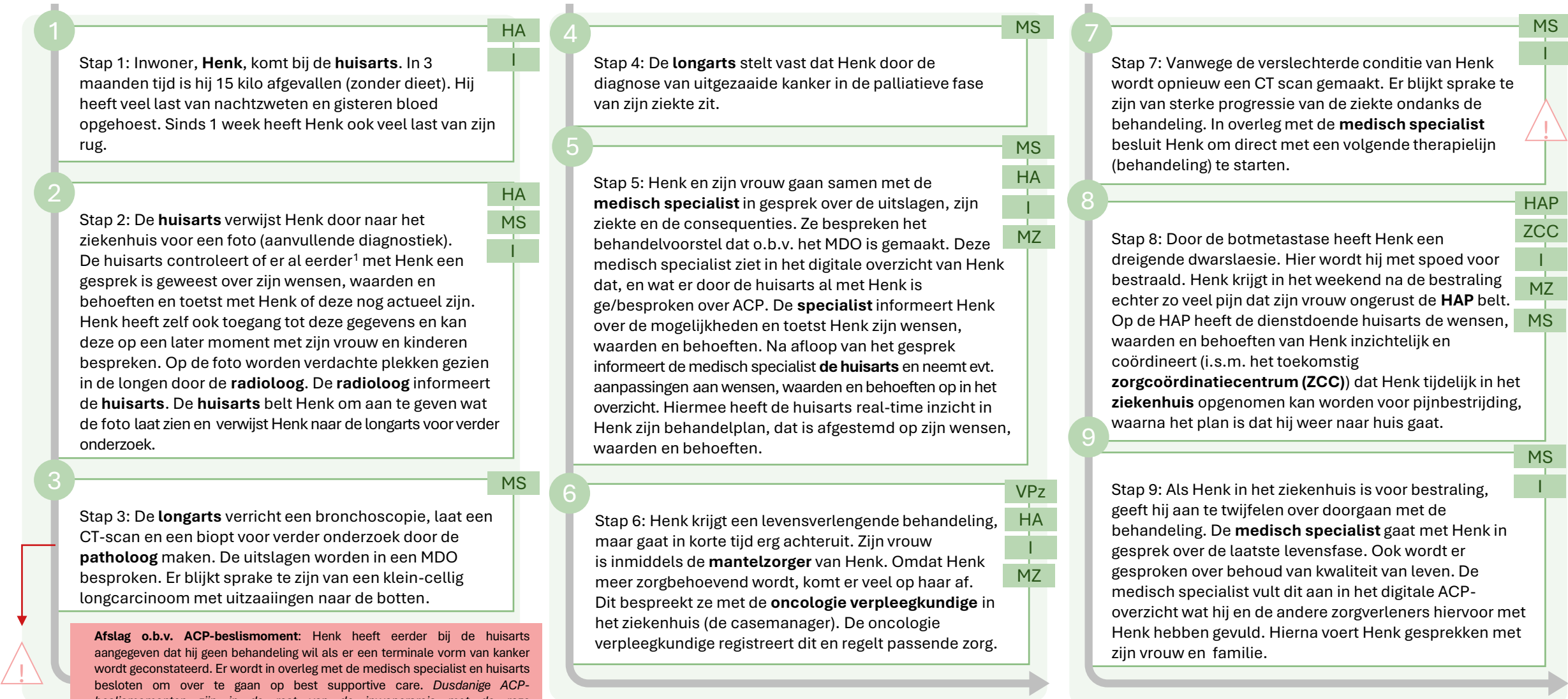
- | | | |
|---|---|--|
|  Inwoner (I) |  Wijkverpleegkundige (WVP) |  Landelijke meldkamer (112) |
|  Huisarts (HA) |  POH-GGZ (POH) |  Ambulancedienst (AMB) |
|  Medisch Specialist (MS) |  Mantelzorger (MZ) |  Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) |
|  Verpleegkundige in ziekenhuis (VPz) |  Huisartsenpost (HAP) | |

NB. Proactieve zorgplanning is een **dynamisch** en **continue proces**, dat niet alleen in de palliatieve of terminale fase van een ziekte plaatsvindt. Dit proces kan namelijk al eerder beginnen, wanneer een inwoner graag zijn wensen, waarden en behoeften wil bespreken met een zorgprofessional. Denk hierbij aan inwoners met een chronische aandoening, waar zij lang mee kunnen leven maar waarin wensen, waarden en behoeften belangrijk zijn om kwaliteit van leven te handhaven of te bevorderen.

Zorgprocessen kunnen veranderen o.b.v. wensen, waarden en behoeften en inwoners kunnen hier ook op terugkomen. Daarnaast zijn er door (veranderingen in) het ziektebeeld van de inwoner ook verschillende mogelijkheden om het proces te doorlopen, waarbij niet alle bovengenoemde stakeholders betrokken hoeven te zijn. Met de fictieve inwoner- en gebruikersreis van Henk geven we conform de ambitie in ieder geval weer welke stakeholders een rol spelen in transmurale gegevensuitwisseling eind 2026.

1.3.5 ACP in de keten | Beschrijving fictieve inwoner- en gebruikersreis ACP in de keten

Er kan t.a.t. rekening gehouden worden met Henk's wensen, waarden en behoeften door actueel inzicht



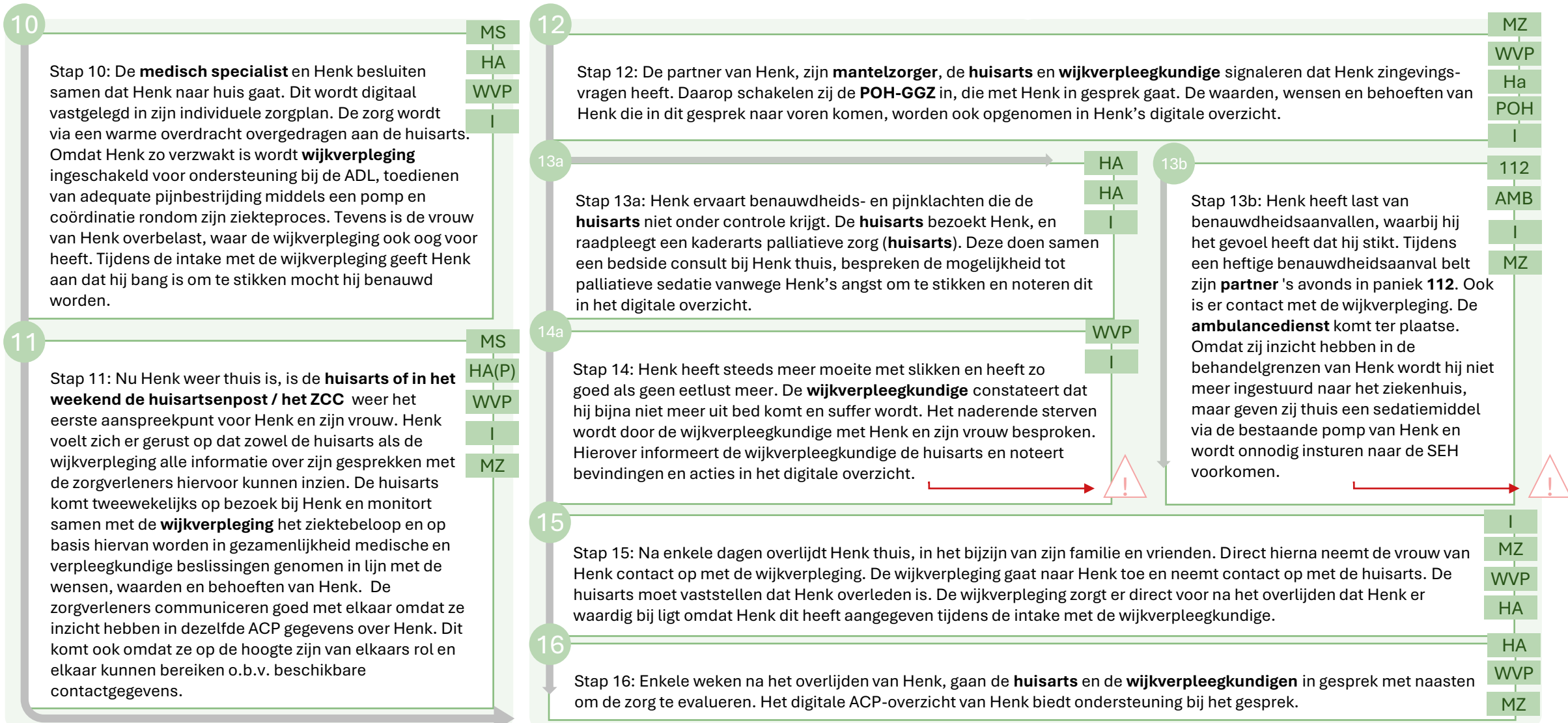
Zie voor vervolg p.55

1) Met eerder bedoelen we de fase waarin Henk nog geen (palliatieve) zorgvraag had. In deze fase kunnen ook wensen, waarden en behoeften van inwoners vastgelegd worden in het digitale ACP-overzicht.



1.3.5 ACP in de keten | Beschrijving fictieve inwoner- en gebruikersreis ACP in de keten

Er kan t.a.t. rekening gehouden worden met Henk's wensen, waarden en behoeften door actueel inzicht





1.3.5 ACP in de keten | Beschrijving beoogde effecten fictieve inwoner- en gebruikersreis ACP in de keten

Er kan t.a.t. rekening gehouden worden met Henk's wensen, waarden en behoeften door actueel inzicht



Beoogde effecten voor Henk

- *Henk heeft er invloed op dat hij passende zorg krijgt die aansluit bij zijn wensen, waarden en behoeften en er wordt niet-passende zorg voorkomen, zoals een opname in het ziekenhuis als hij dit niet wil*
- *Henk heeft inzicht in zijn eigen wensen, waarden en behoeften, die hij bespreekt met zijn naasten en zorgverleners in zijn palliatieve zorgproces*
- *Henk kan aanvullend met de zorgverleners het gesprek voeren over wensen, waarden behoeften i.p.v. elk gesprek met een nieuwe zorgverlener blanco in te gaan*
- *Henk kan eventuele veranderingen in zijn wensen, waarden en behoeften aangeven en kan ervan uitgaan dat ze inzichtelijk zijn voor alle betrokken zorgverleners*
- *Henk ervaart dat zijn vrouw als mantelzorger wordt gezien, onderdeel is van het zorgproces en evt. overbelasting van haar als mantelzorger vroegtijdiger gesignaleerd kan worden*



Beoogde effecten voor de zorgverleners in de inwonersreis van Henk

- *De zorgverleners hebben overzicht over wie er betrokken zijn in het zorgproces en wie, wat aan gegevens over ACP heeft ingevuld en ook wat er niet is ingevuld, of (nog) getoetst moet worden*
- *Bij bestaande ACP-gegevens kunnen de zorgverleners die Henk in zijn palliatieve zorgproces behandelen wensen, waarden en behoeften cyclisch en dynamisch toetsen en verrijken i.p.v. registreren*
- *De zorgverleners hebben met het digitale overzicht duidelijkheid over wie de regie voert over ACP of kunnen hierdoor duidelijker met elkaar het gesprek voeren over wie regie moet voeren.*
- *De zorgverleners kunnen in acute situaties niet-passende zorg voorkomen omdat o.b.v. de beschikbare ACP gegevens weloverwogen beslissingen gemaakt kunnen worden*





1.3.6 ACP in de keten | Fit-gap analyse op inhoud & techniek

Van statische of telefonische uitwisseling van ACP-gegevens naar actueel inzicht o.b.v. uniforme dataregistratie

Inhoud & Techniek	
1. Huidige proces en workflow	- De verschillende zorgprofessionals werken in hun eigen bronsystemen. Tussen deze bronsystemen worden geen ACP-gegevens uitgewisseld. Deze uitwisselingen vinden veelal per statisch document of telefonisch contact plaats: - Huisartsen gebruiken het HIS en veelal VipLive, hierin beschikken zij over een ACP-formulier welke nog niet in alle gevallen wordt gevuld. Ook zijn er andere toepassingen waarin ACP-gegevens geregistreerd worden, bijv. A20 memo's, palliatieve memo's. - Medisch specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis registreren bevindingen in het EPD. Hierin is binnen MST het "proactieve zorg"-formulier beschikbaar, door "iedereen in wit" bij te werken. Overdracht in proces gaat digitaal door als medische brief (statisch document) te verzenden. - Overdrachten binnen het verpleegkundig proces worden gecoördineerd via het transferbureau met aanvraag/overdracht in POINT. - HAP heeft enige toegang tot HiS huisarts, niet tot het EPD en niet tot ACP-gegevens - De wijkverpleging werkt met het ECD van ONS (Nedap) of Ecare Puur en heeft nauwelijks tot geen inzicht in ACP-gegevens die zijn geregistreerd door andere zorgverleners - In verpleeghuizen leggen specialisten ouderengeneeskunde (SOGs) ACP vast in Ysis van Gerimedica 112-melding: centrale meldkamer heeft geen koppeling met andere systemen, waaronder ACP-gegevens niet inzichtelijk zijn - In spoedsituaties: pullverkeer (o.a. opvragen van spoedsamenvattingen) en push-verkeer (verwijzingen of ambulanceberichten) - Ook vindt er nog analoge registratie, in bijv. patzgroepen/ wensboekje etc. Hoewel deze zorgen voor aandacht voor ACP, zijn deze gegevens niet digital beschikbaar - De ACP-gegevens die geregistreerd worden zijn niet volgens een standaard gedefinieerd. Er is nog geen eenheid van taal en communicatie wordt gestuurd door het formulier wat je moet invullen. - Markeringen van de ziektefase van een inwoner vindt niet altijd plaats, wat tot onduidelijkheid kan leiden in het proces
2. Vereisten nieuwe proces	- ACP-gegevens zijn (near) real-time beschikbaar - ACP-gegevens zijn scherp gedefinieerd, o.b.v. zorginformatiebouwstenen (zibs) en kunnen niet anders geïnterpreteerd worden - ACP-gegevens zijn in alle onderliggende systemen gelijk en worden geregistreerd met eenheid van taal - ACP-gegevens komen beschikbaar of zijn gekoppeld aan overdrachten - inwoner en alle betrokken zorgverleners zoals beschreven in de inwonersreis kunnen wensen, waarden en behoeften aanvullen, bijv. voorafgaand aan afspraken met de huisarts. Let op: binnen de ambitie valt nog niet het kunnen verwerken en verrijken van de informatie. - Koppeling tussen landelijke meldcentrale en regionaal systeem die belangrijke gezondheidsproblemen inzichtelijk heeft - Zorgverleners krijgen een melding zodra nieuwe ACP-gegevens zijn geregistreerd - Kunnen markeren van de palliatieve / stervensfase
3. Voorgestelde overbrugging tussen oud en nieuw	- Keuzes maken over ACP-gegevens: - Welke data vastleggen - Wie heeft toegang, met welke rechten (lezen/schrijven) en op welk moment - Hoe is toegang voor zorgprofessionals en de inwoner georganiseerd - Hoe toestemming van de inwoner is georganiseerd - Bij veranderingen in data wordt gealarmeerd - Wie regievoerder is binnen welke stap in het ACP zorgproces - Keuze voor standaard format van data/informatieregistratie t.b.v. gegevensuitwisseling - Geen nieuwe systemen introduceren, maar bronsystemen koppelen met daarbij als startpunt in de integratie een breed gedragen systeem in de regio - Verdere implementatie (en uitbreiding?) van het programma Met Spoed Beschikbaar voor behandelgrenzen in de spoedsamenvatting conform de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg





1.3.6 ACP in de keten | Fit-gap analyse op proces & beleid

Van het ontbreken van afspraken over overdrachten, regie & coördinatie naar een regionale werkwijze

Proces & beleid	
1. Huidige proces en workflow	• Organisaties registreren de informatie in hun eigen systeem, meestal zonder overdracht naar keten/netwerkpartners • Er vindt niet altijd een overdracht plaats. Wanneer er wel (warme) overdrachten plaatsvinden zijn deze telefonisch of per brief (statisch document). • Er zijn geen procesafspraken over overdrachten van ACP-gegevens naar andere zorgverleners; vaak wordt dit op een pragmatische basis gedaan o.b.v. wat een zorgverlener weet over de inwoner en een manier waarop het eerder goed is ervaren • De verantwoordelijkheid voor het delen of geven van informatie is nergens in vastgelegd • Zorgverleners zijn nog te behouden in het delen van ACP-gegevens omdat de AVG niet altijd correct geïnterpreteerd wordt
2. Vereisten nieuwe proces	• AVG wordt correct toegepast (en vormt geen belemmering voor handelen). • Er is duidelijkheid over wie de regievoerder is m.b.t. ACP op elk moment van de inwonersreis • Werkafspraken t.a.v. signalering, monitoring en registratie van ACP gegevens • inwoner krijgt passende informatievoorziening over welke regie de inwoner zelf kan hebben en hoe gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden
3. Voorgestelde overbrugging tussen oud en nieuw	• Afspraken maken over rolverdeling vanuit centrale zorgverlenerschap. Wie heeft welke rol en taak. Een belangrijke taak hierin is het regievoederschap over het ACP proces, bijv. dat de hoofdbehandelaar de regie voert over ACP; tenzij in overleg gedelegeerd • Afspraken maken over een eenduidige regionale werkwijze, doorvertaald naar de eigen organisatie; dit zijn afspraken over het informeren van andere zorgverleners (zoals HAP door huisarts, of de dienstdoende coördinator op het ZCC), maar ook over het invullen van de wensen, waarden en behoeften per zorgverlener gespecificeerd en per stap in het zorgproces gedefinieerd of het actief markeren van de stervensfase (bijv. er staat al een palliakit)





1.3.6 ACP in de keten | Fit-gap analyse op Mens

Van onwetendheid en barrières om ACP-gegevens te registreren naar omarming en goed geïnformeerde zorgverleners en inwoners

Mens		
	Inwoner/naaste	Zorgverlener
1. Huidige proces en workflow	• Er zijn grote verschillen tussen zorgverleners in het wel of niet registreren van ACP-informatie, afhankelijk van de aandacht voor ACP in het eigen zorgproces • Om verschillende redenen kunnen of willen zorgverleners ACP gegevens registreren nog niet inbedden in hun dagelijkse werkzaamheden; dit zijn o.a. het ontbreken van gevoel van eigenaarschap, het ontbreken van tijd, overvraging op andere vlakken, handelingsverlegenheid m.b.t. ACP gespreksvaardigheid, nog geen beeld bij wat het oplevert • De inwoner heeft geen idee wat hem overkomt in het proces, wordt daar ook niet standaard in meegenomen en heeft ook geen beeld bij welke zorgverleners er achter de schermen contact hebben over ACP • Als zorgverleners niet op de hoogte zijn van ACP gegevens moet inwoner zijn hele verhaal vertellen (of zijn MZ) wat erg belastend kan zijn • Er zijn wel degelijk best practices binnen zorgorganisaties m.b.t. ACP, maar deze zijn vaak persoonsafhankelijk en worden niet tussen met andere organisaties gedeeld • De heersende cultuur is nog veel van het ‘halen’ – reactief, wanneer ACP gegevens nodig zijn wordt geïnformeerd bij een ander	
2. Vereisten nieuwe proces	• De inwoner weet wie de regievoerder is en waar hij met vragen omtrent ACP terecht kan en moet samen kunnen beslissen (met mantelzorger) in gesprek met zorgverleners omdat hij beschikt relevante informatie. Hij kan zelf echt regie hebben over zijn wensen, waarden en behoeften • Inwoner heeft zelf ook een rol in ACP en is op de hoogte dat er een mogelijkheid is om zijn wensen te laten registreren en kan vooraf registreren. En weet daarnaast wat de meerwaarde is hiervan voor inwoner zelf en de naasten. • Zorgverleners hebben vertrouwen in henzelf en in andere zorgverleners in het registreren van wensen, warden en behoeften • Zorgverleners voelen dat ze minder barrières hebben om een begin te kunnen maken met ACP gegevens registreren	
3. Voorgestelde overbrugging tussen oud en nieuw	• Scholing van zorgverleners in nieuwe werkafspraken/-processen en transmurale gegevensuitwisseling van ACP-gegevens, o.b.v. ontwikkeld scholingsmateriaal • Communicatie over regievoering en gegevensuitwisseling ACP moet tussen zorgverleners en tussen zorgverlener en inwoner zijn afgestemd • Inwoners en zorgverleners goed informeren over de gevolgen van keuzes te maken bij ACP, bijv. door het kijken van de informatiefilm van NPZT – ontwikkeling van informatiemateriaal over ACP in de keten	





1.3.7 ACP in de keten | Betrokken stakeholders op organisatieniveau, hun rol in het zorgproces en de transformatie

Directe en indirecte beïnvloeders van de registratie van ACP-gegevens



Verdieping op de betrokken stakeholders

	Primaire/secundaire stakeholder	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
inwoner	• Primair	• Hoog	• Inwoner kan proactieve rol innemen in eigen ACP proces omdat hij/zij inzicht heeft in eigen gegevens • Inwoner kan met mantelzorger & naaste(n) in gesprek aan de hand van het digitaal ACP overzicht	• Inwoner is niet meer zelf verantwoordelijk voor het bewaken van het overzicht in wie wat van hem/haar weet
Mantelzorger & naaste(n)	• Secundair	• Hoog	• Mantelzorgers ondersteunen de inwoner in de aanvulling en toetsing van ACP-gegevens (let op: mantelzorg en naasten hebben andere juridische rechten)	• Mantelzorgers hoeven minder in de regelmodus en/of als vertegenwoordiger van de inwoner op te treden om diens wensen, waarden en behoeften te behartigen bij meerdere zorgverleners
Huisarts¹	• Primair	• Hoog	• Huisartsen kunnen regievoerder zijn over het ACP-proces (hieronder vallen taken zoals signaleren, coördineren en monitoren van het proces) • Huisartsen voeren ACP-gesprekken en registreren deze in het digitale ACP-overzicht • Huisartsen toetsen geregistreerde ACP-gegevens baseren behandelplannen op nieuwe of reeds geregistreerde ACP-gegevens	• Als huisartsen regievoerder zijn over het ACP-proces is dit o.b.v. gezamenlijke afspraken duidelijk voor andere zorgverleners en inwoner
Medisch specialist (incl. specialist ouderen-geneeskunde)	• Primair	• Hoog	• Medische specialisten kunnen regievoerder zijn over het ACP-proces (hieronder vallen taken zoals signaleren, coördineren en monitoren van het proces) • Medisch specialisten voeren ACP-gesprekken en registreren deze in het digitale ACP-overzicht • Medisch specialisten toetsen geregistreerde ACP-gegevens en baseren behandelplannen op nieuwe of reeds geregistreerde ACP-gegevens	• Als medisch specialisten regievoerder zijn over het ACP-proces is dit o.b.v. gezamenlijke afspraken duidelijk voor andere zorgverleners en inwoner

De keuze voor **primaire/secundaire** stakeholder is in deze use case afgebakend op de **directe of indirecte beïnvloeding van de registratie van ACP-gegevens**. Onder primaire stakeholders verstaan wij zij die direct gegevens beïnvloeden, onder secundaire stakeholders zij die indirect gegevens beïnvloeden.

De keuze voor **mate van betrokkenheid (hoog/midden/laag)** is gebaseerd op hoe nauw de stakeholder betrokken is bij de inwoner in de tijd die men met inwoner doorbrengt en de band die daardoor tussen inwoner en stakeholder kan ontstaan





1.3.7 ACP in de keten | Betrokken stakeholders op organisatieniveau, hun rol in het zorgproces en de transformatie

Directe en indirecte beïnvloeders van de registratie van ACP-gegevens

 Verdieping op de betrokken stakeholders¹	Primaire/secundaire stakeholder	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
Wijkverpleegkundige	• Primair	• Hoog	• Wijkverpleegkundigen kunnen regievoerder zijn over het ACP-proces (hieronder vallen taken zoals signaleren, coördineren en monitoren van het proces) • Wijkverpleegkundigen voeren ACP-gesprekken en registreren deze in het digitale ACP-overzicht	• Wijkverpleegkundigen kunnen een grotere rol innemen en meer verantwoordelijkheid krijgen in het ACP proces. Vaak zijn zij nauw betrokken bij de laatste levensfase van een inwoner. Hierdoor kunnen zij op een laagdrempelige manier wensen, waarden en behoeften van een inwoner uitvragen, toetsen of aanvullen.
Verpleegkundige in het ziekenhuis, bijv. in PAZ-team	• Primair	• Hoog	• Verpleegkundigen in het ziekenhuis kunnen regievoerder zijn over het ACP-proces (hieronder vallen taken zoals signaleren, coördineren en monitoren van het proces) • Verpleegkundigen in het ziekenhuis voeren ACP-gesprekken, registreren en/of toetsen deze in het digitale ACP-overzicht	• Als verpleegkundigen in het ziekenhuis regievoerder zijn over het ACP-proces is dit o.b.v. gezamenlijke afspraken duidelijk voor andere zorgverleners en inwoner
Huisartsenpost	• Secundair	• Midden	• Op basis van reeds geregistreerde ACP-gegevens weloverwogen besluiten nemen t.a.v. passende zorg voor de inwoner	• De gegevens die de HAP tot zijn beschikking heeft zijn digitaal en actueel inzichtelijk
POH	• Primair	• Laag	• POH voert ACP-gesprekken en kan deze registreren in het digitale ACP-overzicht (bijv. POH-GGZ)	• Mogelijkheid tot registreren
Zorgcoördinatiecentrum²	• Secundair	• Midden	• Op basis van reeds geregistreerde ACP-gegevens weloverwogen besluiten nemen t.a.v. passende zorg voor de inwoner	• De gegevens die het ZCC tot hun beschikking heeft zijn digitaal en actueel inzichtelijk
Ambulancedienst²	• Secundair	• Midden	• Op basis van reeds geregistreerde ACP-gegevens weloverwogen besluiten nemen t.a.v. passende zorg voor de inwoner	• De gegevens die de ambulancedienst tot zijn beschikking heeft zijn digitaal en actueel inzichtelijk
Landelijke meldkamer²	• Secundair	• Midden	• Op basis van reeds geregistreerde ACP-gegevens weloverwogen besluiten nemen t.a.v. passende zorg voor de inwoner	• De gegevens die de landelijke meldkamer tot zijn beschikking heeft zijn digitaal en actueel inzichtelijk
Apotheekzorg²	• Secundair	• Midden	• Op basis van reeds geregistreerde ACP-gegevens weloverwogen besluiten nemen t.a.v. passende zorg voor de inwoner	• De gegevens die de apotheekezorg tot zijn beschikking heeft zijn digitaal en actueel inzichtelijk

1) Vrijwilligers zijn niet meegenomen in het stakeholderoverzicht i.v.m. wet en regelgeving over privacy. Na 2026 willen we onderzoeken in welke vorm vrijwilligers betrokken kunnen zijn bij ACP in de keten, gezien toenemende samenwerking tussen zorgprofessionals en vrijwilligers in de zorg rondom een inwoner, 2) Deze sectoren worden na de transformatieperiode meegenomen in de doorontwikkeling van de use case





1.3.8 ACP in de keten | Afspraken nieuwe werkwijze – Organisatie- en regiobeleid

Landelijke en regionale kaders m.b.t. samen beslissen en palliatieve zorg geven richting aan de invulling van de use case

Wet- en regelgeving & beleid

Aanvullend op de algemene wet- en regelgeving waar de use case aan dient te voldoen, is de volgende landelijke wet belangrijk:

- de **Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding** omdat wensen, waarden en behoeften een euthanasiewens kunnen beschrijven

Daarnaast is er het **Nationaal Programma Palliatieve Zorg II**, waarbinnen digitale gegevensuitwisseling een strategisch thema is. Binnen deze use case houden we rekening met ontwikkelingen in dit programma.

Regionale afspraken

In opdracht van Zorg voor Morgen en Samenwerken aan Waarde is het **regionaal kader en implementatieadvies voor Samen beslissen met kwetsbare ouderen** opgesteld.

Binnen deze documenten speelt proactieve zorgplanning een belangrijke rol. Zo zijn er regionale afspraken over **informatie-overdracht** gemaakt en is er advise uitgebracht welke stappen te zetten om deze te implementeren. Het ontbreekt in deze stappen nog aan keuzes voor de manier waarop informatie wordt overgedragen.

- In lijn met de regionale afspraken over informatie-overdracht dienen keuzes te worden gemaakt en vastgelegd voor de manier waarop informatie wordt overdragen.

Richtlijnen

- Tijdens de COVID-19 pandemie is de **leidraad voor het process en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning** opgesteld door de NHG, V&VN, Verenso, Patiëntenfederatie NL, NVAVG en FMS. Deze leidraad kan inspiratie binnen voor procesafspraken binnen de use case ACP in de keten
- N.a.v. bovengenoemde leidraad is de **richtlijn Proactieve Zorgplanning** opgesteld, met de NHG als regiehouder, in 2023 vastgesteld.
- Er bestaat nog geen richtlijn of informatiestandaard voor de transmurale gegevensuitwisseling van ACP-gegevens. Wel is o.b.v. de richtlijn Proactieve Zorgplanning het IKNL i.s.m. Palliatieve Zorg NL en Stichting CareCodex een **pilot gestart voor het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens**. Het doel is om een gedragen **informatiestandaard** te realiseren, die binnen deze use case een belangrijke rol gaat spelen.
- Het **kwaliteitskader palliatieve zorg en m.n. de secties gericht op regie, coördinatie en proactieve zorgplanning** is een belangrijke richtlijn om te volgen in het ACP-process gedurende de zorg aan een inwoner in palliatieve fase
- Vanuit verschillende koepelorganisaties zijn er richtlijnen en handreiking opgesteld voor proactieve zorgplanning. Hier dient binnen de use case aan te worden voldaan.

- Voldoen aan de informatiestandaard voor het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van ACP-gegevens o.b.v. de IKNL-pilots

Randvoorwaarde





1.3.8 ACP in de keten | Randvoorwaarden nieuwe werkwijze

Focus op het wegnemen van barrières



Randvoorwaarden



Randvoorwaarde aan de techniek

- Het kunnen inzien van het digitale ACP overzicht vanuit de diverse bronsystemen
- Aansluiten bij landelijk ontwikkelde informatiestandaarden en technische ontwikkelingen m.b.t. de ACP-use cases van de CumluZ-coalitie
- Real time beschikbaarheid van het digitale ACP-overzicht (waarbij real time , 15 min)
- Geen nieuwe systemen introduceren, maar huidige systemen ontsluiten
- Mogelijkheid tot invoeren wie regiehouder over de ACP-gegevens is op welk het moment in het zorgproces en regievoering kunnen overdragen
- Voorkomen van toenemende registratielast door dubbelingen registratie/rapportage
- Voorkomen van vinklijsten onder het mom van standaardisatie, t.b.v. van vrijheid in de mogelijkheden om wensen, waarden en behoeften te registreren



Randvoorwaarde aan het proces

- Afspraken maken over en handhaven wie regievoerder (afhankelijk van waar de inwoner zich bevindt in het proces) is over het digitale ACP-overzicht
- Afspraken maken welke rechten stakeholders in het zorgproces hebben m.b.t. het digitale ACP-overzicht
- Afspraak maken over welke gegevens/informatie de inwoner kan beschikken en dat deze dan in begrijpelijke taal is geformuleerd
- De mogelijkheid tot handhaving van warme overdrachten aanvullend op het digitale ACP-overzicht
- Afspraken maken hoe het kwaliteitskader palliatieve zorg NL aangevuld kan worden inzake coördinatie en continuïteit van het ACP zorgproces



Randvoorwaarde aan de mens

- Eigenaarschap over rol in het ACP-proces moet gevoeld worden
- Inwoner wordt geïnformeerd over zijn ACP traject door regievoerder
- Barrières om ACP-gesprekken te voeren zijn weggenomen
- Zorgprofessionals hebben in eigen gespreks- en handelingsvaardigheden m.b.t. ACP en gegevensuitwisseling
- Vertrouwen in elkaar en elkaars ACP registraties
- Mindset-shift als diverse zorgprofessionals in de verschillende domeinen van een haal-cultuur naar een breng-cultuur als het gaat om ACP-gegevens beschikbaar stellen



1.3.9 Impactanalyse | ACP in de keten

Meer regie voor inwoner en zorgprofessional, waardoor meer passende zorg voor het individu mogelijk

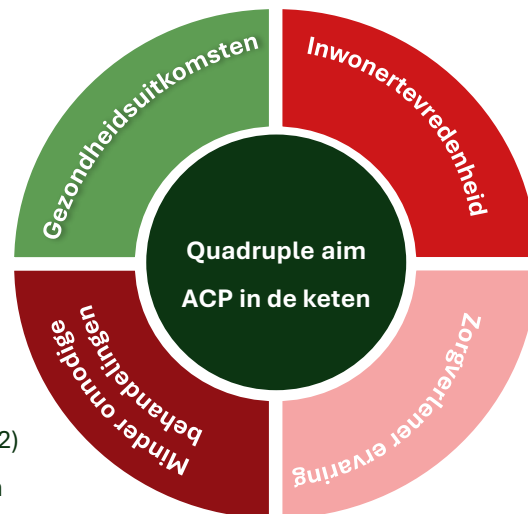
ACP in de keten verbetert de ervaring van inwoners door hen meer regie te geven, waardoor er wordt gestreefd naar meer passende zorg en het voorkomen van onnodige behandelingen en diagnostiek. Daarnaast verbetert de tevredenheid van de zorgprofessional omdat zij weloverwogen besluiten kunnen nemen en regie en coördinatie van het ACP-proces duidelijker is. Met de kanttekening dat deze impact met name wordt gerealiseerd door het toepassen van ACP. Transmurale gegevensuitwisseling faciliteert en katalyseert de ACP gedurende het hele ACP proces van de inwoner door goede gegevensoverdracht en duidelijke regie & autonomie van de inwoner.

Gezondheidszorg uitkomsten

- Meer passende en doelmatige zorg
- Juiste zorg op juiste plek
- Voorkomen niet-passende zorg
- In de toekomst beter kunnen sturen op ACP-proces door inzicht

Minder onnodige behandelingen

- Voorkomen van acute zorg, zoals SEH-opnames (redenatielijn 1)
- Minder klinische ligdagen (redenatielijn 2)
- Minder gebruik dure geneesmiddelen en behandelmaterialen vanwege eerder staken onnodige behandelingen
- Voorkomen overlijden in het ziekenhuis
- Minder diagnostiek (impact niet meegenomen vanwege use case diagnostisch portaal)
- Verschuiving zorglast naar 1^e lijn: Ha, wijkzorg en hospice (gevolg)



Inwonertevredenheid

- Zorg o.b.v. wensen, waarden en behoeften
- Meer eigen regie en gevoel betrokken te zijn
- Geruststelling en vertrouwen door beschikbaarheid wensen, waarden en behoeften bij betrokken zorgverleners
- Inwoner hoeft niet telkens opnieuw wensen, waarden en behoeften vanaf 0 te vertellen
- Ontzorgen familieleden en mantelzorg vanwege meer samen kunnen beslissen

Zorgprofessionaltevredenheid

- Vertrouwen in het (proactiever) kunnen nemen van weloverwogen besluiten
- Verbetering relatie met inwoner
- Minder tijd kwijt aan overdracht in de keten (informeren / halen en brengen)
- Duidelijkheid over regievoering en benodigde acties m.b.t. ACP omdat wie, wat, wanneer heeft vastgelegd inzichtelijk is
- Makkelijker coördineren van ACP-proces

Wat het **vraagt** van betrokkenen:

- Potentieel **meer capaciteit in de 1^e lijn nodig** (huisartsenzorg, wijkzorg en hospice) vanwege mogelijke verschuiving van zorglast
- **Meer tijd & capaciteit voor het voeren van ACP gesprekken**, in een continu proces, door zorgverleners (hier wordt in de business case rekening mee gehouden)
- Mindset-verandering naar **inwoner als partner in het ACP proces**, waarbij er meer samen beslist wordt en op basis van wensen, waarden en behoeften zorg wordt verleend (hier wordt rekening mee gehouden in het inclusiepercentage van de impactdrijvers)





1.3.9 Kwantificatie redenatielij 1: Minder SEH bezoeken van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte

Goede gegevensuitwisseling vermindert in 2026 ~22% van de potentieel niet-passende SEH bezoeken van Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte



Vermindering SEH bezoeken van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte

In acute situaties, waarbij bijv. 112, de HAP of de huisarts wordt gebeld vanuit de thuissituatie, of vanuit een verblijf in een verpleeginstelling, zijn wensen, waarden en behoeften van de individu in het digitale ACP-overzicht in beeld. Hierdoor kan weloverwogen, gebaseerd op de wensen, waarden en behoeften besloten worden om iemand niet meer naar de spoedeisende hulp te brengen, maar best supportive care te verlenen. Wij verwachten dat de use case ACP in de keten op in 2026 ca. 6% van de SEH bezoeken van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte kan verminderen.



Meer zorg verleend in eerste/nuldelijn

Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte worden langer en intensiever in de thuissituatie behandeld door wijkverpleging. Ook zal de inzet van huisartsen voor deze inwonergroep stijgen en zullen huisartsen van meer inwoners hoofdbehandelaar zijn. Daarnaast wordt er meer gebruik van palliatieve sedatiemiddelen en minder gebruik van medicatie voor co-morbide ziekten verwacht o.b.v. resultaten uit wetenschappelijk onderzoek³.

In algemene zin verwachten we dat de zorgkosten van palliatieve inwoners in de MSZ afnemen in de laatste levensfase, maar toenemen voor de huisartsenzorg en voor de wijkverpleging.

Gevolg

Sector	Medisch specialistische zorg
Inwoners	Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte
# inwoners	4603 (Palliaweb Twente, 2022) - + bevolkingsgroei
# effect	28% van de SEH-bezoeken voorkomen o.b.v. Patz-cijfers, waarin we het effect van de palliatieve zorgfunctionaris vergelijken met het beschikbaar hebben van gegevens in de keten¹ - Per inwoner gem. 0,4 SEH bezoeken¹
% inclusiepercentage over de jaren	o.b.v. inclusie van 1) inwoners die hun wensen, waarden en behoeften bespreken met zorgprofessionals en 2) zorgprofessionals die kunnen en willen werken met ACP in de keten en 3) de uitrol van de use case in de regio

Inclusiepercentages

Het inclusiepercentage is gebaseerd op:

- het aantal inwoners dat wensen, waarden en behoeften wil registreren.
- het aantal zorgprofessionals dat wensen, waarden en behoeften-gesprekken aangaat en registreert met inwoners. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op eigen ervaringen binnen de werkgroep
- opstarten technische uitrol in 2025

Jaar	Inclusie inwoners (%)	Inclusie zorgprof (%)
2024	0	0
2025	25	47
2026	40	56
2027	55	61
2028	65	66
2029	70	70
2030	75	75

Uitkomsten impactanalyse (zie p. 67 voor voorbeeldsom)

Jaartal	% van te voorkomen SEH bezoeken gerealiseerd	Aantal SEH-bezoeken
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

¹⁾ Rapport Palliatieve zorg in de eerste lijn (2017, [link](#)), ²⁾ De olifant de kamer uit, Gupta Strategists (2024, [link](#)), ³⁾ Effects of an Integrated Palliative Care Pathway: More Proactive GPs, Well Timed, and Less Acute Care: A Clustered, Partially Controlled Before-After Study (2021)





1.3.9 Kwantificatie redenatielij 2: Minder klinische opnames van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte

Goede gegevensuitwisseling vermindert in 2026 ca. 4% van de potentieel niet-passende klinische ligdagen van Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte



Reductie klinische ligdagen van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte

In situaties waarin de inwoner verslechterd zijn wensen, waarden en behoeften van de individu in het digitale ACP-overzicht in beeld. Hierdoor kan weloverwogen, gebaseerd op de wensen, waarden en behoeften besloten worden om iemand niet meer in het ziekenhuis op te nemen, maar best supportive care te verlenen. Wij verwachten dat de use case ACP in de keten in 2026 5% van het aantal klinische ligdagen kan voorkomen.

Gevolg



Meer zorg verleend in eerste/nuldelijn

Inwoners met een palliatieve zorgbehoefte worden langer en intensiever in de thuissituatie behandeld door wijkverpleging. Ook zal de inzet van huisartsen voor deze inwonergroep stijgen en zullen huisartsen van meer inwoners hoofdbehandelaar zijn. Daarnaast wordt er meer gebruik van palliatieve sedatiemiddelen en minder gebruik van medicatie voor co-morbide ziekten verwacht o.b.v. resultaten uit wetenschappelijk onderzoek³.

In algemene zin verwachten we dat de zorgkosten van palliatieve inwoners in de MSZ afnemen in de laatste levensfase, maar toenemen voor de huisartsenzorg en voor de wijkverpleging.

Sector	Medisch specialistische zorg
inwoners groep / inwoners	Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte en minstens 1 ziekenhuisopname (32%) ¹
# inwoners	32% van 4603 - + bevolkingsgroei
# effect	• 20% van de klinische opnames voorkomen o.b.v. Patz-cijfers, waarin we het effect van de palliatieve zorgfunctionaris vergelijken met het beschikbaar hebben van gegevens in de keten² • Per klinische opname gem. 7,5 ligdagen¹
% inclusiepercentage over de jaren	o.b.v. inclusie van 1) inwoners die hun wensen, waarden en behoeften bespreken met zorgprofessionals en 2) zorgprofessionals die kunnen en willen werken met ACP in de keten

Inclusiepercentages

Het inclusiepercentage is gebaseerd op:

- het aantal inwoners dat wensen, waarden en behoeften wil registreren.
- het aantal zorgprofessionals dat wensen, waarden en behoeften-gesprekken aangaat en registreert met inwoners. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op eigen ervaringen binnen de werkgroep
- opstarten technische uitrol in 2025

Jaar	Inclusie inwoners (%)	Inclusie zorgprof (%)
2024	0	0
2025	25	47
2026	40	56
2027	55	61
2028	65	66
2029	70	70
2030	75	75

Uitkomsten impactanalyse (zie p. 67 voor voorbeeldsom)

Jaartal	% van te voorkomen SEH bezoeken gerealiseerd	Aantal klinische ligdagen
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

¹) Rapport Leren van bestaande data over palliatieve zorg (2020, [link](#)) ²) Rapport Palliatieve zorg in de eerste lijn (2017, [link](#)), De olifant de kamer uit, Gupta Strategists (2024, [link](#)), ³) Effects of an Integrated Palliative Care Pathway: More Proactive GPs, Well Timed, and Less Acute Care: A Clustered, Partially Controlled Before-After Study (2021)



1.3.9 Kwantificatie redenatielij 3: Reductie van overleg- en bemiddeltijd door beschikbaarheid van wensen, waarden en behoeften in het digitale ACP-overzicht



Goede gegevensuitwisseling vermindert in 2025 ca. 2300 uren die niet aan andere (zorg)taken besteed kunnen worden

O.b.v. 4603 Palliatieve inwoners in Twente in jaar 1, 20% van de klinische ligdagen te voorkomen obv goede gegevensuitwisseling, een inwonerinclusiepercentage van 13% en een zorgprofinclusiepercentage van 40%.

 **Vermindering van onnodige tijd¹ die zorgprofessionals om de inwoner met een palliatieve zorgbehoefte heen kwijt zijn aan overleg en overdracht**

Er zijn veel verschillende zorgprofessionals betrokken bij de zorg rondom een inwoner. Zij overleggen met elkaar over o.a. behandelplannen en de situatie van de inwoner. Het is van belang dat zij hierbij actueel inzicht hebben in de wensen, waarden en behoeften van de inwoner. Het digitale ACP-overzicht biedt hier inzicht in. Dit inzicht vermindert de tijd die zorgprofessionals bezig zijn om wensen, waarden en behoeften te achterhalen.

o.b.v. een eerste inschatting door de use case werkgroep o.b.v. het doorlopen van de inwonersreis van Henk welke zorgprofessionals binnen de verschillende lijnen werkzaam zijn rondom een kwetsbare inwoner met palliatieve zorgbehoefte

1 ^e lijn – 25% van 4u		2 ^e lijn – 25% van 4u		Thuis – 50% van 4u	
Huisarts	25%	Verpleegkundige	50%	Wijkverpleegkundige	75%
POH	75%	Medisch specialist	50%	Specialist Ouderengeneeskunde	25%

Sector	Medisch specialistische zorg
Zorgverleners	Huisartsen, WVPK, MS, SOG
# inwoners	4603 (Palliaweb Twente, 2022) - + bevolkingsgroei
Effect	Per inwoner zijn alle zorgverleners betrokken bij deze inwoner in totaal 4 uur bezig met overleg/overdracht, wat met ACP in de keten niet meer nodig is.
Effect	In een verhouding 25% (1 ^e lijn), 25% (2 ^e lijn) en 50% (thuis) wordt deze tijd gereduceerd.
% inclusiepercentage over de jaren	o.b.v. adoptie en handhaving werk- en procesafspraken (bijv. eerst 20%, dan 30%, etc.)

Het inclusiepercentage is gebaseerd op: - het aantal inwoners dat wensen, waarden en behoeften wil registreren. - het aantal zorgprofessionals dat wensen, waarden en behoeften-gesprekken aangaat en registreert met inwoners. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op eigen ervaringen binnen de werkgroep - opstarten technische uitrol in 2025	Jaar	Inclusiepercentage inwoners (%)	Inclusiepercentage zorgprof (%)
	2024	0	0
	2025	25	47
	2026	40	56
	2027	55	61
	2028	65	66
	2029	70	70
	2030	75	75

¹⁾ Naar verwachting zal er in het begin van de transformatieperiode meer tijd geïnvesteerd moeten worden om ACP-gesprekken te kunnen voeren. Dit is ca. 1-2 uur (in 1-3 gesprekken) per inwoner met palliatieve zorgbehoefte door o.a. de huisarts/POH (ingeschat door raadpleging huisarts).



1.3.9 Voorbeeld rekensommen gekwantificeerde impact

Hoe zijn we in de use case tot de verwachte vermindering van zorggebruik gekomen?



Vermindering SEH bezoeken van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte in het jaar 2025

- in 2022 waren er **4603** Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte die overleden
- dat vermenigvuldigen we met gem. 0,4 SEH bezoeken per inwoner met palliatieve zorgbehoefte in de laatste 30 dagen voor overlijden = **1841 SEH-bezoeken in 2022**
- dit aantal vermenigvuldigen we met de verwachte groeiende zorgvraag van de doelgroep 65+ tot en met 2025 = $1841 * (1 + (140.600 \text{ (jaar 2025)} - 132.810 \text{ (jaar 2022)}) / 132.810 \text{ (jaar 2022)}) \sim = 1949 \text{ verwachte SEH-bezoeken in 2025}$
- dit aantal (1948,98) vermenigvuldigen we met 28% effect van de use case ACP in de keten = $1948,98 * 0,28 = 546 \text{ te voorkomen SEH-bezoeken in 2025 bij 100% inclusie en adoptie}$
- 100% inclusie en adoptie is voor de ontwikkelfase van de use case niet realistisch, daarom vermenigvuldigen we nog met 47% zorgprofessional inclusie en 25% patiënt inclusie in jaar 2025 = $545,71 * 0,47 * 0,25 = 64 \text{ SEH-bezoeken voorkomen met ACP in de keten in 2025}$
- het percentage 12% is gebaseerd op de verhouding voorkomen SEH-bezoeken ten opzichte van het potentieel te voorkomen SEH-bezoeken: $64 \text{ (SEH-bezoeken voorkomen met ACP in de keten in 2025)} / 546 \text{ (potentieel te voorkomen SEH-bezoeken in 2025 bij 100% inclusie en adoptie)} * 100\% = 12\%$



Vermindering klinische ligdagen van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte in het jaar 2025

- in 2022 waren er **4603** Twentse inwoners met een palliatieve zorgbehoefte die overleden
- dat vermenigvuldigen we met gem. 7,5 klinische ligdagen per inwoner met palliatieve zorgbehoefte in de laatste 30 dagen voor overlijden = **11048 SEH-bezoeken in 2022**
- dit aantal vermenigvuldigen we met de verwachte groeiende zorgvraag van de doelgroep 65+ tot en met 2025 = $11048 * (1 + (140.600 \text{ (jaar 2025)} - 132.810 \text{ (jaar 2022)}) / 132.810 \text{ (jaar 2022)}) \sim = 11695 \text{ verwachte klinische ligdagen in 2025}$
- dit aantal (11695) vermenigvuldigen we met 20% effect van de use case ACP in de keten = $11695 * 0,20 = 2339 \text{ te voorkomen klinische ligdagen in 2025 bij 100% inclusie en adoptie}$
- 100% inclusie en adoptie is voor de ontwikkelfase van de use case niet realistisch, daarom vermenigvuldigen we nog met 47% zorgprofessional inclusie en 25% patiënt inclusie in jaar 2025 = $545,71 * 0,47 * 0,25 = 275 \text{ SEH-bezoeken voorkomen met ACP in de keten in 2025}$
- het percentage 12% is gebaseerd op de verhouding voorkomen klinische ligdagen ten opzichte van het potentieel te voorkomen klinische ligdagen: $275 \text{ (SEH-bezoeken voorkomen met ACP in de keten in 2025)} / 2339 \text{ (potentieel te voorkomen klinische in 2025 bij 100% inclusie en adoptie)} * 100\% = 12\%$



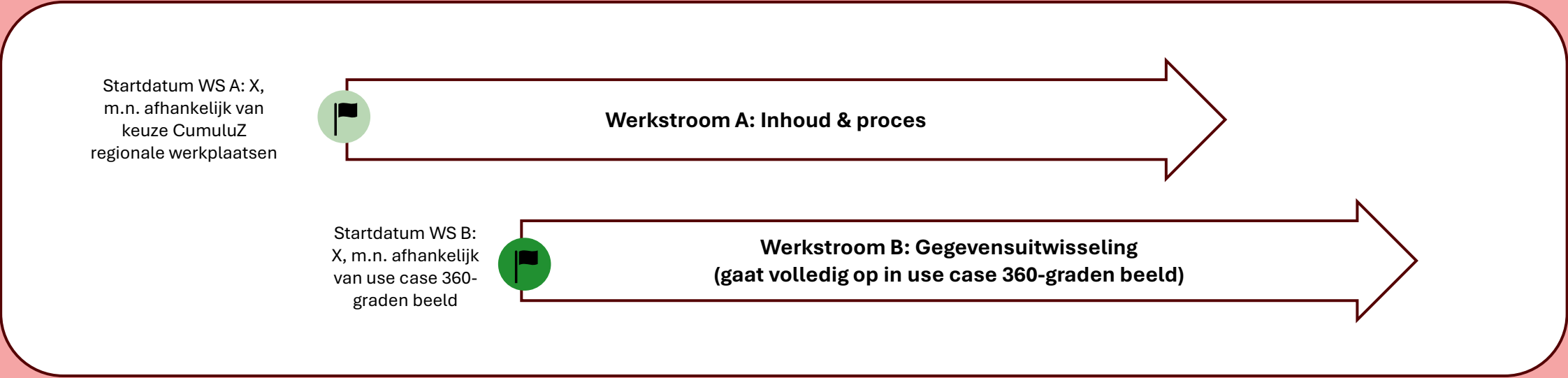


1.3.10 Maatschappelijke business case | Projectaanpak ACP in de keten

In twee werkstromen regiobreed de techniek en het zorgproces met elkaar verbinden

De projectaanpak van de use case ACP in de keten bestaat uit **twee werkstromen**. Binnen deze werkstromen wordt de inhoud & het zorgproces (A) en de gegevensuitwisseling (B) uitgewerkt. De startdatum van de werkstromen hangt af van landelijke en regionale keuzes. Een van deze keuzes is of regio Twente een regionale werkplaats voor de toepassing van transmurale gegevensuitwisseling m.b.t. ACP. Een andere keuze is de startdatum van ACP in de keten, t.o.v. de use case 360-graden beeld. Omdat werkstroom B nauw samenhangt met de use case 360-graden beeld is besloten om deze ontwikkelstroom op te nemen bij de projectaanpak van 360-graden beeld. Voor de volledigheid van de use case ACP in de keten wordt ontwikkelstroom B hier wel nog benoemd, maar niet doorberekend in de projectplanning & resource-allocatie

Naar verwachting start **werkstroom A eerder dan werkstroom B**. Dit is in het geval van ACP in de keten geen onlogische volgorde, omdat op deze manier de techniek kan volgen aan inhoud & proces.



NB. In de projectaanpak die in de volgende hoofdstukken is beschreven staan indicaties van het aantal **effectieve werkmaanden** dat nodig is om de fase af te ronden. Afhankelijk van de startdata van de werkstromen zullen deze fases meer tijd in beslag nemen, vanwege het vallen van de fase in de zomermaanden, of in december. Ervaring in de zorg leert dat zorgorganisaties in deze maanden weinig capaciteit beschikbaar hebben voor integrale samenwerking (bijv. vanwege waarnemingen van collega's met verlof)



1.3.10 Maatschappelijke business case | Projectaanpak ACP in de keten

In twee werkstromen regiobreed de techniek en het zorgproces met elkaar verbinden

De twee werkstromen zijn gezamenlijk opgenomen in onderstaande projectaanpak. Waar relevant is de splitsing gemaakt tussen werkstroom (WS) A en B. Zoals eerder vermeld zullen activiteiten van werkstroom B vallen binnen de use case 360-graden beeld en zijn daar opgenomen in de projectaanpak, projectplanning & resource-allocation. Voor de stappen die beschreven staat in de projectfases is ca. de tijd nodig die boven de projectfase beschreven staat. Als de twee werkgroepen niet tegelijkertijd starten, staat er voor het uitvoeren van de activiteiten door de desbetreffende werkgroep die periode nog steeds de tijdsduur die is geïndiceerd.



~ 3 maanden

1. Start project

- Inrichten projectteams o.b.v. bestuurlijke keuze ACP-werkstromen
- In kaart brengen stakeholders
- Ophalen best-practices m.b.t. ACP in de keten bijv. in Noord-Holland, Noord-Holland-Noord, Gelderse Vallei en Drenthe
- Bepalen projectplan(ning) voor werkstromen A en B met aandacht voor draagvlak
- Vaststellen visie, strategie & doelstellingen voor werkstromen A en B o.b.v. uitwerking transformatieplan
- Vaststellen succesfactoren op inhoud, proces en mens van de werkstromen A en B

~ 3 maanden

2. Procesanalyse en ontwerp

- Procesanalyse regionaal kader Samen Beslissen (WS A)
- Procesanalyse kwaliteitskader Palliatieve zorg NL (WS A)
- Procesanalyses huidige regionale situatie (WS A)
- Definieren zorginhoud van uitwisselingen ACP in de keten (WS A)
- Co-creëren regionale werkwijze (incl. afspraken over regie & coördinatie) en inwonersreizen i.s.m. inwoners en zorgprofessionals, in nauwe samenhang met de richtlijn Proactieve zorgplanning en met als uitgangspunt dat we verbinden wat er al is en aanvullen wat mist (WS A)
- Definieren & concretiseren van het digitale ACP-overzicht incl. programma van eisen o.a. over functionaliteiten, in nauwe samenhang met leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning
- Verdiepen informatiestandaard ACP vanuit IKNL pilots (WS B)
- Analyse zorginformatiesystemen (WS B)

~ 3 maanden

3. Ontwikkel-, configuratie- en implementatieplan

- Uitwerken IT infrastructuur (WS B)
- Koppelen zorginformatie-systemen (WS B)
- Ontwikkelen digitaal ACP-overzicht (WS B)
- Definieren werkafspraken en richtlijnen gebruik digitaal ACP-overzicht
- Inrichten testomgevingen (WS B)
- Opstellen implementatieplan van nieuwe regio brede werkwijze (WS A)
- Opstellen communicatieplan met interventies voor t.b.v. draagvlak (WS A)
- Uitvoeren van 0-meting voor resultaat- en effectmeting op inhoud en proces m.b.t. regio brede werkwijze ACP in de keten (WS B)

~3-6 maanden

4. Testing

- Ontwikkeling van training + trainen van zorgprofessionals in regio brede werkwijze ACP in de keten
- Uitvoeren gebruikers-acceptatietesten in een “zandbak-omgeving” digitaal ACP-overzicht
- Finetunen nieuwe werkproces regio brede werkwijze
- Finetunen digitaal ACP-overzicht o.b.v. gebruikerservaringen

~3 maanden

5. Uitvoeren PoC & valideren

- Implementeren en uitvoeren kleinschalige proof-of-concept in de productieomgeving
- Monitoren PoC o.b.v. succesfactoren & KPIs
- Oplossen issues o.b.v. ervaringen zorgprofessionals en inwoners

~3-6 maanden

6. Duurzame inbedding

- Structureel inrichten regiobrede werkwijze
- Structureel inrichten stuur- en verbetercyclus
- Opschaling naar meer gebruikers
- Opleiding nieuwe gebruikers
- Inrichting beheer
- Afronding project



Tussen deze fases zullen meerdere test en validatiefases plaatsvinden waarin functionaliteiten worden toegevoegd aan het digitaal ACP-overzicht en waarbij werkprocessen aangepast worden



1.3.10 Maatschappelijke business case | Projectplanning & resourceallocatie

Gemiddelde personele inzet per jaar (FTE)			
Rollen	2024	2025	2026
Projectleider			
Opleidingsadviseur			
Communicatieadviseur			
Arts			
(Gesp.) verpleegkundige			
Zorgmanager			
Huisarts			
Praktijk-/ zorgondersteuner			
Sponsor			
(Wijk)Verpleegkundige			
Totaal aantal (FTE)			
Totaal percentage extern (%)			

Legenda:

Intern

Extern

Intern/Extern





1.3.11 SMART-doelstellingen & KPIs

Door registraties en raadpleging van wensen, waarden en behoefte onze doelstellingen behalen



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 - Inhoud & werkwijze m.b.t. het digitale ACP overzicht	I		December: Oplevering fase 1 Deliverable: projectplan werkstroom A Investering: 3,3 FTE inzet personeel	Maart: Oplevering fase 2 Deliverable: regionaal kader werkwijze ACP in de keten Investering: 3,2 FTE inzet personeel	Juni: Oplevering fase 3 Deliverable: Implementatieplan regionaal kader Investering: 3,4 FTE inzet personeel	September: Oplevering fase 4 Deliverable: ontwikkeld scholingsmateriaal Investering: 3,6 FTE inzet personeel		Maart: Oplevering fase 5 implementatie regionaal kader werkwijze ACP Investering 3,2 FTE inzet personeel		September: Oplevering fase 6 Structurele inbedding van regionaal kader werkwijze ACP Investering: 3,4 FTE inzet personeel	
Deelproject 2 - Ontwikkelen digitaal ACP-overzicht (in samenhang met het 360-graden beeld)	I		December: Oplevering fase 1 Deliverable: projectplan werkstroom B		Juni: Oplevering fase2 & 3 Deliverables: 1. regionale leidraad digitaal ACP-overzicht 2. Implementatieplan regionaal kader			Maart: Oplevering fase 4 & 5 Deliverable: implementatie digitaal ACP-overzicht in generiek kerndossier bij 9 instellingen		September: Oplevering fase 6 Deliverable: implementatie digitaal ACP-overzicht in generiek kerndossier bij 7 instellingen	
Vermindering <i>klinische ligdagen</i> t.o.v. 0-meting	R					September: -4% (cum.) in MSZ	December: -7% (cum.) in MSZ	Maart: -11% (cum.) in MSZ	Juni: -15% (cum.) in MSZ	September: -19% (cum.) in MSZ	December: -22% (cum.) in MSZ





1.3.12 Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (1)

Scope	Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Use case specifiek	Er wordt op bestuurlijk niveau geen keuze gemaakt voor inrichting projectgroepen i.r.t. TwenteBeter en de Regionale datahub	Laag	Hoog	Benadrukken van het belang aan de hand van de visie "ondersteunen wat bestaat, aanvullen waar nodig" en dit vastleggen in communicatieplan en handreiking Commitment is cruciaal
Algemeen	Te weinig borging van draagvlak binnen deelnemende organisaties op tactisch en operationeel niveau voor transformatie, met het hoogste risico voor de huisartsenzorg	Gemiddeld	Hoog	Fasering realistisch opstellen (klein beginnen- korte termijn mijlpalen). Organiseren van Feedbacksessies Financiële prikkel kan helpen hierin Ook nog niet deelnemende organisaties tijdig informeren
Use case specifiek	Geen financiële betaaltitels voor ACP-gesprekken en hierdoor voeren zorgprofessionals die niet betaald krijgen deze niet uit	Hoog	Hoog	Gezamenlijke visie ontwikkeling op transmurale gegevens waarbij geld niet de motor moet zijn (is wel helpend) maar de wil om te veranderen (cultuuromslag) naar een lerend netwerk
Use case specifiek	ACP in de keten wordt geen regionale werkplaats binnen de CumuluZ-coalitie	Laag	Hoog	Betrekken van Regionale huisartsenorganisaties zoals FEA en THOON gaan vanaf 2025 een rol spelen in de module ouderenzorg op het gebied van toetsing en financiering. Zij kunnen een rol spelen in het stimuleren van ACP.
Algemeen	Verloren momentum door lange beoordelingsperiode zorgverzekeraars	Gemiddeld	Hoog	Vooraf markers voor een work-arounds bij problemen vaststellen GO/NO GO momenten inbouwen in duidelijk tijdspad. Kan ook moment van bezinning zijn – pas op plaats maken/ doen we nog de juiste dingen volgens plan
Use case specifiek	Lage adoptie van ACP onder zorgprofessionals ondanks vergrote aandacht en aangeboden handvatten voor het onderwerp	Hoog	Hoog	Mogelijkheden exploreren voor opname in regionale ziekte specifieke zorgprogramma's (bv longziekten/hartfalen). Tijdens het gehele proces zorgen voor awareness en aansluiting bij de zorgprocessen en zorgprofessionals. Regionale / landelijke publiekscampagne





1.3.12 Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (2)

Scope	Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Algemeen	Er wordt onvoldoende tot geen rekening gehouden met tijdsinvestering door projectleden (geen rekeninghouden met "samenwerkingsarme" maanden)	Gemiddeld	Hoog	Beschikbaarheid van inzet van mensen vastleggen voor een afgesproken tijd en liefst op vaste dagen. Dit ook vast laten leggen in de Governance
Algemeen	Onvoldoende beschikbaarheid van menscapaciteit tbv de uitvoering	Hoog	Hoog	Planning vroegtijdig kenbaar maken om tijdig mensen vrij te maken om plannen uit te kunnen voeren (commitment vanuit de organisaties en contractueel vastleggen)
Algemeen	Bij tegenslag stekker uit het project halen	Gemiddeld	Hoog	In business case moet vastgelegd worden welke tegenslagen er verwacht kunnen worden en hoe daarmee om te gaan. In KPI's op gezette tijden evaluatiemomenten inbouwen om evt tegenslagen te kunnen voorzien.
Use case specifiek	Ontbreken van juiste governance van strategie naar operationeel	Hoog	Hoog	[van te voren helder hebben welke bestaande netwerken er zijn en waar weloverwogen wel/geen gebruik van gemaakt kan worden] Opstellen Governance tbv de samenwerking
Use case specifiek	Lage adoptie van ACP onder Twentse inwoners ondanks vergrote aandacht voor het onderwerp en inspanningen van Netwerken Palliatieve Zorg Twente	Gemiddeld	Gemiddeld	Inwoners goed informeren en ondersteunen bij het initiëren en voeren van het ACP gesprek Bij de georganiseerde bewustwordingsbijeenkomsten zou het helpen als men ook meteen concreet aan de slag kan met hun wensen waarden en behoeften. Dus richting geven aan het vastleggen van de ACP gegevens.
In het aangaan Algemeen	Te weinig co-creatie van de werkwijze met zorgprofessionals én inwoners in Twente	Gemiddeld	Gemiddeld	Een duidelijk beschreven communicatieplan waarin ook verwachtingen staan beschreven om co-creatie te bewerkstelligen tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals.



1.3.13 Duidelijke afbakening tussen ACP-transformaties in regionale plannen

Voorkomen van dubbel rekenen impact, activiteiten en benodigde investering

In Twente wordt ACP gezien als een onderwerp waarmee een impactvolle transformatie in de zorg gerealiseerd kan worden. ACP is omvangrijk en bevat verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden voor een maximale impact. Vanwege de omvang van dit onderwerp, is ACP belegd in twee transformatieplannen¹; Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente+ en het transformatieplan Twente Beter. In het eerste plan ligt de focus op het inrichten van een optimaal proces terwijl in het tweede de nadruk ligt op het vergroten van het aantal inwoners en zorgprofessionals dat ACP toepast en het inhoudelijk toerusten van (meer) zorgprofessionals. Deze slide maakt duidelijk welke onderdelen van ACP onder welke aanvraag vallen.



ACP in het transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente +

- De impactvolle transformatie beschrijft activiteiten over het **ontwikkelen en technisch ondersteunen van integrale proces- en inhoudelijke werkafspraken over ACP** en de manier waarop ingezamelde gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden tussen zorgprofessionals
- Met deze transformatie richten we het proces voor **zorgprofessionals** in en is duidelijk wie wanneer ACP toepast.
- De transformatie heeft impact op de coördinatie van zorg en het zorggebruik, omdat voor zorgprofessionals **duidelijk is welke afspraken zijn gemaakt over ACP en omdat alle ACP-informatie op 1 plaats staat en altijd inzichtelijk is**
- Extra potentieel m.b.t. deze impactvolle transformatie linken we aan **nog niet in kaart gebrachte vermindering van zorggebruik** (bijv. DGM) en **uitbreiding van de doelgroep waarbij ACP kan worden ingezet**: van inwoners met een palliatieve zorgbehoefte in de laatste 30 dagen van hun overlijden, naar inwoners die vanwege hun gezondheidstoestand wensen, waarden en behoeften vastlegt (bijv. inwoners met een chronische aandoening zoals COPD of ouderen). Dit extra potentieel overlapt niet met de impact zoals bedoeld in het transformatieplan Twente Beter.



ACP in het toekomstig transformatieplan Twente Beter

- De impactvolle transformaties m.b.t. ACP beschrijven activiteiten in het kader van **cultuurverandering en competentieontwikkeling**; bewustwording over het nut en de noodzaak van ACP **bij inwoners (en hun naasten) en zorgprofessionals in de breedte** en activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van een praktische inhoudelijke handvaten over hoe het ACP gesprek te voeren en de **scholing van zorgprofessionals over hoe en wanneer zij het ACP gesprek kunnen voeren**.
- Deze impactvolle transformatie richt zich op de **zorgprofessionals en inwoners van Twente die zich bewust worden van ACP en die de gesprekken hierover op een goede manier willen voeren en vastleggen**
- Door deze impactvolle transformatie wordt **bij meer inwoners** passende zorg verleend die aansluit bij hun wensen, waarden en behoeften. Inwoners zullen zich meer bewust zijn van de mogelijkheden en hun wensen. Zorgprofessionals hebben een actieve rol in het bespreken en vastleggen van deze wensen en passen de zorg daar op aan.

1) Tijdens het schrijven van de snelle toets voor Twente Beter zal ook worden uitgewerkt hoe de governance rondom ACP tijdens implementatie plaatsvindt
2) In dit transformatieplan is extra potentieel van de use cases meegerekend in de maatschappelijke business case, zie p. van het Transformatieplan. We benoemen in deze paragraaf waarop dit extra potentieel is gebaseerd. Zo duiden we dat dit extra potentieel niet overlapt met de impact die wordt beoogd door Twente Beter.



Verdieping 1.4 Gekoppelde thuismonitoring





1.4.1 Gekoppelde thuismonitoring | Kernproblematiek

Zorgaanbieders hebben geen overzicht in geleverde monitoringszorg aan inwoners door versnippering van systemen en gebrek aan gegevensuitwisseling



Huidige situatie

De gezondheidszorg in Nederland staat voor een urgente uitdaging door een stijgende zorgvraag en een stijgende tekort aan zorgprofessionals. Daarnaast speelt de demografische ontwikkeling van een sterk ouder wordende samenleving een kritieke rol, vooral in regio's zoals Twente, waar deze verzilvering nog hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit verhoogt de druk op de VVT, die actief is in alle fasen van zorgverlening, van wijkverpleging tot geriatrie revalidatie en verpleeghuiszorg. Overige zorgpartners (ziekenhuizen, huisartsen, ggz) krijgen in toenemende mate te maken met “geronto” problematiek, multi-morbiditeit etc. Hierdoor verhoogt de druk op de VVT nog meer. Dit vraagt om een andere manier van werken om op lange termijn de zorg betaalbaar te houden en kwalitatief hoge zorg te kunnen blijven leveren. In regio zijn individuele zorginstellingen druk bezig met de herinrichting van hun zorg en processen, voor verschillende zorgpaden, met als doel optimalisatie in de gehele keten. Het vraagt om anders werken met andere inzet van zorgprofessionals, waarbij het overzicht, inzicht en integraliteit enorm belangrijk zijn. Op dit moment is de versnippering van systemen en aanbieders, en het geen inzicht en/of overzicht hebben in elkaars inwoner-/zorgprofessionals monitoringsgegevens een grote belemmering. Dit maakt het lastig voor zorgprofessionals om een compleet zorgbeeld te hebben en informatie uit te wisselen en daarop te acteren. Voor inwoners is dit ook vervelend, aangezien zij op verschillende wijzen en locaties gemonitord worden. Door gebrek aan een volledig overzicht en inzicht, kunnen inwoners niet actief hun eigen regie pakken.



1: geen uitwisseling van informatie

- Door het gebruik (en connectie) van verschillende thuismonitoring oplossingen voor verschillende aanbieders vindt er geen uitwisseling plaats van informatie.
- Ook relevante opgedane kennis en informatie binnen instellingen is moeilijk te delen met andere behandelaren.



2: gebrek aan volledig overzicht

- Een specifieke zorgaanbieder kijkt naar een specifiek stukje van de puzzel en mist een volledig overzicht van monitoringgegevens:
- De mogelijkheid om analyses te integreren of te automatiseren ontbreekt (e.g. risicowaarden).
 - Bijstellen behandelplannen, nemen van behandelbesluiten en ingrijpen bij alarm situaties wordt hierdoor vermoeilijk.



3: onnodige opnames van inwoners

Onnodige opnames van inwoners, die anders in hun eigen omgeving gemonitord hadden kunnen blijven.



4: monitoring multi-morbiditeit moeilijk

De aanwezigheid van meerdere chronische aandoeningen bij inwoners compliceert de monitoring en vereist gespecialiseerde coördinatie tussen diverse zorgaanbieders.



5: kosten/opbrengsten gescheiden

Investeringen in monitoring leiden niet direct tot financiële besparingen op dezelfde plek, zoals bij de VVT waar kosten voor monitoring niet samenvallen met besparingen door vermeden ziekenhuisopnames. In dat geval gaat de schadelast bij de inwoner omlaag en valt het voordeel toe aan de zorgverzekeraar.





1.4.2 Gekoppelde thuismonitoring | Ambitie

Onze **ambitie** is om voor zowel inwoner als zorgprofessional in de regio een **gezamenlijke en geïntegreerde beleving en oplossing** voor thuismonitoring te bieden, zodat inwoner **de juiste zorg op de juiste plek** ontvangt. We beginnen niet vanaf nul, maar bouwen voort op de **initiatieven en kennis die in de regio** aanwezig is.



Ambitie

- Eind 2026 is gekoppelde thuismonitoring voor minimaal 5 transmurale zorgpaden in gebruik genomen door huisartsen en VVT in de 1e lijn en specialisten uit het ziekenhuis; er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over beschikbare capaciteit voor monitoring. Hierdoor...
 - Is de inwoner leidend en heeft regie over het gepersonaliseerde zorgpad en ontvang de juiste zorg op het juiste moment door het juiste zorgprofessional. Ook is er minder fysiek contact nodig waardoor er minder tijd van de inwoner en zorgprofessional wordt gevraagd
 - Kunnen zorgprofessionals zich richten op waardevolle zorg, wat leidt tot meer werkplezier en meer tijd voor de inwoner
 - Wordt er efficiënt gebruik gemaakt van elkaars kunde en capaciteit
- Er wordt gebruik gemaakt van één regionaal (virtueel) thuismonitoring met geüniformeerde oplossingen en standaarden die toegankelijk zijn voor alle betrokkenen in de regio
- Ook niet-acute thuismonitoring (e.g. begeleiding) is beschikbaar voor verschillende categorieën inwoners (bijv. laaggeletterden), daar waar dat zinvol en doelmatig is
- Er zijn afspraken gemaakt in de regio over standaarden, interoperabiliteit en overige randvoorwaardelijke criteria om netwerkzorg optimaal te faciliteren
- We zoeken aansluiting bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven zoals Zorg bij jou en CumuluZ
- De financiering van thuismonitoring is passend voor de betrokken zorgprofessionals

Doelstelling 2026

Eind 2026 is gekoppelde thuismonitoring voor minimaal 5 transmurale zorgpaden in gebruik genomen door huisartsen in de 1e lijn, specialisten uit het ziekenhuis en zorgprofessionals uit VVT en wijkverpleging; er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over 24/7 beschikbare capaciteit voor monitoring, indien noodzakelijk en doelmatig.

Link met IZA-opgaven

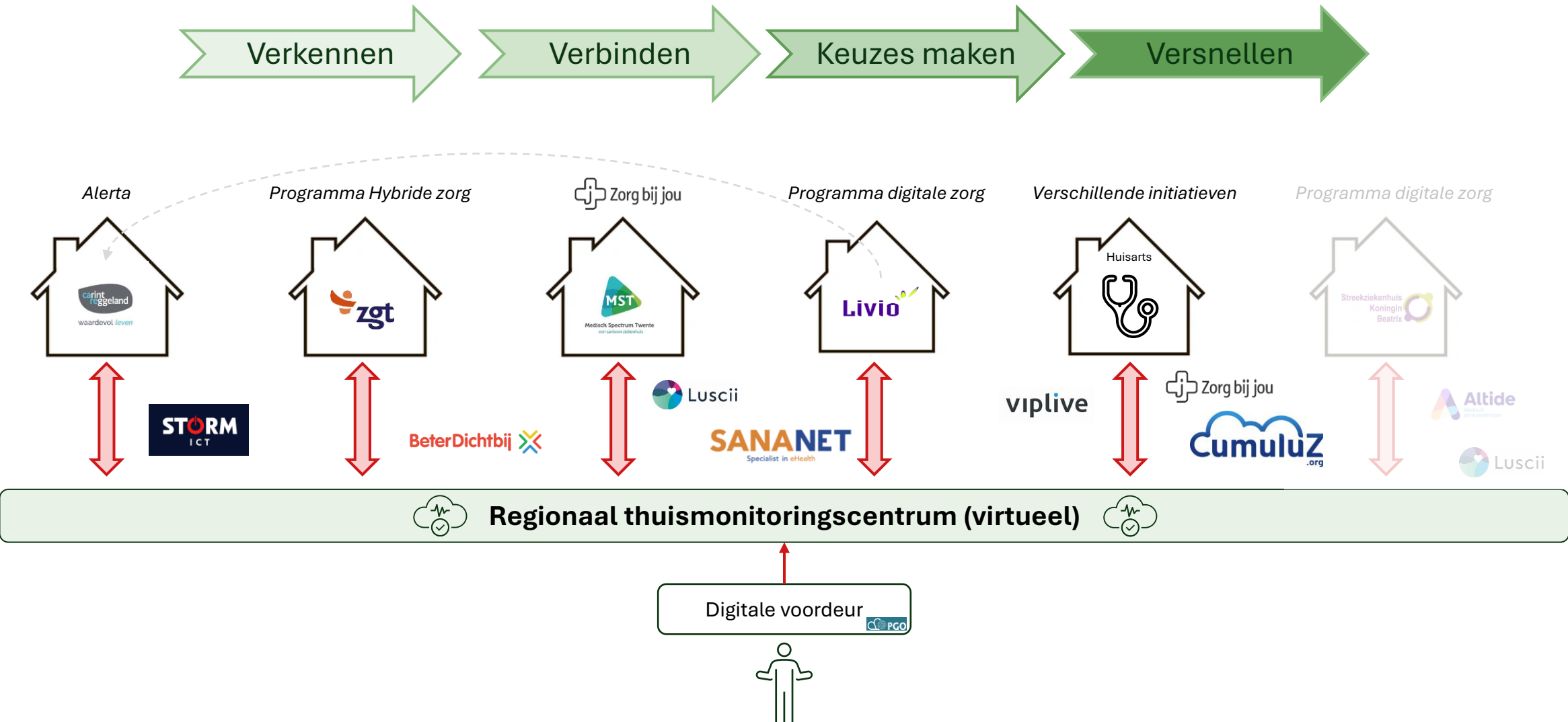
- **JZOJP**; gekoppelde thuismonitoring draagt bij aan het versterken van de integraliteit van zorg in het netwerk om de inwoner en zorgverlening door de juiste zorgprofessional op het juiste moment. Voor de inwoner betekent dit minder onnodig reizen naar zorgprofessionals en minder onduidelijkheid wie te benaderen voor zorg.
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals**; de registratielast van zorg-professionals neemt door de beschikbaarheid van relevante monitoringsgegevens af
- **Hybride zorg**; gekoppelde thuismonitoring ondersteunt de mogelijkheid van hybride zorg naar de regio





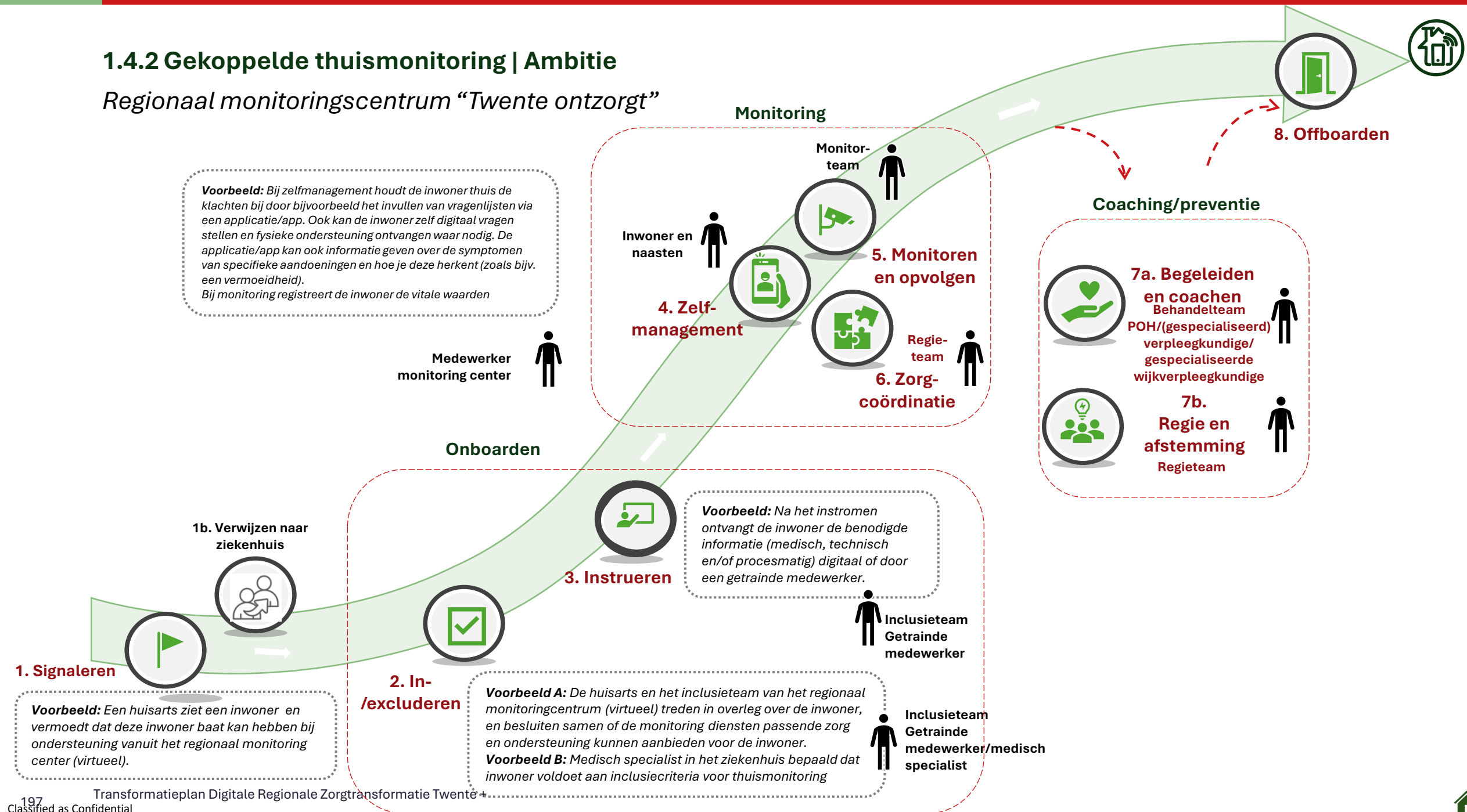
1.4.2 Gekoppelde thuismonitoring | Ambitie

Onze **ambitie** is om voor zowel inwoner als zorgprofessional in de regio een **gezamenlijke en geïntegreerde beleving en oplossing** voor thuismonitoring te bieden, zodat inwoner **de juiste zorg op de juiste plek** ontvangt. We beginnen niet vanaf nul, maar bouwen voort op de **initiatieven en kennis die in de regio aanwezig is**.



1.4.2 Gekoppelde thuismonitoring | Ambitie

Regionaal monitoringscentrum “Twente ontzorgt”





1.4.2 Gekoppelde thuismonitoring | Ambitie

In de huidige situatie onderscheiden we 4 typen patiëntstromen die gaan veranderen in het nieuwe proces met regionale gekoppelde thuismonitoring

Huidige situatie thuismonitoring in de regio Twente

- 1

Inwoners met ziekenhuis-gebaseerde thuismonitoring
Deze inwoners ontvangen (vaak na behandeling) thuismonitoring die rechtstreeks is verbonden aan een van de twee ziekenhuizen in de regio.
- 2

Inwoners zonder ziekenhuis-gebaseerde thuismonitoring
Deze inwoners ontvangen hun zorg in het ziekenhuis zonder thuismonitoring (na behandeling controles bij huisarts of in het ziekenhuis).
- 3

Inwoner met thuismonitoring
Deze inwoners ontvangen zorg buiten het ziekenhuis en worden gemonitord door bijvoorbeeld VVT-instellingen of huisartsen.
- 4

Inwoner zonder thuismonitoring
Deze inwoners ontvangen zorg buiten het ziekenhuis en worden door geen enkele instelling gemonitord

Toekomstige situatie **gekoppelde thuismonitoring** in de regio Twente

In de toekomst ontvangen **alle inwoners** (voor wie thuismonitoring doelmatig en zinlijk is), ongeacht waar de zorg ontvangen wordt (huisarts, VVT, ziekenhuis) gekoppelde thuismonitoring via het **regionale thuismonitoringscentrum**.







1.4.3 Gekoppelde thuismonitoring | Doorontwikkeling na het bereiken van onze ambitie in 2026



Doorontwikkeling

Na de implementatie van de eerste 5 zorgpaden zijn de volgende doorontwikkelingen mogelijk op het gebied van gekoppelde thuismonitoring. Dit helpt ons om een uitgebreide transformatie te realiseren in de gehele regio, waarbij we beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen, zoals personeelstekorten en een toenemende zorgvraag. Ook realiseren we een meer geïntegreerde zorgervaring, voor zowel inwoners, mantelzorgers als (informele) zorgprofessionals door alle sectoren en instanties te betrekken. We doen dit aan de hand van de volgende doorontwikkelingen:

Opschaling zorgpaden

We rollen thuismonitoring (en hybride zorg) verder uit naar andere zorgpaden in de regio, met speciale aandacht voor ouderenzorg.

Ontsluiting

Patiëntgegevens worden toegankelijk gemaakt voor een toenemend aantal zorginstanties en sectoren, waaronder de GGZ, revalidatiezorg, fysiotherapie, diëtisten, en apothekers, etc. Dit vergroot de interdisciplinaire samenwerking en zorgt voor een meer complete benadering van de zorg.

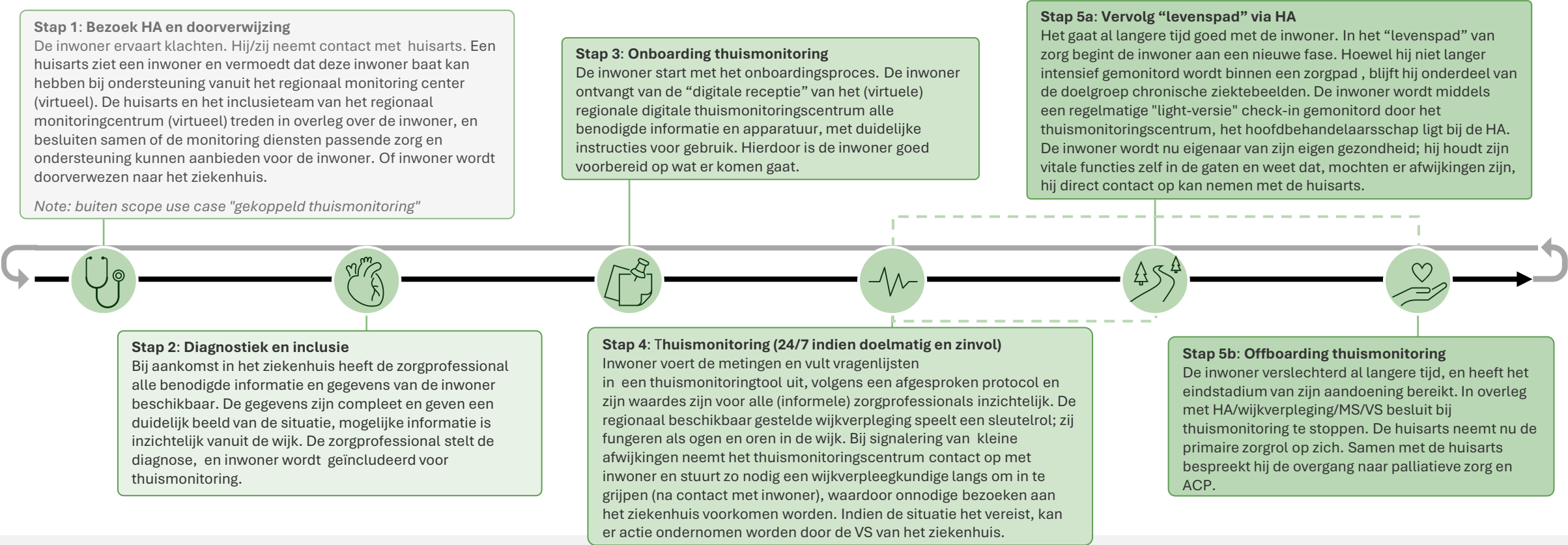
Regie inwoner

Door een geïntegreerd en overzichtelijk zorgsysteem kan de inwoner meer regie voeren en betere coördinatie van zijn eigen zorg realiseren. Dit bevordert de zelfstandigheid en stelt inwoners in staat om actief betrokken te zijn bij hun behandeling en zorgplanning.





1.4.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Beschrijving inwonerreis



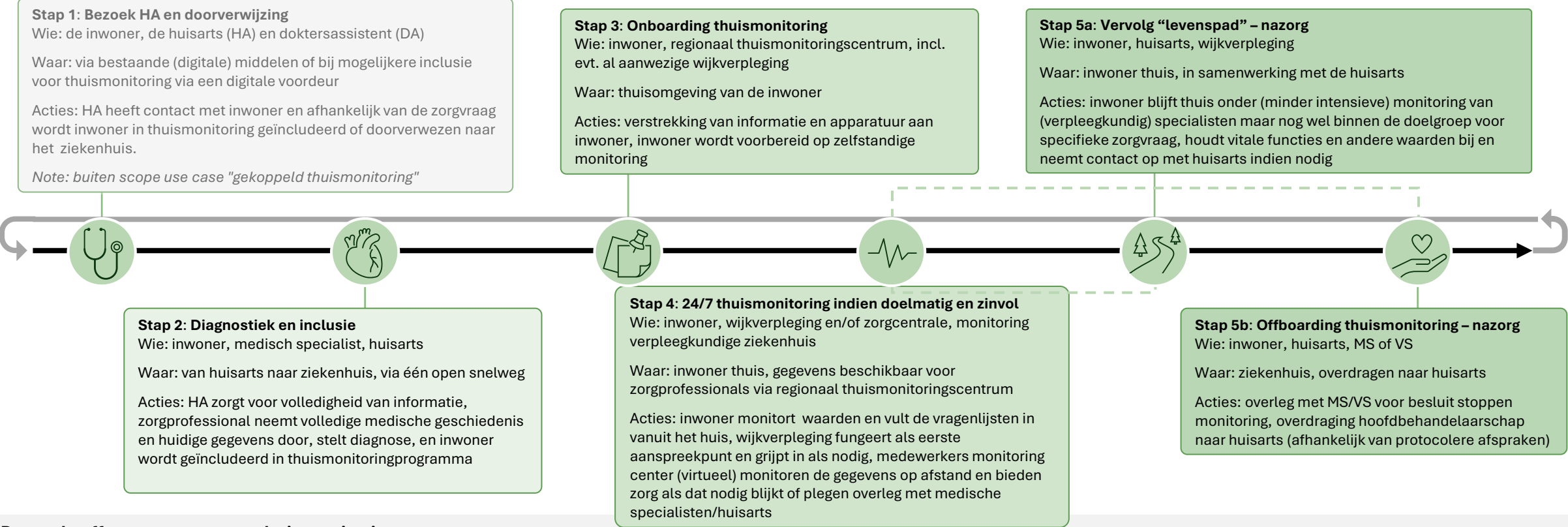
Beoogde effecten voor inwoner

- **Toegankelijkheid;** snelle toegang bij verslechteren van de ziektelast, doordat er meer inwoners thuis worden gemonitord en er dus meer capaciteit vrijkomt in het ziekenhuis.
- **Kwaliteit van zorg;** de inwoner krijgt een hoge kwaliteit van zorg doordat er altijd een volledig beeld is van zijn gezondheidstoestand, door doorlopende verzameling van gegevens vanuit alle zorgprofessionals (HA, MSZ, wijkverpleging) en het thuismonitoringscentrum
- **Zelfredzaamheid en regie;** de inwoner is actief betrokken bij de monitoring en management van zijn gezondheid, waardoor de inwoner meer zelfredzaam wordt en beter in staat is zelf actie te ondernemen bij afwijkingen.





1.4.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Stappen nieuwe zorgproces incl. zorgprofessional



Beoogde effecten zorgproces thuismonitoring

- **Proactieve zorgverlening:** continue stroom van gezondheidsgegevens vanuit thuismonitoring naar het regionale thuismonitoringscentrum stelt zorgprofessionals in staat om proactief te reageren op veranderingen in de inwoner zijn gezondheidstoestand
- **Optimalisatie van zorgcapaciteit:** door de digitale thuismonitoring en de inzet van de regionaal beschikbare monitoringsverpleegkundige wordt onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen, waardoor de zorgcapaciteit effectiever wordt ingezet en de inwoner zijn/haar ziektelast minder zal ervaren.
- **Verbeterde zorgcoördinatie:** de transmurale doorverwijzing en beschikbaarheid van monitoringsgegevens in het regionale monitoringscentrum en communicatie tussen alle betrokken zorgprofessionals zorgen voor een gestroomlijnd zorgproces dat is afgestemd op de individuele behoeften van de inwoner





1.4.4 Beschrijving nieuwe zorgproces | Fit-gap analyse gekoppelde thuismonitoring

Inhoud & Techniek		Proces & Beleid	Mens
1. Huidige proces en workflow	a) Gebruik van verschillende systemen voor het aanvragen, registreren, overdragen, rapporteren en inzichtelijk maken van thuismonitoringsgegevens (zoals bijv. Luscii, Sananet en HiX) b) Levering van de apparatuur wordt door de ziekenhuizen zelf geregeld c) Elke instelling heeft een eigen digitale voordeur, waardoor inwoner de informatie via verschillende kanalen en apps moet invoeren en inzien	a) Protocollen en beleid m.b.t thuismonitoring is per zorginstelling verschillend b) Instructies over thuismonitoring worden door de huizen zelf gegeven en inhoudelijk verschillen ze van elkaar. c) De monitoring wordt op dit moment tijdens de werkdagen aangeboden d) Op dit moment wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van al ingerichte thuismonitoring door VVT-instellingen e) De criteria en protocollen voor het stoppen met monitoring verschillen per instelling en aandoening f) Bij beëindiging deelt VS/MS relevante informatie over de inwoner met de huisarts via een brief	a) Elk zorginstelling heeft eigen team/medewerkers die betrokken zijn bij het monitoren van inwoners. Er vindt geen uitwisseling van kennis en medewerkers plaats
2. Vereisten nieuwe proces	a) Gebruik van één regionale digitale voordeur, dat direct inzichtelijk is voor alle zorgprofessionals, onafhankelijk van eigen gebruikte zorgportalen. b) Apparatuur wordt geleverd vanuit het regionale thuismonitoringscentrum en is ook verantwoordelijk voor o.a. logistieke afspraken c) Inwoner voert gegevens in, in de daarvoor bestemde applicatie; metingen, invullen vragenlijsten etc.	a) Er wordt gewerkt met één regionaal gestandaardiseerd protocol voor thuismonitoring, afhankelijk van zorgpad b) Er wordt gebruik gemaakt van één gestandaardiseerde en regionaal gedragen instructie- en communicatiestrategie die door alle betrokken partijen wordt gevolgd c) Inwoners worden 24/7 gemonitord d) Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande initiatieven zoals zorgcentrale Livio, Alerta en ZBJ (ogen en oren in de huiskamers) zodat de juiste zorg door de juiste medewerker en op de juiste moment kan worden gegeven. Dit om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. e) Er wordt gewerkt met één regionaal gestandaardiseerd protocol voor de on- en off-boarding voor thuismonitoring, alleen verschillend per aandoening f) Stabiele en medicatief goed ingestelde inwoners stoppen niet met thuismonitoring, indien nuttig en doelmatig, maar blijven (laag intensief) gemonitord, tenzij terminale/eindfase is bereikt. Zorg wordt vanuit ziekenhuis overgedragen aan de HA die samenwerkt met de wijkverpleging en apotheker. Dit zal resulteren tot een vroegtijdige ingreep bij verslechterde situatie	a) In regio Twente hebben we één thuismonitoringcentrum (visueel) waarin we als regio onze inwoners monitoren
3. Voorgestelde overbrugging tussen oud en nieuw	a) Ontwikkel één regionaal thuismonitoringscentrum (virtueel) en realiseer interoperabiliteit met verschillende zorgportalen zodat zorgprofessionals toegang hebben tot alle thuismonitoringsgegevens b) Zet een gestandaardiseerd logistiek proces op voor de distributie en onderhoud van apparatuur c) Maak de keuzes in applicatie/applicaties die inwoners gebruiken voor het invoeren van hun monitoringsgegevens, welke inzichtelijk zijn in het regionale thuismonitoringscentrum, zodat inwoners/clienten en zorgverleners een gezamenlijke en geïntegreerde beleving ervaren.	a) Voeg protocollen en beleid samen en ontwikkel een regionaal standaardprotocol per zorgvraag voor thuismonitoring, in aansluiting op de landelijk ontwikkelde protocollen in ZBJ b) Ontwerp en verspreid gestandaardiseerde instructiematerialen voor thuismonitoring c) Zet technologie en personeel in voor het continu monitoren van inwoners, met oog op de landelijke ontwikkelingen zoals CumuluZ d) Ga een samenwerkingsverband aan met wijkverpleging en huisartsen om ziekenhuisopnames te voorkomen en herschikken van de takenverdeling. e) Standaardiseer stopcriteria in het regionale protocol voor thuismonitoring f) Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het “levenspad” aan HA	

Roundtable voor inhoudelijk overleg met zorgprofessionals m.b.t. zorgtransformatie in de regio

Tijdens de ontwikkeling van het transformatieplan bleek het een uitdaging om alle betrokken zorgprofessionals samen te brengen voor een gesprek en hun input te verzamelen. Daarom zal er een roundtable worden georganiseerd om diepgaand de zorgtransformatie door middel van gekoppelde telemonitoring te bespreken. De inzichten die tijdens deze sessie worden verzameld, zullen worden geïntegreerd in de implementatieplannen die in de volgende fase worden opgesteld. Tijdens de roundtable zullen onderwerpen zoals a) de realisatie van zorgtransformatie met behulp van gekoppelde thuismonitoring, b) het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, c) de mogelijke verschuiving van taken binnen de zorgketen met de nodige randvoorwaardelijke ondersteuning, en d) de selectie van specifieke zorgpaden en zorgvragen worden behandeld.





1.4.5 Betrokken stakeholders op organisatieniveau, hun rol in het zorgproces en de transformatie



Verdieping op de betrokken stakeholders (voor de eerste 5 zorgpaden)

		Algemene doelen	Voordelen	Rolbeschrijving
Inwoner met zorgvraag	• Primair	• Mogelijkheid tot langer thuiswonen • Zelfmanagement van ziektelast, bevordert eigen regie en zelfredzaamheid • Hulp: zoveel als mogelijk, zo weinig als mogelijk	• Tijdig ingrijpen • Voorkomen van verergering klachten • Bevordert eigen regie, zelf en samenredzaamheid	• Proactief betrokken bij zorg door zelfmonitoring
Mantelzorger	• Secundair	• Ontzorgen • Up-to-date blijven • Voorkomen van verergering klachten	• Vroegtijdig ingrijpen bij noodsituaties • Betere inzicht in ziekteverloop	• Biedt (praktische) hulp en emotionele steun
Huisarts/POH ¹	• Primair	• Betere en completer inzicht in situatie van inwoner • Tijdwinst/efficiëntie en reductie werklust	• Vroegtijdig ingrijpen bij noodsituaties • Betere inzicht in ziekteverloop	• Monitort gezondheidstoestand
Medisch specialist (MS/VS)	• Primair	• Betere en completer inzicht in situatie van inwoner • Tijdwinst/efficiëntie en reductie werklust	• Vroegtijdig ingrijpen bij noodsituaties • Betere inzicht in ziekteverloop	
Wijkverpleegkundige	• Primair	• Beter en completer inzicht in situatie van inwoner • Tijdwinst/reductie werklust	• Voorkomen onnodige taken • Preventie gezondheidsrisico's • Meer regie bij de inwoner	• Bezoekt inwoner thuis bij afwijkingen en kan deze live inzien • O.b.v. triage wordt inzet wijkverpleegkundige geïndiceerd • Wijkverpleegkundige lost indien mogelijk situatie op afstand op
Ondersteunende diensten (bijv. apotheek, fysio)	• Secundair	• Beter en completer inzicht in situatie van inwoner	• Beter inzicht in ziekteverloop • Medicatiemanagement beter aan laten sluiten op ziekteverloop	• Betrokken bij medicatiebegeleiding passend bij uitkomsten thuismonitoring





1.4.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Organisatie- en regiobeleid

We committeren aan landelijke wet- en regelgeving met aanvullend de onderstaande regelgeving, afspraken en richtlijnen

Wet- en regelgeving & beleid

- NEN 8028
- CE-markering conform MDD
- Gebruik van open internationale standaarden voor interoperabiliteit (zoals de Nuts code)

Regionale afspraken

- Manifest Regionaal Samenwerken
- Twente Beter: verbeteren gezondheidszorg in de regio d.m.v. intensieve samenwerking
- Andere afspraken die gemaakt zijn in regionale programma's, zoals Zorg voor Morgen en waardegedreven zorg

Richtlijnen

- Telemonitoring voor volwassenen thuis
- Handreiking telemonitoring
- Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (VSZ)
- NHG richtlijnen voor geselecteerde zorgpaden (bijv. hartfalen, COPD, etc.)

Randvoorwaarden

- Aansluiten op landelijk ontwikkelde standaarden, afspraken en initiatieven zoals CumuluZ en mogelijk Zorg bij Jou

- Oprichten van een klankbordgroep (afvaardiging van zorgprofessionals én inwoners) per zorgvraag voor de uitwerking van de gekoppelde hybride zorgpaden
- Samenwerkingsafspraken/intentieverklaring tussen alle betrokken stakeholders
- Afspraken over de verdeling van de kosten en baten over de keten en betrokken partijen

- Zoveel mogelijk voldoen aan bovengenoemde richtlijnen om uniformiteit en schaalbaarheid te waarborgen





1.4.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Uitgangspunten voor thuismonitoring diensten in regio Twente



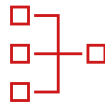
Efficiëntie in resourcegebruik

We vermijden het opnieuw uitvinden van het wiel door geen nieuwe diensten voor gekoppelde thuismonitoring te creëren als er al bestaande diensten in de regio zijn die voldoen aan onze ambities en eisen.



Aansluiting bij landelijke initiatieven

We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en initiatieven zoals CumuluZ, om te zorgen voor consistentie en synergie met breder gedragen projecten.



Integratie met bestaande structuren

We benutten bestaande governance-structuren en werkgroepen met betrekking tot gekoppelde thuismonitoring in de regio, om continuïteit en effectiviteit te garanderen.



Gebruik van bewezen technologieën

We maken gebruik van bestaande, beproefde en goed functionerende applicaties in de regio die flexibel en schaalbaar zijn, om de implementatie te versnellen en de betrouwbaarheid te verhogen.



Benutting van bestaande kennis

We benutten opgedane kennis en ervaringen, zoals bestaande documentaties en praktijkervaringen, om te leren van het verleden en de efficiëntie van nieuwe implementaties te verbeteren.





1.4.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Benodigde diensten voor gekoppelde thuismonitoring

Gebaseerd op de korte- en lange termijn ambities in de regio Twente

Diensten	 Digitale voordeur en receptie	 Monitoring en coördinatie zorgacties	 Logistieke en technische coördinatie
Rol	• Informatiepunt voor inwoners dat informatie rondom thuismonitoring verstrekt • Organiseert alle onboarding en offboarding activiteiten	• Monitoren van inwoners op afstand • Coördinatie van zorgacties tussen zorginstellingen en inwoners	• Coördinatie logistieke processen en medische hulpmiddelen • Technische ondersteuning voor inwoners en zorgprofessionals
Activiteiten	• Verwerken aanmelding en onboarding inwoner/ inwoner: includeren, instrueren en indien nodig trainen inwoner en mantelzorger • Excluderen inwoner: zorgen voor overdracht en communicatie m.b.t. exclusie richting alle betrokkenen • Helpdesk voor algemene vragen	• Monitoren (uitlezen metingsignalen en/of vragenlijsten volgens protocol en begeleiding indien nodig) • Triage o.b.v. afspraken en protocollen • Coördinatie van zorgacties naar zorgprofessionals of andere relevante zorgaanbieder in het netwerk o.b.v. protocollen en gemaakte afspraken	• Logistieke coördinatie van hulpmiddelen: zoals apparatuur, software etc. • Logistieke coördinatie van zorgmedewerkers: zoals onboarding nieuwe zorgprofessionals, instructies en rechten geven • Storingsmeldingen en technische inhoudelijke ondersteuning: incl. coördinatie richting leveranciers
Ambitie 2026	• Waar mogelijk gezamenlijk, anders via eigen voordeur	• Aansluiten bij de bestaande monitoring centra in regio en monitoring via 1 dezelfde applicatie per zorgpad	• Logistieke en technische coördinatie is binnen elke zorginstelling geregeld, indien mogelijk gebruik maken elkaar diensten • Uniformeren van werkwijzen en regionale afspraken m.b.t. apparatuur en logistiek maken
Doorontwikkeling	• Eén centrale (virtuele) punt voor regio Twente	• Triage van inwoners voordat die naar huisarts of ziekenhuis gaan	• Een centrale (virtuele) distributie en coördinatie centrum in regio Twente
Randvoorwaarde	Data beschikbaarheid en informatie uitwisseling via de regionale datahub		





1.4.7 Randvoorwaarden nieuwe werkwijze



Randvoorwaarden



Randvoorwaarden aan de techniek

- Een goed geïntegreerde platform dat gebruik wordt voor thuismonitoring voor zowel inwoner en zorgprofessionals, dat kan landen op de landelijke data-infrastructuur, gebruik makend van internationale standaarden
- De nodige gegevens moeten naadloos en veilig uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende zorgprofessionals en systemen; inzichtelijk maken van minimale set medische gegevens, ook voor inwoners, via digitale portalen
- Generieke bouwstenen voor autorisatie, identificatie, en authenticatie
- De inwoner moet toestemming geven voor het delen en uitwisselen van (medische) gegevens (bijv. via Mitz)
- De nodige digitale infrastructuur (zoals beeldbellen en chatten) moet opgezet en onderhouden worden om thuismonitoring te ondersteunen
- Er moet een dashboard beschikbaar komen
- zorgprofessionals hebben waar nodig de mogelijkheid op afstand en onafhankelijk van tijd te werken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ook bij de inwoner thuis zorg te verlenen. Digitale zorg voor de inwoner is op verschillende apparaten en zoveel mogelijk 24/7 beschikbaar, indien doelmatig en zinnig.
- De inwoner kan uitgaan van veilige zorg, o.a. dat de apparatuur veilig is en voldoet aan alle gestelde eisen



Randvoorwaarden aan het proces

- Er moeten regionaal afgestemde medische protocollen (incl. logistieke en procesmatige afspraken) zijn voor het starten, monitoren en stoppen van monitoring, per zorgvraag
- Zorg moet beschikbaar zijn op het moment dat het nodig is (continuïteit). De inwoner kan erop vertrouwen dat de zorg beschikbaar is, zoals dat is afgesproken. Hiervoor moeten er met regio afspraken gemaakt worden. Vervolgens moeten deze afspraken in alle werkprocessen aangepast zijn, zodat de juiste informatie beschikbaar is en zorgprofessionals beschikbaar zijn.
- Zorgpaden zoals hartfalen moeten geïntegreerd zijn in de digitale en fysieke praktijken van de betrokken zorginstellingen
- Afspraken m.b.t. takenverdeling en verantwoordelijkheden
- Logistieke afspraken m.b.t medische hulpmiddelen zoals apparatuur
- Afspraken m.b.t passende financiering door de zorgverzekeraar, voor registratie en afwikkeling (waar, door wie en hoe)



Randvoorwaarden aan de mens

- Er moet draagvlak onder de verschillende zorgprofessionals in regio zijn of gecreëerd worden om de hybride zorg en thuismonitoring in gezamenlijkheid uit te voeren
- Inwoners en mantelzorgers moeten adequaat geïnformeerd en ondersteund worden over (de mogelijkheden van) thuismonitoring
- Eenduidige regionale communicatie en campagne m.b.t. thuismonitoring
- Inwoners weten waar de regionale thuismonitoring-diensten te vinden zijn (gastvrijheid). De inwoner ervaart de diensten als een geïntegreerd geheel omdat er één digitaal ingang is.
- De diensten zijn gebruiksvriendelijk omdat ze aansluiten bij de doelgroep



1.4.8 Impactanalyse Gekoppelde Thuismonitoring – Quadruple aim

→ Dit zijn de effecten die we verder uitwerken op de volgende pagina(s)

Gezondheidszorg uitkomsten

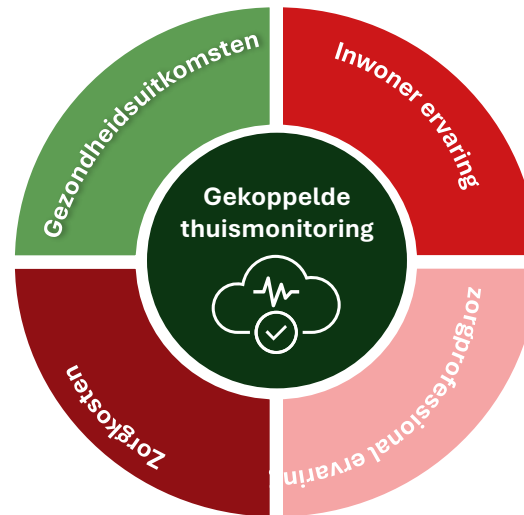
- Inwoners krijgen meer inzicht in hun eigen gezondheid, wat leidt tot meer rust en een hogere kwaliteit van leven
- Er is meer vertrouwen in de zorg en zorg wordt efficiënter aangeboden door deze op de juiste plaats te verstrekken
- Verbeterde toegang tot preventie en vroege signalering

Meer ruimte voor de zorg in de regio Twente

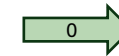
- Door continue monitoring en vroegtijdige signalering:
 - 1 → - Worden onnodige opnames in ziekenhuizen en VVT voorkomen
 - 2 → - Wordt de ligduur per opname verkort en doorstroom naar VVT en huis bevordert
 - 3+4 → - Neemt het aantal (poli)consulten af, zowel in ziekenhuis als bij de huisarts

Hierdoor hebben specialisten in het ziekenhuis meer tijd voor hoog-complexe zorg en kunnen we met minder zorgmedewerkers dezelfde (of zelfs meer) zorg leveren. Inwoners krijgen tijdiger interventies, wat escalatie van ziekten voorkomt.

- 3+4 → — De zorg verschuift van een controle-gebaseerde aanpak naar een vraaggerichte benadering, waarbij zorg wordt geboden wanneer het echt noodzakelijk is, zonder onnodige controles.
- Er komt meer tijd beschikbaar om te besteden aan de groeiende groep ouderen, die toenemend gebruikmaakt van ons zorgstelsel
- Door samenwerking tussen de 1^e en 2^e lijn in de regio verbetert niet alleen de kwaliteit van zorg, maar wordt ook schaalvergroting mogelijk gemaakt omdat meerdere zorginstellingen aansluiten



Inwonertevredenheid

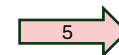


- Inwoners hebben meer regie en zijn beter in staat tot zelfredzaamheid door verbeterde toegang tot zorginformatie en door minder fysieke zorgafspraken
- Het informele netwerk van de patiënt (bijv. naasten en mantelzorgers) worden meer betrokken bij het zorgproces, wat hen in staat stelt om effectiever bij te dragen en eerder in te grijpen
- Zorg wordt flexibeler aangeboden via digitale toegangspunten (o.a. digitale vragenlijsten en consultatie op afstand), waardoor inwoners zorg kunnen ontvangen zonder werkverzuim
- Inwoners kunnen langer thuis blijven wonen dankzij verbeterde ondersteuning en toegankelijkheid van zorg
- Inwoners ervaren kortere lijnen tussen (spoed)zorg en sociaal domein, wat essentieel is in het complexe zorglandschap
- Eenduidige informatie vanuit één zorgprofessional (bijv. informatieverstrekking m.b.t. COPD)

Zorgprofessionaltevredenheid

- Zorgprofessionals ervaren vergemakkelijkte communicatie en een juiste verdeling van taken door betere samenwerking binnen de regio
- Meer werkplezier door juiste en volledige informatie over de juiste inwoner
- Minder administratieve werklast

Wat vraagt het van de zorg in de regio?



- De zorglast voor het monitoren en controleren van de kwaliteit van monitoring verplaatst (mogelijk) richting de uitvoerders binnen het regionale thuismonitoringscentrum.





1.4.8 Impactanalyse Gekoppelde Thuismonitoring – Effecten

Optimalisatie van de driehoek tussen huisarts, wijkverpleging en ziekenhuis om zorg van de 2^e naar de 1^e naar de 0^e lijn te verplaatsen, waardoor instroom huisartsen en ziekenhuis vermindert en zorgkosten dalen¹

0. Regionale gekoppelde thuismonitoring stelt inwoners in staat om meer zelfregie en zelfredzaamheid te ontwikkelen vanuit huis, wat leidt tot een afname van de zorgconsumptie op verschillende plekken binnen verschillende sectoren:									
 1. Voorkomen van ziekenhuisopnames		 2. Verkorten van ligduur in het ziekenhuis		 3. Vermindering van poli consulten		 4. Vermindering van POH consulten		 5. Verschuiving van zorglast	
Met gekoppelde thuismonitoring neemt het aantal ziekenhuisopnames af, gemiddeld gezien voor de gehele populatie per zorgpad. Hierdoor hebben specialisten in het ziekenhuis meer tijd voor hoog-complexe zorg en kan met minder zorgmedewerkers dezelfde / meer zorg geleverd worden.		Door gekoppelde thuismonitoring wordt de ligduur in het ziekenhuis verkort, waardoor zorggebruikers sneller naar huis / VVT kunnen. Voor chronische zorggebruikers betekent dit minder functieverlies en conditieverlies als gevolg van langdurige opnames.		Met gekoppelde thuismonitoring zullen het aantal contactmomenten van zorggebruikers met zorgprofessionals in het ziekenhuis verminderen, doordat de zorg verschuift van een controle-gebaseerde aanpak naar een vraaggerichte benadering.		Met databeschikbaarheid en mogelijkheid van thuismonitoring tooling zullen het aantal contactmomenten van zorggebruikers bij de huisarts verminderen, doordat er meer tijd ontstaat bij POH voor andere taken.		Doordat er meer zorggebruikers worden geïncludeerd bij de implementatie van het thuismonitoringscentrum zal de zorglast verschuiven richting de wijkverpleging en het monitoringscentrum.	
MSZ		MSZ		MSZ		Huisarts		Thuismonitoringcentrum	
Patiëntenpopulatie ZGT ² : 10.260		Patiëntenpopulatie ZGT ² : 10.260		Patiëntenpopulatie ZGT ² : 10.260		Patiëntenpopulatie bij huisarts: VVR patiënten in regio Twente +/- 33.000 (50% van 66.000)		Patiëntenpopulatie ZGT ² : 10.260	
Uit cijfers van het OLVG blijkt dat het aantal SEH-bezoeken en (klinische) opnames van COPD inwoners vermindert. In totaal vermindert het aantal ziekenhuisopnames met 20% per inwoner per jaar.		Uit cijfers van Zorg bij Jou (MST) blijkt dat de gemiddelde ligduur van inwoners met COPD met 1-2 dagen vermindert.		Uit cijfers van het OLVG en Zorg bij Jou blijkt dat het aantal ziekenhuis consulten afneemt met 1 consult per jaar.		Een consult bij POH bij VVR patiënt is 25 min. Op jaarbasis zullen POH's in de regio Twente (SHT-Thoon en FEA) totaal 16.500 uur aan de taken kunnen besteden die op dit moment in de praktijken blijven liggen.		Gemiddeld genomen zal de verschuiving van zorglast een toename van 120 minuten per patiënt per jaar betekenen voor verpleegkundigen in de wijkverpleging of het thuismonitoringscentrum.	
			COPD		Hartfalen	Diabetes type 2	Atriumfibrilleren	Chronisch nierfalen	<i>Gemiddeld</i>
De ambitie van gekoppelde thuismonitoring is om <u>gemiddeld 19%</u> van alle inwoners in scope (5 zorgvragen) in 2026 te includeren.		2024	0%		0%	0%	0%	0%	0%
		2025	10%		10%	0%	0%	0%	4%
		2026	30%		30%	20%	10%	5%	19%

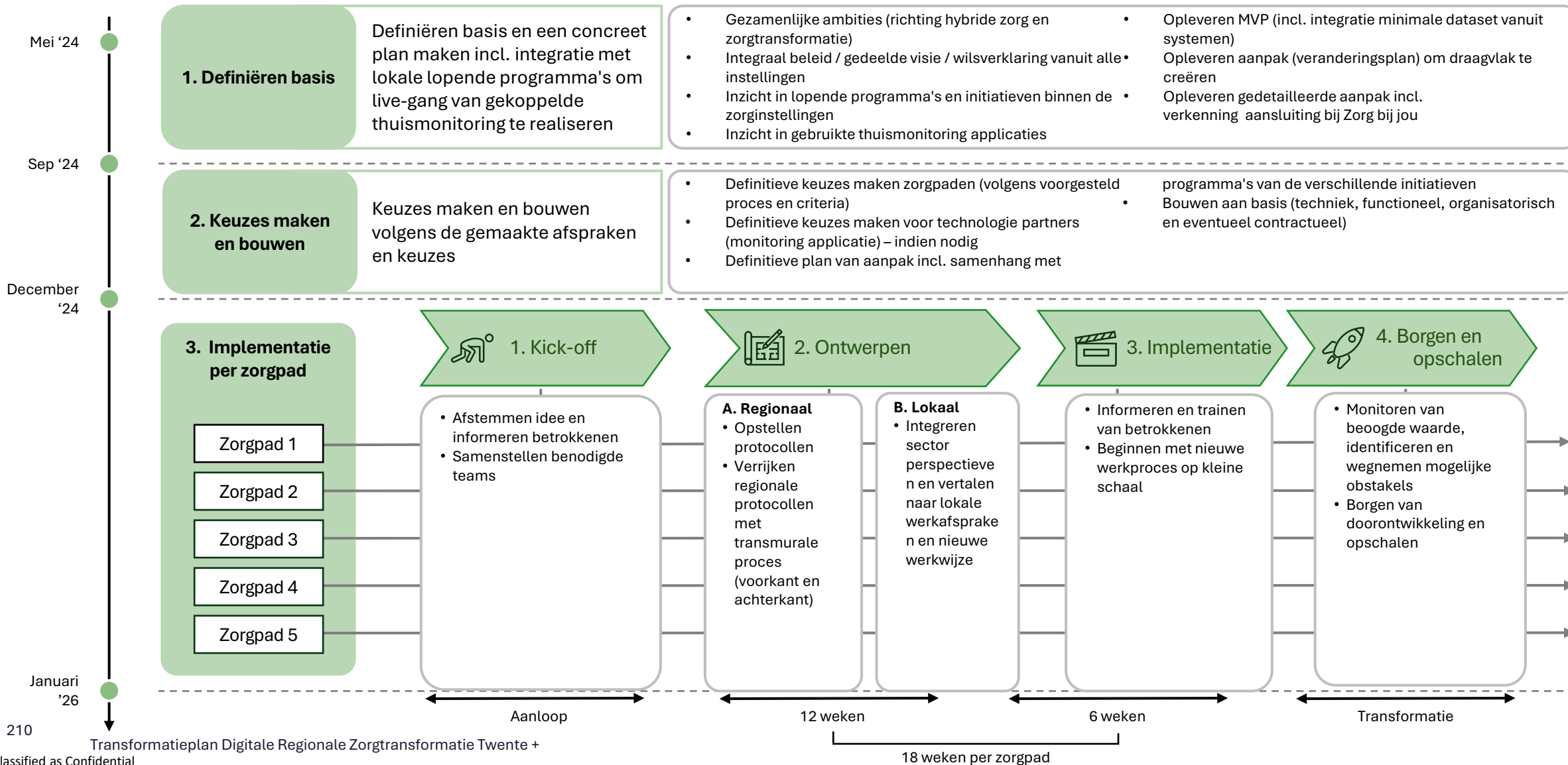
1) Hierbij houden we rekening met al gehonoreerde impact en effecten van Zorg bij Jou voor het MST. 2) Het aantal inwoners waar hier vanuit wordt gegaan is een optelsom van de patiëntenstromen opgeteld voor 5 zorgpaden binnen het ZGT. Dit voorbeeld is exemplarisch uitgewerkt voor 5 nog te selecteren zorgpaden die in aanmerking komen voor regionale gekoppelde thuismonitoring. In dit voorbeeld hebben we populatie van COPD, hartfalen, diabetes type 2, AF en chronisch nierfalen genomen.





1.4.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak gekoppelde thuismonitoring

Stapsgewijs realiseren we de transformatie, die grote veranderingen op het gebied van technologie, samenwerken en leveren van zorg met zich mee brengt



1.4.9 Maatschappelijke business case | Projectplanning & resourceallocatie

Gemiddelde personele inzet per jaar (FTE)			
Rollen	2024	2025	2026
Projectleider			
Arts			
Behandelaren			
(Gesp.) verpleegkundige			
Huisarts			
(Wijk)Verpleegkundige			
projectleider			
Functioneel beheerder			
Totaal aantal (FTE)			
Totaal percentage extern (%)			

Legenda:

Intern

Extern

Intern/Extern





1.4.10 SMART-doelstellingen

Transformatie- planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Definiëren basis	I			Maart Oplevering projectplan live-gang Oplevering PvA & MVP (technisch)							
Deelproject 2 – Verbinden, keuzes maken en bouwen	I				Juni Keuzes maken Definitieve keuzes voor zorgpaden en implementatie plan						
Deelproject 3 – Implementatie en gebruik zorgpaden	I						December Implementatie zorgpad 1 Gem. voor 4% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	Maart Implementatie zorgpad 2 Gem. voor 7,75% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	Juni Implementatie zorgpad 3 Gem. voor 11,5% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	September Implementatie zorgpad 4 Gem. voor 15,25% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik	December Implementatie zorgpad 5 Gem. voor 19% van de patiënten binnen de geselecteerde zorgpaden in gebruik
Vermindering <i>poli consulten</i> t.o.v. 0-meting	R						December Gem. -65 consulten in MSZ	Maart Gem. -480 (cum.) consulten in MSZ	Juni Gem. -980 (cum.) consulten in MSZ	September Gem. -1480 (cum.) consulten in MSZ	December Gem. -2000 (cum.) consulten in MSZ

Disclaimer: de KPI's zijn gebaseerd op gemiddelde inclusiepercentages en patiënten aantallen binnen de vijf te implementeren zorgpaden. Aangezien de volgorde en selectie van de zorgpaden nog niet definitief zijn, kunnen de daadwerkelijke aantallen variëren. Deze cijfers dienen als richtlijn en kunnen fluctueren afhankelijk van de implementatievolgorde. Houd rekening met deze variabiliteit bij het evalueren van de KPI's. Aanpassingen zullen volgen zodra de definitieve selectie en volgorde van de zorgpaden zijn vastgesteld.





1.4.11 Risicoanalyse & mitigerende maatregelen

Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Zorgprofessionals zijn niet voldoende op de hoogte van (regionale) afspraken	Hoog	Gemiddeld	Ontwikkelen van een communicatieplan met regelmatige updates en bijeenkomsten om zorgprofessionals te informeren en goede toegankelijkheid naar de juiste informatie in de regio te bieden.
Mogelijke toename van zorglast door verschuiving van zorg	Hoog	Hoog	Ondersteuning van monitoringcenter bieden waar nodig en doelmatig. De juiste taken verdeling en inzet van digitale middelen om zorgprofessionals te ondersteunen.
Exclusie van bepaalde groepen zoals zorgmijders en digibeten van het thuismonitoringssysteem omdat het niet past of omdat inwoners niet willen	Gemiddeld	Gemiddeld	Het oude systeem blijft bestaan waardoor exclusie niet zozeer een probleem is. Daarnaast moet er ook worden ingezet op het rekening houden met toegang en gebruik voor deze doelgroep (simplificeren), bijvoorbeeld door het toevoegen van animaties, gebruik van weinig knoppen etc.
Toename van (laag-volume) hoog-complexe inwoners in het ziekenhuis of bij de huisarts. <i>Dit is ook tegelijkertijd een goede ontwikkeling, want bijv. co-morbiditeit wil je in ziekenhuis opvangen en niet in 1e lijn.</i>	Hoog	Gemiddeld	Herzien en aanpassen van de huidige systemen en protocollen om zorgprofessionals in staat te stellen meer tijd te besteden aan inwoners met complexe zorgbehoeften.
Weerstand tegen (technologische) verandering bij zorgprofessionals en inwoners	Hoog	Hoog	Bewustwording creëren over de uitdaging in de zorg die ons te wachten staat. Daarnaast moeten we samen successen vieren en dit ook uitdragen in de regio. Ook moeten we het niet te ingewikkeld maken voor inwoners; die willen vaak wel.
Onvoldoende samenwerking en afstemming tussen zorgprofessional, met name bij co-morbiditeit waar inwoners vaak in meerdere zorgpaden betrokken zijn en dus meerdere applicaties gebruiken	Gemiddeld	Gemiddeld	Ontwikkelen van een uniform protocol en werkwijze die door alle zorginstellingen in de regio gebruikt wordt en bewustwording creëren over de nut en noodzaak.
Onvoldoende validiteit en betrouwbaarheid van apparatuur, metingen en registratie	Laag	Laag	Betrekken medische technologie bij de keuzes mbt apparatuur. Duidelijke instructies richting clienten/inwoners mbt uitvoeren metingen.
Kwesties rondom patiënttoestemming en privacy bij gegevensuitwisseling	Laag	Laag	Inwoners toestemming stimuleren via Mitz. Daarnaast moet geborgd worden dat alleen de noodzakelijke medische dataset inzichtelijk is.
Onbetrouwbare en niet valide data	Gemiddeld	Gemiddeld	Gebruik maken van bestaande standaarden, waar mogelijk internationaal



Verdieping 1.5 Regionaal capaciteitsinzicht



1.5.1 Regionaal capaciteitsinzicht | Kernproblematiek

Onvoldoende inzicht in en afstemming tussen vraag naar en aanbod van beschikbare zorgcapaciteit



Huidige situatie

De nood is hoog

De stijgende zorgvraag in Twente en het toenemende tekort aan personeel vragen om goede benutting van beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Jaarlijks wordt voor ca. 7000 inwoners in het ziekenhuis en bij de huisartsen een plek gezocht in de eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)¹, thuiszorg en Wlz. Dit aantal zal alleen maar toenemen. Voor goede benutting van beschikbare zorgcapaciteit en het bepalen van de juiste vervolgzorg is de beschikbaarheid van de juiste informatie noodzakelijk. Anno 2024 is dit (nog) niet overal in de regio Twente het geval.

Informatie ontbreekt

Het organiseren van passende vervolgzorg kost veel tijd en wordt bemoeilijkt door het ontbreken van informatie, zowel in ziekenhuizen als bij huisartsen. Medisch specialisten, (transfer)verpleegkundigen en huisartsen zijn dagelijks druk bezig om voor de genoemde 7000 inwoners een geschikte nazorg plek te vinden. Huisartsen worden vaak gestoord door zorgbemiddelaars van de VVT met vragen over inwoners voor het regelen van nazorg. Het idee is dat het zorgcoördinatie centrum (ZCC), in eerste instantie in de ANW-uren, de nazorgaanvragen voor de huisartsen gaat coördineren. Maar ook voor deze coördinatie is het essentieel dat de juiste informatie beschikbaar is voor de juiste indicatie en het vinden van de geschikte zorg of het geschikte bed. Daarnaast is het van belang dat de juiste (na)zorg ook op het juiste moment beschikbaar is, zowel in acute als electieve zorgsituaties. Op dit moment is de (opname)capaciteit van de juiste (na)zorg niet overal actueel inzichtelijk.

Negatieve gevolgen voor de zorg

Het gevolg hiervan is dat inwoners vaak te lang op een “verkeerd” bed blijft liggen als blijkt dat er geen capaciteit is bij de passende vervolgzorg. Dit kan zowel een bed in het ziekenhuis, in de ELV, GRZ, WLZ of thuiszorg zijn. Een deel van deze inwoners ontvangt hierdoor geen of niet de juiste zorg. Bovendien blokkeren inwoners op een verkeerd bed het bed voor andere inwoners, waarvoor het bed wel de juiste zorg is. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit op de behandellocatie niet optimaal benut. Dit leidt tot onnodige kosten en inwoners krijgen niet de zorg die past bij de zorgvraag op dat moment. Deze situatie is voor zowel de inwoner als de zorgaanbieders onwenselijk. Daarnaast is het momenteel moeilijk om vooruit te kijken (of zelfs te voorspellen) welke capaciteit nodig zal zijn. Hierdoor blijft het afstemmen van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio suboptimaal.

Het bovenstaande geeft een beeld van het huidige zorggebruik in de regio. Goed afstemming van zorgvraag en zorgaanbod is van belang zodat de **juiste patiënt op het juiste moment, in één keer goed, door de juiste hulpverlener** geholpen kan worden. Ketenbreed capaciteitsinzicht is nodig om de patiënt op het juiste moment de juiste zorg te kunnen bieden. Maar allen capaciteitsinzicht is niet voldoende. Inzicht in capaciteit zal niet leiden tot minder verkeerde beddagen, een toename van opname capaciteit of een goede doorstroming in de zorgketen. Hiervoor is aanvullend een goed ingerichte zorgketen met eenduidige procesafspraken voor de hele regio nodig, die met analyses d.m.v. capaciteitsinzicht geoptimaliseerd kan worden.

Zorgvraag van Twentse inwoners



616 duizend
huisarts consulten in 2022²



29.6 duizend
inwoners met
wijkverpleging in 2022³



267 duizend
inwoners behandelt
in het ziekenhuis in 2022⁴



900
inwoners met
een ELV-indicatie in 2022⁴



1100
inwoners met Grz-indicatie
in 2021³



6550
ZZP 4-8 indicaties in
2022⁴



7757
inwoners met een
WLZ-indicatie in 2021⁴



1.5.1 Regionaal capaciteitsinzicht | Kernproblematiek

Onvoldoende inzicht in en afstemming tussen vraag naar en aanbod van beschikbare zorgcapaciteit



Knelpunten



Knelpunt 1: Onvoldoende zicht op zorgvragen in relatie tot de beschikbare capaciteit

Er is onvoldoende inzicht in specifieke (opname)capaciteit. Dit geldt voor acute (opname)capaciteit, van bijv. spoed-ELV, of planbare (opname)capaciteit, zoals thuiszorg. Naast beschikbaarheid van capaciteit is er ook behoefte aan inzicht in de soort of differentiatie van capaciteit bij verschillende zorgaanbieders. Dit is met name een knelpunt in de VVT. In deze sector is er bijvoorbeeld weinig inzicht in welke inwoner (incl. indicatie) er op welk bed past bij welke organisatie. Dit maakt afstemming tussen verschillende zorgverleners inefficiënt en heeft vaak een mismatch tussen vraag en aanbod tot gevolg. Daarnaast is er in de wijkverpleging zeer beperkt inzicht in de beschikbare capaciteit bij spoed (met de kanttekening dat in sommige gevallen er wel wordt gewerkt met een stoplichtmethodiek). Ook ontbreekt het aan zicht op wachttijden en wachtlijsten. Voor het goed kunnen functioneren van het toekomstig ZCC is dit regionale inzicht randvoorwaardelijk.



Knelpunt 2: Ontbreken van zorgsectoroverstijgende samenwerking in de regio door een goed in gerichte zorgketen

Het proces van de doorstroom in de zorgketen is in Twente niet goed op elkaar afgestemd. Dit geldt voor het gehele proces dat betrekking heeft op meerdere zorgsectoren of deelprocessen zoals (huisarts – ziekenhuis – VVT). Een goed ingerichte zorgketen bestaande uit een naadloze aansluiting van de verschillende deelprocessen bevordert de doorstroom in de gehele keten. Een goede doorstroom leidt tot minder wachttijd voor de patiënt, minder herstelwerkzaamheden, minder uitvragen van patiëntinformatie en minder belasting van de zorgprofessional. Zo krijgt de inwoner eerder de juiste zorg, op het juiste bed, bij de juiste professional.

Zo verschilt de aanvraag van nazorg per huisarts, wat het verzamelen van de juiste informatie bij huisartsen door een zorgbemiddelaar in de VVT tijdrovend maakt. Een ander voorbeeld is het ontbreken en niet hanteren van uniforme definities van bedden. In de praktijk wordt vaak naar zorgzwaarte gekeken en dit wordt verschillend geïnterpreteerd in de match tussen zorgvraag en aanbod. Ook zijn werkafspraken met betrekking tot de spoedstroom niet voldoende gestandaardiseerd tussen betrokken organisaties. Daarnaast ontbreken vaak afspraken of houden organisaties zich niet aan afspraken over transparantie m.b.t. data inzicht en deling. Zonder goede samenwerkingsafspraken is er weinig vertrouwen en opnamebereidheid, wat de doorstroom in de keten hindert.



Knelpunt 3: Te weinig sturing op het benutten van bestaande capaciteit binnen het regionale netwerk

Op regionaal niveau wordt nauwelijks actief gestuurd op het bij elkaar brengen van zorgvraag en –aanbod. Dit geldt zowel voor operationele, tactische als strategische sturing. De kern van dit probleem ligt in het ontbreken van inzicht in de vraag en het aanbod binnen verschillende sectoren. Bovendien wordt er binnen ziekenhuizen en VVT-instellingen weinig geanticipeerd op vervolgzorg bij het plannen van planbare zorg. Dit gebrek aan afstemming tussen zorgvraag en –aanbod belemmert efficiënte doorstroom van inwoners vanuit de plek waar ze oorspronkelijk behandeld zijn. Bestaande capaciteit wordt hierdoor onvoldoende efficiënt benut.



1.5.2 Regionaal capaciteitsinzicht | Ambitie

Real-time inzicht in capaciteit, gezamenlijke afspraken over het proces en sturing in de acute en electieve zorgketen



Ambitie voor eind 2026

- **Inzicht:** In het ontwikkelde regionaal capaciteitsdashboard is de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen en de intramurale en extramurale VVT eind 2026 inzichtelijk voor zorgprofessionals. Beschikbare capaciteit betreft niet alleen een beschikbare bed of plek, maar ook welke zorg er geleverd kan worden. Daarnaast is beschikbare capaciteit van organisaties die acute zorg aanbieden, waaronder de ziekenhuizen, inzichtelijk. Tevens is informatie over zorginstellingen (bv. organisatie-, contact-, en profielgegevens) beschikbaar. Het dashboard is schaalbaar naar capaciteitsinzicht van de andere sectoren, zoals de GGZ en ambulancezorg. Het dashboard kan gebruikt worden door o.a. ZCC-triagisten, huisartsen en transferverpleegkundigen en –coördinatoren om de overdracht van inwoners naar een andere zorginstelling te ondersteunen. Dit betekent dat:
 - Applicaties waarin momenteel capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt zijn ontsloten (zoals elektronische patiënt en –clientdossiers). Hierdoor is de acute en planbare zorgcapaciteit binnen de ziekenhuizen en VVT-sector real-time in te zien. Wij sluiten hierbij zo veel als mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied (bv. het Landelijke Platform Zorgcoördinatie).
 - Beschikbare capaciteit automatisch vanuit bronsystemen inzichtelijk is. Administratieve vertragingen in het werkproces zijn opgelost en informatie is gebaseerd op de laatst beschikbare data. Als voorbeeld nemen we hier het Landelijke Platform Zorgcoördinatie, dat automatisch (elke 5 minuten) data uit de ziekenhuis-EPDs ontsluit.

Link met IZA-opgaven*

- **JZOJP;** Inzicht in de regionale capaciteit van de juiste zorg op het moment dat de patiënt deze nodig heeft. De verbeterde doorstroom naar die zorg draagt bij aan JZOJP.
- **Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals;** de last en werkdruk die zorgprofessionals ervaren in het regelen van vervolgzorg (belletjes/mailcontact/etc.) neemt door de beschikbaarheid van relevante capaciteitsgegevens af
- **Basis voor zorgcoördinatie in de ROAZ regio;** Regionaal capaciteitsinzicht levert een belangrijke basis voor zorgcoördinatie

*De use case Regionaal capaciteitsinzicht hangt nauw samen met het 360-graden beeld en ACP in de keten. In overdrachten tussen zorgprofessionals gaat de synergie tussen deze use cases naar schatting veel waarde voor de inwoners van Twente en zorgprofessionals opleveren.



1.5.2 Regionaal capaciteitsinzicht | Ambitie

Real-time inzicht in capaciteit, gezamenlijke afspraken over het proces en sturing in de acute en electieve zorgketen



Ambitie voor eind 2026

- **Zorgsectoroverstijgende samenwerking** : Er is een gezamenlijk zorgketenproces beschreven voor zowel huisartsen, de ziekenhuizen en de VVT. Het zorgketenproces is een werkproces over de verschillende organisaties heen, voor optimale doorstroom van de inwoner door de zorgketen; het is dan ook geen verzameling of opeenvolging van werkafspraken van de verschillende zorgorganisaties. Dit betekent dat:
 - Op basis van een gezamenlijk zorgketenproces werkafspraken zijn gemaakt voor de overdrachten (incl. indiceren, aanbieden, beoordelen en overplaatsen). De werkafspraken ondersteunen een optimale doorstroom van inwoners in de keten, waardoor er in de regio minimale aantallen verkeerde bedden in de VVT en het ziekenhuis zijn en de zorgprofessionals die taken uitvoeren die behoren bij hun functie. Momenteel worden zorgprofessionals (zoals huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden) belast met taken in het kader van nazorg die eigenlijk niet bij hun functie horen. Deze belasting is niet wenselijk in het kader van een toenemend tekort op de arbeidsmarkt.
 - Het capaciteitsdashboard ondersteunt aan het nieuw ingerichte zorgketenproces, vooral bij de overdracht naar een andere zorgvraag of zorgaanbieder. Werkafspraken m.b.t. het capaciteitsdashboard sluiten aan op gezamenlijke werkafspraken. Er zijn bijvoorbeeld reeds werkafspraken gemaakt voor de LPZ-modules die zijn geïmplementeerd in deze regio (COVID, spoedmodule en geboortezorg).
 - Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de definitie van beschikbare capaciteit, o.a. de labels van bedden en welke zorg(zwaarte) door welke zorgaanbieder in de regio geleverd kan worden. Dit geldt voor zowel electieve als acute bedden, maar ook voor de differentiatie van zorg binnen de wijkverpleging
 - Er zijn gezamenlijke werkafspraken gemaakt over de coördinatie van nazorg (wie heeft welke rol, taak en verantwoordelijkheid). We werken vanuit wederzijds vertrouwen op proces en data. ZCC-triagisten, transfercoördinatoren en VVT-coördinatoren (clientadviseurs) kennen elkaar en werken meer vanuit ketensamenwerking en o.b.v. vertrouwen in de informatievoorziening die men aanlevert.
- **Databeschikbaarheid voor procesoptimalisatie en sturing op zorgvraag en -aanbod**: Het zorgketenproces wordt zo ingericht en ondersteunt door databeschikbaarheid dat de inwoner op het juiste moment, de juiste zorg door de juiste hulpverlener, door de juiste zorgaanbieder ontvangt. Deze inrichting leidt tot minder wachttijd, minder verkeerde beddagen en inzet van zorgprofessionals. Voor het in stand houden van de nieuwe ingerichte zorgketen is inzicht in de data noodzakelijk (doen we wat we hebben afgesproken en levert dit de gewenste resultaten op).
 - Inzicht in de data geeft ook de mogelijkheden om te analyseren waar het beter kan (doen we de goede dingen). Deze inzichten kunnen leiden tot procesverbetering, aanpassingen van werkprocessen of efficiëntere inrichting van de keten. Hierdoor komen meer inwoners op het juiste moment, bij de juiste zorgprofessional en ontvangen zij de juiste zorg.
 - De data heeft mogelijkheden de trends in zorgvraag en het zorg gebruikt te ontdekken. Het aanbod van de verschillende voorzieningen kunnen hier op worden aangepast. Denk daarbij aan planbare orthopedische operaties, maar ook een wisselende vraag naar GRZ bedden gedurende het jaar. AI (artificial intelligence) kan ondersteunen bij de analyse van inwonerstroom zodat de ontwikkeling van de zorgvraag (per voorziening) kan worden voorspeld en het zorgaanbod hier op kan worden afgestemd.



1.5.3 Regionaal capaciteitsinzicht | Doorontwikkeling

Toevoegen nieuwe toepassingen en sectoren en de ontwikkeling van analyse- en voorspelmodellen



Doorontwikkeling – inzicht in het netwerk

Na de implementatie van het transformatieplan zijn de volgende doorontwikkelingen mogelijk op het gebied van regionaal capaciteitsinzicht:



Ontsluiting van inzicht in de capaciteit en drukte van andere sectoren

Na 2026 willen wij ook het inzicht in de capaciteit van zorgaanbieders uit andere sectoren verbeteren om overdrachten binnen zorgnetwerk nog beter te ondersteunen. Dit geldt voor zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn en betekent dat deze sectoren ook hun eigen capaciteit inzichtelijk maken via het dashboard:

- Ambulancezorg
- Huisartsenzorg en HAP's, met de kanttekening dat hooguit inzichtelijk is welke praktijken open/gesloten zijn voor inschrijving
- Revalidatiezorg
- GGZ
- Apotheek-spoedzorg

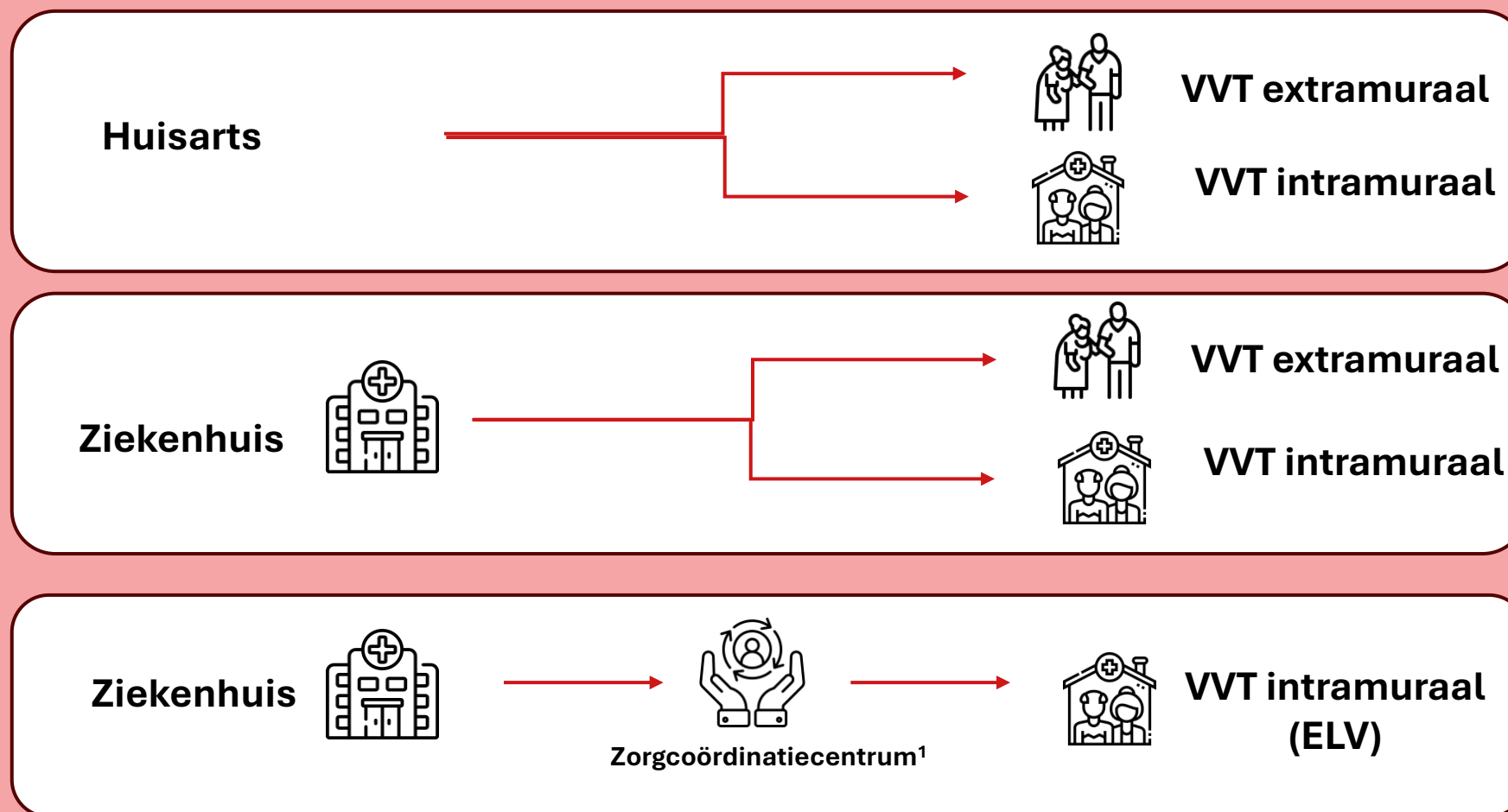
Ontwikkeling analysemodellen

Ontwikkeling van analysemethoden (bijv. met toepassing van AI) om zowel historische analyses als voorspelmodellen te ontwikkelen voor sturing binnen het regionale zorgnetwerk.

Als we op basis van de gegevens kunnen voorspellen wat de zorgvraag gaat zijn, kunnen we hier op inspelen door bijv. het aanbod aan te passen (spreiding en concentratie).



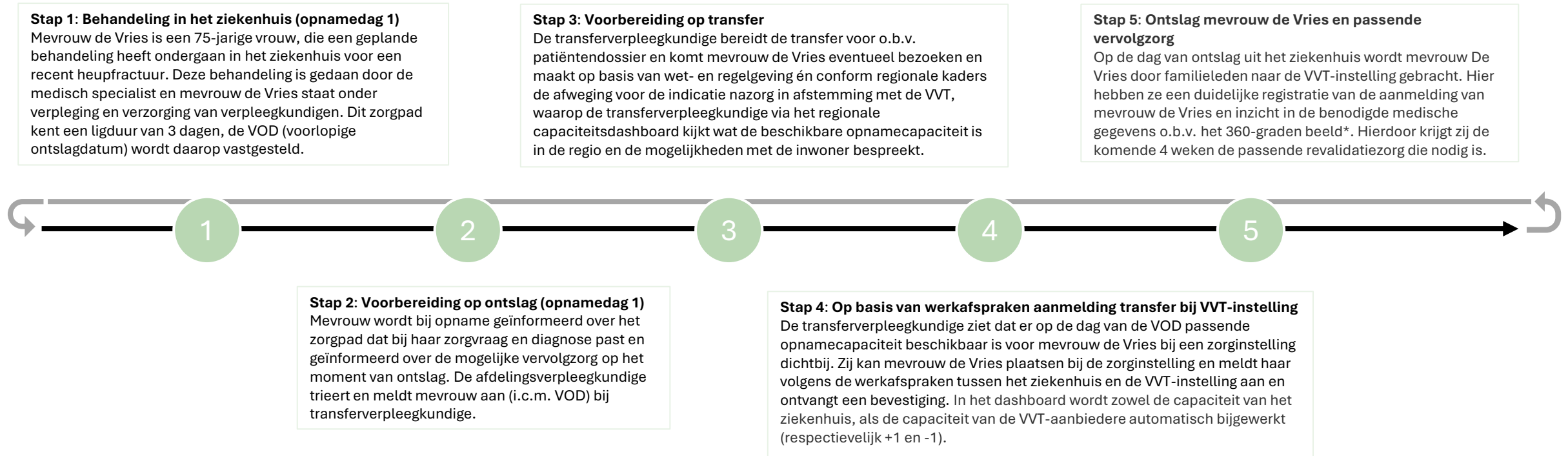
De volgende overdrachten van inwoners om de juiste zorg op de juiste plek, in één keer bij de juiste zorgprofessional te ontvangen zijn in scope binnen deze use case:



Na 2026 worden de inwoner- en gebruikersreizen uitgebreid met de doorontwikkelingen zoals beschreven op p.6

1.5.4a Beschrijving van regionaal capaciteitsinzicht in gebruik | Beschrijving inwonersreis (electief)

De passende vervolgzorg van mevrouw de Vries sluit haarfijn aan op haar ontslag vanuit het ziekenhuis door inzicht in capaciteit



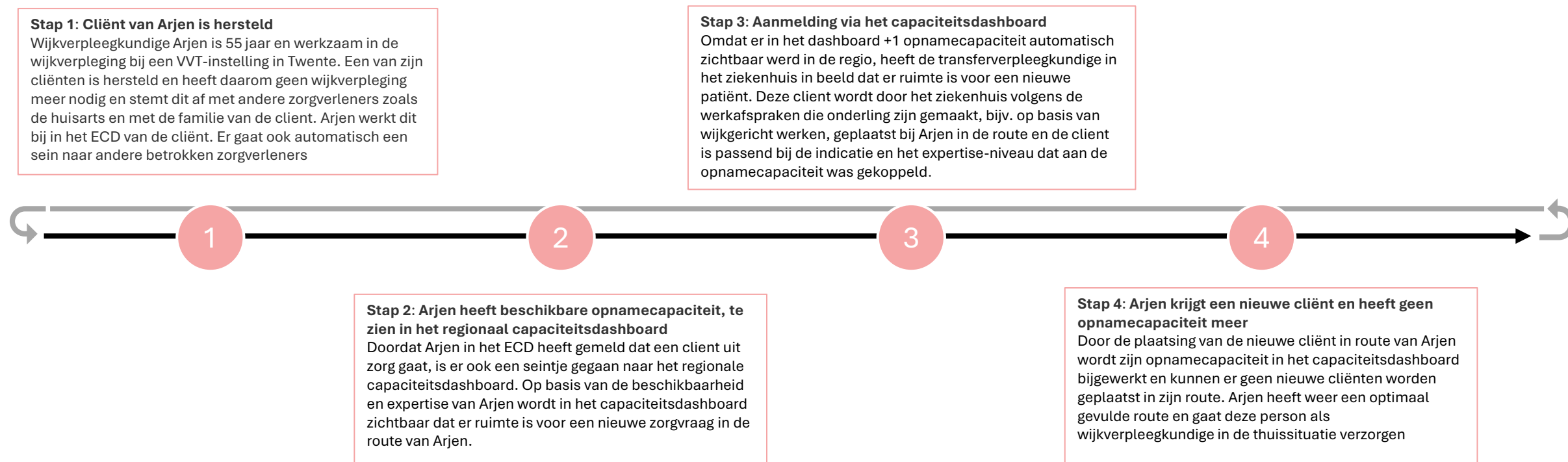
Beoogde effecten voor mevrouw de Vries

- *Mevrouw de Vries wordt op dag 1 van de opname geïnformeerd over de mogelijkheden t.a.v. passende vervolgzorg in de regio en heeft zodoende verwachtingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk*
- *Door goede werkafspraken hoeft mevrouw de Vries niet langer dan nodig in het ziekenhuis te blijven, waar zij niet de passende zorg voor haar zorgvraag kan krijgen*
- *Mevrouw de Vries wordt conform verwachtingen die geschept zijn op dag 1 van de opname (voor zowel verblijf in het ziekenhuis als in de VVT-instelling) in haar zorgvraag geholpen en is daarmee erg tevreden over het verloop*



1.5.4b Beschrijving van regionaal capaciteitsinzicht in gebruik | Beschrijving gebruikersreis (electief)

Verpleegkundige Arjen's opnamecapaciteit wordt in het regionaal capaciteitsdashboard bijgewerkt



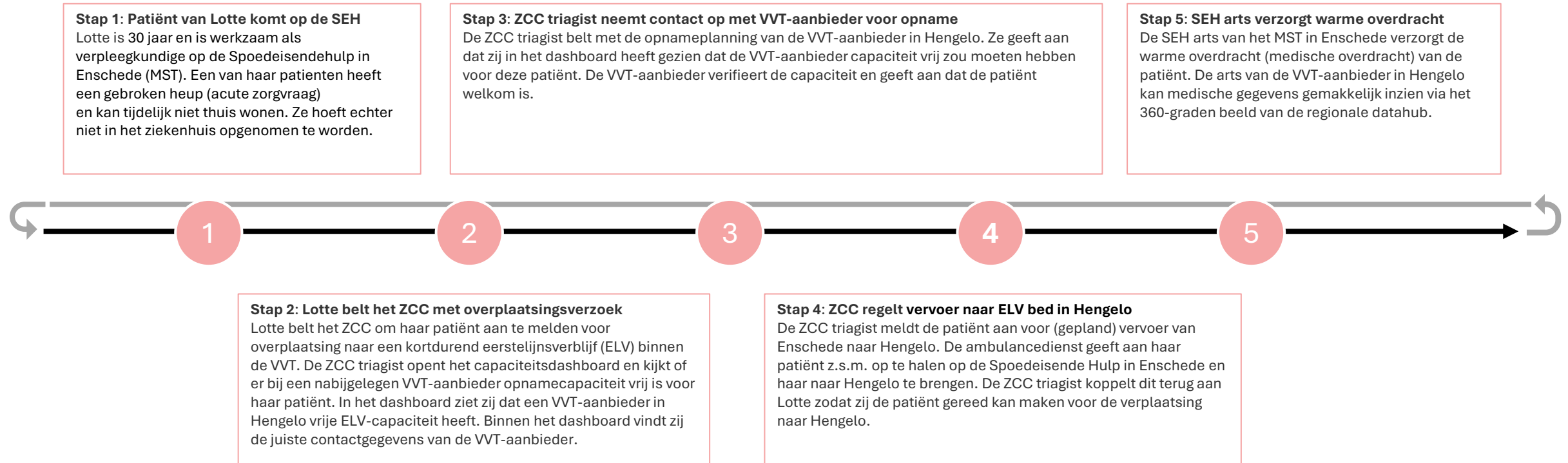
Beoogde effecten voor Arjen en de VVT-instelling

- De opnamecapaciteit van de wijkverpleging wordt automatisch bijgewerkt en behoeft geen extra administratieve handelingen, dit scheelt Arjen tijd
- Wijkverpleegkundige Arjen krijgt geen telefoontjes meer vanuit de VVT-instelling of vanuit het ziekenhuis of er inwoners aangemeld kunnen worden terwijl er geen plek is
- Arjen is erop gerust dat er goede werkafspraken zijn gemaakt tussen het ziekenhuis en de VVT-instelling waardoor inwoners worden aangemeld die passen bij zijn opnamecapaciteit
- Arjen heeft altijd een optimaal ingevulde route en weet tijdig wanneer er afgeschaald of opgeschaald moeten worden



1.5.4c Beschrijving van regionaal capaciteitsinzicht in gebruik | Beschrijving gebruikersreis (acuut)

Lotte coördineert opnameplek (acuut) ELV-bed door regionaal capaciteitsinzicht



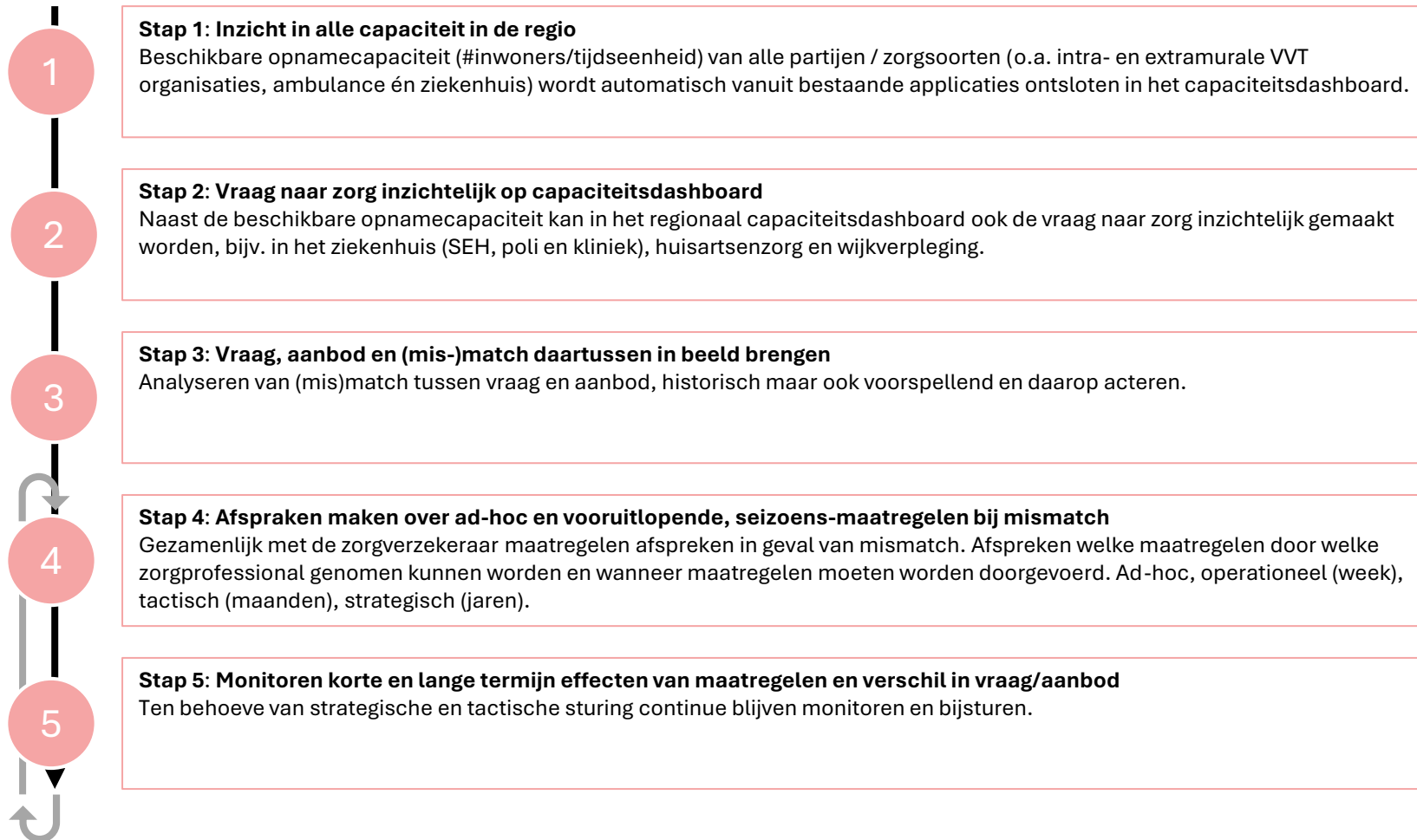
Beoogde effecten voor Lotte en haar collega's van de SEH

- De opnamecapaciteit van VVT-aanbieders wordt automatisch bijgewerkt en behoeft geen extra administratieve handelingen, dit scheelt Lotte tijd
- Lotte weet waar zij haar patiënt kan aanmelden voor opname en hoeft hierdoor maar 1 telefoontje te plegen (en dus niet rond te bellen voor een bed)
- Lotte is erop gerust dat er goede werkafspraken zijn gemaakt tussen de ziekenhuizen en VVT-aanbieders waardoor haar patiënt wordt aangemeld die past bij de opnamecapaciteit



1.5.4d Beschrijving van regionaal capaciteitsinzicht in gebruik | Stappen om te komen tot tactische sturing

Op den duur tactisch kunnen sturen op capaciteit in de gehele keten



Beoogde effecten zorgproces

- *Mismatch tussen vraag en aanbod is tijdig in beeld zodat hier op geanticipeerd kan worden, zodat er een betere afstemming is tussen vraag en aanbod.*
- *Processen en planning worden beter op elkaar aangesloten, zodat er minder verkeerde beddagen zijn in iedere sector en minder wachttijd.*
- *Tactische bijsturing op gemaakte afspraken en strategische sturing op toekomstige zorgvraag (voorspellen) wordt tijdig ingezet om een zorginfarct te voorkomen.*



1.5.4e Beschrijving van regionaal capaciteitsinzicht in gebruik | Fit-gap analyse

1. Huidige proces en workflow	• Acuu: De ziekenhuizen hebben een koppeling vanuit hun EPD (Chipsoft Hix) met LPZ. De VVT heeft dit nog niet, hoewel er wel landelijke ontwikkelingen zijn waarin POINT aan LPZ wordt gekoppeld. • Acuu: Hoewel POINT in de hele regio door de VVT wordt gebruikt is er geen actueel inzicht in extramurale opnamecapaciteit. De inrichting, het gebruik en de werkafspraken met betrekking tot POINT zijn in verschillende betrekkingengebieden verschillend. • Electief: In de VVT gebruikt men de applicatie POINT om capaciteit in te registreren. Zorgorganisaties hebben echter zelf niet altijd gedigitaliseerd inzicht in eigen capaciteit per indicatie. Er zwerven nog steeds 'Excelletjes' rond. • Electief: Er zijn geen regiobrede werkafspraken over het transferproces, waaronder het inplannen van de voorgestelde ontslagdatum. Wel wordt er in de sub-regio Almelo/Hengelo binnen de Twentse Transferketen gewerkt met sub-regionale werkafspraken die resultaat opleveren. In de sub-regio Enschede/Haaksbergen zijn ook regionale werkafspraken waarbij capaciteit centraal inzichtelijk is en waarop geanticipeerd wordt. Er worden in verschillende stuurgroepen toegewerkt naar een optimalisatie van dit proces. • Electief: Capaciteit in het aantal bedden wordt handmatig ingevuld in POINT door de VVT, zowel intramuraal als extramuraal. • Electief: Opnamecapaciteit wordt o.b.v. "ervaring" aangeboden, bijv. op hoe vaak er ruimte is of zorg geleverd kan worden. • Electief: Er is niet automatisch inzicht in welk wijkteam van de wijkverpleging er plek heeft.
2. Vereisten nieuwe proces	• Zorgketenproces: Inrichten van een zorgketenproces bestaande uit samenwerkingsafspraken voor de overdracht van inwoners voor nazorg door de huisartsen, ziekenhuizen en VVT. In het proces is de overdracht, het aanvragen van vervolgzorg en het overplaatsen van inwoners aan de hand van werkafspraken beschreven. • Zorgketenproces: Uniforme definities over opnamecapaciteit, zoals voorgestelde ontslagdata en het verschil in type/labels bedden en evt. zorgzwaarte regiobreed hanteren. • Zorgketenproces: Werkafspraken m.b.t. triage voor transfers, het inzichtelijk maken van capaciteit in het regionaal capaciteitsdashboard bijv. door middel van de stoplichtmethodiek zoals wordt toegepast in de Almelo sub-regio, prioritering van inwoners uit de regio en wanneer transfers kunnen plaatsvinden (bijv. in de ANW-uren). Tevens dienen regionale afspraken gemaakt te worden over up-to-date houden van informatie. • Techniek: Een regionaal capaciteitsdashboard waarin een actueel inzicht in de opnamecapaciteit van VVT-instellingen en ziekenhuizen in de regio 24/7 beschikbaar is • Techniek: Koppelingen realiseren met de EPD/ECDs zodat capaciteit niet meer handmatig hoeft te worden geregistreerd • Techniek: Routeplanningen van de wijkverpleging zijn gedigitaliseerd. Op basis hiervan blijkt of er nog ruimte is in de planning is en dus beschikbare capaciteit.
3. Voorgestelde overbrugging van oud naar nieuw	Deze ziet er tweeledig uit: • Het technisch ontwikkelen van een regionaal capaciteitsdashboard, waarin bovenstaande vereisten als functionaliteiten worden opgenomen. Aanvullend op de ontwikkeling van het dashboard zijn ook werkafspraken over het gebruik van het dashboard nodig. • Werkafspraken voor de gehele regio waarin o.a. uniforme definities en procesafspraken met elkaar zijn afgesproken o.b.v. best practices uit de sub-regio's Enschede-Haaksbergen en Hengelo/Almelo.



Als voorgestelde overbrugging naar de nieuwe situatie waarin regionaal capaciteitsinzicht regiobreed geïmplementeerd is, stellen wij de volgende ontwikkelstromen voor:



1.5.5 Betrokken stakeholders op organisatieniveau, hun rol in het zorgproces en de transformatie



Verdieping op de betrokken stakeholders

	Primaire/secundaire stakeholder	Mate van betrokkenheid	Rol in nieuwe zorgproces	Verandering t.o.v. huidig zorgproces
Ziekenhuizen	• Primaire stakeholder	• Hoog	• Aanleveren capaciteitsinzicht middels automatische verbinding EPD en datahub/dashboard • Gebruiker van het regionaal capaciteitsdashboard om transfers tussen ziekenhuizen en de VVT mee te organiseren • EPD up-to-date houden (garbage in, garbage out principe) conform (nieuwe) werkafspraken	• Interne werkprocessen stroomlijnen m.b.t. bijhouden EPD, in de praktijk wordt informatie nu onvoldoende bijgewerkt (bv. bed blokkeren of vrijgeven).
VVT-aanbieders	• Primare stakeholder	• Hoog	• Aanleveren capaciteitsinzicht middels automatische verbinding ECD en datahub/dashboard • ECD up-to-date houden (garbage in, garbage out principe) conform (nieuwe) werkafspraken	• VVT-aanbieders hebben geen automatisch inzicht in (acute) capaciteit. Systemen moeten hiervoor opgezet worden en worden gekoppeld aan datahub/dashboard.
Zorgcoördinatie-centrum (ZCC)	• Primaire stakeholder	• Hoog	• Triage en coördinatie van zorginzet en vervolgzorg (in eerste instantie in ANW-uren) o.b.v. regionale capaciteitsinzicht.	• Op dit moment doet de centralist van de meldkamer ambulancezorg, de triagist van de HAP en de zorgcentralist van de VVT de triage, coördinatie van zorginzet en vervolgzorg vanuit de eigen domeinen. Door dit gezamenlijk vanuit het ZCC te doen is er 1 punt waar gezamenlijk vanuit een totaaloverzicht de juiste zorg ingezet kan worden.
Huisartsen ¹	• Primaire stakeholder	• Hoog	• Contact opnemen met het ZCC voor coördinatie van acute vervolgzorg voor inwoners. • Organiseren en coördineren van transfers vanuit planbare opname naar VVT .	• Niet meer zelf zorginzet regelen, direct contact opnemen met ZCC waar inzicht in capaciteit is en snel inzet van zorg gerealiseerd kan worden. Voorbeeld hiervan is de coördinatie van inwoners binnen de VVT met een grotere zorgbehoefte. De huisarts is hier nu nog een tussenschakel in, maar kan in het toekomstige proces wellicht door de verpleegkundige in de VVT i.s.m. het ZCC passende vervolgzorg krijgen.

1) Mogelijke veranderingen in rol e/o taken bij de implementatie van de regionale datahub, dienen verder afgestemd en gevalideerd te worden met de huisartsen in de regio.



1.5.6 Afspraken nieuwe werkwijze – Organisatie- en regiobeleid

Bestaande afspraken worden gehandhaafd en regiobreed geüniformeerd, een sturingsmethodiek is nodig rondom beheer, werk- en zorgprocesafspraken voor het regionaal capaciteitsdashboard

Wet- en regelgeving & beleid

- Het regionaal capaciteitsdashboard verwerkt organisatie- en capaciteitsgegevens in overeenstemming met geldende wet - en regelgeving. Deze gegevens bevatten nadrukkelijk géén gegevens van inwoners of andere gegevens die tot concrete personen kunnen worden herleid.
- Daarnaast zijn er landelijke afspraken m.b.t. de implementatie van het zorgcoördinatiecentrum gemaakt waar rekening mee gehouden moet worden.
- Ook dient rekening te worden gehouden met beleidsregels met betrekking tot ZZP/CIZ indicaties en Zvw (Elv en Grz).

Regionale afspraken

- In Euregio is er vanuit het bestuurlijk ROAZ commitment om aan te sluiten bij de landelijke (door)ontwikkeling van LPZ, inclusief de daar bijbehorende werkafspraken. Hiermee wordt ook een nadrukkelijke link gelegd met de regionale implementatie van zorgcoördinatie (in de vorm van een ZCC), waarvoor capaciteitsinzicht een belangrijke randvoorwaarde is.
- Er is regionaal door de samenwerkingsverbanden 'Samenwerken aan Waarde' en 'Zorg voor Morgen' besloten om, gelet op best practices uit de Twentse Transferketen, werkafspraken in de regio te uniformeren. Deze best practices zullen aangevuld moeten worden met afspraken over de keten- en procesinrichting m.b.t. regionaal capaciteitsinzicht en het gebruik van het regionaal capaciteitsdashboard.

- Er dient een regionale sturingsmethodiek ingericht te worden, waarin het beheer van het dashboard en bijbehorende werk- en zorgprocesafspraken samen komen.

Richtlijnen

- **Informatiestandaard eOverdracht.** Regiobrede afspraken over het gebruik van regionaal capaciteitsinzicht houden rekening met de informatiestandaard eOverdracht. Deze informatiestandaard zorgt voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens.
- **Twentse crisisregeling.** Twentse zorgaanbieders onder de vlag van IZO Twente hebben een regeling voor crisisplaatsing bij ouderenzorginstellingen. In de coördinatie hiervan kan regionaal capaciteitsinzicht een rol spelen, vandaar dat de richtlijn afgestemd moet worden.
- Regiobrede en sectoroverstijgende uniformering en optimalisatie van proces- en werkafspraken over het gebruik van capaciteitsinzicht (incl. Uniforme definities) dienen in een richtlijn te worden opgenomen.

Randvoorwaarde

- Gedurende de transformatieperiode dient de werkgroep op de hoogte te zijn van veranderende wet en regelgeving (bijv. Wegiz) rondom de uitwisseling van gegevens die in het capaciteitsinzicht worden gebruikt.



1.5.7 Randvoorwaarden nieuwe proces



Randvoorwaarden



Randvoorwaarde aan de techniek

- Ziekenhuizen hebben API-verbinding (o.b.v. FIHR HL7) van EPD naar LPZ. Eenzelfde API verbinding kan ook gemaakt worden voor het regionaal capaciteitsdashboard.
- API-verbinding tussen ECDs/POINT/Zorgdomein en het regionaal capaciteitsdashboard (o.b.v. FIHR HL7), voor automatische ontsluiting van capaciteitsgegevens
- Gestandaardiseerde inrichting van het regionaal capaciteitsdashboard.
- Het regionaal capaciteitsdashboard is web-based, dus locatie-onafhankelijk te benaderen (ook via iPhone/iPad). Internet noodzakelijk.



Randvoorwaarde aan het proces

- Duidelijke werkafspraken over gebruik en interpretatie van het regionaal capaciteitsdashboard. Hier hoort een uniforme definitielijst bij.
- De informatie getoond in het dashboard dient als middel voor zorgcoördinatie. Aanvullend kan er extra afstemming nodig zijn, waarvoor werkafspraken gemaakt moeten worden.
- De informatie getoond in het regionaal capaciteitsdashboard mag niet anders gebruikt worden dan de doeleinden zoals beoogd in de gemaakte samenwerkingsafspraken.
- Het nieuw ingerichte zorgproces (samenwerkingsafspraken) worden door zowel de huisarts, het ziekenhuis als de VVT in gezamenlijkheid ingericht en uitgevoerd. Met als uitgangspunt dat afspraken niet per deel van het proces worden gemaakt, maar als geheel
- Werkprocessen worden zo veel mogelijk geautomatiseerd t.b.v. uniformiteit en verkleinen van foutgevoeligheid.
- De zorginstelling is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het dashboard. Dit geldt voor de capaciteitsdata, maar ook voor de telefonische bereikbaarheid (deze gegevens kunnen in het dashboard worden ingevoerd bij contactgegevens).



Randvoorwaarde aan de mens

- Juiste datakwaliteit en registratie aan de bron.
- Transparantie wat betreft beschikbare capaciteit en houdt hiervoor het EPD/ECD zorgvuldig bij.
- Training van zorgverleners in het goed gebruik van regionaal capaciteitsdashboard.
- Onderling vertrouwen over gedeelde capaciteitscijfers en gemaakte samenwerkingsafspraken.
- Bestuurlijk vertrouwen en commitment
- Eenduidige implementatie van gezamenlijke werkafspraken per organisatie, afgestemd op de interne processen
- Gelijkericht commitment vanuit zorgverzekeraars op aanpassen inkoopbeleid o.b.v. efficiëntere bedrijfsvoering zorgorganisaties



1.5.8 Impactanalyse | Overkoepelende quadruple aim regionaal capaciteitsinzicht

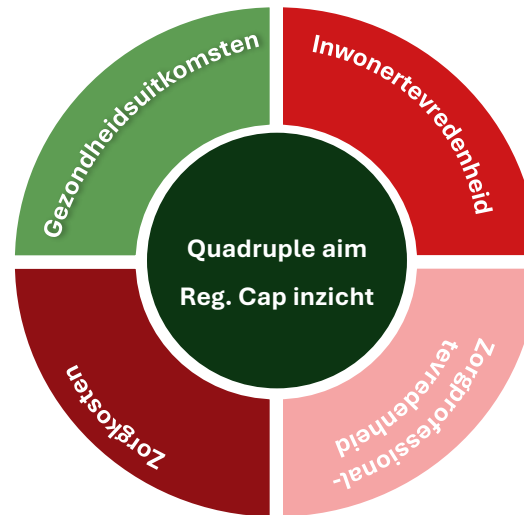
Meer tijd voor zorgprofessional en juiste zorg op de juiste plek voor de inwoner

Gezondheidsuitkomsten

- Juiste zorg op juiste plek
- Meer passende en doelmatige zorg voor de inwoner
- Betere kwaliteit van leven voor de inwoner
- Borgen toegankelijkheid van zorg gezien de stijgende zorgvraag

Zorgkosten

- Verminderen verkeerde bedproblematiek in de ziekenhuizen door betere match zorgvraag/-aanbod (juiste uitstroom) vanwege *sectoroverstijgende werk- en procesafspraken en sturing*
- Juiste inzet van vervolgzorg en daarmee reductie verkeerde bedproblematiek in de ouderenzorg door betere match zorgvraag/aanbod (goede instroom en doorstroom) vanwege *sectoroverstijgende werk- en procesafspraken en sturing*
- Vermindering administratietijd transfers voor huisarts, transfer-verpleegkundigen en –coördinatoren vanwege *inzicht*
- Vermindering coördinatietijd nazorg voor huisartsen door *sectoroverstijgende werk- en procesafspraken*
- Betere benutting van bestaande en toekomstige capaciteit in ziekenhuis en ouderenzorginstellingen vanwege *sturing en procesoptimalisatie*



Inwonertevredenheid

- Minder wachten op passende vervolgzorg door kortere doorlooptijd vanwege *netwerk- en procesafspraken en sturing en procesoptimalisatie*
- Grotere tevredenheid door beter verwachttingsmanagement over vervolgzorg vanwege *inzicht*

Zorgprofessionaltevreidenheid

- Zorgprofessionals hoeven minder te shoppen / leuren voor plekken en krijgen ook minder directe persoonlijke verzoeken voor plaatsing vervolgzorg vanwege *inzicht*
- Meer tijd voor het verlenen van zorgtaken mogelijk vanwege *inzicht en sectoroverstijgende werk- en procesafspraken*
- Juiste zorgprofessional wordt belast met nazorgtaken, zodat de schaarse professionals juist worden ingezet
- Vertrouwen in coördinatie van vervolgzorg door gemaakte afspraken tussen zorgprofessionals onderling vanwege *werk- en procesafspraken en sturing en procesoptimalisatie*



1.5.8 Impactanalyse - Impact van het regionaal capaciteitsdashboard

Door inzicht in de beschikbare capaciteit hoeven zorgprofessionals niet meer lang te zoeken naar een beschikbare plek



²⁾ o.b.v een inschatting door de regionale use case werkgroep, ²⁾ o.b.v cijfers van Alerta 2022



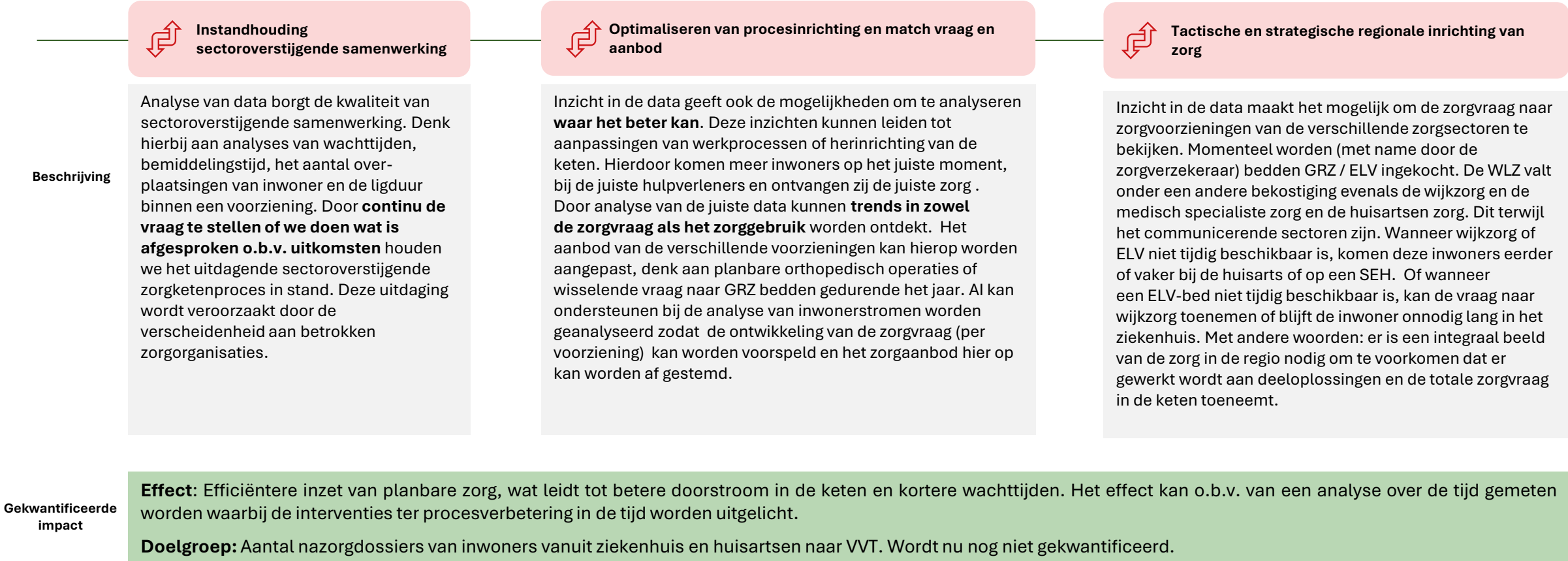
1.5.8 Impactanalyse - Impact van versterkte sectoroverstijgende samenwerking

Een efficiënt ingericht zorgnetwerk, in plaats van inrichting per zorgaanbieder of sector leidt tot meer passende zorg



1.5.8 Impactanalyse - Impact van sturen & procesoptimalisatie

Sturen & verbeteren door inzicht in capaciteit* resulteert in regionale verbetering van processen en inrichting van zorg



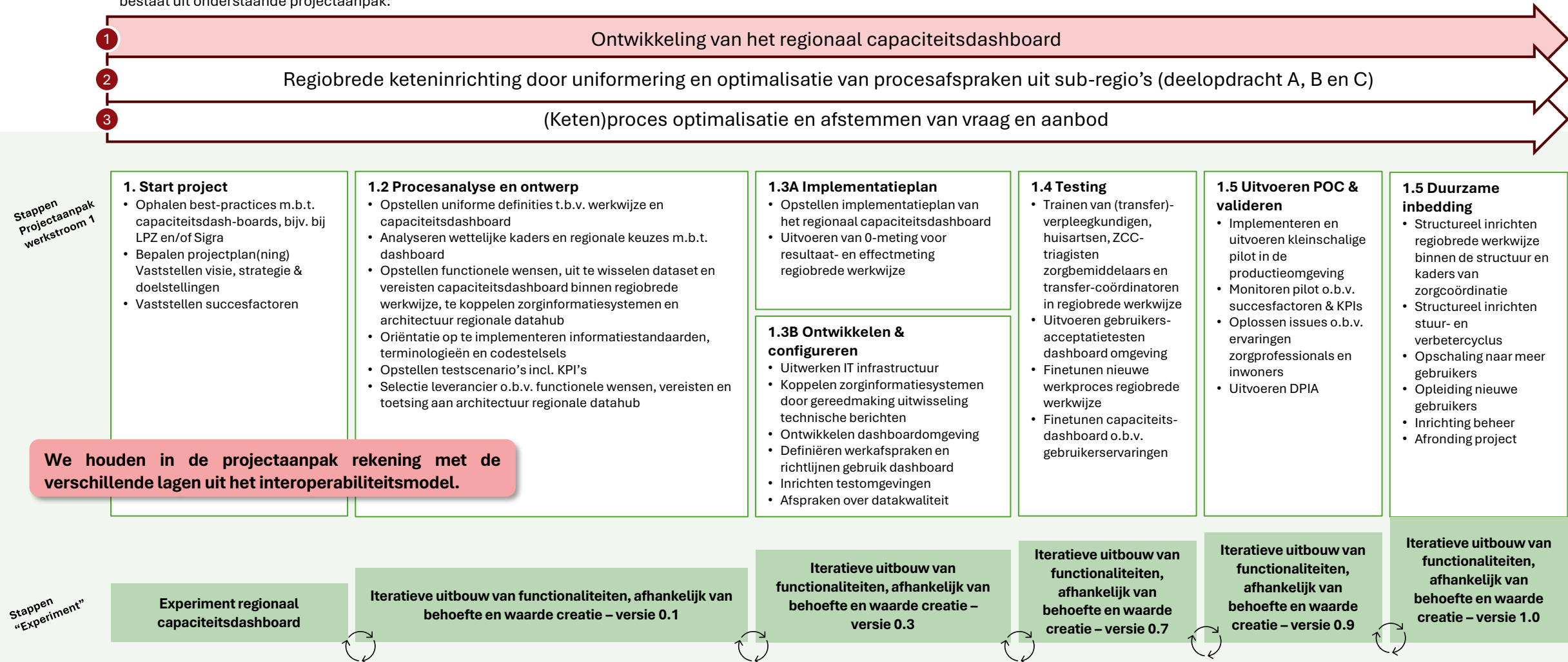
¹⁾ Inzicht in capaciteit d.m.v. het regionaal capaciteitsdashboard is randvoorwaardelijk aan het kunnen sturen & verbeteren van de regionale werkwijze. Zonder het regionaal capaciteitsdashboard kan de impact niet gerealiseerd worden.



1.5.9 Maatschappelijke business case | Projectaanpak – verdieping werkstroom 1 in het kader van het “experiment”

Iteratief uitbouwen van het experiment o.b.v. behoefte en waardecreatie

Vanuit de fit-gap analyse zijn drie ontwikkelstromen gedefinieerd. De ontwikkeling van het regionaal capaciteitsdashboard (werkstroom 1) hangt nauw samen met het KPMG/Microsoft-”experiment” en bestaat uit onderstaande projectaanpak:

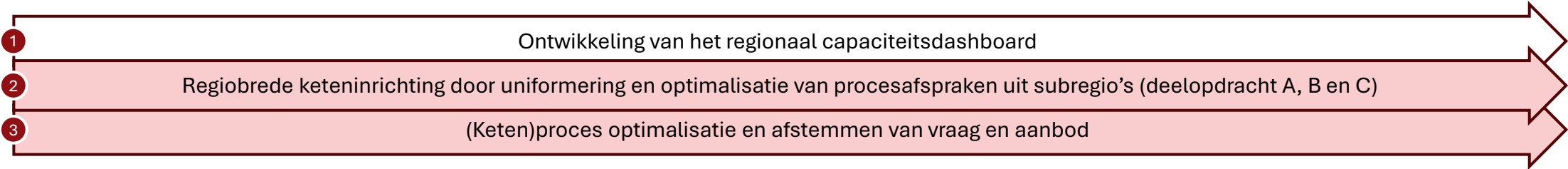


Het experiment begint klein en bouwt steeds verder uit, afhankelijk van waar de behoefte ligt en waar waarde uit gehaald kan worden. Tussen deze fases zullen meerdere test en validatiefases plaatsvinden waarin functionaliteiten worden toegevoegd aan het capaciteitsdashboard en waarbij werkprocessen aangepast worden



1.5.9. Maatschappelijke business case | Projectaanpak werkstromen 2 en 3

In twee werkstromen regiobreed sectoroverstijgende processen inrichten

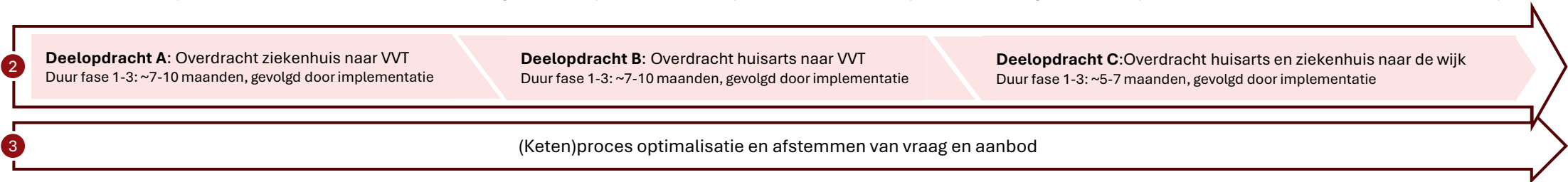


Voor de werkstromen 2 en 3 zijn de volgende activiteiten in kaart gebracht over de tijd:

Stappen
Projectaanpak
Werkstromen
2 en 3

1. Start project - Inrichten projectteams - In kaart brengen stakeholders - Bepalen projectplan(ning) voor de werkstromen - Vaststellen visie, strategie & doelstellingen voor de deelprojecten binnen werkstromen 2 en 3 o.b.v. uitwerking transformatieplan - Vaststellen succesfactoren werkstromen 2 en 3	1.2 Procesanalyse en ontwerp - Analyseren huidige proces - Identificeren eisen nieuwe proces - Ontwerpen nieuwe proces - Visualiseren en valideren nieuwe proces <i>Specifieke onderwerpen per deelopdracht</i> - Deelopdracht A: Analyse op verrijking van de overdracht ziekenhuis naar VVT, o.a. op basis van fit/gap procesanalyse werkwijze subregio Enschede en Almelo (Twentse transferketen) - Deelopdracht B: Ontwerp van overdrachtsproces huisartsen naar VVT in samenhang met het zorgcoördinatiecentrum. Ontwerp is gebaseerd op de inrichting van de Twentse transferketen, zodat er een afgestemde zorgketen ontstaat van Huisarts, ziekenhuis en VVT - Deelopdracht C: Doorontwikkeling verwijzing naar de wijkverpleging vanuit de Twentse transferketen	1.3 Implementatieplan - Opstellen implementatieplan van nieuwe regiobrede werkwijze o.b.v. deelopdrachten - Uitvoeren van 0-meting voor resultaat- en effectmeting regiobrede werkwijze	1.4 Testing - Trainen van (transfer)-verpleegkundigen, huisartsen, ZCC-triagisten - zorgbemiddelaars en transfer-coördinatoren in regiobrede werkwijze - Finetunen nieuwe werkproces regiobrede werkwijze	1.5 Uitvoeren & valideren - Implementeren en uitvoeren kleinschalige pilot in de productieomgeving - Monitoren pilot o.b.v. succesfactoren & KPIs - Oplossen issues o.b.v. ervaringen zorgprofessionals en inwoners	1.6 Duurzame inbedding - Structureel inrichten regiobrede werkwijze binnen de structuur en kaders van zorgcoördinatie - Structureel inrichten stuur- en verbetercyclus - Opschaling naar meer gebruikers - Opleiding nieuwe gebruikers - Afronding project
--	--	--	--	--	---

Werkstroom 2 en 3 starten parallel aan elkaar. Binnen werkstroom 2 volgen de deelopdrachten elkaar op. We starten met deelopdracht A, vervolgen met deelopdracht B en ronden de werkstroom af met deelopdracht C.



1.5.9 Maatschappelijke business case | Projectplanning & resourceallocatie

Gemiddelde personele inzet per jaar (FTE)			
Rollen	2024	2025	2026
Business analist			
IT-consultant			
PMO			
Projectleider			
(Gesp.) verpleegkundige			
(Wijk)Verpleegkundige			
Huisarts			
Zorgmanager			
Sponsor			
Sponsor			
Sponsor			
Totaal aantal (FTE)			
Totaal percentage extern (%)			

Legenda:

Intern

Extern

Intern/Extern



1.5.10 SMART-doelstellingen & KPIs

Met meetbare resultaten toewerken naar regionaal capaciteitsinzicht in de zorg



Transformatie-planning	I/R	2024		2025				2026			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelproject 1 – Deelopdrachten keteninrichting	I			Maart Oplevering projectplan overdracht ZKH – VVT (A) Oplevering PvA	Juni Implementatie projectplan overdracht ZKH – VVT (A) Evaluatierapport implementatie	September Oplevering projectplan overdracht HA – VVT (B) Oplevering PvA	December Oplevering projectplan overdracht HA/ZKH – Wijk (C) Oplevering PvA	Maart Implementatie projectplan overdracht HA – VVT (B) Evaluatierapport implementatie	Juni Implementatie projectplan overdracht HA/ZKH – Wijk (C) Evaluatierapport implementatie		
Deelproject 2 – Sturen en verbeteren	I				Juni Oplevering projectplan sturen & verbeteren Oplevering PvA		December Implementatie projectplan overdracht HA – VVT (B) Evaluatierapport implementatie		Juni Oplevering verbeterrapport 1 Evaluatierapport sturen & verbeteren		December Oplevering verbeterrapport 2 Evaluatierapport sturen & verbeteren
Deelproject 3 – Ontwikkelen regionaal capaciteitsdashboard	!				Juni Oplevering implementatie-plan reg. cap. dashboard Oplevering PvA		December Proof-of-concept reg. cap. dashboard Werkende versie 0.7 van dashboard bij 2 ZKH, 3 VVT		Juni Go-live reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij 2 ZKH, 3 VVT	September Opschaling reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij +1 ZKH, +4 VVT	December Opschaling reg. cap. dashboard Werkende eerste versie van dashboard bij overige VVT
Vermindering verkeerde beddagen t.o.v. 0-meting	R						5% (cum.) in ZKH		10% (cum.) in ZKH		15% (cum.) in ZKH



1.5.11 Risico-analyse & mitigerende maatregelen

Tijdig bouwen aan vertrouwen en capaciteit vrijmaken

Scope	Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Algemeen	Onvoldoende (personele) capaciteit bij functioneel beheer en ICT voor technische inrichting/koppeling tussen EPD/ECD en dashboard	Hoog	Hoog	• Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren. • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans
Algemeen	Onvoldoende (personele) capaciteit bij betrokken zorgorganisaties voor het maken van nieuwe werkafspraken	Hoog	Hoog	• Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren. • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans
Algemeen	Het niet tijdig meenemen van privacy en security officers (o.a. FGs en CISOs) in de ontwikkel en implementatie fase	Gemiddeld	Hoog	• Vaste rol, verantwoordelijkheid en mandaat geven in projectteams • Tijdig en vanuit genoeg zorgorganisaties betrekken
Use case specifiek	Een gebrek aan onderling vertrouwen kan transparantie over beschikbare capaciteit in de weg staan	Gemiddeld	Hoog	• Duidelijke afspraken maken in samenwerkingsovereenkomsten over welke organisaties welke (beschikbare) capaciteit mogen inzien en verwerken, en met welk doel
Use case specifiek	Onjuiste, onvolledige of niet tijdige registratie aan de bron. De datahub kan nog zo intelligent zijn, wanneer hierin onjuiste gegevens (garbage in) worden gevoerd, zal het uiteindelijk een onzinnig resultaat (garbage out) geven.	Gemiddeld	Hoog	• Zorgprofessional opleiden in goed en eenduidige EPD-gebruik. Registratie van capaciteit beleggen bij specifieke functionaris. Eventueel aanstelling van dedicated medewerker capaciteit. • Ontwikkelen van gebruikersvriendelijke applicaties of toepassingen voor zorgprofessionals om relevante gegevens in te zien en automatisering om gestandaardiseerd, direct aan de bron te kunnen registreren.



Duidelijke afbakening tussen transformaties m.b.t. inzicht in capaciteit in regionale plannen

Voorkomen van dubbel rekenen impact, activiteiten en benodigde investering

In zowel het transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente + als binnen het transformatieplan Twente Beter worden impactvolle transformaties met betrekking tot inzicht in capaciteit beschreven. We willen zo concreet mogelijk aangeven waarin deze transformaties van elkaar verschillen. De belangrijkste verschillen liggen op het gebied van activiteiten en de impact van de transformaties. Door deze verschillen in aanpak van de transformaties is het duidelijk dat er geen dubbele investering wordt aangevraagd.



Regionaal capaciteitsinzicht

Transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente +

- De impactvolle transformatie beschrijft activiteiten over de **inrichting van de zorgketen en het proces m.b.t. diverse overdrachten van Twentse inwoners tussen verschillende zorgaanbieders**. Daarnaast beschrijft de transformatie de **inrichting van een capaciteitsdashboard**.
- Met deze impactvolle transformatie optimaliseren we het proces voor **zorgprofessionals die inwoners overdragen en inwoners die overgedragen worden**
- De impact van deze impactvolle transformatie ligt in het verminderen van zorg die niet op de juiste plek op het juiste moment wordt verleend. Concreet voor deze transformatie betreft dit **verkeerde beddagen in het ziekenhuis**
- Extra potentieel wordt gerealiseerd door het voorkomen van **verkeerde beddagen in de VVT**, wat niet is meegenomen in de bottom-up business case. Dit extra potentieel overlapt niet met de impact zoals wordt beschreven in het transformatieplan Acute Zorg Euregio.



Zorgcoördinatie

Toekomstig transformatieplan Acute Zorg Euregio

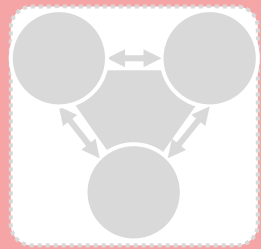
- De impactvolle transformaties m.b.t. zorgcoördinatie beschrijven activiteiten voor **eenduidige toegang, eenduidige triage en coördinatie in vervolgzorg**. Inzicht in capaciteit en patiëntgegevens is hierbij randvoorwaardelijk, maar wordt niet meegenomen in de activiteiten van het transformatieplan voor zorgcoördinatie in Twente, behoudens de overgangperiode
- Deze impactvolle transformaties richten zich op **zorgprofessionals van de huisartsenposten, meldkamer ambulance zorg (niet 112), onplanbare VVT-zorg (ELV-coördinatiepunten), onplanbare wijkzorg, acute GGZ en SEH**
- De ambitie is om met gelijkblijvende middelen en gelijke inzet van medewerkers de toenemende zorgvraag op te vangen, **om er voor te zorgen dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg ontvangt, op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste zorgverlener**. Dit resulteert in bijv. minder telefoontjes die de huisartsen hoeven te plegen voor coördinatie van zorg

1) In dit transformatieplan is extra potentieel van de use cases meegerekend in de maatschappelijke business case, zie p. van het Transformatieplan. We benoemen in deze paragraaf waarop dit extra potentieel is gebaseerd. Zo duiden we dat dit extra potentieel niet overlapt met de impact die wordt beoogd door Acute Zorg Euregio.

Verdieping 2.1 Governance uitgangspunten voor de datahub

Uitgangspunten voor de datahub governance: de gezamenlijke sturing

De datahub governance omvat de besturing en de kaderstelling voor de datahub op strategisch niveau. Het vaststellen van standaarden, beleid en andere is hier onderdeel van



Datahub governance

U1.1 Transparantie en vertrouwen is de basis

We zijn transparant in onze belangen en in de uitdagingen die we ervaren. Deze transparantie legt de basis voor vertrouwen, begrip en elkaar te kunnen helpen bij uitdagingen. De implicatie van dit uitgangspunt ligt in de afspraken voor hoe we samenwerken en een nadruk op verslaglegging en communicatie, opdat besluiten uitlegbaar en transparant blijven – ook voor partners die later aansluiten.

U1.2 De governance voor de datahub is een onderdeel van de governance van het bredere zorgecosysteem in de regio

Er is gelaagdheid in de governance van de datahub. Er wordt een orgaan of gremium (of meerdere) ingericht dat de kaders en de strategische richting voor de datahub kan vaststellen. Dat moet een onderdeel zijn van de bredere regionale samenwerking, zowel met de huidige samenwerking alsmede de opschaling naar nieuwe partners in de regio. Voor het verbinden van het zorgecosysteem in de regio zal een governance ingericht moeten worden die schaalbaar is in diversiteit (type organisaties) en kwantiteit (groot aantal deelnemers). De implicatie is dat de taken en verantwoordelijkheden van deze governance goed moeten aansluiten op die van de datahub organisatie, om de sturing vanuit deze bredere samenwerking en de verbinding met alle partners te borgen.

U1.3 De datahub is de standaard voor databeschikbaarheid voor netwerkzorg

Met de datahub bewegen we ons weg van vrijblijvendheid in het kunnen kiezen van meerdere opties voor dezelfde type oplossingen. We moeten het samen doen in de regio en daarin moeten we gezamenlijk keuzes maken. De waarde ligt niet altijd in de oplossing zelf, maar in de brede adoptie en gebruik van dezelfde oplossing. De datahub voorziet in use-cases (diensten en uitwisselingen) en databeschikbaarheid voor netwerkzorg. Daarbij

accepteren we dat, voor de use-cases zoals vastgesteld in de datahub, de datahub de standaard is. De implicatie ligt in de (werk)afspraken die we met elkaar (in de gehele regio) moeten maken. Op het gebied van data en technologie kunnen organisaties andere keuzes maken, zolang ze maar convergeren naar regio niveau.

U1.4 De governance is afgestemd op de technologie en de organisatie

Er moet een goede balans zijn in het mandaat van besturing in de governance en de mate waarin dit praktisch gerealiseerd kan worden door de organisatie in de technologie. Voor de gezamenlijke onderdelen van een use-case moet de governance ook in een breed gezamenlijke sturing voorzien. Voor onderdelen van een use-case die meer specifiek zijn voor één type gebruiker (bijvoorbeeld een dashboard specifiek voor huisartsen) moet de governance kunnen voorzien in een sturing vanuit deze meer specifieke gebruikers om te komen tot een passende inrichting.

U1.5 Duidelijke spelregels

We stellen duidelijke spelregels op voor wat we van elkaar mogen verwachten, hoe we met elkaar samenwerken en waar welke bevoegdheden liggen. Dit is onderdeel van de bredere governance, zie U1.2.

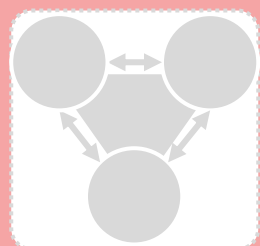
U1.6 Datahub eigenaarschap ligt bij de deelnemers: van de regio, voor de regio

De datahub is er voor de zorginstellingen in de regio, en van de zorginstellingen in de regio. Dit moet gereflecteerd zijn in het eigenaarschap van de datahub en de betrokkenheid van deelnemers. De essentie van dit uitgangspunt is dat de deelnemers aan de datahub niet enkel afnemen, maar ook een stem hebben in de keuzes die door datahub worden gemaakt.



Uitgangspunten voor de datahub organisatie: bureau ZNO

De datahub organisatie voert het dagelijkse management en beheer op het dataplatform uit. Dit wordt georkestreerd door één centrale organisatie met regie over de datahub: Bureau ZNO



Datahub organisatie

U2.1 Voorkomen van dubbel werk in de regio en landelijk

In lijn met U1.3 (de datahub is de standaard), moet de datahub niet leiden tot dubbelingen in type oplossingen maar juist tot gezamenlijke keuzes. Dat we niet concurreren met vergelijkbare oplossingen in de regio, maar schaal behalen met een afgesproken standaard. De implicatie hiervan is dat de organisatie voor de datahub voldoende afstemming moet borgen met initiatieven in de regio en op landelijk niveau om hier actief op te acteren.

U2.2 Landelijk boven regionaal, regionaal boven lokaal

Voor de kaders, standaarden, richtlijnen, voorzieningen of andere type keuzes die worden gehanteerd geldt: we volgen ten eerste landelijke ontwikkelingen en keuzes. Waar deze er niet zijn, volgen we regionale keuzes. Waar keuzes niet zijn gemaakt op landelijk of regionaal niveau, is ruimte voor meer lokale invulling van keuzes.

U2.3 De datahub organisatie is afgestemd op de technologie

In lijn met U1.4 (de governance is afgestemd op de organisatie en technologie) moet ook de organisatie een spiegel zijn van de technologie. Waar componenten van de technologie gedeeld zijn, moet centrale regie worden georganiseerd op de (door)ontwikkeling en beheer (wat mogelijk is middels centrale organisatie of een centraal afgegeven mandaat). Waar componenten meer specifiek zijn voor een bepaalde use- case of bepaalde gebruiker, kan daarop ook decentraal worden (door)ontwikkeld (binnen gestelde kaders).

U2.4 Maximaal gebruik van bestaande structuren en competenties: Bureau ZNO voert de centrale regie

Een goede samenwerking in de regio behoeft vereenvoudiging van

hoe we samenwerken in de regio. Het onnodig creëren van nieuwe complexiteit door bijvoorbeeld nieuwe entiteiten of structuren in te richten, werkt dit tegen. De grootste implicatie van dit uitgangspunt voor de inrichting van de datahub, betreft de keuze om de centrale regie te beleggen bij Bureau ZNO.

U2.5 De datahub organisatie staat voor regie & fundament, en voor innovatie & vernieuwing

De organisatie voor de datahub moet ook de (door)ontwikkeling van use-cases kunnen faciliteren. Daarmee wordt de datahub een fundament voor innovatie in de regio. De implicatie hiervan is dat de organisatie ook moet kunnen voorzien in afstemming, portfoliomanagement van use-cases, communicatie en duidelijke richtlijnen (als bijvoorbeeld architectuur) om deelnemers de juiste kaders mee te geven, opdat innovaties goed kunnen landen in de datahub.

U2.7 Het gaat om configuratie en om regie, geen eigen ontwikkeling

Bureau ZNO zal regie voeren op de datahub, maar er wordt geen centrale ontwikkelorganisatie neergezet. Technologie wordt gerealiseerd middels inkoop en aangepast op basis van configuratie. Dit uitgangspunt heeft een implicatie voor de competenties en rollen die binnen Bureau ZNO ingevuld zullen moeten worden om deze regie te kunnen voeren.

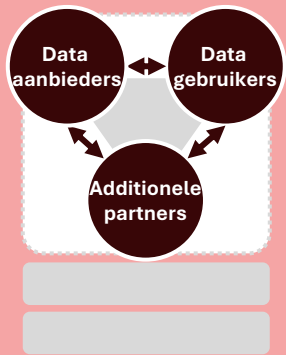
U2.8 Techniek op regionaal niveau wordt regionaal en gezamenlijk ingekocht

De keuzes voor technologie op regionaal niveau worden met en voor de regio gemaakt. Voor dezelfde functionaliteiten zullen geen twee verschillende technologieën worden ingekocht.



Uitgangspunten voor de datahub gebruikers

De verschillende gebruikers die deelnemen aan de datahub: de aanbieders van data, de gebruikers van data (en toepassingen bovenop het dataplatform) en gebruikers die een toepassing aanbieden via de regionale datahub



U3.1 Het zorgproces op regioniveau is leidend voor de inrichting

Het doel van de datahub is het anders organiseren en coördineren van de gezondheidzorg in Twente gericht op gezondheid in plaats van zorg. Daarom staan de integrale zorgprocessen centraal in de keuzes die worden gemaakt voor de inrichting van de diensten en waardestromen waar de datahub in faciliteert. Dit vraagt aanpassing van bestaande zorgprocessen. De datahub helpt ons ook nieuwe/aangepaste zorgprocessen te realiseren. De belangrijkste implicatie van dit uitgangspunt ligt in de betrokkenheid van gebruikers en volgorde van hoe use-cases worden (door)ontwikkeld, waarin het zorgproces leidend is.

U3.2 Deelname betekent het accepteren van regionale regie en deels opgeven van autonomie

Deelnemers aan de datahub committeren zich aan de samenwerking en geven hier ook een deel van hun autonomie mee op. We maken immers gezamenlijke keuzes waar je als individuele organisatie aan conformeert.

U3.3 Wederkerigheid: deelnemers dragen waar ze kunnen bij aan de datahub en helpen elkaar

Het succes van de datahub is een gezamenlijke uitdaging voor de hele regio. Zo dragen we als deelnemers ook bij waar we dat kunnen doen en helpen elkaar waar dat nodig is. In essentie gaat het erom dat deelnemers niet enkel halen, maar ook brengen. In welke capaciteit dat voor hen redelijk is.

U3.4 Iedereen heeft zijn eigen startpunt, route en snelheid. Maar iedereen voldoet ook aan minimale eisen

Er is begrip dat we allen een eigen route hebben te bewandelen.

Het startpunt is per organisatie verschillend, alsmede de snelheid van verandering die van een organisatie redelijkerwijs verwacht kan worden. De snelheid mag dan verschillen, maar stilstaan niet. We stellen minimale vereisten op waar we met elkaar op kunnen sturen en elkaar op kunnen aanspreken. Dit raakt de benodigde aanpassingen die men moet maken binnen de eigen organisatie, de bijdrage aan de samenwerking en het verandermanagement om de gezamenlijk de beoogde transformatie in de regio te realiseren.

U3.5 Het eigenaarschap van data van aanbieders ligt bij de aanbieders van de data

De data blijft in essentie bij de aanbieders van de data in de bronsystemen. Daarmee ook het eigenaarschap en de regie wat met deze gegevens kan worden gedaan, en de verantwoordelijkheid voor datakwaliteit en beschikbaarheid. Waar het om organisatie-overstijgende data gaat, zijn uitzondering hierop mogelijk. Dit is toegelicht in U3.6.

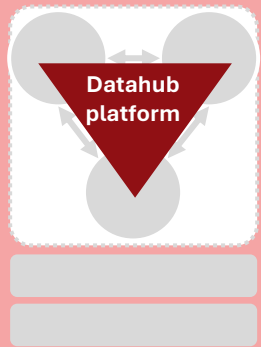
U3.6 Het eigenaarschap van meta data en regionale data ligt bij de regievoerder van de datahub

Naast de data die door aanbieders wordt aangeboden en bij hen in eigenaarschap blijft, zal er sprake zijn van organisatie-overstijgende data voor de datahub: meta data over de datahub, data over de performance en veiligheid van de datahub en eventuele regionale data die benodigd kan zijn voor bepaalde use cases.



Uitgangspunten voor de datahub platform

De inrichting van de technologie, het middel, waarmee de waardestromen tussen de gebruikers worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Additioneel is dit het technologische fundament voor nieuwe innovaties en de (door)ontwikkeling van use-cases die nieuwe regionale zorgleveringsmodellen en samenwerking ondersteunen



Uitgangspunten voor datahub platform zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3

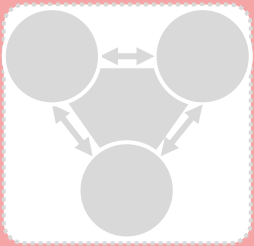


Verdieping 2.2 Governance en organisatie van de datahub

Governance en organisatie van de datahub

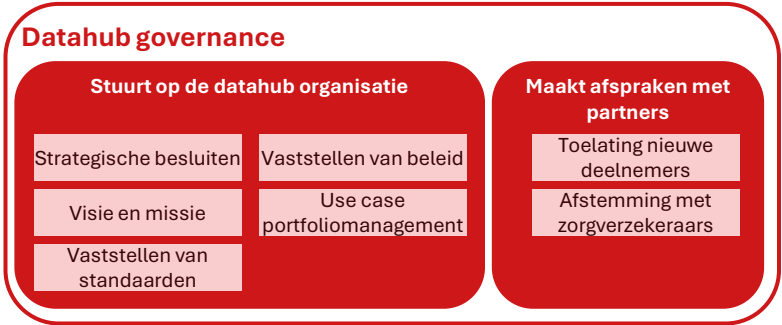
De datahub governance betreft de gezamenlijke sturing op strategisch niveau

Gedurende de transformatiefase is dit in de projectgovernance georganiseerd. Echter moet dit na het project ook landen in een structurele samenwerking: de datahub governance. Deze structurele datahub governance is een resultaat van het project.



Datahub governance

Figuur: Taken en verantwoordelijkheden van de datahub governance



De datahub governance ligt bij de regio. De exacte vorm wordt uitgewerkt in het project en om goed aan te sluiten op TwenteBeter

Gedurende het project werken we toe naar een duidelijke governance voor de datahub. Deze governance zal worden ingevuld door de samenwerkende zorginstellingen in de regio. Hoe de besturing wordt ingericht is een resultaat van de opvolgende fase van het project. Dit is verder toegelicht in de project governance. We sluiten aan op de bestaande structuren tot zover dat past. Voor de governance betreft dit in de basis: TwenteBeter. Ondanks dat de governance verder uitgewerkt moet worden in het project, kunnen we vanuit de benodigde sturing op de datahub al een aantal taken en verantwoordelijkheden vaststellen waar de governance in moet voorzien.

De eindverantwoordelijkheid voor strategie en visie ligt bij de regionale samenwerking, intellectueel eigendom in de gezamenlijke organisatie

De governance voor de datahub zal voorzien in de strategische

besluitvorming, het vaststellen van beleid- en visiedocumenten en het bewaken van het goed functioneren van de datahub. De ondersteuning (PMO) om deze verantwoordelijkheden uit te voeren wordt geboden door bureau Zorgnetoost. Besluiten, documenten om vast te stellen, financiële resultaten en portfoliorapportages worden door bureau Zorgnetoost opgesteld en voorbereid. De besluitvorming en accordering zal plaatsvinden in de gezamenlijke governance. Om het gezamenlijke eigenaarschap van intellectueel eigendom van de datahub vorm te geven, zal dit bij bureau Zorgnetoost worden belegd.

Gezamenlijke prioritering en sturing op het portfolio van use-cases (in relatie tot bijvoorbeeld netwerkzorg)

De datahub governance zal voorzien in de sturing op het portfolio van use cases, als een middel om vanuit de regio gezamenlijk te kunnen sturen op de realisatie van de strategie en de focus van de datahub. De governance stelt de – door bureau Zorgnetoost – voorgestelde roadmap vast en kan hierop aanpassingen maken door use-cases te prioriteren en/of use-cases te initiëren of stop te zetten. In de rapportagelijijn vanuit bureau Zorgnetoost naar de datahub governance ligt daarbij ook een route voor escalatie van incidenten of andere aandachtspunten naar de bredere samenwerking op strategisch niveau.

Afspraken met nieuwe partners en de zorgverzekeraars

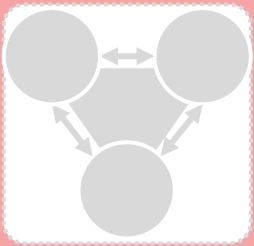
De datahub governance, waarin de regionale partners op strategisch niveau samenkomen, is ook het hoofdelijke aanspreekpunt en heeft de verantwoordelijkheid voor afspraken met (nieuwe) deelnemers en de zorgverzekeraars. Hetzelfde geldt ook voor afspraken die worden gemaakt met andere partijen, zoals bijvoorbeeld een strategische samenwerking met een vergelijkbaar initiatief in het land. Dergelijke gesprekken dienen op strategisch niveau en met breed draagvlak gevoerd te worden.



Governance en organisatie van de datahub

Voor de doorlopende sturing op de datahub zijn gremia nodig waarin experts en vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties samenkomen

Gedurende het project groeien we toe naar de uiteindelijke governance om in de regio samen te sturen op regionale zorglevering. Om op de datahub (organisatie en platform) te kunnen sturen, is er al een eerste beeld op expertises die binnen deze governance samen moeten komen.



Datahub governance

- Rollen in de governance**:**
- Afvaardiging van deelnemers op bestuurlijk niveau
 - Architecten (op proces en informatie)
 - CISO's en/of ISO's
 - CIO's
 - CMIO's
 - CNIO's
 - Juridisch adviseurs
 - Business & financial control
 - Afvaardiging van gebruikers op strategisch niveau
 - (zorg)managers

Taken en verantwoordelijkheden	Benodigde rollen/expertise*	Toelichting
Strategische besluitvorming	Afvaardiging bestuurlijk niveau	De governance moet kunnen sturen namens het zorgecosysteem van de regio.
Vaststellen van beleidsdocumenten	Architecten (op proces en informatie en technologie), (C)ISO's, CIO's, CMIO's, CNIO's, juridisch adviseurs	De benodigde expertise verschilt per onderwerp waarop beleid wordt vastgesteld. Denk aan architecten voor gezamenlijke standaarden en uitgangspunten, (C)ISO's voor beleid op informatiebeveiliging en CMIO's, CNIO's, en CIO's om de lijn met verschillende ontwikkelingen op het gebied van Zorg-ICT goed te borgen.
Vaststellen van missie en visie	Afvaardiging bestuurlijk niveau	De governance moet kunnen sturen namens het zorgecosysteem van de regio.
Bewaken van het functioneren van de datahub (baten en lasten)	Business & financial control	De governance moet de baten en lasten, zowel de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten, goed kunnen duiden om daarop bij te kunnen sturen en strategische besluiten te voeren.
Prioritering en sturing op het portfolio van use-cases	Vertegenwoordiging van gebruikers op strategisch niveau, (zorg)managers	De gebruikers moeten kunnen sturen op de prioritering van nieuwe use-cases
Afstemming en afspraken maken met de zorgverzekeraars	Afvaardiging bestuurlijk niveau	De governance moet voorzien in een gremium/orgaan/vertegenwoordiging dat op strategisch niveau de afspraken kan maken met zorgverzekeraars en nieuwe deelnemers. Dat nieuwe deelnemers ook op bestuurlijk niveau zich committeren aan de nodige afspraken.
Includeren van nieuwe deelnemers in de governancestructuur (opschaling)		

*Dit betreffen rollen en expertises die in de governance georganiseerd moeten worden. Hoe dit wordt georganiseerd (bijvoorbeeld decentraal bij deelnemende organisaties, gezamenlijke gremia, een aparte entiteit of anders) zal gedurende het project verder worden uitgewerkt.

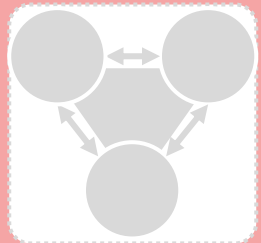
**Deze rollen in de governance zijn ter besturing van het datahub platform. Voor andere doeleinden van de regionale samenwerking kunnen additionele rollen nodig zijn.



Governance en organisatie van de datahub

De datahub organisatie moet een centrale hub worden voor coördinatie en regie op het platform

De missie van Zorgnetoost is het Coördineren en faciliteren van de realisatie van de regionale missie digitalisering: “juiste informatie tijdig op de juiste plek”. Deze missie en de positionering van Zorgnetoost in de regio passen goed op de benodigde rol voor regie op de datahub.



Datahub organisatie

Regie en coördinatie op het realiseren van het manifest

Zorgnetoost draagt bij aan de realisatie van het manifest voor regionale samenwerking in de regio. Dit doet Zorgnetoost middels coördinatie om de sturing door regiopartners te faciliteren (momenteel: de regieraad van Zorgnetoost) en instellings-overstijgende activiteiten te coördineren.

Met de realisatie van de datahub blijven deze competenties in stand en worden verder ontwikkeld en aangevuld.

Realisatie van de regionale “luchtverkeersleiding”

Met deze ontwikkeling wordt Zorgnetoost steeds sterker gepositioneerd in de regio als “luchtverkeersleiding” voor de digitalisering van transmurale ketens, netwerkzorg, hybride zorg, zelfzorg en realisatie van gezamenlijke uitdagingen omtrent digitalisering.

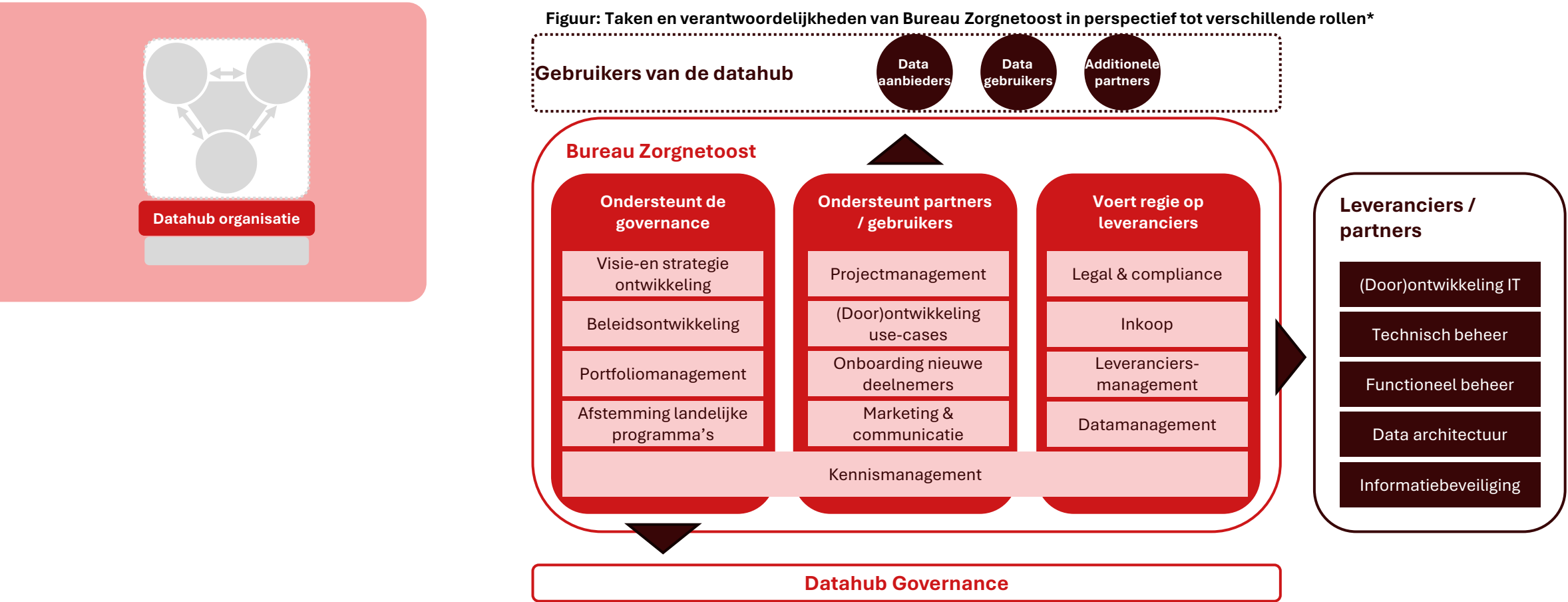
De “luchtverkeersleiding” is het knooppunt tussen de regionale uitdagingen in de zorg en de gewenste digitale oplossingen in de regio.



Governance en organisatie van de datahub

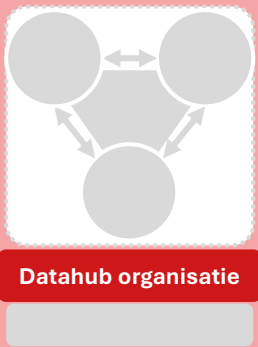
De doorlopende regie op de datahub ligt in de centrale organisatie: Bureau Zorgnetoost

Bureau Zorgnetoost zal voorzien in het dagelijkse management en beheer op de datahub. Dit is op onderdelen uitvoerend, maar in grote mate middels regie op leveranciers en deelnemende organisaties.

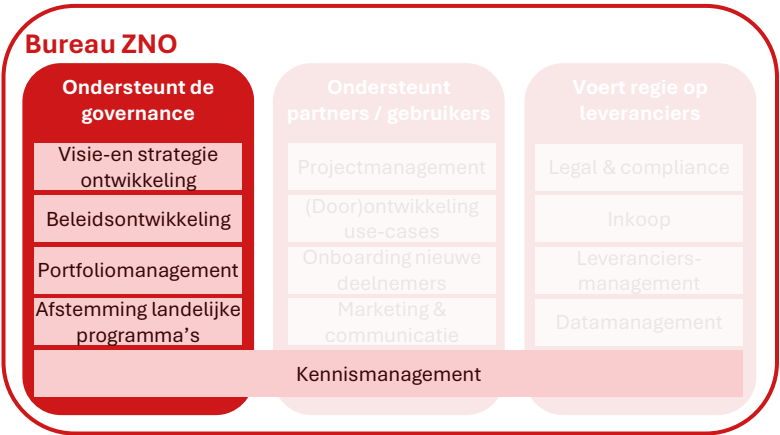


Bureau ZNO organiseert de ondersteuning van de governance

Bureau ZNO zal de samenwerkende partijen in de governance ondersteunen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van besluiten en documenten om te bespreken.



Figuur: Taken en verantwoordelijkheden ter ondersteuning van de governance



Ondersteuning van de governance in de totstandkoming van de visie, strategie en beleid

De samenwerkende partijen in de governance zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de visie, strategie en beleid. Daarin is Bureau ZNO uitvoerend in de totstandkoming van deze documenten en adviserend aan de governance met betrekking tot besluitvorming. In de praktijk organiseert en ondersteunt Bureau ZNO de totstandkoming van dergelijke documenten, waarin zij gebruik kan maken van de expertise van deelnemende organisaties, en levert ze op aan betreffende gremia in de governance. Benodigde expertises voor het opstellen van beleid worden dus ook geleverd door deelnemende organisaties, denk bijvoorbeeld aan de architecten die samenkomen – met ondersteuning van Bureau ZNO – om de visie op architectuur op te

stellen.

Management van het portfolio aan use-cases en projecten

Bureau ZNO zal ook voorzien in het portfoliomanagement, waarin de voortgang op (door)ontwikkeling van use-cases en andere projecten (bijvoorbeeld doorontwikkeling van het platform of een project om gebruikersondersteuning te verbeteren) in een periodieke rapportage worden aangeboden aan de governance. Bureau ZNO bereidt ook de overleggen voor waarin projecten en initiatieven voor (door)ontwikkeling van use-cases door de governance geprioriteerd en getoetst kunnen worden.

Tactisch en operationele afstemming met landelijke programma's

De datahub moet blijven meebewegen met de ontwikkelingen van landelijke programma's, waaronder CumuluZ en de generieke voorzieningen die op landelijk niveau worden gerealiseerd. Afstemming is nodig om constant bij te sturen op o.a. een goede aansluiting tot architectuur richtlijnen, nieuwe standaarden of integraties die gerealiseerd moeten worden met landelijke voorzieningen of infrastructuur. De standaarden en de landelijke ontwikkelingen waarop aan te sluiten worden vastgesteld door de governance. Bureau ZNO is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat zij zelf kan doen of middels regie bij leveranciers kan beleggen.

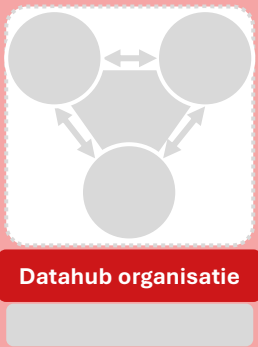
Integraal kennismanagement voor de datahub

Het kennismanagement omtrent de datahub wordt bewaakt door Bureau ZNO en beschikbaar gesteld (voor zover relevant) aan de partijen in de governance, partners en gebruikers, en leveranciers. Bureau ZNO is verantwoordelijk voor het up to date houden van de documentatie voor de datahub naar al deze partijen.

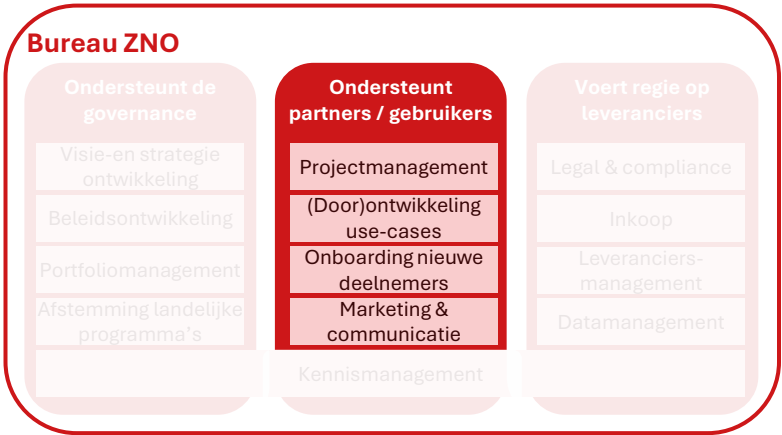


Bureau ZNO ondersteunt gebruikers met projecten en aansluiting tot de datahub, en de ontwikkeling van use-cases

Bureau ZNO zal gebruikers en partners ondersteunen in de aansluiting tot de datahub en de (door)ontwikkeling van use-cases en initiatieven waarin de datahub een rol speelt.



Figuur: Taken en verantwoordelijkheden ter ondersteuning van partners en gebruikers



Doorontwikkeling van use-cases en het succes van de datahub

Bureau ZNO is voornamelijk een regie-organisatie, waarbij ontwikkeling van zowel use-cases als IT met name belegd is bij partners (zowel leveranciers als de deelnemende organisaties in de regio). Er wordt geen centrale projectmanagementorganisatie ingericht. Echter vindt in enige mate regie plaats op de projecten en de ontwikkeling van use-cases voor de datahub vanuit de centrale organisatie (Bureau ZNO). Een dergelijke centrale regie is om te bewaken dat de projecten en keuzes in doorontwikkeling blijven bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen, beleid en dat er zicht is op onderlinge afhankelijkheden.

De tactische en operationele onboarding van nieuwe deelnemers

Voor de opschaling van de datahub zal Bureau ZNO voorzien in de onboarding op tactisch en operationeel niveau van nieuwe deelnemers. Dit betreft het opstellen en aanbieden van o.a. documenten hoe integraties te voorzien, inzicht in relevante processen in het gebruik van de datahub en beleid waaraan de nieuwe deelnemer zich zal moeten conformeren. De uitvoering van de integraties en eventuele aanpassingen in proces of technologie bij de nieuwe deelnemer, is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.

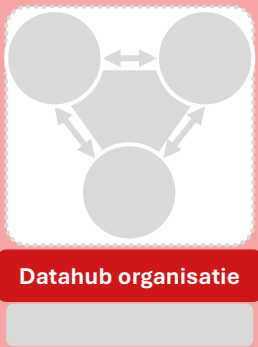
Communicatie over de datahub

Bureau ZNO voorziet in communicatie naar gebruikers en partners over veranderingen en ontwikkelingen over de datahub. Dit zijn bijvoorbeeld gerealiseerde successen of nieuwe functionaliteiten. Daarin is ook een verantwoordelijkheid voor marketing naar de regio toe, om de opschaling van de datahub te stimuleren. Hierin ligt echter een duidelijke afscheiding van de scope voor Bureau ZNO: dit betreft enkel de communicatie en marketing over de datahub. Andere initiatieven vanuit de samenwerkende partijen in de regio, waaronder vanuit TwenteBeter, worden gecommuniceerd vanuit de betreffende samenwerking. De communicatie en marketing-functie vanuit Bureau ZNO stemt met de betreffende communicatie-collega's af vanuit de samenwerkende organisaties om op een juiste manier om te gaan met berichten waar deze scheidslijn minder concreet is. Dit om zorg te dragen dat zowel de datahub als andere samenwerkingsverbanden hetzelfde verhaal uitdragen.

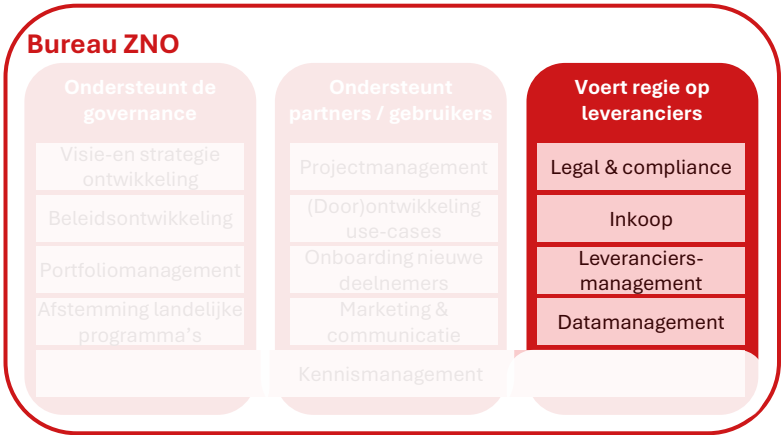


Bureau ZNO is een regie-organisatie voor het beheer van de technologie, wat in uitvoering bij leveranciers zal liggen

Bureau ZNO voert regie op de leveranciers van technologie en beheer om het goed functioneren van het platform te bewaken, alsmede de kaders waar het aan moet voldoen (o.a. datastandaarden en compliance).



Figuur: Taken en verantwoordelijkheden voor regie op leveranciers



Bureau ZNO organiseert de centrale inkoop namens de regio

De inkoop van Bureau ZNO zal de technologie voor de datahub inkopen namens de samenwerkende regio organisaties. Dit is naast de technologie ook inclusief beheer, projectleiders of adviseurs die in het kader van de datahub worden ingezet. Niet alle inkoop omtrent de datahub moet per definitie vanuit Bureau ZNO ingekocht worden. Zo kunnen bijvoorbeeld individuele organisaties hulp of middelen inkopen voor de implementatie van de datahub in de eigen organisatie of bijvoorbeeld (in samenwerking met andere organisaties) voor de ontwikkeling van een use-case. Dit is in lijn met de vrijheid van deelnemende organisaties om bijvoorbeeld sneller stappen te zetten dan anderen.

Leveranciersmanagement centraal bij Bureau ZNO

In lijn met de inkoop zal ook het doorlopend leveranciersmanagement binnen Bureau ZNO worden belegd. Op deze manier kan vanuit een centraal en overkoepelend perspectief op de leveranciers worden gestuurd en gemonitord. Hierin kan Bureau ZNO bijdragen aan de prioritering van leveranciers op verschillende taken (in lijn met de prioriteiten gesteld door de governance) en het oplossen van eventuele incidenten in de keten – indien het afhankelijkheden tussen verschillende leveranciers betreft – helpen coördineren. Vanuit deze functie ligt er dus ook een verantwoordelijkheid voor incidentenmanagement bij Bureau ZNO, echter enkel ter monitoring en begeleiding. Het oplossen van incidenten in de technologie ligt hoofdelijk bij de leveranciers van de betreffende technologie.

Middels legal, compliance en datamanagement stelt Bureau ZNO de kaders voor leveranciers en gebruikers

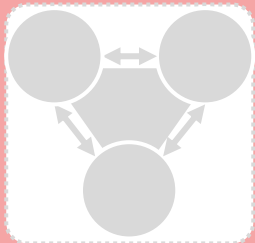
De ontwikkeling en het beheer van de technologie voor de datahub ligt bij leveranciers, evenals een groot deel van het datamanagement. Echter, om goed op de leveranciers te kunnen sturen zal in enige mate ook datamanagement bij Bureau ZNO worden ingericht. Deze functie monitort en stuurt op goed datamanagement door de leveranciers en gebruikers (waaronder data aanbieders). De leveranciers en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan datastandaarden en standaarden voor uitwisseling, de datakwaliteit, de levenscyclus van data en de catalogus voor welke data middels welke wijze beschikbaar is.

Legal & compliance stelt eveneens kaders vast voor de leveranciers, waaronder op informatiebeveiliging en het voldoen aan gestelde normen (bijvoorbeeld NEN7510) en wetgeving (bijvoorbeeld AVG). Het is aan leveranciers om hier aan te voldoen. De legal & compliance functie van Bureau ZNO, in samenwerking met het leveranciersmanagement, controleert of dit het geval is.



Dit betekent een transformatie van Zorgnetoost tot een regie-organisatie met nieuwe rollen (1/2)

Om in de beoogde competenties te voorzien, zal de huidige organisatie van Zorgnetoost doorontwikkeld moeten worden en aangevuld met nieuwe rollen en vaardigheden.



- Rollen Bureau Zorgnetoost:**
- Strategisch adviseur
 - Portfoliomanager
 - Informatiemanager
 - Informatie en proces-architect
 - Projectmanagementondersteuner (PMO)
 - Communicatiemedewerker
 - Functionaris Persoonsgegevens**
 - Compliance officer
 - Inkoper
 - Contractmanager
 - Risico- en incidentenmanager
 - Data manager

Taken en verantwoordelijkheden	Benodigde rollen*	Toelichting
Visie- en strategie ontwikkeling	Strategisch adviseur, projectmanagementondersteuner, informatie en proces-architect	Begeleiding van de totstandkoming van visie, strategie en beleid. Inhoudelijke expertise wordt geleverd door deelnemers.
Beleidsontwikkeling		
Portfoliomanagement	Portfoliomanager	Centrale regie op het totale portfolio aan initiatieven en use-cases voor de datahub in afstemming met andere regionale initiatieven.
Afstemming landelijke programma's	Strategisch adviseur, informatiemanager, portfoliomanager	Afhankelijk van de aard van programma's kunnen hier meerdere rollen de tactische afstemming uitvoeren.
Kennismanagement	Informatiemanager, communicatiemedewerker	Om alle benodigde informatie omtrent de datahub aan partners, gebruikers en leveranciers beschikbaar te stellen
Projectmanagement	Projectmanagementondersteuner, portfoliomanager	Regie en ondersteuning van projecten, maar exclusief de uitvoering (dit ligt bij partners en leveranciers).
(Door)ontwikkeling use-cases	Informatiemanager, portfoliomanager	Enige mate van coördinatie dat nieuwe use-cases bijdragen aan de visie, voldoen aan beleid en afhankelijkheden bewaakt zijn.
Onboarding nieuwe deelnemers	Informatiemanager	Het opstellen en aanbieden van informatie voor onboarding.
Marketing & communicatie	Communicatiemedewerker	Communicatie over de datahub en afstemming met regiopartners over communicatie.

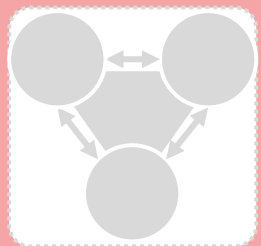
*Meerdere rollen kunnen in de praktijk samenkomen bij één functieprofiel of persoon. Hoe rollen in te vullen kan verschillen (bijv. in loondienst bij Zorgnetoost of middels inhuur vanuit organisaties in de regio).

**De wettelijke verplichting om deze rol in te vullen is afhankelijk van de data die in de datahub wordt verwerkt. Of deze verplichting van toepassing is in deze situatie moet gedurende de transformatieperiode worden vastgesteld de juridische adviseurs.



Dit betekent een transformatie van Zorgnetoost tot een regie-organisatie met nieuwe rollen (2/2)

Om in de beoogde competenties te voorzien, zal de huidige organisatie van Zorgnetoost doorontwikkeld moeten worden en aangevuld met nieuwe rollen en vaardigheden.



Datahub organisatie

Rollen Bureau Zorgnetoost:

- Strategisch adviseur
- Portfoliomanager
- Informatiemanager
- Informatie en proces-architect
- Projectmanagementondersteuner (PMO)
- Communicatiemedewerker
- Functionaris Persoonsgegevens**
- Compliance officer
- Inkoper
- Contractmanager
- Risico- en incidentenmanager
- Data manager

Taken en verantwoordelijkheden	Benodigde rollen*	Toelichting
Legal & Compliance	Functionaris persoonsgegevens** Compliance officer	Kaderstelling voor leveranciers en controle op leveranciers dat hier aan wordt voldaan.
Inkoop	Inkoper	Uitvoering of coördinatie van gezamenlijke en regionale inkoop.
Leveranciersmanagement	Contractmanager, informatiemanager, risico- en incidentenmanager	Doorlopende afstemming met leveranciers en coördinatie bij incidenten die meerdere leveranciers raken.
Datamanagement	Data manager	Datamanagement ligt bij de leverancier(s) en is binnen Zorgnetoost gelimiteerd tot regie/monitoring van datamanagement.

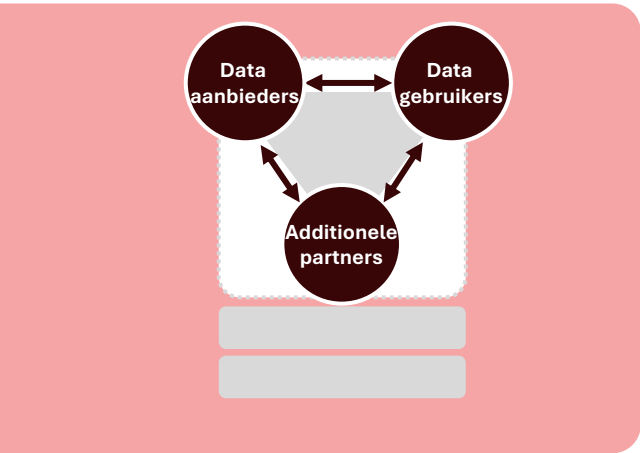
*Meerdere rollen kunnen in de praktijk samenkomen bij één functieprofiel of persoon. Hoe rollen in te vullen kan verschillen (bijv. in loondienst bij Zorgnetoost of middels inhuur vanuit organisaties in de regio).
**De wettelijke verplichting om deze rol in te vullen is afhankelijk van de data die in de datahub wordt verwerkt. Of deze verplichting van toepassing is in deze situatie moet gedurende de transformatieperiode worden vastgesteld de juridische adviseurs.



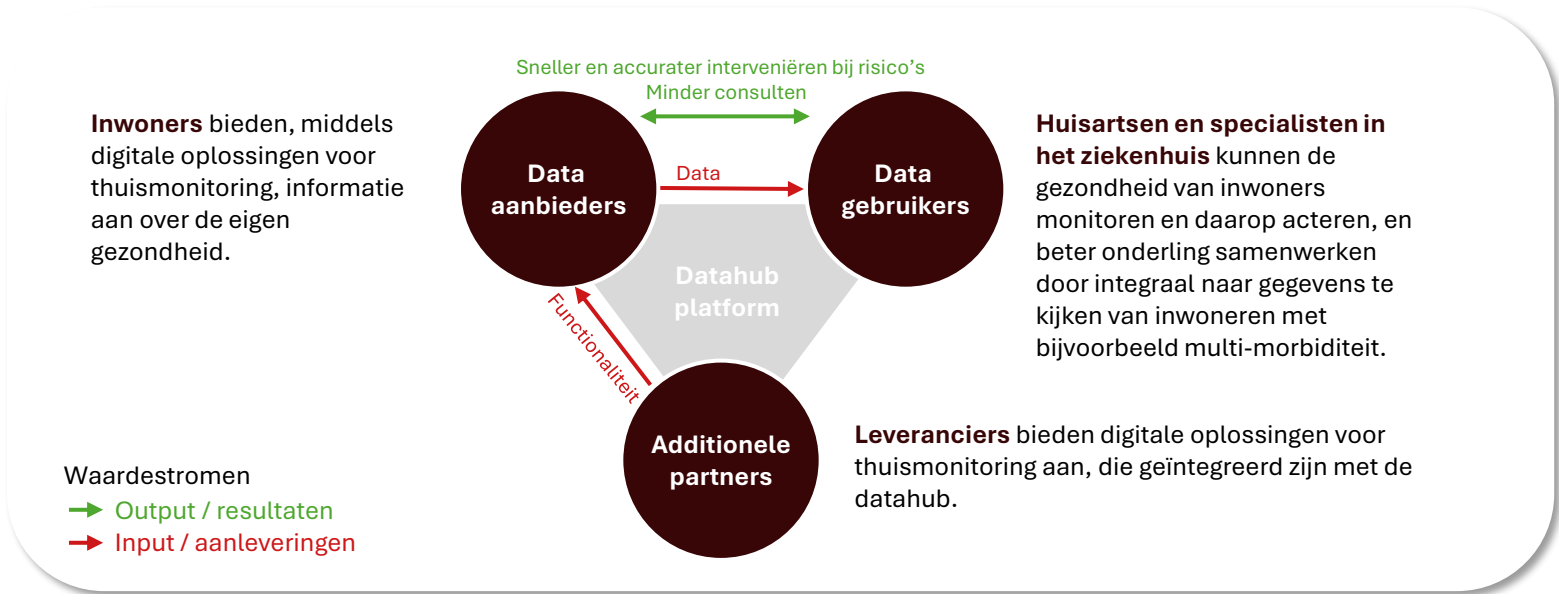
Dienstverlening en gebruik van de datahub

De dienstverlening van de datahub is het weghalen van fricties tussen partners in de regio

De datahub is een platform. Dat wil zeggen: de datahub genereert niet enkel zelf de waarde die wordt afgenomen door gebruikers, maar faciliteert juist de waardecreatie tussen haar gebruikers onderling.



Figuur: voorbeeld van waardestromen voor use case ‘Gekoppelde thuismonitoring’ (excl. doorontwikkeling van de use case)



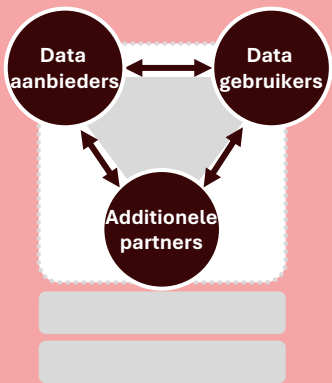
Het platform voorziet in de uitwisseling, de analyse en visualisatie van de data en de processen daaromheen waarin beleid is geïntegreerd. De gebruiker kan erop vertrouwen dat werken middels de datahub veilig, betrouwbaar en in lijn is met o.a. de afspraken voor samenwerking. Hiermee mitigeert het platform de fricties, bijvoorbeeld dat gegevens niet volledig of niet inzichtelijk bij elkaar komen voor monitoring, dat een effectieve samenwerking in weg zou staan. Door het platform kan de waarde beter stromen tussen partijen, maar de waarde zelf komt vooral vanuit gebruikers en niet het platform.



4.2 Datahub beheergovernance – Dienstverlening en gebruik van de datahub

Ook de gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de datahub

Dit betekent het invullen van benodigde taken en verantwoordelijkheden. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn tot grote mate een direct gevolg van de uitgangspunten (U3.1 t/m U3.6). Notitie: één partij kan meerdere of zelfs alle rollen vervullen.



Taken en verantwoordelijkheden voor gebruikers van de datahub

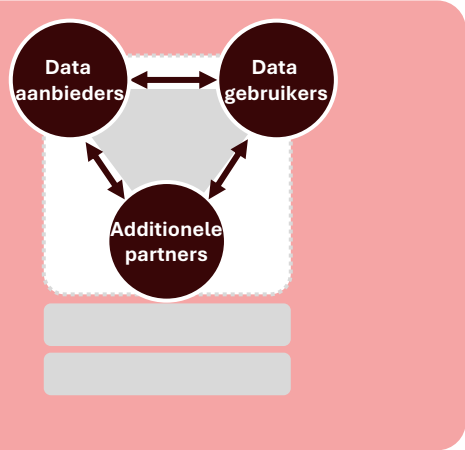
Data aanbieders	Data gebruikers	Additionele partners
Integratie en aansluiting tot de datahub Nieuwe deelnemers aan de datahub zijn zelf verantwoordelijk voor een goede aansluiting tot de datahub. Dat betekent deels een samenwerking met Bureau Zorgnetoost om zorg te dragen dat de technische integratie wordt gerealiseerd, en deels de aanpassingen die gedaan moeten worden om aan het beleid van de datahub te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van Zorgnetoost om zorgaanbieders te ondersteunen met een propositie om (eenvoudig) aan te kunnen sluiten op de datahub.	Verandermanagement – naar regionale zorgleveringsmodellen In lijn met U3.4 zullen deelnemende organisaties zelf de nodige veranderingen moeten maken binnen de eigen organisatie. Dit betreft de benodigde veranderingen in technologie, informatie, proces, mens en strategie om mee te gaan in de nieuwe manieren van samenwerken, alsmede het stimuleren van adoptie. (Door)ontwikkeling van de datahub In lijn met U3.3 over wederkerigheid, verwachten we van gebruikers van de datahub ook dat zij bijdragen, waar dat voor hen mogelijk is, in de (door)ontwikkeling van de datahub. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van capaciteit/expertise om een use case verder te brengen, deelname aan project voor nieuwe use-cases voor de datahub (denk aan het helpen realiseren van processen of afspraken voor in het beleid) en/of het zijn van een data aanbieder.	Decentraal inkoop en leveranciersmanagement Naast de centrale inkoop en leveranciersmanagement dat door Bureau Zorgnetoost wordt ingevuld, is er ook sprake van leveranciers die afspraken hebben met deelnemers van de datahub, maar welke niet centraal worden ingekocht. Denk bijvoorbeeld aan het ECD of EPD dat niet centraal wordt ingekocht door de regio, maar wel complementair is aan de datahub. De inkoop en leveranciersmanagement van dit product zal blijven bij hen die deze producten afnemen, en niet centraal worden belegd. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn bij een nieuwe AI oplossing die gebruik maakt van de informatie in de datahub. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om eventueel sneller nieuwe innovaties te realiseren, in lijn met U3.4.



Dienstverlening en gebruik van de datahub

Om in deze verantwoordelijkheden te voorzien moeten ook deelnemende organisaties in bepaalde rollen voorzien

In lijn met U3.9 versterken we elkaar en werken we samen aan het succes van de datahub. Waar een individuele gebruiker niet in een benodigde rol kan voorzien, zullen deelnemende organisaties elkaar helpen om deze rollen in te vullen.



Rollen deelnemers aan de datahub*:

- Informatiemanager
- Architect
- Integratiespecialist
- Projectleider
- Data owner
- Data steward
- Projectleider
- Business owner / proceseigenaar
- Inkoper
- Contractmanager
- Risico- en incidentenmanager

*Welke rollen van toepassing zijn, zijn afhankelijk van welke type(s) van gebruik een specifieke deelnemer vervult (zie tabel hiernaast welke rollen bij welk type gebruiker van toepassing zijn).

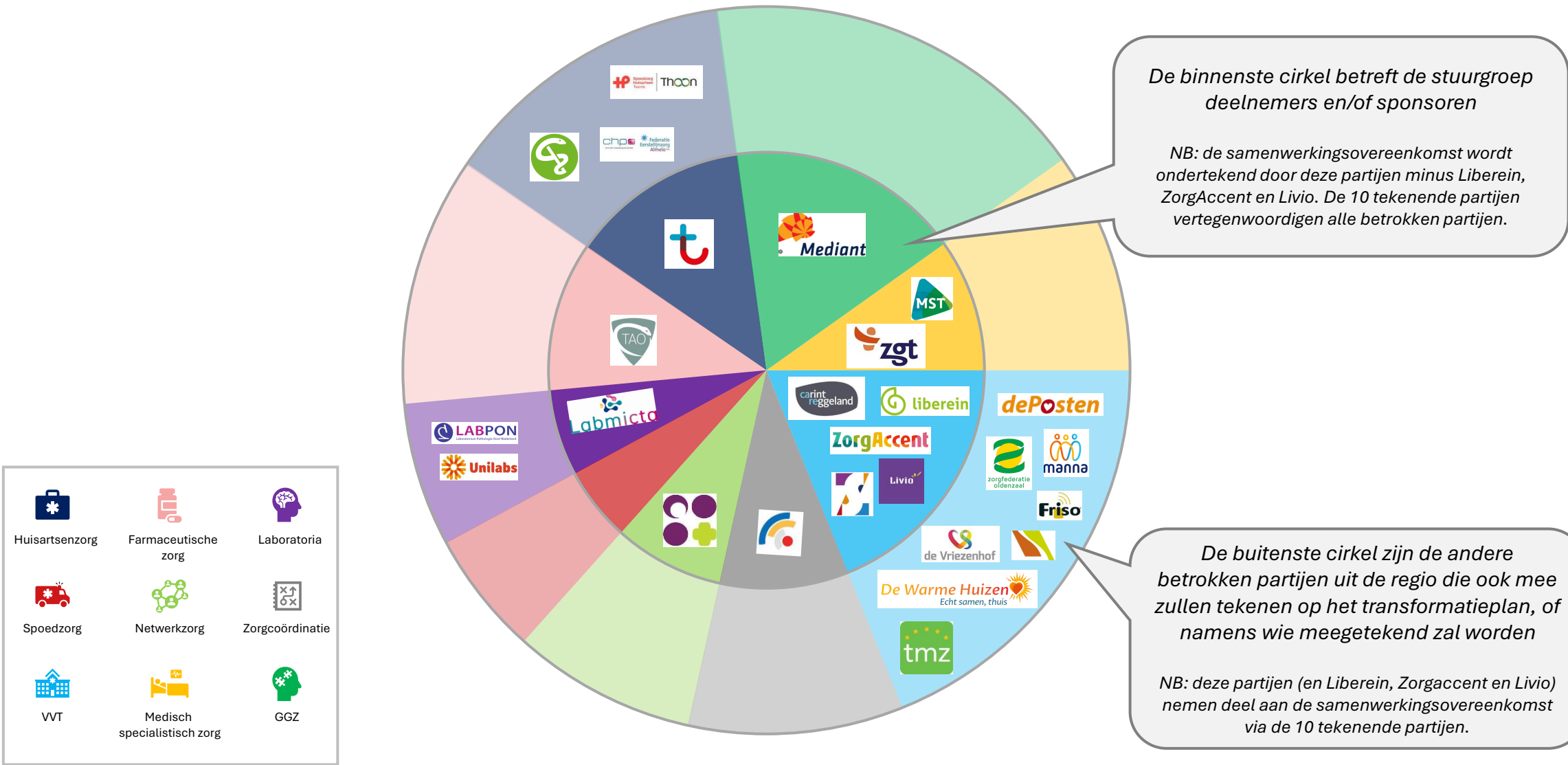
Type gebruiker	Taken en verantwoordelijkheden	Benodigde rollen	Toelichting
Data aanbieders	Integratie en aansluiting tot de datahub	Informatiemanager, architect, technisch integratiespecialist en projectleider	Het realiseren van de benodigde integraties en processen, met ondersteuning georganiseerd vanuit Bureau Zorgnetoost.
	Datamanagement	Data owner, data steward	Bewaking van datakwaliteit en beschikbaarheid van aan te leveren data.
Data gebruikers	Verandermanagement	Projectleider	De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het effectieve gebruik van de datahub en mee te bewegen naar meer regionale levering van zorg.
	(Door)ontwikkeling van de datahub	Projectleider, informatiemanager, business owner / proceseigenaar	Ontwikkeling van use-cases vindt plaats in decentrale projecten en samen met meerdere gebruikers. Ook in andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld projecten om tot beleidsdocumenten te komen, dragen de gebruikers van de datahub bij.
Additionele partners	Inkoop	Inkoper	Waar diensten of producten complementair zijn aan de datahub, maar niet centraal worden ingekocht, ligt de verantwoordelijkheid voor inkoop en leveranciersmanagement bij de gebruiker(s) die deze diensten of producten afnemen.
	Leveranciersmanagement	Contractmanager, informatiemanager, risico- en incidentenmanager	



Verdieping 3 Project Governance

3. Overzicht van stakeholders en hun betrokkenheid in de project-governance

Overzicht welke stakeholders per sector betrokken zijn bij het transformatieplan en de samenwerkingsovereenkomst

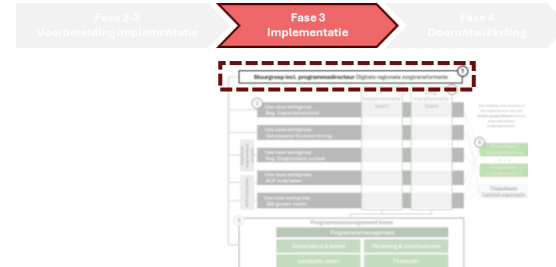


3. Juridische samenwerkingsvorm

Overige afspraken

Fase 3: Overige afspraken <i>bij geadviseerde juridische vorm</i>	Fase 4: Overige afspraken <i>bij geadviseerde juridische vorm</i>
Financiering: Afrekening van bijvoorbeeld personeelskosten en licentiekosten vindt plaats van de financiële afspraken in de samenwerkingsovereenkomst (zie hoofdstuk 5.1 en 5.4). Toetreden leden: In fase 3 kunnen partijen toetreden middels de samenwerkingsovereenkomst. Echter kunnen deze leden geen directe aanspraak maken op de transformatiegelden en moet nader worden besloten in hoeverre deze leden deel mogen nemen aan de besluitvorming rondom de datahub. Betrokkenheid interne gremia: Uiteraard worden de gremia (zoals de Ondernemingsraad, Raad van Toezicht, Cliëntenraad) per deelnemende organisatie betrokken bij het programma rondom de digitale regionale zorgtransformatie. De werkwijze om deze gremia te betrekken wordt nader onderzocht en aan het begin van fase 3 vastgesteld.	Verantwoording: De programmaorganisatie van de digitale regionale infrastructuur krijgt een eigen plek in de organisatie van Zorgnetoost. De directie van Zorgnetoost legt over het totaal verantwoording af aan de coöperatieleden (ALV). Deze coöperatieleden zijn de afnemers van de diensten van Zorgnetoost, waartoe ook behoren de partijen van de digitale regionale zorgtransformatie zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Leveranciers: Bij afspraken die worden gemaakt met leveranciers moet vanaf fase 2 worden voorgesorteerd op de toekomstige regierol van Zorgnetoost met betrekking tot de datahub organisatie. Dit gebeurt onder meer door in de contracten op te nemen dat deze te zijner tijd overgaan op Zorgnetoost. Benodigde professionalisering: De beheergovernance werkgroep brengt de benodigde transformatie binnen Zorgnetoost in kaart (hoofdstuk 3 Beheergovernance). Uit interviews blijkt bijvoorbeeld dat onderzoek nodig is of het huidige personeelsbestand 1) over voldoende capaciteit beschikt en 2) voldoende kennis en ervaring heeft om de toekomstige rollen en verantwoordelijkheden juist uit te voeren. Toetreden leden: Vanaf fase 4 kunnen partijen toetreden middels de coöperatie van Zorgnetoost. Transformatiegelden zijn dan niet meer van toepassing, en de besluitvorming is geregeld middels in ieder geval een Algemene Leden Vergadering.





3. Project-governance en organisatie

Stuurgroep incl. programmadirecteur – Rollen en verantwoordelijkheden

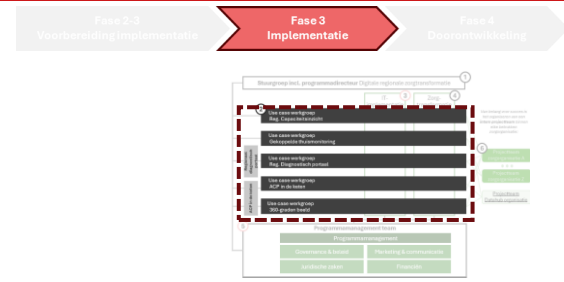
Rollen

- Stuurgroeplid:** gemandateerd bestuurder met digitale affiniteit uit MST, ZGT, Mediant, Zorgschakel Enschede, CarintReggeland, Labmicta en Acute zorg Euregio, HZT, TAO-UA, Zorgnetoost
- Programmadirecteur**

Verantwoordelijkheden

- Opdrachtgever** implementatie
- Besluitvorming en sturing** in de implementatie van de digitale regionale zorgtransformatie
- Sponsoring van een team of werkgroep** uit de programmaorganisatie
- Borging draagvlak** in de regio

- Draagt zorg voor de **totstandkoming, de besturing en uitvoering van het programma** en de bijbehorende begroting
- Ontwikkeling **visie en strategie** met input vanuit stuurgroep en Governance & Beleid
- Zet **strategische en tactische koers** uit met betrekking tot de regionale datahub en de bijbehorende zorgtransformatie
- Stakeholder management**
- Eindverantwoordelijk voor de **voortgang** van de digitale regionale zorgtransformatie



3. Project-governance en organisatie

Use case werkgroepen – Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen

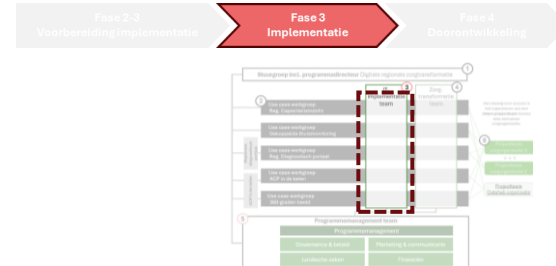
- Sponsor
- Regionale eigenaar
- Projectleider
- Deelnemer use case werkgroep: professionals met inhoudelijke expertise op de desbetreffende use case. Goede representatie vanuit de regio, de verschillende zorgsectoren, en zorgprofessionals is hierbij wenselijk

Verantwoordelijkheden

- Vertegenwoordigt belang werkgroep in **stuurgroep** en is verantwoordelijk voor oplossen escalaties
- Ambassadeur** van werkgroep in regio en **adviseert** regionale eigenaar en projectleider, bewaakt gezamenlijk met hen projectdoel
- Inhoudelijke koersbepaler** over visie, ambitie en doelstelling van werkgroep
- Biedt **inhoudelijke ondersteuning** in voorbereiding en verwerking werksessies
- Reviewt** stukken vanuit overige teams en werkgroepen
- Ontzorgt regionale eigenaar en is linking pin naar **projectmanagement**
- Zet samen met eigenaar op inhoud de koers voor de use case uit en stut deze in het uitdragen van de visie en ambitie
- Draagt zorg voor de **realisatie en uitwerking** van de implementatie vanuit de eigen werkgroep
- Organiseert werksessies**, bereid voor, legt vast en voorziet projectleden van uitwerking
- Is verantwoordelijk voor de planning en **informeert** deelnemers over de inhoud en proces
- Ambassadeur en aanjager voor **afstemming** door de deelnemers binnen betrokken organisaties
- Neemt **eigenaarschap** op ten minste één “**werkstroom**” (onderdeel) van de werkgroep. Dit wordt onderling bepaald per werkgroep.
- Brengt eigen inhoudelijke expertise mee in **werksessies, reviewmomenten** en het creëren van **deliverables**
- Toetst en **daagt uit op de inhoudelijke koers** die wordt uitgezet door de regionale eigenaar en projectleider

- Use case groepen (geheel)

- Werken multidisciplinair aan implementatie van use cases zoals opgesteld in het transformatieplan en worden hierin ondersteund door het IT-implementatie en zorgtransformatie team.



3. Project-governance en organisatie

IT-implementatieteam – Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen
• Sponsor
• Regionale eigenaar
• Projectleider
• Data engineer
• Architect
• Power BI Developer
• Power Platform Expert
• Business analyst healthcare

Verantwoordelijkheden
• Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Sponsor – Use case werkgroepen’.
• Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Regionale eigenaar – Use case werkgroepen’.
• Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Projectleider – Use case werkgroepen’.
• Ontwerpen, bouwen en beheren van data-infrastructuren en -pipelines voor efficiënte data-opslag en -verwerking.
• Verantwoordelijk op het gebied van proces en informatie. Stelt gezamenlijke standaarden en uitgangspunten met betrekking tot de architectuur vast
• Ontwikkelen van interactieve dashboards en rapporten voor datavisualisatie en analyse met behulp van Power BI.
• Configureren, ontwikkelen en beheren van oplossingen binnen het Power Platform
• Analyseren van zorgprocessen, verzamelen van vereisten en aanbevelingen doen voor IT-oplossingen ter verbetering van zorgkwaliteit en efficiëntie.

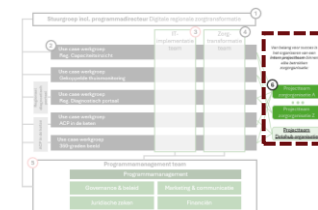


Zorgtransformatieteam – Rollen en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Regionale eigenaar – Use case werkgroepen’.
- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Projectleider – Use case werkgroepen’.
- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘Sponsor – Use case werkgroepen’.
- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘PMO – Programmamanagementteam’.
- *Decentrale coach:* **Helpt vanuit het centrale programmateam de regio op individueel niveau** de zorgtransformatie te bewerkstelligen. Begeleidt de interne projectteams per organisatie met de transformatie van zowel zorginhoudelijke als ondersteunende functies binnen de zorginstellingen. Delen best practices tussen de interne projectteams en/of met werkgroep uit de programmastructuur.
- *Centrale coach:* **verantwoordelijk voor de implementatie van de zorgtransformatie** (o.a. organiseren bijeenkomsten, afstemmen met use cases).
- Verantwoordelijk voor **het ontwerpen en beheren van de informatiestructuur binnen het zorgtransformatieteam**, ten behoeve van de aansluiting van informatiestromen in regio op interne processen.
- Verantwoordelijk voor **het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om inzichten te genereren** die de zorgtransformatie ondersteunen. O.a. analyse, rapportage en visualisatie.





3. Project-governance en organisatie

Decentrale organisaties – Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen

- **Projectleider**
- **Programmamedewerker**
- **PMO**
- **Communicatieprofessional**
- **Leveranciersmanager**
- **Inkoper**
- **Data owner / steward**
- **Informatiemanager**
- **Decentrale projectteamlid IT-implementatie**
- ***Projectteam Datahub organisatie rollen***

Verantwoordelijkheden

- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘use case werkgroepen’. **Verantwoordelijk voor de verbinding** tussen het programma digitale regionale zorgtransformatie en de individuele zorgaanbieder. **Leidt het project** binnen de individuele organisatie.
- **Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project** binnen de individuele organisatie, onder leiding van de projectleider.
- Zie rollen en verantwoordelijkheden ‘PMO - programmamanagement’.
- **Dragen zorg voor interne communicatie** binnen hun eigen organisatie, op basis van de centrale aansturing van het marketing & communicatie team vanuit het programma
- Optioneel deelnemen in klankbordgroep van communicatieadviseurs
- Waar diensten of producten complementair zijn aan de datahub, maar niet centraal worden ingekocht, ligt de verantwoordelijkheid voor inkoop en leveranciersmanagement bij de gebruiker(s) die deze diensten of producten afnemen.
- **Bewaking van datakwaliteit en beschikbaarheid** van aan te leveren data.
- Het **realiseren van de benodigde integraties en processen**, met ondersteuning georganiseerd vanuit Bureau Zorgnetoost.
- Voert IT-implementatie decentraal uit bij de diverse zorgaanbieders (zoals bij ziekenhuizen, VVT)
- Zie Transformatieplan hoofdstuk 3.2 Beheergovernance en Verdieping 2.2.



Programmamangementteam – Rollen en verantwoordelijkheden



Programmamangementteam – Rollen en verantwoordelijkheden



3. Governancestructuur | Overzicht programmaoverleggen*

Interactie tussen groepen uit de programmastructuur in fase 3

Naam overleg	Doel en mandaat	Betrokkenen	Frequentie	Rollen**
Stuurgroepoverleg	Strategische besluitvorming o.b.v. input voortgangsoverleg met aandacht voor stakeholder management, algehele voortgang m.b.t. implementatieplanning, aftekening van stukken vanuit de werkgroepen en escalaties uit teams.	- Stuurgroepleden (vertegenwoordiging van diverse zorgaanbieders en deelnemerde partijen) 1-2 programmamanagers	Maandelijks (even weken)	- Facilitator: programmamanagers - Agendabepaling: progr.managers en stuurgroepleden
Voortgangsoverleg	Tactische, strategische en operationele besluitvorming o.b.v. input uit stroomlijnoverleg en use case groepsoverleg met als uitkomst voorstellen aan de stuurgroep ter besluitvorming. Onderwerpen: focus op proces en inhoud, bewaken van voortgang t.a.v. implementatieplanning en KPI's, escalatiemogelijkheid, monitoren risico's, en afstemming van inhoud en stakeholders.	- Regionale eigenaren vanuit use case werkgroepen - Projectleiders vanuit use case werkgroepen - Managers progr.mgmt.team 1-2 programmamanagers - Op afroep: specialisten zoals lead architect	Tweewekelijks (oneven weken)	- Facilitator: programmamanagers - Agendabepaling: progr.managers - Voortgang update: reg. eigenaren en projectleiders - Inhoudelijke expertise: evt. specialisten zoals lead architect
Implementatieoverleg	Afstemming onderlinge samenhang digitale/technische en proces/adoptie kant van de implementatie, o.b.v. input use case groepsoverleg. Uitkomst geeft richting aan de inhoud van het managementoverleg.	- Regionale eigenaar en projectleider IT-implementatieteam - Regionale eigenaar en projectleider zorgtransformatieteam - Op afroep: regionale eigenaar en/of projectleider use case werkgroepen - Op afroep: deelnemers use case werkgroep	Maandelijks (wijkt twee weken af van managementoverleg)	- Facilitator: projectleiders - Agendabepaling: reg. eigenaren en projectleiders
Managementoverleg	Afstemming ondersteunende functies (zoals marketing & communicatie) en optimale ondersteuning programmamanagement subteams bij de digitale zorgtransformatie, o.b.v. input uit implementatie- en managementoverleg. Uitkomsten geven richting aan de werkzaamheden en overleggen van de programmamanagement subteams (zoals 'financiën')	- Regionale eigenaar en projectleider IT-implementatieteam - Regionale eigenaar en projectleider zorgtransformatieteam - Managers progr.mgmt.team 1-2 progr.managers	Maandelijks (wijkt twee weken af van implementatieoverleg)	- Facilitator: progr. managers - Agendabepaling: reg. eigenaren en projectleiders - Inhoudelijke expertise: managers programmamanagementteam
Use case groepsoverleg	Afstemming binnen iedere use case werkgroep om uitvoering van implementatie vorm te geven, met als uitkomst voorstel aan het implementatieoverleg en voortgangsoverleg ter besluitvorming.	Use case werkgroepleden incl. regionale eigenaar en projectleider vanuit één use case	Driewekelijks	- Facilitator: projectleider - Agendabepaling: projectleider en regionale eigenaar
Decentraal afstemmingsoverleg	Afstemming projectcoaches vanuit zorgtransformatie met de interne projectteams binnen elke betrokken zorgorganisatie. Onderwerpen: o.a. impact op zorgprocessen en IT, communicatie, randvoorwaarden zoals financiën en juridische zaken.	- Toegewezen projectcoach van desbetreffende betrokken zorgorganisatie - Projectleider van desbetreffende betrokken zorgorganisatie	Maandelijks	- Facilitator: projectcoach - Agendabepaling: projectcoach - Inhoudelijke expertise: projectleider



3. Governancestructuur | Overzicht stakeholderoverleggen*

Interactie tussen programmastructuur en belangrijke stakeholdergroepen in fase 3

Naam overleg	Doel en mandaat	Betrokkenen	Frequentie	Rollen**
Zorgverzekeraars overleg	Afstemming met zorgverzekeraar(s) over de voortgang van de digitale regionale zorgtransformatie t.o.v. de vooraf bepaalde resultaats- en inspanningsverplichtingen (mijlpalen, KPI's).	Vertegenwoordiger zorgverzekeraar, vertegenwoordiger uit 'Financiën' groep van programmamanagementteam, programmamanager, evt. programmadirecteur	Eens per kwartaal	- Facilitator: programmamanager - Agendabepaling: programmamanager i.s.m. Financiën team - Inhoudelijke expertise: vertegenwoordiger uit 'Financiën'
Governance en organisatie klankbordgroep	Toetsing van de financiering, organisatie- en governancestructuur, juridische samenwerkingsvorm (met name bij de partijen die minder goed vertegenwoordigd zijn in de programmastructuur).	- Medewerkers vanuit deelnemende partijen met juridische en/of financiële kennis en ervaring - Projectleider en/of regionale eigenaar Governance & beleid	Eens per 1-2 maanden	- Facilitator: projectleider en/of regionale eigenaar Gov. & beleid - Agendabepaling: projectleider en/of regionale eigenaar Gov. & beleid - Inhoudelijke expertise: klankbordleden
Zorgprofessionals klankbordgroep	Toetsing van bevindingen binnen de use case groepen en/of het zorgtransformatieteam onder zorgprofessionals. De klankbordgroep biedt de mogelijkheid aan zorgprofessionals om laagdrempelig betrokken te blijven bij de digitale regionale zorgtransformatie in Twente e.o. Focus op de impact bij de operationele zorgprocessen en stakeholder management.	- Zorgprofessionals (o.a. huisartsen, apothekers, verpleegkundigen) - Projectleider en/of regionale eigenaar zorgtransformatieteam - Op afroep: projectleider en/of regionale eigenaar use case groepen	Eens per 1-2 maanden	- Facilitator: projectleider en/of regionale eigenaar Zorgtransformatieteam - Agendabepaling: zorgtransformatieteam i.s.m. use case groepen - Toetsing bevindingen: klankbordleden - Inhoudelijke expertise use case (op afroep): projectleider en/of regionale eigenaar use case groep
Inwoner focusgroepen (optioneel)	Toetsing van bevindingen onder inwoners (patiënten, cliënten en/of burgers) bij specifieke onderwerpen waar hun betrokkenheid / co-creatie gewenst is (bijv. advanced care planning). Focus op de impact voor de patiënt, cliënt of burger.	- Patiënten en/of cliënten die affiniteit met het specifieke onderwerp hebben (zoals ACP) - Projectleider en/of regionale eigenaar zorgtransformatieteam - Projectleider en/of regionale eigenaar van desbetreffende use case	Naar behoefte	- Facilitator: projectleider en/of regionale eigenaar Zorgtransformatieteam - Agendabepaling: zorgtransformatieteam i.s.m. use case groepen - Toetsing bevindingen: klankbordleden - Inhoudelijke expertise use case: projectleider en/of regionale eigenaar use case groep

NB: de klankbord- en focusgroepen vinden plaats in afstemming met de adoptieaanpak zoals beschreven in het transformatieplan (zie hoofdstuk 4 -Zorgtransformatie & adoptie).



Verdieping 4 Maatschappelijke business case

4.1 Uitgangspunten van de impactanalyse en maatschappelijke business case

Voor de impactanalyse en maatschappelijke business case hanteren we de volgende uitgangspunten

- 1 De aangevraagde IZA-gelden worden ingezet voor **nieuwe initiatieven** alsook opschaling/ vervolg van **lopende initiatieven**. Waar mogelijk wordt (her)gebruik gemaakt van bestaande producten/ diensten. Er mag **geen** sprake zijn van **dubbele financiering**.
- 2 Professionals worden **vergoed** voor hun **inspanning** in de transformatie (verleturen). Ook de **inzet** van **zorgprofessionals** in de benodigde **projectorganisatie/ werkgroepen** wordt opgenomen.
- 3 Berekeningen zijn gebaseerd op het **prijspeil van 2024** en zijn zoveel mogelijk afkomstig van **interne en/of gestandaardiseerde bronnen** (bijvoorbeeld huidige kosten of NZa tarieven 2024). De benodigde investeringen worden berekend inclusief btw.
- 4 Voor het doorrekenen van de impact gaan we uit van een **potentieel- en investeringsberekening**. Hierbij hanteren we de **ceteris paribus** voorwaarde: 'alle overige factoren blijven gelijk'. *Om zoveel mogelijk 'appels met appels' te vergelijken, wordt een artificiële doorrekening gemaakt van een potentiële besparing ten opzichte van een toename van patiënten, opnames, etc. niet gehemd door randvoorwaarden zoals personele tekorten.*
- 5 Er wordt een **jaarlijkse indexatie toegepast**. Deze is gebaseerd op de gemiddelde indexatiecijfers van de NZa over de afgelopen 10 jaar (en betreft ~3 % per jaar).
- 6 De uitkomsten worden getoond in besparing van euro's en FTE. Waarbij het met FTE-besparing niet gaat om een FTE besparing, maar om een **fictieve afbuiging** van de groei in zorgvraag
- 7 Voor de **interne** personele inzet wordt een **vast tarief** gehanteerd. Hoewel er verschillende functies zijn, worden deze gegroepeerd in drie categorieën: regionale eigenaar, projectleider en werkgroeplid
- 8 Waar nog **geen referentiewaarden** beschikbaar zijn, wordt een zo **realistisch** mogelijke aanname gemaakt door **experts** in het veld.
- 9 De uitkomst van de business case wordt **zuiver** weergegeven. Dit kan betekenen dat de (financiële) business case voor een bepaalde use cases **negatief kan zijn** - maar de impact hiervan wel een **bijdrage** levert aan (o.a.) de **personele tekorten** op specifieke plekken in de keten.
- 10 De te verwachten tijdswinst/'-besparing' is een uitkomst van deze business case. Het **effectueren** hiervan dient binnen de zorgorganisaties plaats te vinden wat niet alleen een **digitale**, maar ook een **proces-** en **cultuurverandering** vergt, die geborgd wordt met de **veranderaanpak** die deel is van dit transformatieplan.
- 11 Er wordt geen rekening gehouden met **omzetplatforms** op zorgproducten en/of voor zorgorganisaties
- 12 Zorgverrichtingen die niet meer worden gedaan, worden **aangevuld** met nieuwe zorgverrichtingen - gegeven de **stijgende zorgvraag**.



4.2 Jaarlijkse impact use cases tot en met 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Cumulatief
360-graden beeld	Impact op fte (in fte)							
	Impact op zorgkosten (x € 1.000)							
Regionaal diagnostisch portaal	Impact op fte (in fte)							
	Impact op zorgkosten (x € 1.000)							
ACP in de keten	Impact op fte (in fte)							
	Impact op zorgkosten (x € 1.000)							
Gekoppelde thuismonitoring	Impact op fte (in fte)							
	Impact op zorgkosten (x € 1.000)							
Regionaal capaciteitsinzicht	Impact op fte (in fte)							
	Impact op zorgkosten (x € 1.000)							
Totaal	Impact op fte							
	Impact op zorgkosten							



4.3a Algemene input parameters die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke business case

Bevolkingsontwikkeling (o.b.v. het regiobeeld)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal	633.920	638.900	632.090	632.290	632.490	632.370	632.130	631.870	631.480	630.920	630.320
%		0,8%	-1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
0-19	137.680	136.970	131.400	129.770	128.440	127.190	126.280	125.470	124.860	124.320	124.050
%		-0,5%	-4,1%	-1,2%	-1,0%	-1,0%	-0,7%	-0,6%	-0,5%	-0,4%	-0,2%
20-64	363.430	366.720	362.680	361.920	360.790	359.220	357.380	355.270	352.890	350.240	347.710
%		0,9%	-1,1%	-0,2%	-0,3%	-0,4%	-0,5%	-0,6%	-0,7%	-0,8%	-0,7%
65+	132.810	135.210	138.010	140.600	143.260	145.960	148.470	151.130	153.730	156.360	158.560
%		1,8%	2,1%	1,9%	1,9%	1,9%	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%	1,4%

Inflatie (o.b.v. NZa prijsindex)

	2014 -2023		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NZa - Materieel	2,77%		2,88%	1,04%	0,32%	0,38%	1,87%	1,55%	2,49%	1,97%	1,77%	9,25%	7,02%
NZa - Personeel	2,83%		2,64%	1,94%	0,08%	1,74%	2,04%	2,96%	3,42%	3,28%	2,01%	4,42%	6,36%



4.3b Algemene input parameters die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke business case

Interne & externe tarieven



4.4a Impact Digitale Regionale Zorgtransformatie in de MSZ

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Impact op zorgpersoneel in fte	Tijdsbesparing arts						
	Tijdsbesparing (gesp.) verpleegkundige						
Financiële impact x € 1.000	“Anders doen”						
	“Niet meer doen”						

“Anders doen” is de doorrekening van de ombuiging van zorgpersoneel wat op een andere manier ingezet kan worden.
“Niet meer doen” verwijst naar zorgverrichtingen die niet langer worden uitgevoerd, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor het opvangen van de toenemende zorgvraag. bijv. minder herhaalconsulten d.m.v. thuismonitoring of minder SEH-opnames door ACP

Grootste impactdrivers:

- Reductie in tijd voor het verzamelen van (zorg)informatie t.b.v. overdracht vanuit de verzendende & ontvangende partij
- Reductie in tijd voor het verzamelen van (zorg)informatie m.b.v. generiek kerndossier
- Reductie klinische ligdagen van palliatieve patiënten in Twente
- Reductie SEH bezoeken van palliatieve patiënten in Twente
- Reductie van tijd mbt overleg en overdracht van palliatieve patiënten in Twente
- Voorkomen van klinische opnames door thuismonitoring
- Verkorten van ligduur in het ziekenhuis door thuismonitoring
- Vermindering van (poli)consulten door thuismonitoring
- Reductie van verkeerde beddag voor de GRZ, ELV en WLZ

Impact op zorgpersoneel t.o.v. financiële impact (x € 1.000)



4.4b Impact Digitale Regionale Zorgtransformatie in de VVT

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Impact op zorgpersoneel in fte	Tijdsbesparing verpleegkundige							
	Extra tijd benodigd voor thuismonitoring *							
Financiële impact x € 1.000	“Anders doen”							
	“Niet meer doen”							
<i>“Anders doen” is de doorrekening van de ombuiging van zorgpersoneel wat op een andere manier ingezet kan worden. “Niet meer doen” verwijst naar zorgverrichtingen die niet langer worden uitgevoerd, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor het opvangen van de toenemende zorgvraag. bijv. minder herhaalconsulten d.m.v. thuismonitoring of minder SEH-opnames door ACP</i>								
Grootste impactdrivers: ▪ Reductie in tijd voor het verzamelen van (zorg)informatie t.b.v. overdracht vanuit de verzendende & ontvangende partij ▪ Reductie van tijd mbt overleg en overdracht van palliatieve patiënten in Twente ▪ Additioneel personeel benodigd om verkeerde beddagen vanuit MSZ op te kunnen vangen					Impact op zorgpersoneel t.o.v. financiële impact (x € 1.000)			

* Nog te bepalen door wie de thuismonitoring (of monitoring in de wijk) wordt uitgevoerd



4.4c Impact Digitale Regionale Zorgtransformatie in de huisartsenzorg

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Impact op zorgpersoneel in fte	Tijdsbesparing huisarts						
	Tijdsbesparing POH						
Financiële impact x € 1.000	“Anders doen”						
	“Niet meer doen”						

“Anders doen” is de doorrekening van de ombuiging van zorgpersoneel wat op een andere manier ingezet kan worden.
“Niet meer doen” verwijst naar zorgverrichtingen die niet langer worden uitgevoerd, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor het opvangen van de toenemende zorgvraag. bijv. minder herhaalconsulten d.m.v. thuismonitoring of minder SEH-opnames door ACP

Grootste impactdrivers:

- Reductie in tijd voor het verzamelen van (zorg)informatie m.b.v. generiek kerndossier
- Verbeterde efficiëntie voor aanvragen diagnostiek (in één portaal)
- Tijdswinst door inzicht in uitgevoerde diagnostiek
- Reductie van tijd mbt overleg en overdracht van palliatieve patiënten in Twente
- Vermindering van herhaalconsulten door thuismonitoring
- Vermindering van POH-consulten door thuismonitoring

Impact op zorgpersoneel t.o.v. financiële impact (x € 1.000)



4.4d Impact Digitale Regionale Zorgtransformatie in de diagnostiek

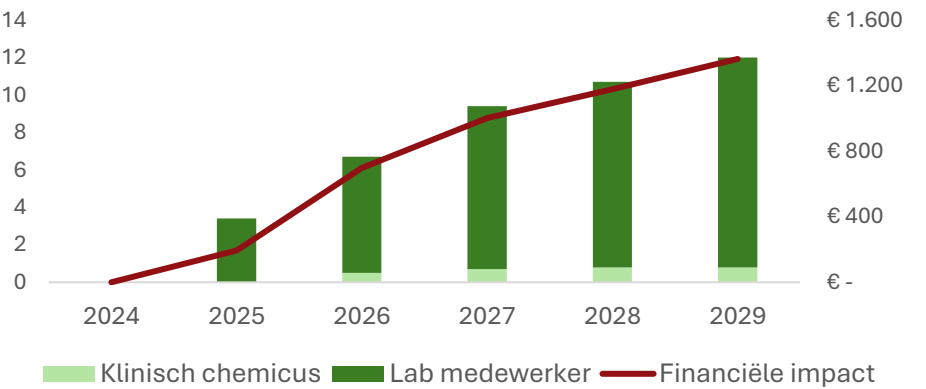
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Impact op zorgpersoneel in fte	Tijdsbesparing klinisch chemicus	0	0	0,5	0,7	0,8	0,8	
	Tijdsbesparing lab medewerker	0	3,4	6,2	8,7	9,9	11,2	
Financiële impact x € 1.000	“Anders doen”	-	193	331	477	560	648	2.209
	“Niet meer doen”	-	-	365	526	618	715	2.224

“Anders doen” is de doorrekening van de ombuiging van zorgpersoneel wat op een andere manier ingezet kan worden.
“Niet meer doen” verwijst naar zorgverrichtingen die niet langer worden uitgevoerd, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor het opvangen van de toenemende zorgvraag. bijv. minder herhaalconsulten d.m.v. thuismonitoring of minder SEH-opnames door ACP

Grootste impactdrivers:

- Voorkomen dubbele diagnostiek (door overzicht uitgevoerd onderzoek) 2e lijn
- Tijdswinst door inzicht in uitgevoerde diagnostiek

Impact op zorgpersoneel t.o.v. financiële impact (x € 1.000)



4.4e Impact Digitale Regionale Zorgtransformatie voor de apotheek

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Impact op zorgpersoneel in fte	Tijdsbesparing apotheker						
	Tijdsbesparing apothekersassistente						
Financiële impact x € 1.000	“Anders doen”						
	“Niet meer doen”						

“Anders doen” is de doorrekening van de ombuiging van zorgpersoneel wat op een andere manier ingezet kan worden.
“Niet meer doen” verwijst naar zorgverrichtingen die niet langer worden uitgevoerd, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor het opvangen van de toenemende zorgvraag. bijv. minder herhaalconsulten d.m.v. thuismonitoring of minder SEH-opnames door ACP

Grootste impactdrivers:

- Reductie in tijd door direct toegang te hebben tot ontslagmedicatie van patiënten

Impact op zorgpersoneel t.o.v. financiële impact (x € 1.000)



Verdieping 5 Risico's en mitigerende maatregelen

Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (1/3)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Project-management	1	Onvoldoende beschikbaarheid van menscapaciteit t.b.v. het maken van nieuwe werkafspraken en de uitvoering	Hoog	Hoog	• Escaleren naar en afstemmen met stuurgroepleden • Planning vroegtijdig kenbaar maken om tijdig mensen vrij te maken om plannen uit te kunnen voeren (commitment vanuit de organisaties en contractueel vastleggen) • Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans • Er zijn out-of-pocket kosten opgenomen in de business case om in dit geval extern personeel te kunnen inschakelen
Project-management	2	Gebrek aan integraliteit en samenwerking van de use cases, waardoor niet het maximale uit de use cases gehaald kan worden	Hoog	Hoog	• Sessies organiseren met alle use cases om dit te borgen en bespreken, met name om de tijdslijnen en technische afhankelijkheden in detail met elkaar door te nemen
Project-management	3	Gebrek aan capaciteit en focus door grote hoeveelheid verschillende projecten in de regio	Hoog	Hoog	• Prioriteren binnen de regio vanuit bestuurders en/of initiatieven onder de paraplu van dit project organiseren
Project-management	4	Vertraging in de uitbetaling van IZA-transformatiegelden door het niet op tijd behalen van mijlpalen o.b.v. de KPIs	Hoog	Hoog	• Regelmatig monitoren en rapporteren op de KPIs zodat eventuele vertragingen tijdig gesignaleerd kunnen worden • Nauwe afstemming met de zorgverzekeraars over de haalbaarheid van de mijlpalen i.r.t. de realiteit van de transformatie
Project-management	5	Er treden onvoorziene kosten op gedurende de implementatie van de zorgtransformatie.	Hoog	Gemiddeld	• Indien voortschrijdend inzicht aantoon dat een (deel)project weinig kans van slagen heeft, worden alle bijbehorende activiteiten 'on hold' gezet. Tot dan toe voltooide fases/activiteiten worden vergoed op basis van inspannings-KPI's, zonder verdere kosten
Project-management	6	Niet in iedere organisatie zijn interne projectteams beschikbaar	Gemiddeld	Hoog	• Als een organisatie dit zelf niet kan organiseren, dan faciliteert het adoptie team vanuit programma/regio dit
Project-management	7	De gebruikers binnen de betrokken zorgorganisaties van de datahub voeren de bedachte zorgtransformatie onvoldoende uit	Laag	Hoog	• De zorgtransformatie en adoptie aanpak (hoofdstuk 5) en reguliere evaluatie van de projectstructuur (implementatieplanning, hoofdstuk 7) helpen dit risico te verkleinen



Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (2/3)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Governance	8	Het betrekken van een uitgebreide groep belanghebbenden, met name in het vinden van de juiste balans tussen betrokkenheid en de beschikbare tijd van zorgprofessionals voor dit programma	Hoog	Hoog	• Optie deelname aan werkgroepen óf klankbordgroep
Governance	9	Financiële middelen voor realisatie zijn ontoereikend om de gewenste doelen te behalen	Gemiddeld	Hoog	• Afspraken betreffende commitment van alle betrokken stakeholders op bestuurlijk niveau welke periodiek zullen worden geëvalueerd
Governance	10	Binnen één v/d betrokken partijen ontstaat weerstand en deze partij trekt zich terug uit de transformatie en het samenwerkingsverband	Gemiddeld	Gem./Hoog afh. v/d partij	• De zorgtransformatie en adoptie aanpak (hoofdstuk 4) helpt dit risico te verkleinen
Governance	11	Er treden 'hindernissen' op bij een partij die niet is aangesloten bij de zorgtransformatie. Denk hierbij aan onvoldoende aansluiting in zorgprocessen of grote financiële consequenties.	Gemiddeld	Gemiddeld	• Indien dit zich voordoet kunnen de projectcoaches deze partij begeleiden (zie Rollen en verantwoordelijkheden)
Governance	12	Onduidelijkheid en geen afspraken over welke partij de voorfinanciering van het programma dit uitvoeren zo lang de tranches nog niet door de zorgverzekeraar zijn uitgekeerd	Gemiddeld	Gemiddeld	• Er worden afspraken over voorfinanciering gemaakt in tussenfase 2-3, voordat de implementatie begint
Governance	13	KPI's worden niet gehaald, lagere uitgekeerde financiering	Gemiddeld	Gemiddeld	• Financiële afspraken in samenwerkingsovereenkomst besteden hier aandacht aan. Daarnaast project control
Governance	14	Onduidelijkheid over of en wanneer het programma onder de paraplu van Twente Beter komt te vallen. Onduidelijkheden gaan over wanneer er overgang zal plaatsvinden en welke gevolgen dit zal hebben voor de governance, programmastructuur en financiering	Gemiddeld	Laag	• Twente Beter is betrokken gedurende dit project en wordt ook in het vervolg betrokken
Governance	15	Besluitvormingsprocessen leiden tot het resultaat dat een coöperatie bij Zorgnetoost toch geen wenselijke juridische samenwerkingsvorm is	Laag	Gemiddeld	• Het subteam Governance en Beleid werkt een nieuwe juridische samenwerkingsvorm uit in tussenfase 2-3



Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (2/3)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Zorgtransformatie	16	Verandermoeheid onder betrokkenen door meerdere projecten/initiatieven tegelijkertijd of opvolgend (in de regio en/of in organisaties)	Hoog	Hoog	• Prioritering en bijsturen door bestuurders noodzakelijk
Zorgtransformatie	17	Geen goede borging in de regio door hoge mate van externe inzet	Hoog	Hoog	• Mensen vanuit de regio inzetten als eigenaren en in werkgroepen. Externen (gefaseerd) laten uitstromen zodra mogelijk
Zorgtransformatie	18	Weerstand tegen (technologische) verandering bij zorgprofessionals en inwoners	Hoog	Hoog	• Bewustwording creëren over de uitdaging in de zorg die ons te wachten staat. Daarnaast moeten we samen successen vieren en dit ook uitdragen in de regio. Ook moeten we het niet te ingewikkeld maken voor inwoners; die willen vaak wel.
Zorgtransformatie	19	Onvoldoende onderling vertrouwen tussen deelnemende partijen en/of vertrouwen in de gezamenlijke zorgtransformatie	Gemiddeld	Hoog	• Gezamenlijke sessies organiseren om onderling vertrouwen op diverse niveaus (bestuurders, sectoren, organisaties etc.) uit te bouwen
Zorgtransformatie	20	Verschil in kwaliteit van projectteams per organisatie kan leiden tot wisselende mate van adoptie en veranderbereidheid	Gemiddeld	Hoog	• Vanuit het programma de voortgang bewaken en bijsturen/opschakelen waar nodig
Zorgtransformatie	21	Lage mate van vertrouwen in data integriteit, waardoor datahub niet wordt gebruikt	Gemiddeld	Hoog	• Sturen op kwaliteit van registratie aan de bron en communicatie hierover
Zorgtransformatie	22	Als gebruiksvriendelijkheid niet voldoet aan de wensen of niet past binnen werkprocessen, dan gaan mensen de datahub niet gebruiken	Gemiddeld	Hoog	• UX ontwerp borgen in ontwikkeling datahub
Zorgtransformatie	23	De processen worden met de "nieuwe" informatiestromen niet/niet goed geïmplementeerd/ingebed in reguliere processen binnen een organisaties	Gemiddeld	Gemiddeld	• Vanuit het programma de voortgang bewaken en bijsturen/opschakelen waar nodig
Zorgtransformatie	24	Een individuele organisatie is niet bereid om eigen werkprocessen op te geven/aan te passen voor het grote geheel	Gemiddeld	Gemiddeld	• Maandelijkse bestuurlijke sessies organiseren zodat er vertrouwen ontstaat. Daarnaast het belang van de transformatie blijven benadrukken



Risicoanalyse & mitigerende maatregelen (2/3)

Scope		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Implementatie datahub	25	Generieke functie Toestemming (MITZ) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	• (Werk-)afspraken maken mbt het vastleggen van toestemming in bronsystemen van zorgaanbieders
Implementatie datahub	26	Generieke functie Identificatie & Autorisatie voor zorgprofessionals (Dezi) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	• Tijdelijke work-around ontwikkelen en implementeren (bijv SSO)
Implementatie datahub	27	Ontwikkeling Landelijk Vertrouwensstelsel gaat te langzaam	Hoog	Hoog	• Ontwikkeling data- en integratiediensten in samenspraak met CumuluZ-coalitie, andere regio's, leveranciers, e.d.
Implementatie datahub	28	Kwaliteit van (gestructureerde) data is te laag door interpretatieverschillen van standaarden bij het inbouwen/ doorontwikkelen van informatiestandaarden/ zorginformatiebouwstenen (zibs) door leveranciers terwijl deze wel gekwalificeerd zijn door Nictiz	Hoog	Hoog	• Agenderen bij VWS, Nictiz, e.a. mbv voorbeelden uit de praktijk • Afspraken maken m.b.t. wijze van aggregeren data • Gezamenlijke teststrategie Nictiz, leveranciers en zorgaanbieders formuleren en uitvoeren
Implementatie datahub	29	Onvoldoende (personele) capaciteit bij functioneel beheer en ICT voor technische inrichting/koppeling tussen EPD/ECD en dashboard	Hoog	Hoog	• Prioritering van datahub projecten binnen de zorgorganisatie (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans
Implementatie datahub	30	Geen capaciteit voor inrichting en beheer, waardoor gestelde doelen weggezet in de tijd niet worden gehaald en er dus niet kan worden voldaan aan inspanningsverplichting en levering verplichtingen	Gemiddeld	Hoog	• Afspraken betreffende commitment van alle betrokken stakeholders op bestuurlijk niveau welke periodiek zullen worden geëvalueerd



Inhoudsopgave Verdieping en bijlage IZA transformatieplan

1. Verdieping 1 use cases

2. Verdieping 2 datahub beheergovernance

3. Verdieping 3 projectgovernance

4. Verdieping 4 Risico's en mitigerende maatregelen

5. Bijlagen

- A – Regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven
- B – Toelichting Buurtzorg Alliantiepartners
- C – Landelijke wet- en regelgeving m.b.t. databeschikbaarheid
- D – Visie op CumuluZ
- E – Technische uitgangspunten en doelarchitectuur
- F – Overzicht van huidige applicaties/oplossingen in de regio
- G – Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden
- H – Kosten datahub
- I – Landelijke architectuur principes
- J – Generieke functies
- K – Toelichting van gebruik generieke functies per use-case
- L – Afkortingenlijst

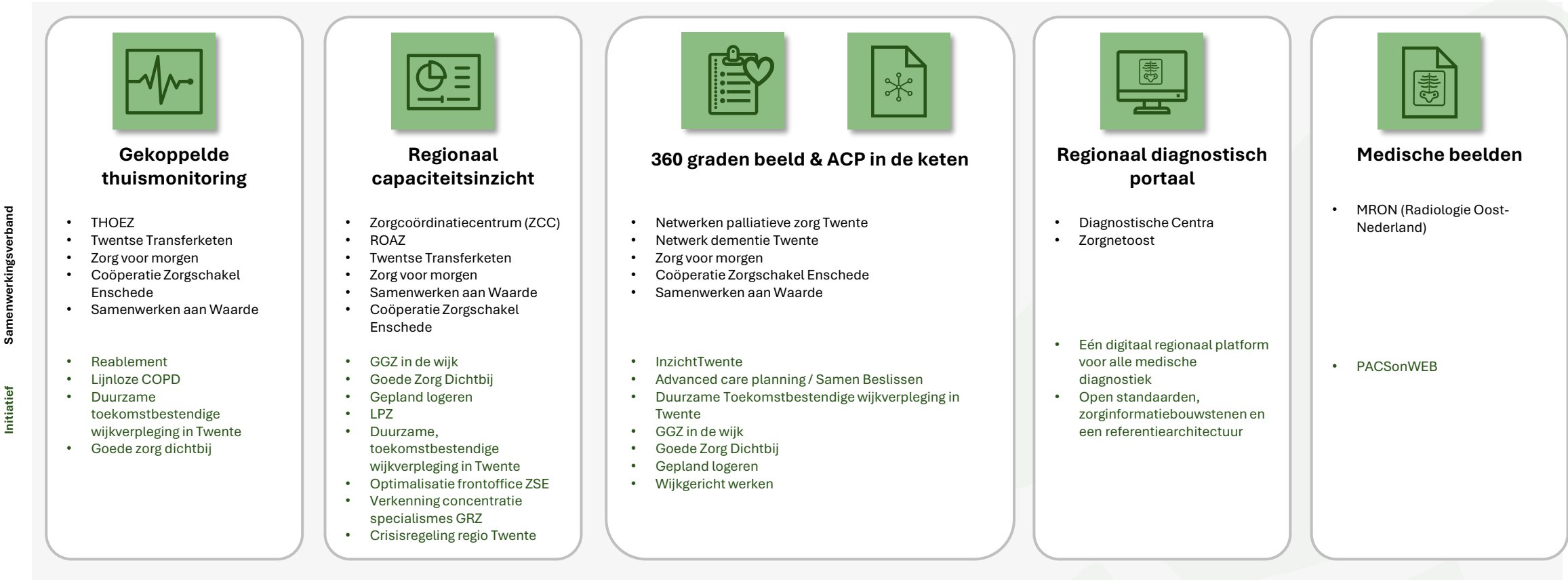


Bijlage A Regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven

VERDIEPING: Bestaande Twentse samenwerkingsverbanden en initiatieven gekoppeld aan use cases Regionale Digitale Transformatie

Samenwerkingsverbanden versnellen (door) realisatie regionale datahub

In regio Twente werken zorgorganisaties in verschillende samenwerkingsverbanden samen. Binnen deze samenwerkingsverbanden zijn al veel initiatieven genomen die raken aan de use cases van de regionale datahub. In de Regionale Digitale Zorgtransformatie wordt zo veel mogelijk voortgebouwd op deze initiatieven. Enerzijds om bestaande kennis en stappen die hierin gezet zijn niet verloren te laten gaan, anderzijds om op korte termijn waarde te kunnen toevoegen. Daarnaast hebben de onderstaande samenwerkingsverbanden hebben ook baat bij de realisatie van de datahub en de use cases, bijv. omdat databeschikbaarheid een randvoorwaarde is voor andere transformaties.



Bijlage B Toelichting Buurtzorg

Alliantiepartners

Bij Buurtzorg Alliantie betrokken VVT-organisaties onderzoeken samenhang met het transformatieplan en stemmen af met de zorgverzekeraars

De Buurtzorg Alliantie heeft 200 miljoen euro IZA-transformatiegelden toegekend gekregen om Zorgzame Buurten te ontwikkelen

Een aantal van de VVT-organisaties dat betrokken is bij de IZA- aanvraag Regionale Digitale Zorgtransformatie Twente is ook betrokken als Alliantiepartner bij de Landelijke IZA aanvraag “de buurt als ecosysteem” (CarintReggeland, Zorgaccent). Deze organisaties hebben met Buurtzorg (namens de wijkverpleging alliantie) expliciet afgesproken om overlappen en synergieën in beide aanvragen regelmatig te onderzoeken en op basis daarvan gezamenlijk een vervolgplan af te stemmen met de verzekeraars. Uitgangspunten hierbij zijn: a) voorkomen van overlap en dubbelfinanciering om zinvolle besteding van IZA gelden te borgen; b) benutten en versterken van synergieën van de aanvragen om de impact in beide plannen te vergroten; c) gebruik maken en uitwisselen van open internationale standaarden om in beide plannen de implementatie en opschaling te versnellen.



Bijlage C Landelijke wet- en regelgeving m.b.t. databeschikbaarheid

VERDIEPING: Samenhang landelijke ontwikkelingen

We commiteren ons aan geldende landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot databeschikbaarheid in de zorg

Er gelden landelijk verschillende wet- en regelgevingen als het gaat om **de borging van veiligheid en privacy in gegevensuitwisselingen en databeschikbaarheid in de zorg** (figuur rechts). Een aantal hiervan gelden in hun algemeenheid, andere specifiek voor de zorgsector. Voor het gehele transformatie-plan zullen wij voldoen aan en rekening houden met deze wetten en regelgevingen. Daarnaast werken we vanuit de nationale visie en strategie gegevensuitwisseling in de zorg, ook benoemd in het IZA. Enkele daarvan lichten wij hieronder uit. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen uitputtende lijst betreft en zullen nauwlettend aanvullingen en ontwikkelingen in de privacy- en security wetgeving volgen en implementeren.

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke bepaalt op welke manier onder andere zorgaanbieders, ongeacht hun omvang of activiteiten binnen de EU, persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De verwerking van deze gegevens moet voldoen aan specifieke voorwaarden.

Wabvpz = Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, welke onder andere de vormen van digitale uitwisseling van medische gegevens en patiëntrechten beschrijft.

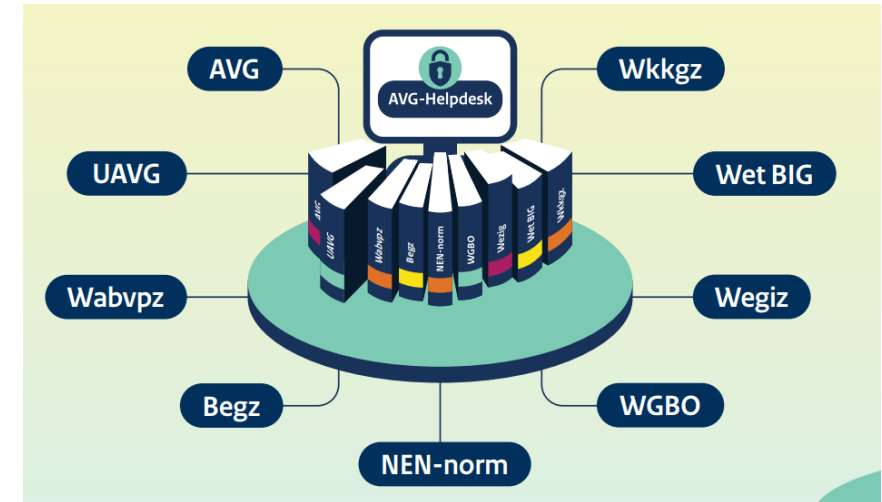
Begz = Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, welke gaat over de verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apothekers.

NEN-normen = Regels voor het beveiligen, vaststellen en communiceren van persoonsgegevens (in de zorgsector)

Wegiz = Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, welke het mogelijk maakt dat aangewezen gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals én tussen zorgprofessionals en patiënten, genormaliseerd en elektronisch plaatsvindt. De beveiliging hiervan is vastgelegd in NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden.

Ook wordt er rekening gehouden met Europese wetgeving zoals o.a.

EHDS = De European Health Data Space (EHDS) is een voorstel van de Europese Commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen: primair datagebruik waarbij de burger centraal staat, secundair datagebruik en regulering van de zorg-ICT-markt.



Uit de: Infographic AVG-helpdesk voor zorg, welzijn en sport

Met betrekking tot de **regionale datahub** sluiten we ook aan de volgende afspraken:

- eIDAS = 'Electronic Identification And Trust Services' waarin begrippen, betrouwbaarheidsgegevens en onderlinge digitale infrastructuur zijn afgestemd
- Goed Beheerd Zorgsysteem = Eisen waaraan een zorginformatiesysteem dient te voldoen m.b.t. applicaties, de implementatie en exploitatie van het zorginformatiesysteem

In de uitwerkingen van de **use cases** wordt verder gespecificeerd welke specifieke wet- en regelgevingen, maar ook normen en informatiestandaarden aanvullend gelden op de algemene wet- en regelgevingen



Bijlage D Visie op CumuluZ

Visie op CumuluZ

De regionale datahub (RDH) en CumuluZ hebben hetzelfde primaire doel: data uit de keten ontsluiten en beschikbaar stellen. Zodra CumuluZ landelijk beschikbaar is, volgt aansluiting met de RDH

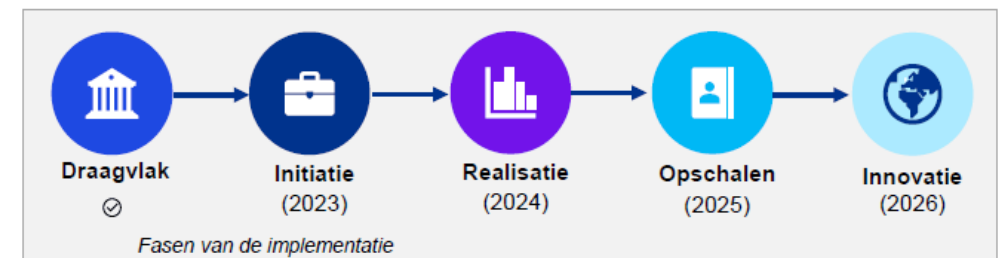
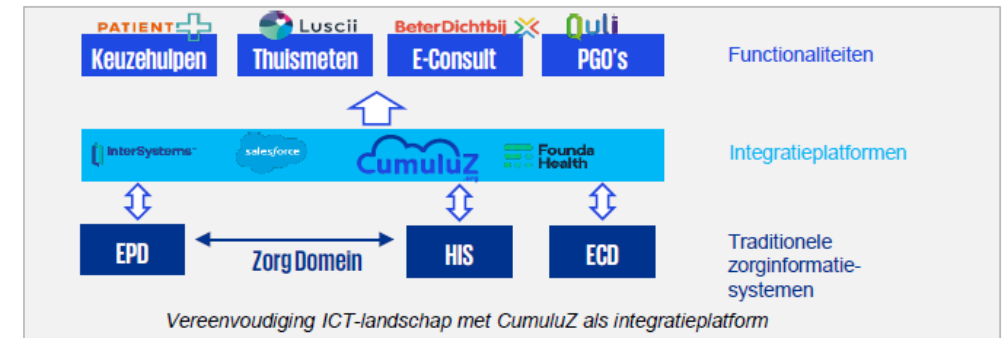
Het CumuluZ initiatief is net als de RDH een data-integratieplatform. Zowel CumuluZ als de RDH hebben als primaire doel om data te ontsluiten uit bronsystemen. De intentie van beide platformen is om op te schalen in een regionale setting.

CumuluZ is ontworpen als transmuraal longitudinaal levenslooppdossier. Dit betekent dat het de levensloop van een patient volgt, startend bij de huisarts. Daarnaast wordt CumuluZ gepresenteerd als platform voor wetenschappelijk onderzoek (secundair gebruik).

CumuluZ heeft als doel, net als de RDH, om te integreren met oplossingen voor digitale zorg. Voorbeelden hiervan zijn Luscii, BeterDichtbij en de PGO's. CumuluZ is ontworpen op bewezen Microsoft technologie, wordt gehost in Azure en maakt gebruik van standaarden zoals FHIR en OpenEHR. Het CumuluZ platform heeft interne vertaalmogelijkheden in het ontwerp opgenomen.

De ontwikkeling van CumuluZ loopt. De werking van CumuluZ wordt door middel van use-cases aangetoond.

De regio Twente wil aansluiten op bewezen en beschikbare initiatieven. De landelijke infrastructuur voor CumuluZ is nog niet gereed en tijdslijnen zijn onbekend. De regio Twente wil bijdragen aan het ontwikkelen van CumuluZ.



Visie op CumuluZ

De uitgangspunten van CumuluZ zijn beoordeeld en getoetst op de uitgangspunten van de RDH. Deze komen met elkaar overeen.

Momenteel wordt er gewerkt aan de doelarchitectuur voor CumuluZ, de huidige status van deze ontwikkeling is bij schrijven van het transformatieplan nog niet helder. Het is bekend dat CumuluZ in deze doelarchitectuur werkt met generieke Microsoft Azure componenten en ondersteuning wil bieden voor vergelijkbare generieke functies, afsprakenstelsels en standaarden als de RDH. CumuluZ werkt met een aantal uitgangspunten welke zijn getoetst op de uitgangspunten op van de RDH. Deze zijn als volgt:

1. *CumuluZ is data centrisch en data wordt gescheiden van functionaliteit.* De RDH wordt, net als CumuluZ, ontwikkeld om data uit geïsoleerde bronsystemen te ontsluiten en integreren voor primair en secundair gebruik. De RDH biedt net als CumuluZ een open architectuur. Alle gezondheidsdata worden toekomstbestendig opgeslagen in leverancier onafhankelijke open datamodellen om afhankelijkheid van ICT-leveranciers te minimaliseren.
2. *CumuluZ hanteert semantische interoperabiliteit.* Eenheid van taal is een van de focusgebieden van het Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling. De informatie moet bij uitwisseling de volledige betekenis houden, dit is ook essentieel voor de RDH. De RDH committeert zich aan het gebruik van gestandaardiseerde FHIR-resources, -extensies en -profielen, maar ook aan beschikbare zibs. De RDH hanteert uitwisseling in een combinatie van zibs 2020 en FHR R4 waar mogelijk.
3. *CumuluZ werkt met standaard APIs (standaard acties, datasets volgens eenheid van taal en standaard metadatering).* De RDH werkt met standaard APIs waar mogelijk en volgt de API-strategie van Nictiz. Binnen de RDH zijn verschillende (FHIR-)APIs beschikbaar voor semantische interoperabiliteit.
4. *CumuluZ wil niet onnodig dupliceren.* De RDH hanteert dezelfde principes waarbij eenmalig registreren voor meervoudig gebruiken de standaard is. Daarnaast moet data worden behandeld volgens de FAIR-principes. Ook willen zowel CumuluZ als de RDH werken volgens het *multiplier principe* waarbij architectuurcomponenten worden hergebruikt voor andere toepassingen.
5. *CumuluZ gaat uit van generieke functies op basis van internationale standaarden, zonder versnippering en geschikt voor primair en secundair gebruikt.* De RDH wordt ontwikkeld op basis van dezelfde generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden als CumuluZ, waarbij per generieke functie en afsprakenstelsel is getoetst wat de impact is voor de specifieke use-case en de RDH.

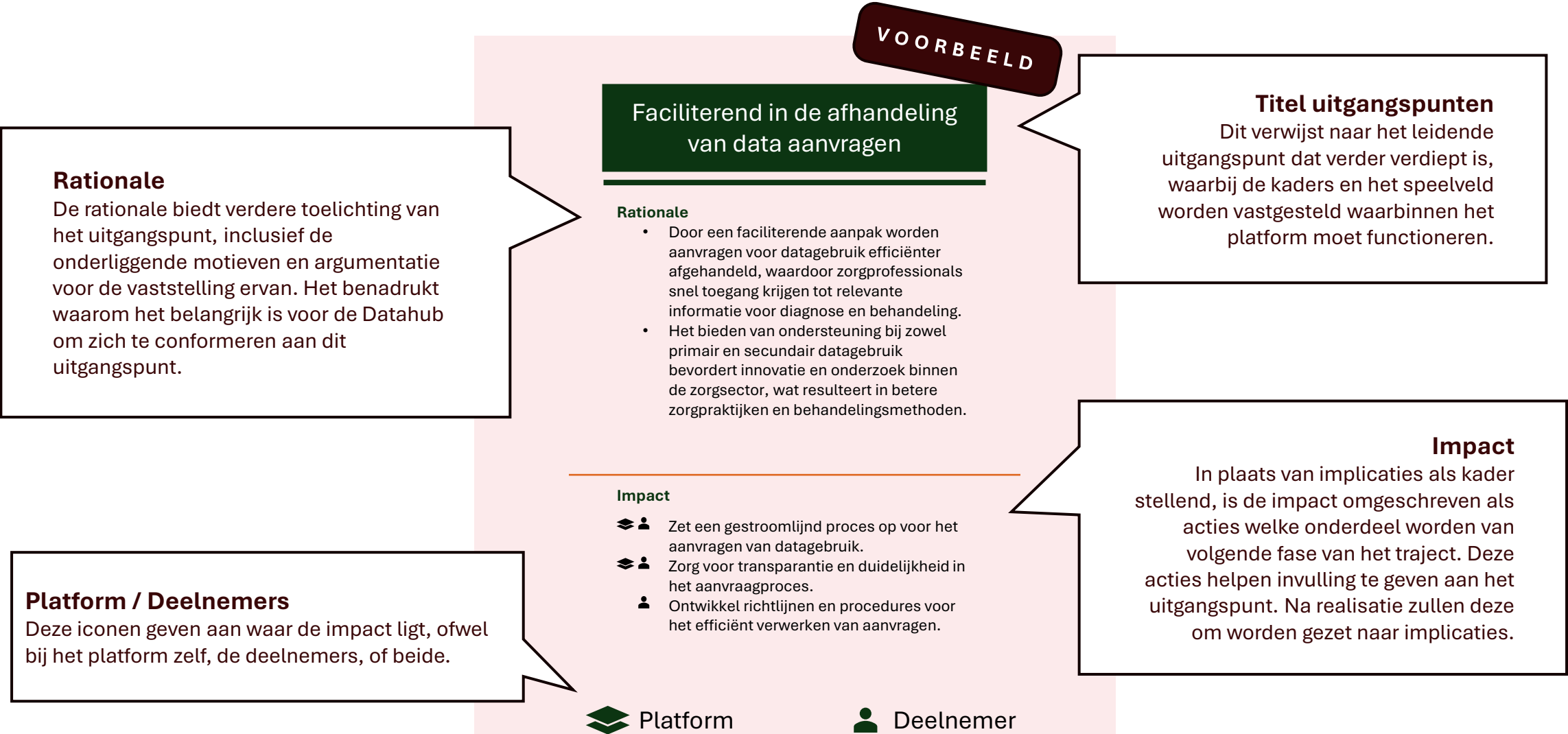
Er kan worden geconcludeerd dat zowel CumuluZ als de RDH vergelijkbare doelstellingen hebben en gebruik (gaan) maken van dezelfde generieke componenten. Dit biedt vertrouwen in de integratie en schaalbaarheid van beide platforms.



Bijlage E Technische uitgangspunten en doelarchitectuur

Technische uitgangspunten

Navigeer door de verdiepende uitgangspunten met behulp van onze leesgids.



Technische uitgangspunten

Architectuur uitgangspunten* geven sturing en kaders mee voor de Datahub

Faciliterend in de afhandeling van data aanvragen	Data is FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar)	Eén waarheidsbron met minimalisatie van data duplicatie en opslagretentie	(Her)gebruik van bestaande bouwstenen
Rationale - Door een faciliterende aanpak worden aanvragen voor datagebruik efficiënter afgehandeld, waardoor zorgprofessionals snel toegang krijgen tot relevante informatie voor diagnose en behandeling. - Het bieden van ondersteuning bij zowel primair en secundair datagebruik bevordert innovatie en onderzoek binnen de zorgsector, wat resulteert in betere zorgpraktijken en behandelingsmethoden.	Rationale - Het waarborgen van FAIR-principes zorgt ervoor dat zorgdata gemakkelijk te vinden, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, waardoor de uitwisseling en hergebruik van informatie tussen verschillende zorgprofessionals en instanties wordt vergemakkelijkt. - Het verbeteren van de FAIR-heid van data ondersteunt onderzoek en innovatie door het gemakkelijker maken van hergebruik van data voor nieuwe inzichten en toepassingen.	Rationale - Door data bij de bron te houden, en (alleen) daar op te halen, wordt data zo weinig mogelijk gekopieerd, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid ervan worden gewaarborgd. - Het behouden van data bij de bron minimaliseert ook de kans op dataverlies of onbedoelde wijzigingen tijdens datatransport, wat de kwaliteit van de zorginformatie verbetert.	Rationale - Versnelt de ontwikkeling en vermindert kosten, terwijl tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van bewezen technologieën en praktijken. - Bevordert de interoperabiliteit en standaardisatie, wat de uitwisseling van informatie vergemakkelijkt en de adoptie van versnelt. - Vereenvoudigt het beheer van de Datahub
Impact  Zet een gestroomlijnd proces op voor het aanvragen van datagebruik.  Zorg voor transparantie en duidelijkheid in het aanvraagproces.  Ontwikkel richtlijnen en procedures voor het efficiënt verwerken van aanvragen.	Impact  Implementeer standaarden voor het realiseren van FAIR-data.  Ontwikkel infrastructuur en technologieën om de FAIR-heid van data te ondersteunen.  Creëren van richtlijnen voor data-archivering en -documentatie om vindbaarheid en herbruikbaarheid te waarborgen.  Ondersteunen van training en bewustwording om het belang van FAIR-data te benadrukken en de adoptie ervan te bevorderen.	Impact  Elke ontsloten bron heeft een duidelijke eigenaar.  Data is terug te leiden naar één (waarheids)bron.  Stel duidelijke verantwoordelijkheden en eigendom vast voor de gegevensbron.  De Datahub haalt gegevens alleen op uit de daarvoor aangewezen bronapplicatie.  Wijzigingen in brongegevens worden aangebracht in het betreffende bronsysteem.  De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en integriteit van data blijft bij de eigenaar van de bron.	Impact  Ontwikkel richtlijnen en procedures voor het evalueren en selecteren van geschikte bestaande bouwstenen.  De Datahub maakt herbruikbare functionaliteit/gegevens beschikbaar.  Reguliere evaluatie van de bruikbaarheid en relevantie van bestaande bouwstenen voor huidige en toekomstige projecten.  Ontwikkel een centrale repository of catalogus van beschikbare connectoren voor (her)gebruik.  Stimulering van de adoptie van API-first design om de flexibiliteit en schaalbaarheid van connectoren te maximaliseren en tegelijkertijd de afhankelijkheid van legacy-systemen te verminderen.

*Om vast te stellen wat de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, moet eerst worden nagegaan 1) of er daadwerkelijk (direct dan wel indirect) herleidbare gegevens worden verwerkt en 2) voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Dit dient per use case bepaald te worden



Technische uitgangspunten

Architectuur uitgangspunten geven sturing en kaders mee voor de Datahub



Gebruik van open standaarden en landelijke richtlijnen (bijv. FHIR, OpenEHR maar ook CumuluZ, EHDS)	Schaalbaar en flexibel om mee te evolueren met toekomstige ontwikkelingen	We werken naar één uniform datamodel voor de regio
Rationale • Zorgt voor consistentie en compatibiliteit tussen verschillende bronsystemen en instanties, waardoor de interoperabiliteit en uitwisseling van gegevens worden verbeterd. • Toegang tot en de uitwisseling van informatie wordt vergemakkelijkt, wat resulteert in betere en snellere zorgcoördinatie en -kwaliteit.	Rationale • Zorgt dat het platform relevant en effectief blijft in een snel veranderende digitale omgeving. • Zorgt dat het systeem gemakkelijk kan worden aangepast en dat het kan blijven voldoen aan de behoeften van zorgprofessionals en inwoners. • Zorgt dat (kleine) organisaties relatief snel aan kunnen sluiten.	Rationale • Het bevordert de consistentie en standaardisatie van zorggegevens, wat de uitwisseling en analyse van informatie vereenvoudigt en de kwaliteit van de zorg verbetert. • Vergemakkelijkt ook de integratie van verschillende systemen en databronnen, waardoor er een meer holistisch beeld van de zorg gerealiseerd kan worden.
Impact • Integreer landelijke richtlijnen zoals CumuluZ, Health-RI en EHDS in de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen van de Datahub. • Zorg voor naleving van open standaarden en landelijke richtlijnen bij de ontwikkeling en implementatie van de Datahub. • Creëer een mechanismen voor continue monitoring en evaluatie van de implementatie van open standaarden en richtlijnen. • Zorg ervoor dat gebruikte en toekomstige standaarden compatibel blijven, door ondersteuning te bieden voor vertaalslagen.	Impact • Implementeer flexibele configuratieopties om aanpasbaarheid te garanderen. • Gebruik public cloud aanbieders om schaalbaarheid te maximaliseren. • Regelmatige monitoring en evaluatie van de technologische trends. • Gebruik agile ontwikkelmethodieken om sneller te kunnen reageren op veranderingen. • Zorg voor flexibele on-boarding van organisaties en gebruikers, en hun autorisaties.	Impact • Zorg ervoor dat alle (toekomstige) bronsystemen en use-cases conformeren tot het uniforme datamodel. • Zorg daarbij voor een flexibele en configureerbare koppeling met het uniforme model; opdat niet iedere organisatie met dezelfde (inrichting van) bronsystemen werkt. • Regelmatige monitoring en naleving van de standaarden om de kwaliteit en consistentie van gegevens te waarborgen. • Implementeer (governance) processen voor het beheren en bijwerken van het model. • Train betrokken organisaties in het gebruik van het uniforme datamodel.



Technische uitgangspunten

Architectuur uitgangspunten geven sturing en kaders mee voor de Datahub

 Platform

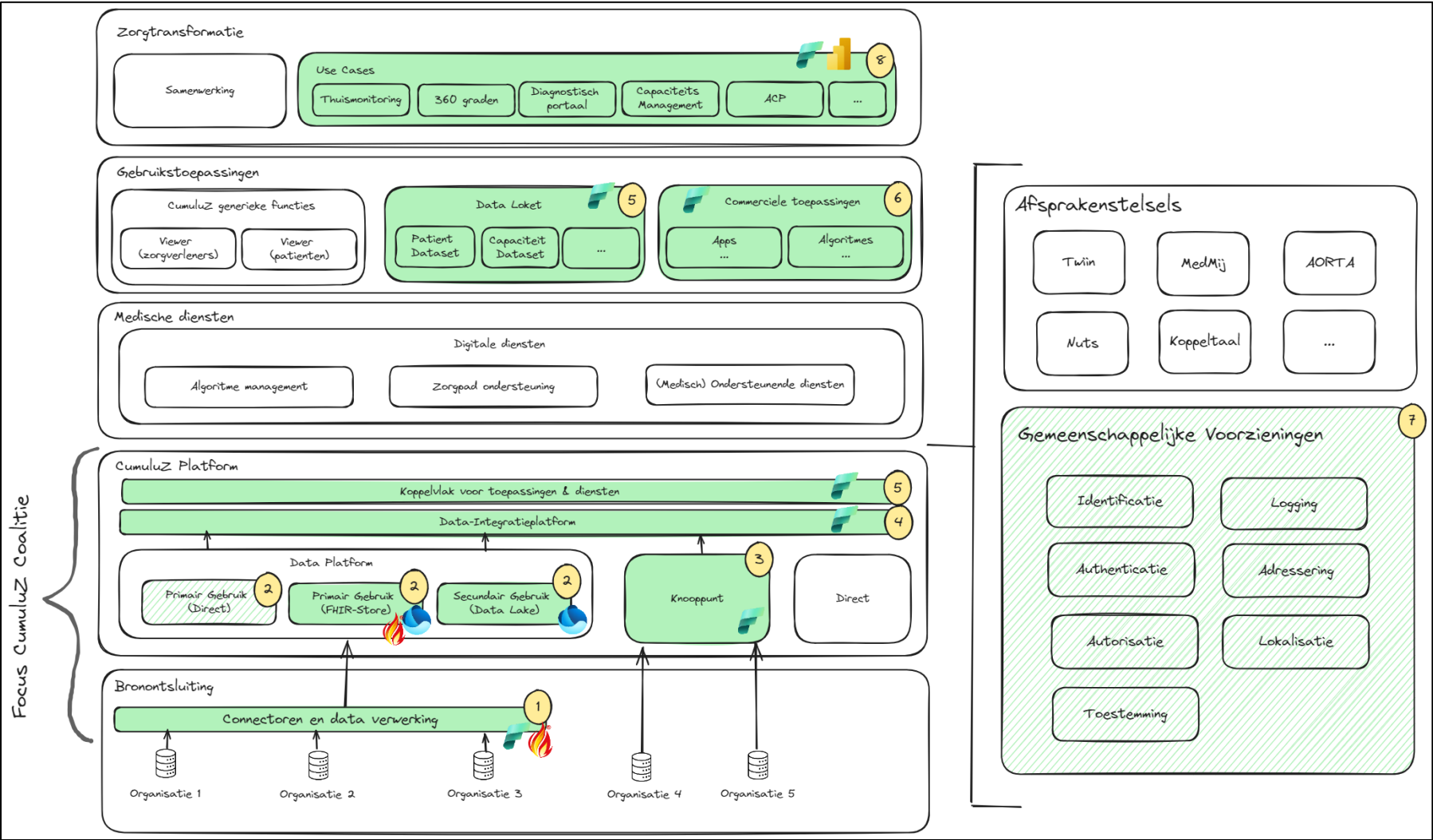
 Deelnemer

Transparant en uitlegbare dataverwerking	Bewust van kosten en voetafdruk	Security en privacy by design
Rationale • Cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen in de (ontwikkelde use-cases op de) Datahub bij alle indirect en directe belanghebbenden (Zorginstellingen, inwoners, nationale en internationale overheidsinstanties, burgers, enz.) • Door processen en gegevensstromen transparant te maken, kunnen gebruikers beter begrijpen hoe gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, wat de acceptatie en adoptie bevordert.	Rationale • Essentieel om duurzame en kosteneffectieve beslissingen te nemen bij het ontwerpen en onderhouden van de Datahub. • Inefficiënties kunnen worden geïdentificeerd en geëlimineerd, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en middelen effectiever worden ingezet.	Rationale • De beveiliging en privacy van de Datahub wordt ingebed in alle aspecten van het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie, waardoor de bescherming van gevoelige gegevens wordt versterkt. • Proactieve aandacht voor beveiliging en privacy helpt om potentiële kwetsbaarheden en risico's vroegtijdig te identificeren en aan te pakken, wat de kans op datalekken en inbreuken verkleint.
Impact •  Alle gegevensbewerkingen moeten transparant en herleidbaar zijn. •  Documenteer en communiceer duidelijk de beleidslijnen en procedures met betrekking tot gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik. •  Zorg voor een begrijpelijke en toegankelijke gebruikersinterface, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en begrijpen hoe ze gegevens kunnen invoeren, wijzigen of opvragen. •  Implementeer feedbackmechanismen waarmee gebruikers vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven of bezorgdheden kunnen uit.	Impact •  Prioriteer initiatieven en functionaliteiten op basis van hun verwachte financiële impact en bijdrage aan kostenbesparingen of operationele efficiëntie. •  Voer kostenanalyses uit om te evalueren waar optimalisaties mogelijk zijn. •  Implementeer maatregelen voor het monitoren en beheren van energieverbruik, servercapaciteit en andere middelen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. •  Stimuleer een cultuur van kosten- en milieubewustzijn binnen de organisatie.	Impact •  Integreer beveiligings- en privacy vereisten in alle fasen van het ontwikkelingsproces, van ontwerp tot implementatie en onderhoud. •  Implementeer robuuste authenticatie- en autorisatiemechanismen om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens te voorkomen. •  Versleutel gevoelige gegevens tijdens opslag en verzending om de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te waarborgen. •  Voer regelmatig security audits en compliance controles uit om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te valideren.



Visie datahub doelarchitectuur

We hebben de regionale datahub geplot op de CumuluZ doelarchitectuur. Veel componenten worden ingevuld door middel van standaardoplossingen

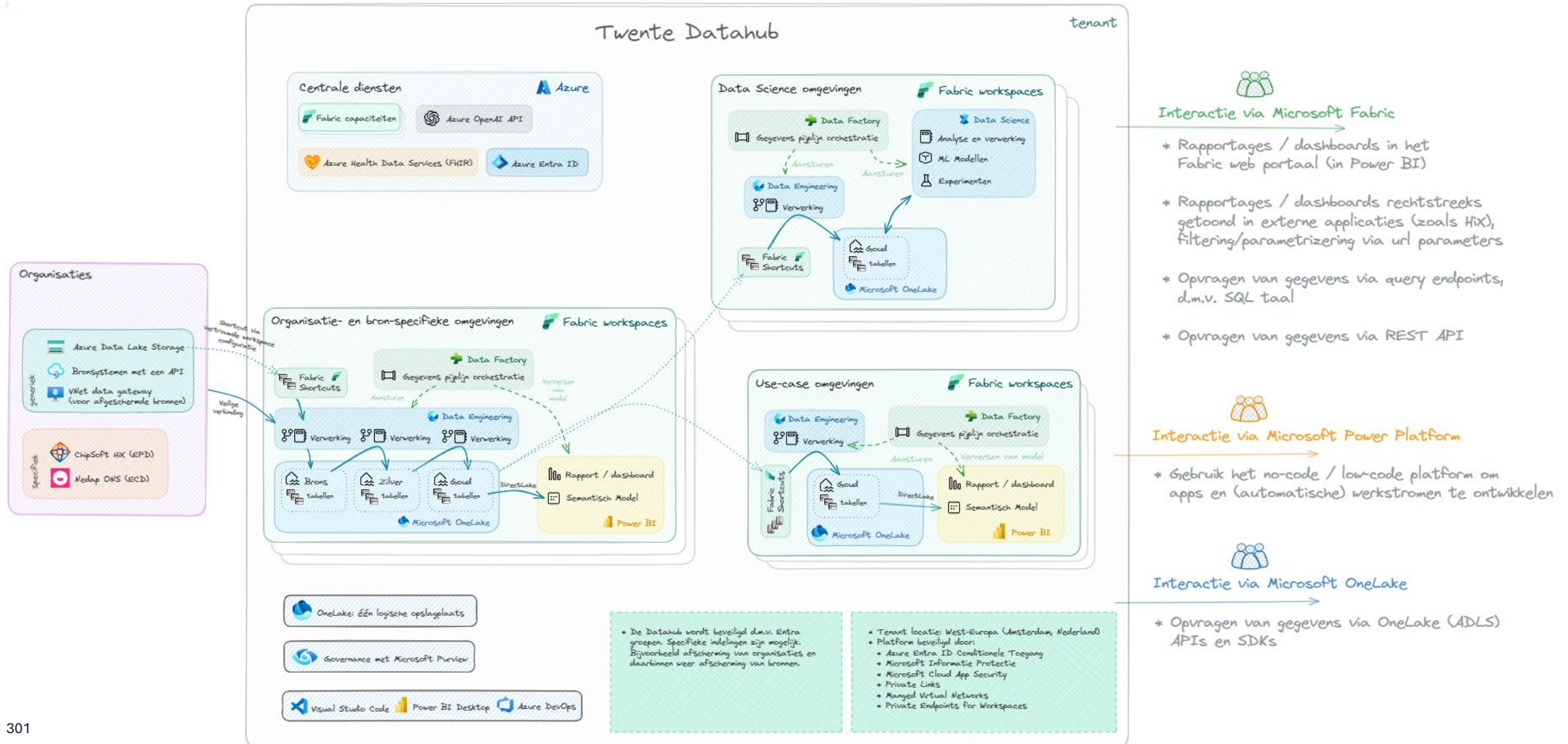


- 1 Bronontsluiting kan lopen via Azure Health Data Services, met ondersteuning voor FHIR en ZorgInformatieBouwstenen (zibs).
- 2 Microsoft Fabric biedt een Data lake (Microsoft OneLake) zowel voor primair gebruik via FHIR-store als voor secundair gebruik. Afhankelijk van de broninfrastructuur is ook directe integratie mogelijk.
- 3 De regionale datahub Twente wordt een knooppunt en kan eenvoudig koppelen met andere knooppunten, bijvoorbeeld via Data Sharing met Microsoft Purview of OneLake API's. Purview Data Sharing ondersteunt ook het direct delen van data.
- 4 Data integratie wordt vanuit Microsoft Fabric ondersteund door middel van data pipelines en gateways, notebooks, API's en connectoren.
- 5 Diensten en toepassingen kunnen ondersteund worden vanuit Microsoft Fabric workspaces waarin standaard functionaliteit voor data science, data engineering en Power BI geleverd wordt. Daarnaast biedt Microsoft Power Apps voor het zelf ontwikkelen van business applicaties en integraties.
- 6 Microsoft Fabric workspaces kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van commerciële use-cases, zoals het aanbieden van algoritmes. Daarnaast kunnen Microsoft PowerApps en API integration services gebruikt worden voor het ontwikkelen van commerciële applicaties en integraties.
- 7 Gemeenschappelijke voorzieningen worden mogelijk gemaakt door integraties tussen het platform en landelijke functies.
- 8 Om de zorgtransformatie mogelijk te maken, biedt het regionale data platform de mogelijkheid om use-cases op het platform te ontwikkelen bijvoorbeeld door ondersteuning vanuit Power BI.



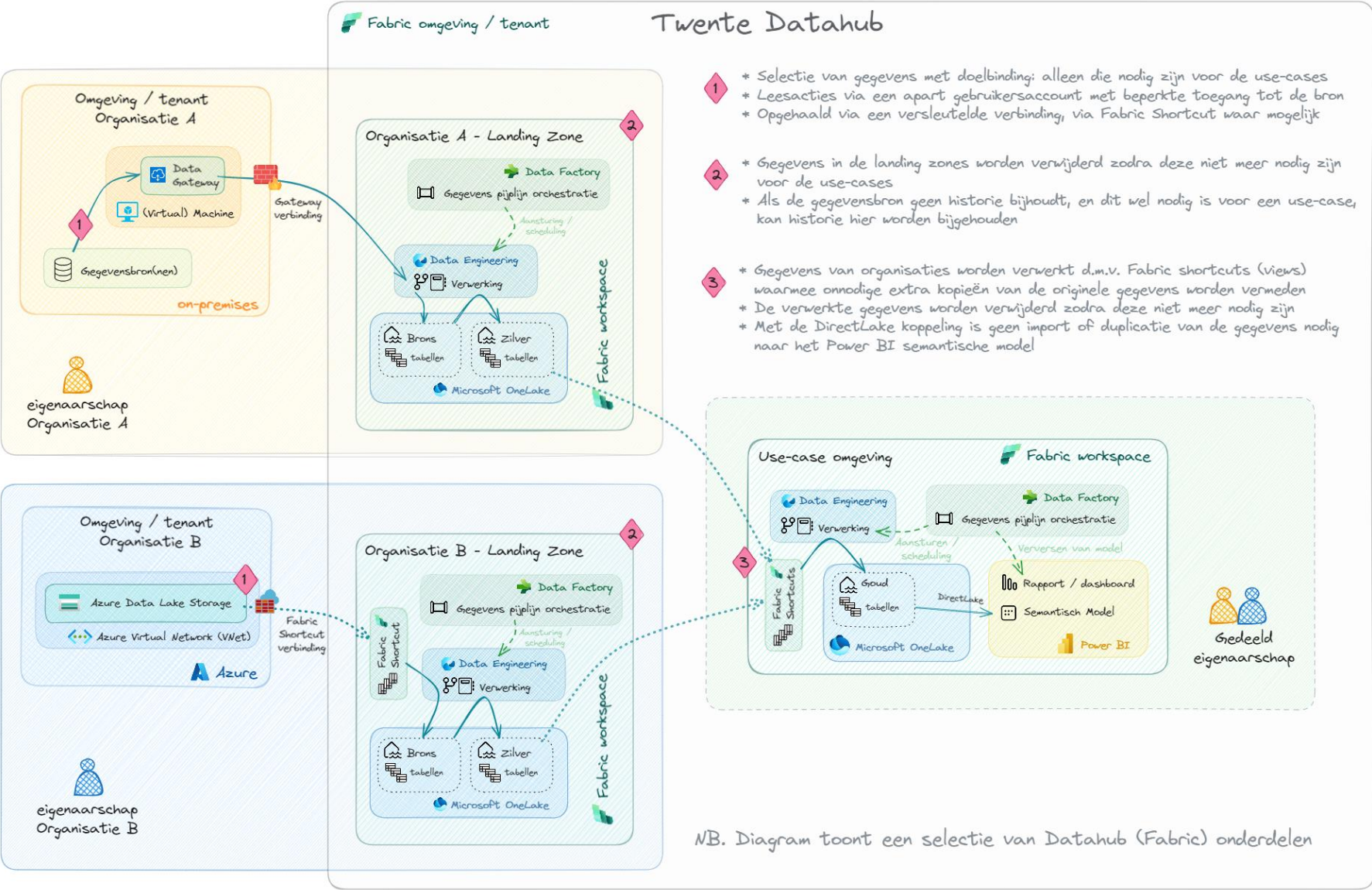
Visie datahub doelarchitectuur

Doelarchitectuur: Low Level Design (1/2)



Visie datahub doelarchitectuur

Doelarchitectuur: Low Level Design (2/2)



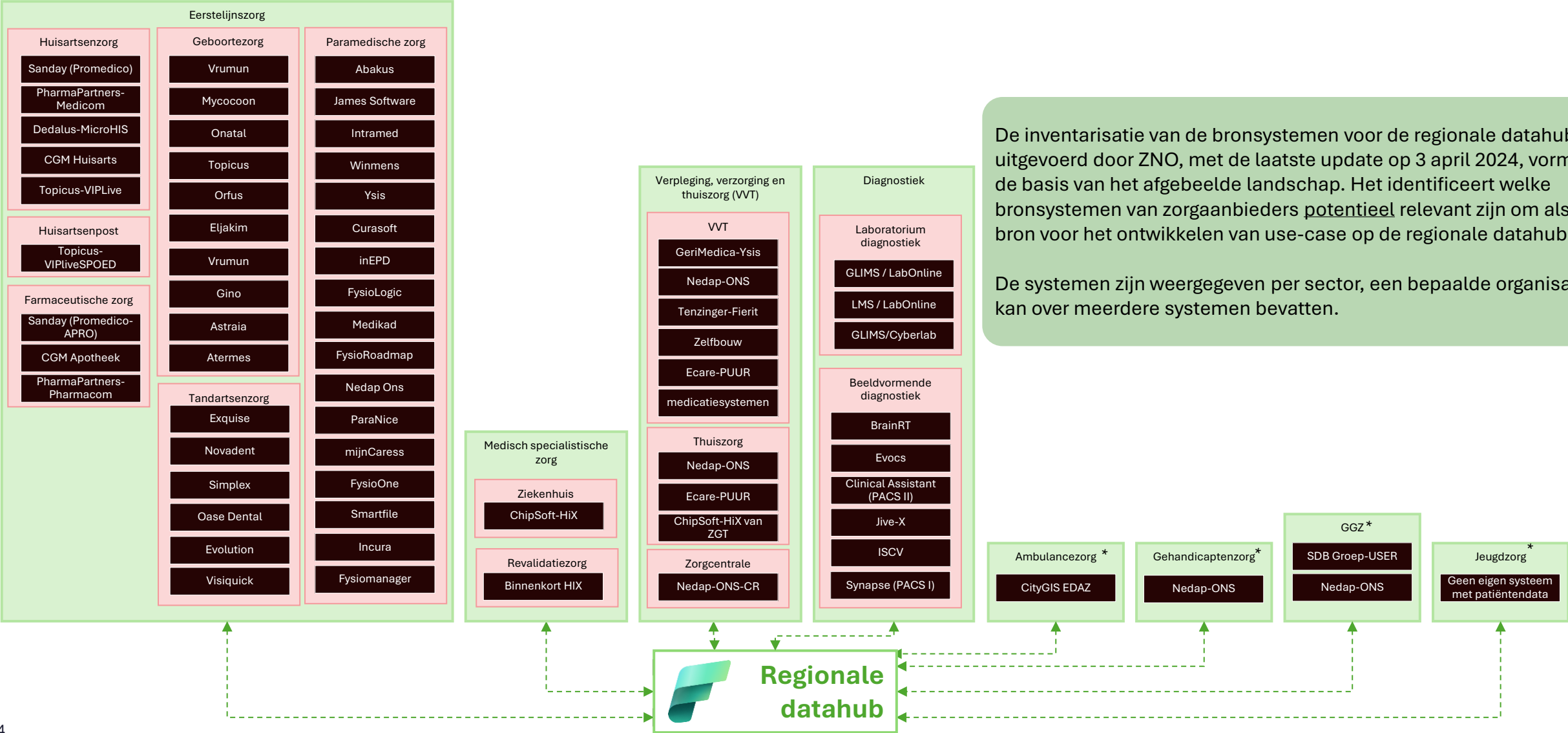
NB. Diagram toont een selectie van Datahub (Fabric) onderdelen



Bijlage F Overzicht van huidige applicaties/oplossingen in de regio

Overzicht potentiële bronnen en applicaties voor integratie met de datahub

Inventarisatie regionale datahub Twente; bronsystemen zorgaanbieders in relatie tot use-cases



De inventarisatie van de bronsystemen voor de regionale datahub, uitgevoerd door ZNO, met de laatste update op 3 april 2024, vormt de basis van het afgebeelde landschap. Het identificeert welke bronsystemen van zorgaanbieders potentieel relevant zijn om als bron voor het ontwikkelen van use-case op de regionale datahub.

De systemen zijn weergegeven per sector, een bepaalde organisatie kan over meerdere systemen bevatten.



Bijlage G Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden

5. Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden

De onderstaande matrix biedt inzicht in de verschillende soorten zorg die relevant zijn voor elke use-case. Verder is er een overzicht van de relevante bronsystemen, informatiestandaarden en afsprakenstelsels

Soort zorg		use-cases					Bronsystemen	Informatie-standaarden	Afsprakenstelsel
		360 graden	ACP	Thuismonitoren	Diagnostisch portaal	Capaciteitsmanagement			
Eerstelijnszorg	Huisartsenzorg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	HIS	Huisartsgegevens PDF/A	AORTA-LSP MedMij
	Huisartsenpost	Ja	Ja	Ja	Ja		VIPliveSPOED	(Professionale samenvatting)	AORTA-LSP
	Apotheek zorg	Ja	Ja	Ja	Ja		AIS	(Medicatiegegevens)	AORTA-LSP
Medisch specialistische zorg	Ziekenhuis	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	EPD	BgZ eOverdracht PDF/A (medicatiegegevens)	Twijn-BgZ Twijn (TA Notified Pull)-eOverdracht MedMij AORTA-LSP
VVT	VVT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	ECD, behandel dossier, medicatie	eOverdracht BgZ PDF/A	NUTS MedMij
	Zorgcentrale	Ja	Ja	Ja		Ja	ECD, behandel dossier, medicatie		
Diagnostiek	Laboratorium diagnostiek	Ja	Ja		Ja		LIP, VIPlive	Labuitwisseling	



5. Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden

De onderstaande matrix biedt inzicht in de deelnemers van het transformatieplan (specifiek eerstelijnszorg, MSZ, en diagnostiek) en de beschikbaarheid van de zibs

Soort zorg		Deelnemers transformatieplan	Beschikbaarheid zibs		
			Deelname VIPP	Informatiestandaard	Stand van zaken implementatie
Eerstelijnszorg	Huisartsenzorg	SHT-THOON	OPEN	Huisartsgegevens	Afgerond
		FEA	OPEN	Huisartsgegevens	Afgerond
	Huisartsenpost	CHP Almelo	nvt		
		SHT (Enschede, Hengelo)	nvt		
	Apotheek zorg	TAO-UA			
Medisch specialistische zorg	Ziekenhuis	MST	VPP5	BgZ	Afgerond
			InZicht	eOverdracht	14 zibs overlap BgZ in EPD bsb
			BabyConnect	BgZ	Verwachte go-live medio 2024
		ZGT	VIPP5	BgZ	Afgerond
			InZicht	eOverdracht	14 zibs overlap BgZ in EPD bsb
			BabyConnect	BgZ	Verwachte go-live medio 2024
Diagnostiek	Laboratorium diagnostiek		nvt	Labuitwisseling	# zibs in LIS bsb
GGZ		Mediant	VIP GGZ	BgGGZ	29 zibs
Overige participanten ZNO		Niet in scope			

Inzicht in de beschikbaarheid van zibs binnen de VVT staat op
de volgende pagina



5. Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden

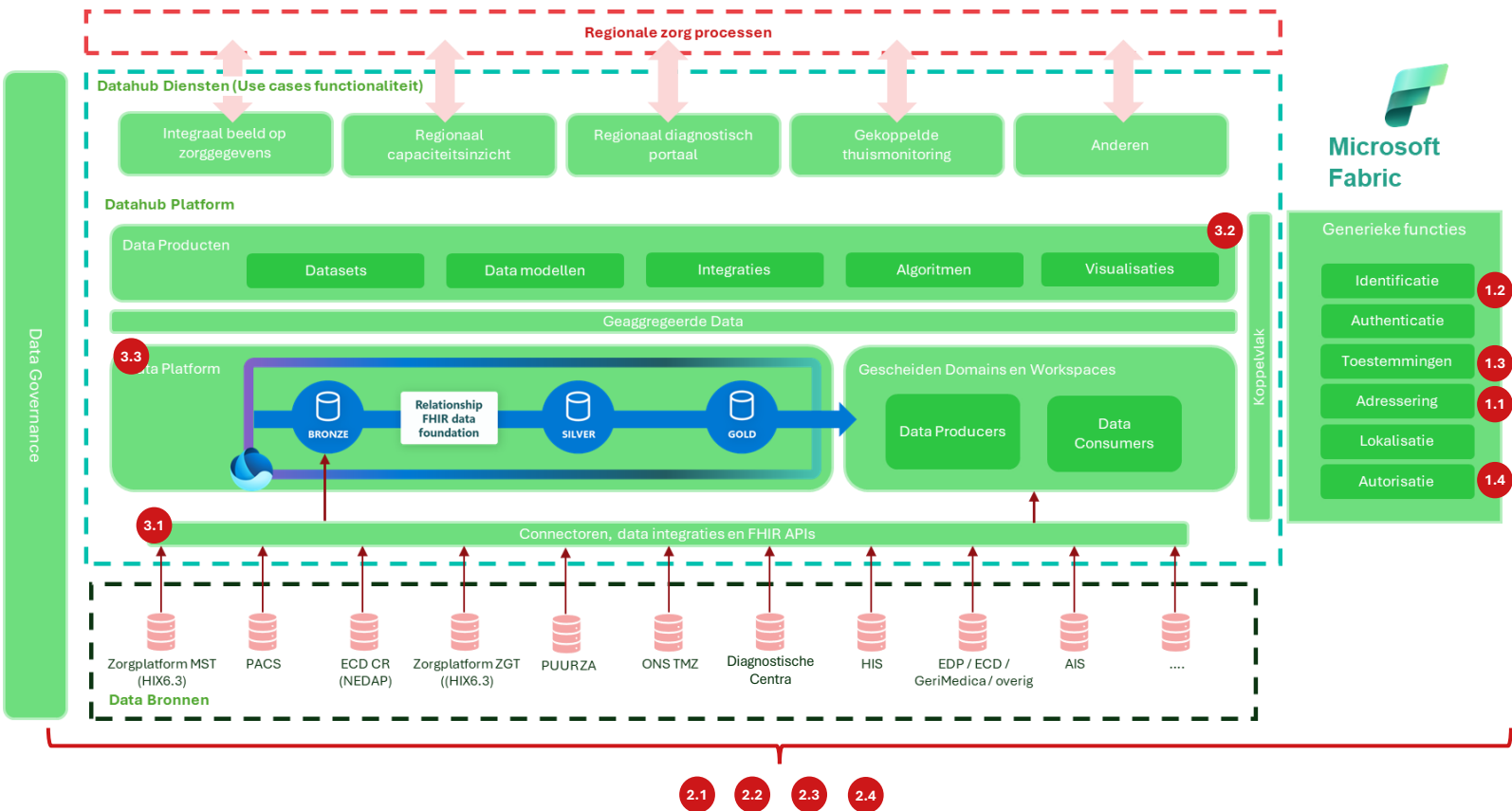
De onderstaande matrix biedt inzicht in de deelnemers van het transformatieplan (specifiek eerstelijnszorg, MSZ, en diagnostiek) en de beschikbaarheid van de zibs

Soort zorg		Deelnemers transformatieplan	Beschikbaarheid zibs		
			Deelname VIPP	Informatiestandaard	Stand van zaken implementatie
VVT	VVT	Carintreggeland	InZicht	eOverdracht BgLZ	+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		TriviumMeubelbeltZorg	InZicht	eOverdracht BgLZ	+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		ZorgAccent	InZicht	eOverdracht BgLZ	+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		Zorggroep Sint Maarten	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		De Posten	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		Liberein	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		Livio	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		De zorggroep Manna	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		Zorgfederatie Oldenzaal	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		De Vriezenhof	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		De Warme Huizen	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
		Friso	nvt		+ 45 zibs in ECD bsb, nog niet geïmplementeerd
	Zorgcentrale		nvt		



5. Fit-gap analyse generieke functies, afsprakenstelsels en informatiestandaarden

De generieke functies, afsprakenstelsels en standaarden zijn in relatie tot het platform weergegeven.



Generieke functies

- 1.1 Zorg-AB
- 1.2 Zorg-ID
- 1.3 Mitz
- 1.4 Twiin portaal

Afsprakenstelsels

- 2.1 AORTA-LSP
- 2.2 NUTS
- 2.3 MedMij
- 2.4 Twiin

Standaarden

- 3.1 FHIR
- 3.2 OMOP
- 3.3 OpenEHR

Legenda:
● Fit ● Gap ● Te onderzoeken in vervolg fase



Bijlage H Kosten datahub

7. Kosten datahub

De technische middelen achter de datahub

De technische kosten van de RDH zijn grofweg te verdelen in drie categorieën: kosten voor de data (gebaseerd op Microsoft Fabric), infrastructurele kosten voor Microsoft Azure en kosten om de benodigde applicaties (viewers, portalen) te kunnen faciliteren (op basis van het Microsoft Power Platform). Het betreft een groffe inschatting van te gebruiken Microsoft services omdat de exacte kosten afhankelijk zijn van het totale aantal gebruikers, exacte hoeveelheid en type data, en bestaande licenties die gebruikers kunnen inbrengen indien nodig.

Disclaimers:

- Er is gerekend met list-prijzen zonder kortingen en bijvoorbeeld *reserved instances* toe te passen. Daadwerkelijke kosten zullen dus lager uitvallen door nog te maken contractuele afspraken met Microsoft
- Infrastructurele kosten en applicatiekosten zijn gegroepeerd, de uitwerking per dienst/licentie volgt bij implementatie van de individuele use-cases
- Eventuele in te brengen al aanwezige licenties (zoals voor gebruik van login (Entra ID) en Microsoft 365 zijn niet meegenomen)
- Er is geen nog onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten data (zoals het uitwisselen van beelden)
- De kosten inschatting is gemaakt om zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke kosten in de buurt te komen op basis van al beschikbare informatie. Eventuele benodigde aanpassingen gedurende implementatiefase kunnen de kosteninschatting doen veranderen
- De geschatte kosten hebben betrekking op de Microsoft-componenten en niet op eventuele andere externe services die mogelijk vereist zijn

Microsoft Fabric (Data):

- De RDH maakt gebruik van een gedeelde capaciteitspool ter ondersteuning van alle mogelijkheden in Microsoft Fabric, van gegevensmodellering en datawarehousing tot visualisaties en kunstmatige intelligentie. De pool wordt 'vloeiend' uitgevoerd: wanneer kleine gebruikspieken optreden wordt het rekengebruik in de loop van de tijd afgevlakt om te voorkomen dat u wordt geconfronteerd met extra kosten. De pool kan ingezet worden voor zowel productie en non-productie (ontwikkel)werkzaamheden. De grootte van de pool bepaald hoeveel capaciteit er in totaal beschikbaar is voor een maand
- De te verwachten benodigde capaciteitspool voor de productieomgeving van de RDH is een F128 pool; zie de volgende slide voor de gebruikte inputwaarden in de berekening. De te verwachten benodigde capaciteitspool voor de non-productieomgeving van de RDH, ter ondersteuning van de ontwikkel en testwerkzaamheden is een F128 pool. Iedere ontwikkelaar van Power BI rapportages dient een Power BI Pro licentie te hebben. Dit aantal is op 50 personen begroot. Zowel de grootte van de capaciteitspool, als het aantal Power BI Pro licenties is eenvoudig op te schalen indien nodig.
- De kosten voor Microsoft Fabric worden geschat op **EUR 480.000** per jaar op basis van de geselecteerde use-cases die in productie draaien



7. Kosten datahub

De technische middelen achter de datahub

Azure Infrastructuur:

- Naast kosten voor Microsoft Fabric zijn er verschillende infrastructuur en netwerkkosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van Azure Key Vault. De kosten voor Microsoft Azure worden geschat op **EUR 480.000,-** op basis van de geselecteerde use-cases die in productie draaien.

Applicaties en licenties:

- Voor de geselecteerde use-cases zijn verschillende interfaces benodigd die gefaciliteerd worden door de RDH. Voor de applicatielaag van de RDH zijn componenten van het Microsoft Power Platform benodigd, zoals Power BI voor visualisaties van rapportages en dashboards, maar ook low-code toepassingen als Power Apps of Power Pages om eenvoudig applicaties, viewers of portalen te kunnen faciliteren vanuit de RDH. Dit is niet standaard onderdeel van Microsoft Fabric maar belangrijk in de doelarchitectuur. Daarom zijn deze kosten aanvullend op de kosten voor het Fabric platform, welke kosten heeft voor data-opslag en verwerking. Ook worden er externe diensten ingezet (bijvoorbeeld voor de use-case thuismonitoring) met eigen applicaties en interfaces. Deze kosten zijn niet onderdeel van de Microsoft kosteninschatting. Tot slot zijn er licenties benodigd om bijv. gebruikers te kunnen laten inloggen (Entra ID) en data governance in te regelen (Microsoft 365 E5 licenties). Dit is echter sterk afhankelijk van de in te brengen licenties van de regiopartijen en gebruikers. De kosten voor de benodigde applicaties en aanvullende licenties worden geschat op EUR 500.000,-. Voor de geselecteerde use-cases zijn verschillende interfaces benodigd die gefaciliteerd worden door de RDH. Hiervoor zijn componenten van het Microsoft Power Platform benodigd, zoals Power BI voor visualisaties van rapportages en dashboards, maar ook low-code toepassingen als Power Apps of Power Pages om eenvoudig applicaties, viewers of portalen te kunnen faciliteren vanuit de RDH. Tot slot zijn er licenties benodigd om bijv. gebruikers te kunnen laten inloggen (Entra ID) en data governance in te regelen (Microsoft 365 E5 licenties). Dit is echter sterk afhankelijk van de in te brengen licenties van de regiopartijen en gebruikers. De kosten voor de benodigde applicaties en aanvullende licenties worden geschat op **EUR 500.000,-**.

Dataopslag, verwerking en analyse (Microsoft Fabric)

Geschatte kosten per jaar: € 480.000

Infrastructuur en netwerk (Microsoft Azure)

Geschatte kosten per jaar: € 480.000

Applicaties en licenties (Microsoft Power Platform en Microsoft 365)

Geschatte kosten per jaar: € 500.000

Verwachte maximale investering RDH

Totale geschatte kosten per jaar: € 1.460.000

General	Select # of Working Days in a week	7
	Total Data Size (Compressed) (GiB)	1.000
	Daily DW/LH Processing	12
	# of ETL Source tables/Jobs	200
	% Hot Data	20%
Lakehouse	Per Batch cycle Incremental Data	20
	Is Gold Layer processed by SPARK	Yes
	Does Serving Layer require DW Endpoint	Yes
Power BI	# of Report Creators/Authors	50
	Already have Microsoft 365 E5 Licenses?	No
	Existing # of Power BI Pro / PPU CALs	No
Power BI Embedded	# of Report/Dashboard users	500
	Do you require Power BI Embedded?	Yes
	Daily Active Power BI Embedded Users	100
SQL	Daily Service Hours	24
	Ad-hoc Duty Cycle(h/day)	10
Data Science	# of Concurrent Queries	5
	Is Fabric Data Science in use?	Yes
	Daily Avg. # of DS Batch Scoring Models	5
	# of Data Scientists	10
No expected use for Data Activator, KQL, and Event Streaming		

Input gebruikt voor kostenberekening.



7. Kosten datahub

Projectkosten implementatie

Rol	FTE kalenderjaar 1	FTE kalenderjaar 2	FTE kalenderjaar 3
Projecteigenaar			
Projectleider			
Sponsor			
Projectteam • Architect • Data Engineers • Power BI Developer • Power Platform Expert • Business Analyst Healthcare			
Projectleider regio			
Projectteam regio • Per ziekenhuis • Voor hele VVT • Apotheek en kleine organisaties binnen VVT • SME			
Totaal			



Aansluiting Zorgviewer en Twente Datahub

Indicatie van impact en kosten voor het verbinden van oplossingen

Hergebruik aan van componenten en ervaringen tbv versnelling in de regio's

Functioneel: Het hergebruiken van componenten versnelt zowel het zorgproces als het technische niveau. Zorgviewer, ontwikkeld in samenwerking met medische professionals op een praktische basis, kan deze versnelling faciliteren bij het ontwikkelen van een 360-graden beeld. De integratie van deze informatie in zorgprocessen en technologie bevordert een snellere implementatie. Ervaringen in Twente met de VIPP-programma's hebben de effectiviteit van koppelingen en datagebruik bewezen. Deze twee elementen samen kunnen het werkproces versnellen en zorgmedewerkers efficiënter ondersteunen.

De geplande functionaliteiten van het 360-graden beeld omvatten ook de validatie en interpretatie van gegevens uit verschillende bronsystemen, en indien nodig, de overdracht van gegevens naar andere systemen. Dit is cruciaal voor het verminderen van administratieve lasten, zoals bij e-overdracht en het generieke kern dossier, wat aansluit bij de ACP-casus.

Technische Verbinding: Door het dataplatform te plaatsen tussen de bronverbindingen (laag 1, Cumuluz) en de diensten in (laag 3), krijgen we meer controle over de gegevens. Zo kunnen verbindingen die voor Zorgviewer zijn ontwikkeld, ook in andere regio's worden toegepast, en omgekeerd.

Investering: Een schatting van de investering voor alleen het aansluiting van de huidige versie van Zorgviewer, waarbij in latere stappen, op basis van nadere beslissingen, extra bronnen worden ontsloten. Het is belangrijk om op te merken dat dit direct samenhangt met de verdere ontwikkeling van Zorgviewer waarvan de impact nu niet te kwalificeren is.

Doorontwikkeling: Als regio's kunnen we elkaar versterken bij de doorontwikkeling zowel vanuit technisch perspectief als implementatiekracht.

Tijdslijn



Zorgviewer	Basis	doorontwikkeling per add. bronsysteem
Stappen	Indicaties	Indicaties2
proces en afstemming	€ 30.000,00	€ 15.000,00
platform configuratie		
bestaande koppelingen	€ 50.000,00	€ 20.000,00
generieke aansluitingen	€ 30.000,00	€ 5.000,00
totaal	€ 110.000,00	€ 40.000,00



Bijlage I Landelijke architectuur principes

Landelijke architectuur principes

Ter ondersteuning van en als aanvulling op de architectuurprincipes van de individuele zorginstellingen werken we vanuit de doelarchitectuur met landelijke en regionale principes. Hierbij zijn uitgangspunten opgesteld

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Het Twiin en het NUTS Afsprakenstelsel voor de ontsluiting van bronsystemen van zorgaanbieders, en daarmee compliant aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Wegiz en het Integraal Zorgakkoord (IZA). De uitgangspunten dienen als leidraad voor zorginstellingen in de regio en ondersteunen bij het maken van toekomstbestendige keuzes die in lijn zijn met het IZA, de Wegiz, Twiin en NUTS.
- Het Nictiz 5-lagen model als structuur. Hierbij wordt voortgebouwd op beschikbare structuren zoals de datasetgenerator van Santeon, gebaseerd hetzelfde Nictiz model. Santeon heeft deze datasetgenerator (het Santeon Information Model) ontworpen zodat ziekenhuizen die deze generator gebruiken gemakkelijker data uit lokale bronsystemen kunnen halen
- Landelijke referentiearchitecturen NORA & DIZRA.
- Toekomstige aansluiting op initiatieven zoals CumuluZ en Zorg bij jou van Santeon.
- De juiste industriestandaarden en best practices voor architecturen (bijvoorbeeld TOGAF) zullen worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de datahub-architectuur.

De uitgangspunten worden gebruikt om nieuwe initiatieven te toetsen waarmee zorggegevens uitgewisseld of beschikbaar gesteld worden buiten de eigen zorginstelling. Ze helpen om in gezamenlijkheid de gewenste richting te helpen vasthouden. Als er een goede reden voor is, kunnen zorginstellingen afwijken van de architectuurprincipes.



Landelijke architectuur principes

In Twente benutten we het Nictiz 5-lagen model om structuur te geven aan ons ontwerp. We zorgen dat de afspraken op elk van de niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan wet- en regelgeving en beveiligingseisen

- **Organisatie:** onze regionale zorgtransformatie vraagt om een totaal nieuwe manier van werken en samenwerken, met afspraken op bestuurlijk niveau over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Die governance en organisatie krijgen een vaste / definitieve vorm.
- **Zorgproces:** we streven in Twente naar een zorgtransformatie waarin we lijnloos willen samenwerken en zorgprocessen met behulp van technologie in het netwerk zullen organiseren.
- **Informatie:** we maken duidelijke afspraken over terminologie, classificaties en informatiestandaarden. We sluiten maximaal aan bij internationale en landelijke afspraken over te hanteren standaarden.
- **Applicatie:** In Twente en omgeving is ervoor gekozen om te werken met standaard data platform technologie voor het realiseren van de datahub. We maken daarmee data beschikbaar die nu nog opgesloten zit in diverse bronsystemen.
- **IT-infrastructuur:** We gaan voor de IT-infrastructuur uit van gestandaardiseerde technologie, bij voorkeur op basis van internationale ontdekkingen .

We houden rekening met wet- en regelgeving zoals de AVG en de WGBO om de privacy en de rechten van inwoners te waarborgen. Bovendien, is beveiliging op alle niveaus van cruciaal belang om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie te waarborgen



Landelijke architectuur principes

De datahub hanteert regionale architectuurprincipes die in DIZRA zijn gedefinieerd. Per principe is de vertaling naar de datahub gemaakt

Zoals eerder vermeld in de vorige dia, is het DIZRA (Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur)-manifest het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de doelarchitectuur, omdat daarbij ook een link wordt gelegd met de ZIRA, Twiin en Nationale Visie en Strategie-principes. Zie hieronder de principes die beschreven staan in de DIZRA en hoe de regionale datahub daarmee verband houdt, aangezien dit de basis vormt voor de doelarchitectuur:

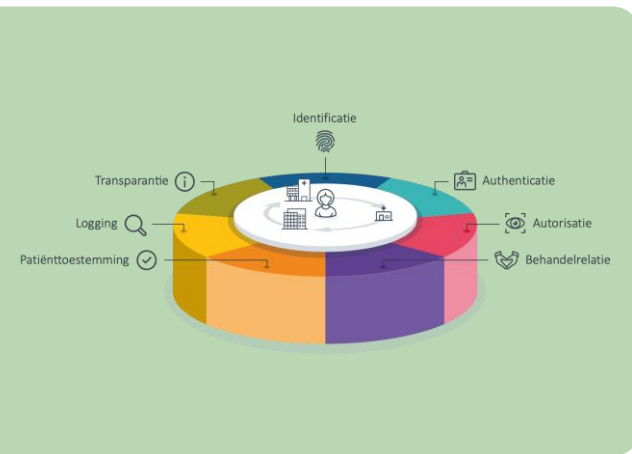
1. In het informatiestelsel hebben Inwoner regie op hun eigen gezondheidsgegevens en kunnen deze gegevens meenemen en delen in hun reis door het zorglandschap en in het netwerk van zorgprofessionals en ondersteuners dat zich rondom hen vormt.	1. De Regionale Datahub stelt inwoners in staat om veilig gezondheidsgegevens te beheren en te delen binnen het zorgnetwerk. Het biedt centrale opslag, gegevensbezitcontrole en interoperabiliteit. Inwoners kunnen veilig delen, updates ontvangen en actief deelnemen aan hun zorgtraject.
2. In het informatiestelsel spreken we een gemeenschappelijke taal en hanteren we gemeenschappelijke terminologie, waarbij we de contextuele verschillen omarmen.	2. De Regionale Datahub kan dit faciliteren door standaardisatie van kaders, gegevensmodellen en interoperabiliteit. Het bevordert een gedeelde taal en terminologie, met consistentie, lokale variaties en samenwerking, rekening houdend met contextuele verschillen.
3. De data blijft bij de bron , onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder, voor een veilig en vertrouwd informatiestelsel waarin het voor inwoners transparant is welke bronhouders welke gezondheidsgegevens registreren en wie het raadpleegt.	3. De Regionale Datahub zorgt ervoor dat gegevens op hun bron blijven onder de verantwoordelijkheid van de gegevenshouder. Met authenticatie- en toegangscontrolefuncties biedt de dtahub transparantie voor inwoners over gezondheidsgegevensregistratie en toegang, wat resulteert in een veilig informatiesysteem.
4. Het informatiestelsel hanteert een gelijk speelveld voor alle leveranciers . Afspraken worden gemaakt over het gebruik van standaarden, niet over het gebruik van een product of dienst. Iedere organisatie kiest haar eigen leveranciers voor het implementeren van de standaarden.	4. De Regionale Datahub vergemakkelijkt dit door interoperabiliteit met verschillende cloudplatforms te ondersteunen en aanpasbare integratiemogelijkheden te bieden. De Datahub stelt organisaties in staat hun voorkeursleveranciers te kiezen voor het implementeren van standaarden.
5. Het informatiestelsel is duurzaam doordat het relevant is en blijft. Het omarmt voor nu en in de toekomst de complexiteit van meerdere standaarden in een stelsel waarin verandering en innovatie welkom is.	5. De Regionale Datahub ondersteunt interoperabiliteit en aanpasbaarheid met een flexibele architectuur. Het kan meerdere standaarden integreren en biedt tools voor het beheren van complexe gegevensstructuren. Continu bijgewerkte ondersteuning en adaptatie aan opkomende technologieën bevorderen innovatie, waardoor een duurzaam informatiesysteem ontstaat.
6. Data wordt enkelvoudig geregistreerd bij de bron en vervolgens beschikbaar gesteld voor meervoudig gebruik in verschillende toepassingen. Hiervoor hanteert het informatiestelsel de FAIR-data principes.	6. De Regionale Datahub maakt dit mogelijk door zich te houden aan de FAIR-data principes, waardoor gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn via functies zoals indexerings, toegangscontroles, ondersteuning van interoperabiliteitsnormen en gegevensbeheermechanismen.
7. Data is machineleesbaar , machines begrijpen de data, zonder daarbij de leesbaarheid van deze data voor mensen uit het oog te verliezen. Dit opent de mogelijkheden voor secundair gebruik (data-analyse en data-science)	7. De Regionale Datahub maakt dit mogelijk door ondersteuning te bieden voor gestandaardiseerde gegevensformaten en protocollen, zoals JSON, XML of CSV, die door machines kunnen worden gelezen en toch begrijpelijk blijven voor mensen. Het biedt ook tools en API's voor gegevensextractie, transformatie en analyse, waardoor gebruikers kunnen profiteren voor secundaire doeleinden zoals gegevensanalyse en data science.
8. In het informatiestelsel wordt federatief samengewerkt aan afspraken voor data en voor services. Iedereen implementeert deze afspraken en is aanspreekbaar op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van de implementatie.	8. De Regionale Datahub kan dit technisch ondersteunen door tools en frameworks te bieden voor federale samenwerking, inclusief API's en protocollen voor gegevens- en service-integratie. Het biedt functies voor het handhaven van afspraken en het monitoren van kwaliteit, waardoor verantwoordelijkheid en naleving van de vastgestelde normen binnen het ecosysteem worden gewaarborgd.
9. Semantische en technische interoperabiliteit wordt in het informatiestelsel gerealiseerd door te kiezen voor open internationale standaarden . Iedere deelnemer aan het stelsel moet voldoen aan de standaarden die zijn afgesproken.	9. De Regionale Datahub biedt FHIR-API's en standaard workloads voor semantische en technische interoperabiliteit. Bovendien kan het worden aangepast om andere regionale normen over te nemen, waardoor flexibiliteit wordt gegarandeerd terwijl internationale normen worden nageleefd.



Bijlage J Generieke functies

Technische uitgangspunten & doelarchitectuur - Generieke functies

Zoals beschreven in het IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, geeft het programma Implementatie generieke functies van VWS met generieke functies invulling aan het vertrouwensmodel, corresponderend met gemeenschappelijke voorzieningen van VZVZ, CIBG, iRealisatie, Zorginstituut Nederland, Twiin en NUTS.



Bij de generieke functies voor data-uitwisseling is van belang:

1. **Identificatie:** moeten zorgaanbieders er op kunnen vertrouwen dat de andere zorgaanbieder is wie zij zegt te zijn en moet er tevens zekerheid zijn over de identiteit van de patiënt over wie de uitgewisselde gegevens gaan;
2. **Authenticatie:** zorgaanbieders zekerheid hebben over de identiteit van de andere zorgaanbieder en betrokken zorgprofessional;
3. **Autorisatie:** moeten zorgaanbieders zorgen dat alleen die gegevens uitgewisseld worden die nodig zijn voor de behandeling van de betrokken patiënt. De landelijke afspraken over zijn in ontwikkeling, beschikbare protocollen zijn gebaseerd op UZI-rolcodes
4. **Lokalisatie:** moeten zorgaanbieders specifieke gegevens kunnen vinden, zodat de juiste informatie tijdig op de juiste plek is.
5. **Toestemming:** moeten zorgaanbieders erop vertrouwen dat de betrokken patiënt toestemming heeft gegeven die voldoet aan de voorwaarden (gebruik Mitz);
6. **Adressering:** moeten zorgaanbieders kunnen bepalen wat het digitale adres is van de ontvanger of bron.



Bijlage K Toelichting van gebruik generieke functies per use-case

Toelichting van gebruik generieke functies per use-case

Onderstaande matrix* geeft een overzicht van de generieke functies per use-case (huidige situatie april 2024)

	Generieke functies (uit programma generieke functies)					
	Adressering	Identificatie	Toestemming	Lokalisatie	Authenticatie	Autorisatie
Regionaal capaciteitsinzicht	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Gekoppelde thuismonitoring	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ACP in de keten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Integraal beeld op zorggegevens	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Regionaal diagnostisch portaal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



Bijlage L Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

ACP	Advance care planning	MST	Medisch Spectrum Twente
API	Application programming interface	MSZ	Medisch specialistische zorg
BgLZ	Basisgegevens Langdurige Zorg	PGO	Persoonlijke gezondheidsomgeving
Bgz	Basisgegevensset Zorg	POH	Praktijkondersteuner huisarts
BV	Besloten Vennootschap	RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ECD	Elektronisch cliëntendossier	ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorgketen
EHDS	European Health Data Space	RSO	Regionale samenwerkingsorganisatie
EPD	Elektronisch patiëntendossier	SEH	Spoedeisende hulp
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	TAO-UA	Twente Apothekers Organisatie-UA
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg	VVT	Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
HAP	Huisartsenpost	VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
HIS	Huisartsen Informatiesysteem	ZCC	Zorgcoördinatiecentrum
HZT	Huisartsenzorg Twente	ZGT	Ziekenhuisgroep Twente
IZA	Integraal Zorg Akkoord	Zibs	Zorginformatiebouwstenen
KPI	Key Performance Indicator	Zkhs	Ziekenhuis
LPZ	Landelijk Platform Zorgcoördinatie	ZN	Zorgverzekeraars Nederland

